

✏️ 신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색 밑줄**
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색

[1] 기증, 혈증, 담음증 + 스트레스 이론

0절. 개요

精氣神이란?

- 精, 氣, 神은 인간 생명의 근본으로 三寶라고도 불린다.
- 이 셋은 불가분의 관계이며 삼위일체의 관계이다.
- 精, 氣, 神은 상호 작용에 의하여 消長盛衰하며 상호 轉化한다.¹

1. 精

- 후천적으로는 水穀의 정미한 것으로부터 얻어지는 물질로서 인체활동의 **물질적 기초**가 되는 것

2. 氣

- 水穀의 精氣가 천공의 氣와 합쳐져서 **생리작용의 추동력**을 발휘하는 작용을 함
- **에너지의 흐름 정도로 보자**

3. 神

- 水穀之味와 精, 氣의 협동으로 이루어지는 것으로 **인체의 정상적인 사유활동**을 총괄하는 것²

神은 精과 氣를 통괄하는 가장 최상의 단계로서, 인체라는 유형의 물질체계는 精神이라는 무형의 메시지에 의해서 유지되고 조절되어 건강한 전체성을 보존하게 된다.

¹ 氣者神之祖 精乃氣之子 氣者精神之根蒂也

1절. 氣證

氣의 병리

1. 氣虛: 氣의 生化不足 혹은 耗傷太過. **잘 안 만들어지거나 너무 많이 손상된 것**
 - 원인: 久病, 老年體弱, 飲食失調
 - 증상: 頭暈目眩, 小氣懶言, 神倦乏力, 自汗, 舌淡, 脈虛無力,
2. 氣機失調: 氣의 기능실조, 운동실조. **기의 순환이 잘 안되는 것**
 - 氣滯: **氣가 잘 움직이지 못함**. 脹悶, 疼痛
 - 氣逆: **氣가 위로 솟구침**. 嘔惡, 呃逆, 噯氣, 咳嗽, 頭痛, 眩暈
 - 氣陷: **기가 아래로 빠짐**. 脘腹墮脹, 二便滑泄難禁, 脫肛, 陰挺
 - 氣脫: **탈진된 것**. 大汗淋漓, 神識萎靡(인지↓), 昏迷, 手足不溫, 脈微慾絕
 - 氣閉: **氣가 꼭 막힌 것**. 人事不省, 牙關緊急(턱이 안 열림)

氣證의 분류

1. 스트레스 현상

- 七氣, 九氣, 氣鬱, 中氣, 氣痛, 氣逆

2. 체력의 허실

- 기의 출입상태(호흡력): 少氣, 短氣
- 에너지의 승강상태: 下氣, 上氣

→ **氣의 병리는 스트레스 이론과 유사하다.**

氣證의 분류

1. 七氣, 九氣, 氣鬱, 中氣, 氣痛, 氣逆
2. 체력의 허실
 - 기의 출입상태(호흡력): 短氣, 少氣
 - 에너지의 승강상

² 협의의 神

七情, 七氣, 九氣의 정의와 차이점

七情	- 정의: 사람이 가질 수 있는 여러 종류의 감정과 심리상태. - 외계사물에 대한 인간 정신의식의 반응 - 喜, 怒, 思, 憂, 悲, 恐, 驚 - 발현부위: 가슴 양 유두 사이 정중양(전중) ← 사실 급소라 누르면 다 아픔
七氣	- 喜怒哀思悲恐驚을 말하며, 七氣證은 七情의 氣가 손상되어 발생한 병증 - 즉, 七情의 병리적 현상(仁齋直指) - 七情은 心에서 생기고 七氣는 氣에 속한다.(醫學入門)
九氣	- 喜, 怒, 思, 憂, 悲, 恐, 驚(감정의 변화) + 寒熱(外氣의 변화) + 勞(육체적 과로) - 怒則氣上, 喜則氣緩, 悲則氣消, 恐則氣下, 寒則氣收, 熱則氣泄, 驚則氣亂, 勞則氣耗, 思則氣結 ← 암기 - 氣의 운행은 감정적인 변화 때문에 바뀔 수 있다.

七情

喜	- 생리: 氣血의 정상소통. 喜即 氣緩, 氣下→ 氣泄 - 병리: 평소에 바라던 바가 이루어져 너무 기뻐서 기쁨의 양을 감당못함 - 어느 순간까지 절망적이었던 것이 극적 반전에 의해 기쁨으로 변화 - “喜樂無極卽傷魄魄傷卽狂”(너무 기쁜 나머지 우울증에 걸린 경우) - 심폐(心肺)를 상한다.
怒	- 奴(노예 노) + 心(마음 심) - 가장 조절하기 어려운 감정 - 노상간(怒傷肝), 怒則氣逆, 氣上
憂	- 思則氣結. 생각을 너무 많이 하면 기가 올체된다.
思	- 사건이 결정되기 전 속태우고 걱정하는 것 - 憂와 思는 밀접한 관계. 憂+思=기울체(氣鬱滯)
悲	- 과거에 대한 후회, 걱정, 근심 - 憂+思+悲
恐	- 구체적 대상에 대한 두려움. 불안 - 뚜렷한 원인을 알고 있음 - 공상신(恐傷腎)
驚	- 순간적으로 낯선 것에 대한 놀람

- 원인 없음, 막연한 불안함

七氣證

- 七氣證: 七情의 氣가 손상되어 발생한 병증
- 정신적인 스트레스로 인해 감정의 표현인 七氣가 과도하게 나타난 결과, 이것이 또 하나의 스트레스 인자로서 역할을 하게 되어 七氣證을 발생
- 체질적 소인과 관계가 깊음: 감정 변화가 심한 사람, 痰飲이 많은 사람
- 정상적인 것은 七情, 병리적인 것은 七氣. (仁齋直指)
- 七情은 心에서 생기고 七氣는 氣에 속한다 하여 七情과 七氣를 구분(醫學入門)

※ 매핵기

“七氣相干 痰涎凝結 如絮如膜 甚如梅核 窒碍於咽喉之間 咯不出 嚥不下 或中滿艱食 或上氣喘急 日氣隔 日氣滯 日氣秘 日氣中 以至五積六聚 疝癖癥瘕 心腹塊痛 發則欲絕 殆無往而不至矣.”

- 七氣가 서로 어울려 痰涎이 뭉친 것
- 이명: 氣隔, 氣滯, 氣秘, 氣中
- 증상: 인후부 이물감. 咽喉를 막은 듯이 느껴지지만 뱉어지거나 삼켜지지도 않는다. 심해지면 五積, 六聚, 疝癖, 癥瘕, 心腹塊痛
- 증상이 나타나면 숨이 끊어지는 것 같고, 안 가는 곳이 없이 돌아다닌다.
- 서양의학: GERD 유사, 역류성 식도염, 히스테리구
- 치료원칙: 先 豁痰, 後 調氣
- 치료: 폐정격, 칠기탕, 분심기음, 향굴탕, 반하후박탕

九氣證

- 喜, 怒, 思, 憂, 悲, 恐, 驚(감정의 변화) + 寒熱(外氣의 변화) + 勞(육체적 과로)
- 九氣는 氣의 기능을 실조시킴으로써 氣病을 유발한다.
- 9개 중 6개가 감정으로 氣病은 대부분 감정의 이상변화에 의해 발생한다.

※ 九氣의 병리기전(素問.舉痛論) ← 객관식

- ① 怒則氣逆, 甚則嘔血及飧泄, 故氣上矣.
- ② 喜則氣和志達, 榮衛通利, 故氣緩矣.
- ③ 悲則心係急, 肺布葉舉, 而上焦不通, 榮衛不散, 熱氣在中, 故氣消矣.
- ④ 恐則精却, 却則上焦閉, 閉則氣還, 還則下焦脹, 故氣不行矣.

- ⑤ 寒則腠理閉, 氣不行, 故氣收矣. ⑥ 熱則腠理開, 榮衛通汗大泄, 故氣泄.
- ⑦ 驚則心無所倚, 神無所歸, 慮無所定, 故氣亂矣.
- ⑧ 勞則喘息汗出, 內外皆越, 故氣耗矣.
- ⑨ 思則心有所存, 神有所歸, 正氣留而不行, 故氣結矣.

- 치료 원칙: 高者抑之 下者舉之 寒者熱之 熱者寒之 驚者平之 勞者溫之 結者散之 喜者以恐勝之 悲者以喜勝之 九氣治法各 有分別

- 처방: 神仙九氣湯, 正氣天香湯 ← 암기

中氣

- "내 눈에 흠이 들어가기 전까지 안돼!" 하면서 쓰러지는 것

- 일과성의 의식상실과 경련

- 전환장애와 유사

- 증풍과 구별해야한다.

- 中風 脈浮 身溫 口多痰涎

- 中氣 脈沈 身冷 口無痰涎

- 병인: 대부분 怒로 인한다.

- 증상: 돌연혼도하여 인사불성한다. + 牙關緊急, 手足痙攣, 厥冷, 脈沈

- 때로는 깨어나면서 분노, 억울, 공포, 경악, 비탄 등의 감정을 표현하고, 심하면 환각과 더불어 섬망상태에 빠지기도 하며, 점차 안정되면서 각성되거나 수면을 취하게 된다.

- 치료원칙: 먼저 폐색된 것을 열어주고 기를 통하게 한 후 순기지제를 사용한다.³

- 구급방: 소합향원 사용한 후 칠기탕가석창포

- 처방: 虛하면 팔미순기산, 實하면 사칠탕. / 목향순기산, 성향정기산

- 강형원 교수님은 분신기음, 교감담 잘 쓰신다.

上氣證

- 병인

1. 肺에 邪氣가 있는 경우⁴

2. 氣有餘한 경우⁵

3. 痰이 胃脘에 정체되어 痰과 氣가 肺道를 막았을 경우⁶

- 증상: 氣가 上逆, 呼多吸少, 氣息促急

- 처방: 소자강기탕, 비전강기탕, 지성래복단, 침향강기탕, 쾌기탕

下氣證

- 완강한 下痢 또는 만성 소모성 질환 등으로 元氣가 쇠퇴했을 때나 육체적인 과로, 영양 부족, 과음 등으로 眞氣가 고갈

- 원인: 下氣屬心虛. 心の 기능이 부족할 때 氣가 아래로 쳐져서 氣泄

- 증상: 무력감, 허탈감, 脫肛, 脫陰, 後重便下泄無度

- 처방: 보중익기탕, 사군자탕

短氣證

- 短氣: 호흡이 짧고 빠른 것

- 腹脹滿의 경우 흔히 볼 수 있는 호흡상태

- 원인

1. 結胸, 停水怔忡, 風濕相搏, 素弱氣虛

2. 心腹脹滿者는 實證이니 邪가 裏에 있는 것

3. 心腹濡滿者는 虛證이니 邪가 表에 있는 것

- 증상: 호흡이 잘 이어지지 않음⁷, 숨이 가쁘고 몹시 짧음⁸

- 처방: 영계출감탕, 신기환, 사군자탕, 보중익기탕, 인삼양영탕

³ 急救開閉塞而通氣 後用順氣之劑

⁴ 邪在肺則 皮膚病 寒熱 上氣喘

⁵ 氣有餘則喘咳上氣

⁶ 痰停胃脘 痰與氣搏 肺道壅塞 亦令人上氣

⁷ 呼吸不相接續

⁸ 氣急而短促

少氣證

- 少氣: 호흡이 미약한 상태
- 일반적으로 체력이 허약한 사람. **형상적으로 약한 부분이 있어야 한다.**
- 원인
 1. 氣를 藏하는 肺의 氣가 不足한 경우
 2. 氣를 生하는 腎이 虛한 경우
 3. 氣가 모이는 膻中의 氣가 不足한 경우
 4. 內傷脾胃하여 中氣가 不足한 경우
- 증상: 懶言, 重言復言하며 四肢痛 無力
- 처방: 생맥산, 인삼고, 독삼탕, 황기탕, 사군자탕, 인삼황기탕, 익기환, 보중익기탕, 익위승양탕

氣痛證

- 氣痛: 氣의 순행이 응체되거나 역행하여 氣血의 소통이 저해된 것
- 분노, 억울, 욕구불만, 불쾌감, 불안, 공포 등의 감정은 자율신경계를 긴장
- 원인: 대부분 칠정, 음식으로 인해 울체되고 담음이 발생. 元氣와 혈액이 臟腑之間에 소통되지 못하여 氣痛
- 증상: 氣滯가 있는 위치에 따라 다름
 - 上焦: 心胸痞痛
 - 中焦: 腹脇刺痛
 - 하조: 腰痛疝瘕⁹
 - 외부: 周身刺痛或浮腫(몸이 전체적으로 찌르는 것 같은 통증과 부종)
- 치료원칙: 초기에는 신온한 약재로 開鬱, 行氣, 豁痰, 消積하고 오랜 병에는 신한한 약으로 降火시켜 뿌리를 제거해야 한다.
- 처방: 오침탕, 복원통기산, 신선침사원, 소오침탕

氣逆證

- 諸逆衝上皆屬於火: 火는 정신적 충격이나 갈등, 기온의 변화, 濕熱의 축적
- 원인
 1. 憂愁太過 過思深慮: 정신적인 부분이 원인
 2. 濕熱停蓄 痰飲停滯: 습열이 정축되어 담음이 정체된 것이 원인
- 증상: 氣가 때때로 복중에서 上衝하는 것. **실제로 아래에서 위로 올라가는 느낌이라고 표현함**
- 치료원칙: 散火之法은 必先破氣라 하였으며 氣降則火自降한다.
- 처방: 퇴열청기탕, 도기지각환, 자음강화탕가변향부자복신침향

호흡

- 氣證환자들은 얇은 숨을 쉬며 흉식호흡을 하고 외부 자극에 의해 쉽게 호흡이 거칠어진다.
- 호흡은 활력징후 중 유일하게 스스로 조절할 수 있는 것으로 중요하다.
- 氣爲呼吸之根: 기는 호흡의 근본이다.
- 호흡이 기본, 호흡이 안정되어야 변화가 생긴다.

2절. 스트레스 이론

- 氣의 병리는 스트레스 이론과 유사하다.
- # Stress란?
 - 정의: 신체에 가해지는 내부, 외부의 압력에 대한 각 개인의 생리적, 심리적, 행동학적 반응
 - 자극이라는 스트레스원에 대해 인간은 스트레스 반응을 보인다. 이 자극과 반응이 상호 작용하며 좋은 스트레스, 나쁜 스트레스가 된다.



⁹ 疝瘕: 아랫배에 열이 차는듯하면서 통증이 있고 흰 점액이 요도로 흘러나오는 증상

자극중심 관점

- 개체의 환경에서 일어나는 자극을 스트레스로 본다.
- 스트레스원을 아래와 같이 4가지로 나눈다.
 1. Acute stressors: 사나운 개, 검사결과 기다리는 경우.
 2. Stressor sequences: 실직, 가족의 사망. **스트레스가 계속 지속되는 것**
 3. Chronic intermittent stressors: 중간고사, 특정 수업시간. **만성적이고 간헐적인 것**
 4. Chronic stressor: 직장에서 적대적인 상사, 만성 질병, 경제적 어려움, 성기능 장애. **간헐적이지 않고 계속 유지되는 것**
- 이런 사건들이 심리적 고통을 일으키거나 행동장애, 일의 지장을 초래하면 스트레스 인자로 지칭한다. 이외에도 daily hassles(일상적인 성가신 일)
- 평가방법: 생활사건 스트레스를 측정한다.(사회 재적응 평가척도)
 - 0~50 LCU: 스트레스 관련 질병 가능성 無
 - 50~199 LCU: 경증의 생의 위기(35%)
 - 200~299 LCU: 중등도 생의 위기(50%)
 - 300 이상 LCU: 중증의 생의 위기(80%)

심리학자인 홀즈와 라헤가 43개로 분류한 생활 스트레스 순위

1 배우자의 죽음	100점	21 저당물의 감소	30점
2 이혼	73점	22 일의 책임상의 변화	29점
3 별거	65점	23 저서의 출가	29점
4 고소수상 생활	63점	24 사회적 문제	29점
5 가까운 가족의 죽음	63점	25 우수한 개인적 성취	38점
6 상해 및 질병	53점	26 아내의 사망이 시작 또는 중지	26점
7 공과	50점	27 입학 또는 졸업	26점
8 재고	47점	28 거주환경 변화	25점
9 부부간 별거후 재결합	45점	29 개인적인 비웃 고장	24점
10 영년학위	45점	30 상사와 갈등	23점
11 가족의 병	44점	31 근무시간 및 근무조건의 변화	20점
12 임신	40점	32 거주지 변화	20점
13 생적인 장애	39점	33 학교의 변화	20점
14 가족 수의 증가	39점	34 오락활동의 변화	19점
15 사업의 재적응	39점	35 교외활동의 변화	19점
16 재정변화	38점	36 사회활동의 변화	18점
17 가까운 친구의 죽음	37점	37 1000만원 이하의 저당	17점
18 전직 및 부사임용	36점	38 수면습관의 변화	16점
19 배우자의 알코올 또는 흡수의 변화	35점	39 동거인수의 변화	15점
20 1000만원 이상의 저당	31점	40 식습관의 변화	15점
		41 증가	13점
		42 상환일	12점
		43 가까운 법률 위반	11점

스트레스 지수 체크방법

- 6개월 내의 자신에게 예상되는 일련의 점수를 모두 더한다.
- 같은 항목의 발생여부(예)상인 경우에는 점수에 발생한 횟수만큼 곱한다.

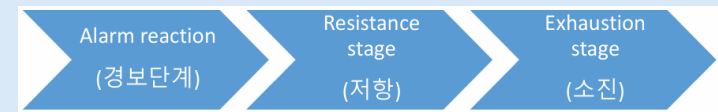
0-150점 미만	151-199점 (경미한 스트레스)	200-299점 (중등도 스트레스)	300점 이상 (심각한 스트레스)
-----------	---------------------	---------------------	--------------------

단, 이 점수는 생활사건 점수 지수로만 활용되는 점수이다.

반응중심 관점

- 개인이 사건에 대한 반응을 보임으로서 스트레스가 존재. **같은 사건을 겪어도 반응이 다르다!**
- 주요 스트레스 반응
 1. 신경생물학적 반응(monoamine, neuropeptide, cortisol)
 2. 생리적(전류에 의한 피부반응, 혈압 근육긴장)
 3. 심리적(부정적 감정, 기타 정신증상의 정도)

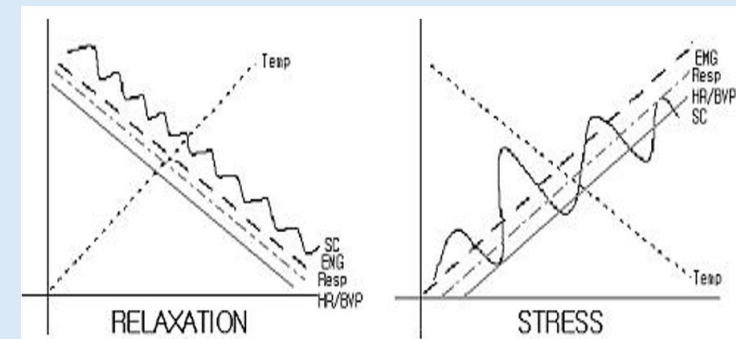
※ Selye의 일반적응증후군



- 사람들의 스트레스에 대한 반응이 일반적으로 이런 순서로 이루어진다.
 1. 경보단계: 처음 스트레스원을 맞닥뜨렸을 때 격양되는 단계
 2. 저항단계: 아직 남은 에너지로 버티는 단계
 3. 소진단계: 버틸 에너지가 떨어지고 번아웃이 온 단계
- 평가방법: 정신병리에 관한 임상적 연구들에 토대
인지기능장애, 대인 및 사회적 관계의 붕괴, 기타 장기간 지속되는 각종 정신장애의 증상들이 스트레스의 존재를 알려준다.

Ex) MMPI, SCL-90R, SRI, BDI, STAI

※ 이완 상태와 스트레스 상태에서 신체의 변화



- Temp: 온도. 스트레스 상황에서는 땀이 난 후 식으면서 체온이 떨어진다.
- SC: 피부전도도. 스트레스 상황에서는 땀이 나서 피부가 축축해지면서 피부전도도가 올라간다.
- ENG: 자율신경계 척도

- Resp: 호흡수

- HR/BVP: 심박수/혈압

Q. 스트레스 환자 중 교감신경이 항진된 환자가 있고 부교감신경이 항진된 환자가 있는데 둘은 무슨 차이인가요?

A. 처음 경보단계에 있는 사람은 교감신경이 항진되지만 에너지가 떨어지고 소진단계로 갈수록 역으로 부교감신경이 항진됩니다. 따라서 만약 환자가 부교감신경이 항진되어 있다면 이미 경보, 저항단계가 지나서 병원에 온 것입니다.

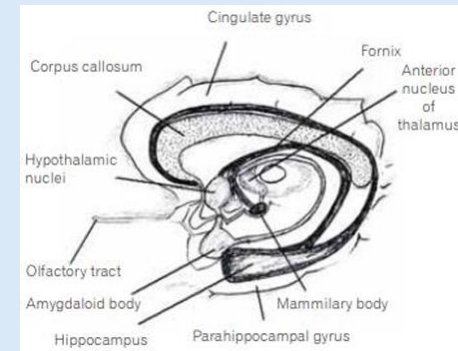
상호작용중심 관점

- '자극만' 혹은 '반응만' 중요한 것이 아닌 둘 다 봐야 한다는 관점
- 환경의 자극적 요인 + 개인의 인지, 지각, 인격 특성의 상호작용을 중시한다.
- 유기체의 특성을 강조한다.
- 개인적 자원(장점, 단점), 행동양상, 대응양식
- 평가방법: 대응방법척도

만성 스트레스

1. 스트레스 반응은 기본적으로 생존을 위한 반응으로 단기간의 조절 가능한 스트레스는 신체적, 정신적 건강에 큰 영향을 미치지 않는다.
2. **BUT** 조절 불가능하고 예측하지 못하는 불확실한 스트레스 → 생체 내 스트레스 반응 체계를 지나치게 장기간 활성화 → 정동장애, 불안장애 등의 정신질환 & 심혈관계, 대사계 질환 같은 스트레스 관련 질환에 대한 취약성을 증가
3. 일차 진료 현장에서 만나게 되는 환자들의 상당수는 스트레스와 연관되어 발병하거나, 기존의 신체적 질병이 악화되었다고 호소하는 수가 많다. **물론 신체적인 문제를 배제하는 것이 먼저다.**
 - 일반적으로 일차 진료의가 접하는 환자들은 급성의 심한 충격적 스트레스보다는 오히려 **만성적으로 일상적인 스트레스가 누적되어** 점차 기관의 조직 및 생리에 파괴적 변화가 초래된 경우가 많다.
 - 만성적인 스트레스로 인한 비정상적인 스트레스 반응에 있어 **전뇌의 부신피질자극호르몬 방출인자(corticotropin releasing factor, CRF)와 NE**가 핵심적인 역할을 한다.

※ 스트레스 반응의 신경해부학: LHPA축



- 편도의 축 및 기저축핵: 시상으로부터의 감각 정보와 피질과 해마로부터의 인지 정보를 통합
- 편도 중심핵: 스트레스 인자에 대한 내분비계, 자율신경계, 행동계 반응을 통합적으로 관장
- 해마는 스트레스에 대한 생리적, 심리적 반응을 종합하는 핵심적 부위의 하나
- CRF는 작은세포신경에서 생성되며 뇌하수체 전엽에서 ACTH 분비를 조절하는 역할
- CRF는 스트레스 반응을 매개하는 신경전달물질로서의 역할
- 동물실험에서 CRF를 중추신경계에 직접적으로 주입했을 때 스트레스, 우울, 불안증상을 유발, 말초 카테콜라민의 분비를 증가, 심박수, 혈압의 증가, 식욕감소, 불면 등의 증상 ← 만성 스트레스로 올 수 있는 증상들

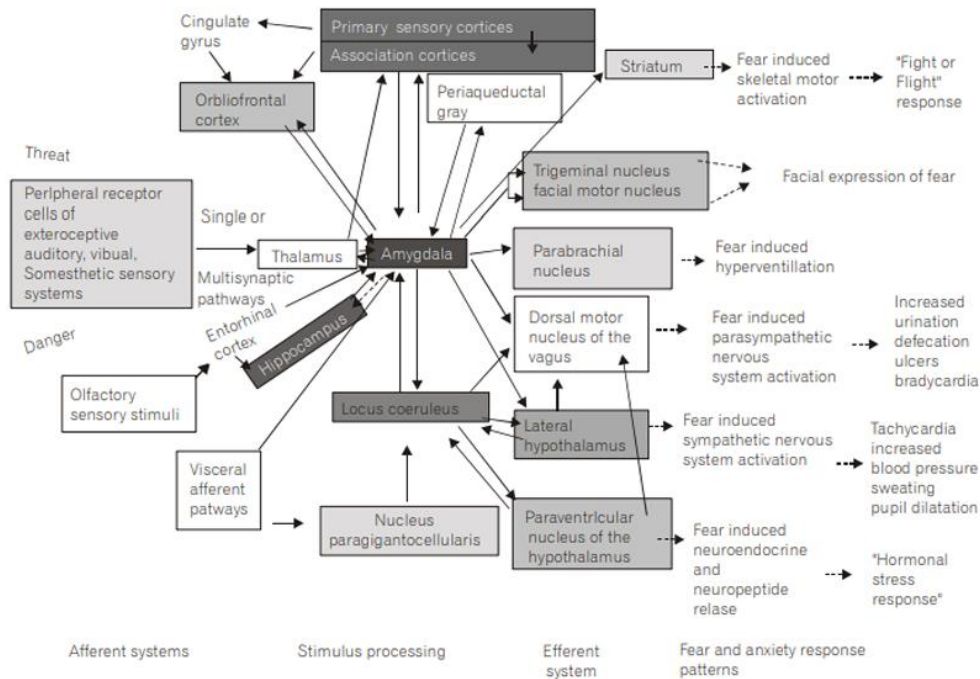
만성 스트레스와 건강

- LHPA 시스템과 LC/NE 시스템에 의해 매개되는 스트레스 반응 → 지질 분해, 글리코겐 분해, 단백질 대사 → 에너지 활용도 증가
- 당질코르티코이드, 카테콜아민의 분비 증가 → 심혈관계 기능 항진
- BUT 만성화된다면**
 - 지속적인 스트레스 호르몬 분비의 상승 → 동화작용의 억제, **근육 위축**, 인슐린 감수성의 감소와 당뇨 위험성 증가, 고혈압, 고지혈증, 무월경, 동맥질환
 - 인지와 정동 상태의 심각한 변화: 터널 시야, 기억력 저하 등
 - 스트레스 상황에서 CRF 시스템은 중추신경계의 세로토닌, NE 경로를 활성화시켜 과각성 상태를 유발 → 위협이 되는 상황에 대한 주의력을 높임
 - 당질코르티코이드와 카테콜아민 → 스트레스 인자와 관련된 정보의 학습을 증가, 스트레

스 인자와 관련이 없는 정보에 대한 주의력과 학습능력은 현저하게 떨어짐 (이런 반응은 적응을 위해 필수적이나 신경회로가 과잉활성화되어 신경 손상)

- 만성적으로 당질코르티코이드 농도가 높으면 해마에 직접적인 구조적 손상을 일으키며 특정 인지기능의 장애

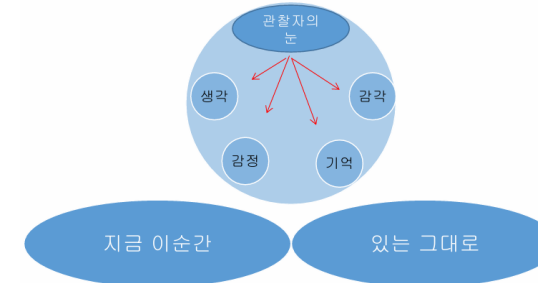
※ 참고: 스트레스 반응의 신경해부학



3절. 마음챙김(Mindfulness)

마음챙김이란?

- 지금 이 순간 있는 그대로 내 마음을 관찰자의 눈으로 직시하는 것
- 마음을 바라볼 때는 판단을 하지 않도록 한다.

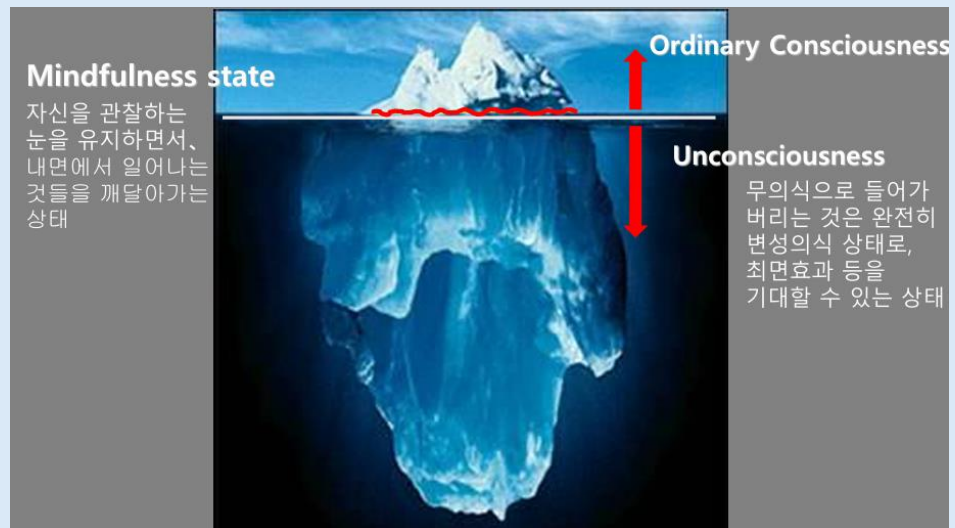


- 비판단적이고 의도적으로 주의를 현재에 기울이게 하는 자각훈련
- 한역: 念(지금 념) = 今(9이제 금) + 心(마음 심) → 지금에 마음을 둔다. / 守意, 觀
- 의의: 감정, 또는 감각을 있는 그대로 수용하여 온전히 경험하는 것을 촉진하고자 함

※ 기억(memory)와 마음챙김(mindfulness)

- 기억: 이미 경험한 사실에 대한 마음의 작용
- 마음챙김: 현재의 대상에 대한 마음의 작용
- 내용
 - 의식을 자기 내면으로 향하여 자기 안에서 일어나는 경험을 지켜보는 사람이 되는 상태
 - 지금 자신의 내면에서 일어나는 경험을 따라가되 한걸음 뒤에서 오로지 그것을 관찰하는 것
 - 일어나는 것에 대하여 비판도, 판단도, 평가도 걱정도 하지 않는 상태
 - 아무 것도 하지 않아도 되며, 자연스럽게 의식으로 올라오는 것을 그냥 받아들이며 알아차리면 되는 상태

※ 마인드풀니스 상태는 변성의식상태가 아니다.



- Ordinary: 일상생활할 때 우리의 상태. 눈에 보이는 것을 판단하면서 산다. Ex) 강의실이 덥네. 저번에도 더웠는데 오늘도 덥네. 내일 진료 때 힘들지 않을까?
- Mindfulness: 자신을 바라보는 것. Ex) 내가 지금 더워하고 있구나

Mindfulness를 이용한 심리치료

- Mindfulness 상태에서
 - 사람의 심층에 들어있던 **핵심신념(Core Belief)**이 의식의 수면 위로 떠오르게 됨. **있는 그대로 볼 수 있을 때 자신의 핵심신념을 볼 수 있다.**
 - 의식의 수면으로 떠오른 신념을 **바라보고 그게 무엇인가를 공부하고** 그것을 이해하게 됨. 만약 **인지행동치료**처럼 환자에게 뭐가 문제라고 직구로 콧으면 시비 유무 상관없이 환자가 거부를 보일 수 있다. 하지만 스스로 보도록하면 거부를 줄일 수 있다.
 - 이 과정에서 무의식의 협력을 얻는 게 매우 중요한데, 마인드풀니스 상태가 아니어서는 무의식의 협력을 얻을 수가 없다.

Mindfulness를 이용한 심리치료

MBSR	Mindfulness-Based Stress Reduction, 마음챙김에 기반한 스트레스 감소, 잔 카밧진(Kabat-Zinn), 1979년메사추세츠주립대학
MBCT	Mindfulness-Based Cognitive Therapy, 알아차림인지치료
ACT	Acceptance & Commitment Therapy, 수용전념치료)
DBT	Dialectical Behavior Therapy, 변증법적행동치료
MB-EAT	Mindfulness-Based Eating Awareness Training, 마음챙김 기반 식이자각 훈련
MBPM	Mindfulness-Based Pain Management, 마음챙김에 기반을 둔 통증관리

한의학에서 Mindfulness

1. 수행: 虛心合道

- 천지가 비록 크나 **형태가 있는 것은 조종할 수 있어도** 형태가 없는 것은 조종하지 못한다. 음양의 이치가 비록 묘하지만 **기운이 있는데만 작용하고** 기운이 없는 데는 작용하지 못한다. 그리고 온갖 생각이 어지럽게 떠올라도 **의식이 있는데만 작용하고** 의식이 없는 데는 작용하지 못한다.
- 대표적인 예가 **마음의 방 그리기**. 이는 **마음 속에 있는 것을 형태를 띠는 형태로 만드는 작업이다.** 표현할 수 있는 것이 없는 것보다 효과적으로 치료할 수 있다.

2. Mindfulness에서 의식상태: 神明之心, 靈明

- 心者 君主之官, 神明出焉.
- 대개 마음은 물이 흔들리지 않고 오래있으면 맑아져서 그 밑바닥을 들여다 볼 수 있는 것과 같다. 이것을 **영명(靈明)**이라고 한다.¹⁰

¹⁰ 蓋心은 如水之不撓에 久而澄清이면 洞見其底하야 是謂靈明이니라

4절. 血證

혈이란?

- 氣의 작용에 의하여 生體를 循行하는 赤色の 液體
- 陰血은 음식물에서 생긴다.¹¹.
- 中焦가 음식물의 氣를 받아서 붉게 변화시킨 것이 血이다.¹²
- 血은 氣와 짝이 된다.¹³

血證이란?

- 정의: 모든 혈액이 일반적인 경로를 순행하지 않거나 혹은 口鼻諸竅로上 溢(鼻衄, 咳血, 吐血)하거나 혹은 前後二陰으로 下泄(尿血, 便血)하거나 혹은肌膚로滲出(肌衄)하여 형성 되는 질환을 총칭 → 비생리적 출혈성 질환을 血病이라 칭한다.
- 주요병리: 熱能傷血, 七情動血, 內傷失血
- 분류: 血虛證, 血脫證, 血瘀證, 血熱證, 血燥證, 血寒證

※ 혈증의 예후: 참고로 보세요~

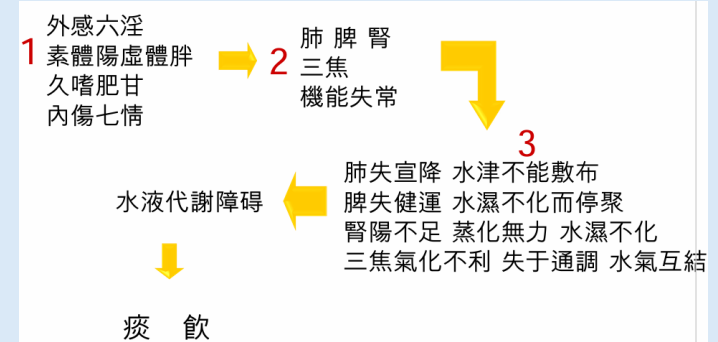
출처	혈증의 예후
의학입문	①血逆行 難治 順行 易治 ②無潮熱者輕 有潮熱者重 潮盛脉大者死 ③九竅出血身熱不得臥者即死 ④凡血證 陽盛則 身熱多渴 陰盛則 身涼不渴然血陰也 身涼者 易愈 ⑤如心肺脉 破血若湧泉口鼻俱出者 不治
영추	①淫而脫形 身熱色天然白及 後下血 衄血衄篤重是 爲逆 ②衄而不止 脉大是 爲逆 ③咳且澀血脫肉其 脉小動是爲逆 ④嘔血胸滿引背 脉小而疾是爲逆 ⑤腹脹便血其 脉大時絶是爲逆 ⑥咳澀血形肉脫 脉搏是爲逆
동원	①身熱脉大者 難治 難治者邪勝也 身涼脉靜者易治 易治者 正氣復也 ②血溢上行 或唾 或嘔 或吐 皆凶也 若變而下行爲 惡病者 順也 ③上行爲逆 其治難 下行爲順其治易

5절. 痰飲證

痰이란?

- "十病九痰", "百病多由痰作祟" → 痰으로 인한 병이 매우 많다.
- 濕이 모이면 水가 되고 水가 쌓이면 飮이 되고 飮이 응체되어 痰이 생긴다.¹⁴
- 痰은 수액대사로 형성된 병리적 산물
- 有形之痰: 痰濁, 飮液, 가래, 喀痰, 喘息, 腸鳴, 呼吸分泌物, 痰液
- 無形之痰: 痰飮으로 일어나는 특수한 질병, 怔忡, 頭暈目眩, 惡心嘔吐, 心悸氣短, 神昏.

※ 痰飮의 생성기전



- ①로 인해 ②와 같이 폐비신, 삼초에 기능실조가 발생하면 ③과 같은 문제가 발생해서 수액대사장애가 생기고 痰飮이 생성된다.
- 痰飮은 신경정신과 질환에서도 중요한 병리산물이자 발병인자이다.
- 痰飮이 질병으로 인해 발생하면 그 痰飮이 다시 질병을 악화시키는 악순환이 생길 수 있다.
- 대체로 氣機의 升降出入 不利로 痰飮이 발생하여 腦에 정체하면 腦神이 失用하여 정신 과적 질환이 발생할 수 있다.
- 수액이 운행하다 痰飮이 발생되어 腦竅에 정체되면 神昏, 眩暈, 癲狂 등이 유발된다.
- 氣鬱痰結로 腦絡하여 조체하여 腦竅不利하면 전증(癲症), 치매, 울증(鬱蒸), 두통 및 정신 분열병, 공포증, 신경쇠약 등이 발생할 수 있다.
- 痰火가 神을 요란하게 하면 불면다몽이 되거나 심하면 곡소무상(哭笑無常), 광월망동(狂

¹¹ 陰血生於水穀

¹² 中焦受氣變化而赤是胃血又曰 榮出於中焦

¹³ 血爲氣配, 氣行卽血行 氣止卽血止

¹⁴ 濕聚爲水 積水成飮 飮凝成痰

越妄動)할 수 있다.

- 風動痰升하여 淸竅를 蒙蔽(蒙蔽)하면 뇌졸중, 간질발작 및 각종 계종(癭癭), 경련, 추축(抽搐) 등이 발생되고 기체담응(氣滯痰凝)하면 매핵기가 발생한다.

※ 痰證과 飲證의 분류: 참고만 하세요~

痰 證	飲 證
肺	咳嗽, 痰多
心	心悸, 神昏, 或失眠, 癲狂
肝	面青, 眩暈, 動風
脾	腹脹, 身重, 肢倦
腎	腰膝酸痛, 足冷
胃	脘痞, 嘔惡
頭	眩暈
咽喉	喉中梗阻(梅核氣)
胸脇	胸脇脹滿疼痛
四肢	麻木, 疼痛
皮下	癰癰, 痰核, 陰疽, 流注
經脈	肢麻, 半身不遂

痰飲의 병리적 특성

1. 經脈氣血의 運行을 阻滯한다.

- 痰飲은 氣를 쫓아 인체내외를 流行, 經脈을 阻滯不暢시켜 氣血運行을 不利시킨다.
- 증상: 肢體麻木, 屈伸不利, 半身不遂, 國部 담핵나력(痰核癰癰), 음저류주(陰疽流注)

2. 氣機의 升降出入을 막는다.

- 기기(氣機)의 升降과 臟腑氣機의 升降失常을 유발
- 痰飲이 肺에 정체하면 宣發肅降 기능이 실조되어 胸悶, 咳嗽, 氣喘, 甚則不能 平臥
- 痰飲이 胃에 정체하면 和降기능이 실조되어 嘔吐, 腹脹腸鳴, 飲食減少

3. 수액대사를 저해한다.

- 肺脾腎의 氣化기능에 영향을 준다.
- 寒飲이 肺에 저류하면 宣發肅降, 通調水道機能이 失常된다.
- 痰飲이 腎陽에 영향을 미치면 蒸化無力, 水液의 輸布와 排泄에 영향을 준다.

4. 神明을 蒙蔽(蒙蔽)시킨다.

- 痰濁이 상요(上擾)하면 淸竅를 蒙蔽하면 頭昏目眩, 精神不振
- 痰迷心竅 혹은 痰濁擾心하여 心神을 被蒙시키면 神昏譫妄, 癲狂癇 등의 증상

담음(痰飲)의 진단

1. 과거에 肥滿했다가 현재는 瘦瘠해지고, 腸間의 漉漉有聲이 있다.
2. 맑은 물을 토하면서 痰涎이 있으며, 口渴이 있으나 물을 마시지 못하고 물을 먹으면 바로 토한다.
- 3.背部에 넓게 寒冷感이 있고 頭暈目眩, 心悸短氣가 있다.
4. 咳逆, 倚息不得臥하면서 胸脇脹滿, 咳唾引痛이 있다.
5. 飲水가 四肢에 분포하여 汗出이 있어야하는데 不出하고 身體疼痛하다.
6. 膈滿, 喘咳, 嘔吐, 腰背痛, 目淚出, 振振身瞤이 있다.
7. 舌苔白, 脈弦하다.

[2] 신체형 장애

0절. 개요

신체형 장애란?

- 원인이 불분명한(주로 심리적 요인) 신체증상을 호소하거나 그에 대한 과도한 집착과 걱정을 나타내어 부적응적 문제들이 초래되는 장애(DSM-5)
- 일반적인 의학적 질병이나 직접적인 물질의 영향에 의해 **충분히 설명되지 않는** 신체증상이 특징 ← 타질환과 감별진단하는 조건 중 가장 중요한 개념
- 이러한 특징 때문에 **신체형 장애로 진단받기까지는 오랜 시간이 걸린다**. 원인을 못 찾으니까 **각종 검사를 받은 후에서야 진단받음**
- 심리적 원인에 의한 다양한 신체적 증상과 건강염려를 나타내는 경우에 해당된다.
- 일상적인 기능 수행에 심각한 고통 또는 지장을 초래하는 신체 증상에 강하게 집중하는 특성이 있는 정신건강장애

신체형 장애의 DSM 분류 범주 변화

- 이름이 많이 바뀌었다.

DSM-4	DSM-5
신체형 장애	신체증상 및 관련장애(Somatic Symptoms Related Disorders)
신체화 장애	신체 증상 장애
통증 장애	삭제되고 신체 증상 장애의 특정형 하위로 포함 주된 통증 동반형(with predominant pain) 신체 증상 장애인데 주증상이 통증인 것
건강 염려증	질병 불안 장애
신체추형 장애	신체변형 장애 강박 및 관련 장애 영역으로 이사감
	허위성(인위성)장애 추가 됨

신체증상 및 관련 장애(DSM-5)

1. 신체증상장애
2. 질병불안장애
3. 전환장애
4. 허위성 장애

허위유형	증상의 자발적 통제가 가능한가?	증상이 심리사회적 요인과 연관되어 있는가?	뚜렷한 목표가 있는가? (예: 외적 보상의 취득)
신체증상장애	아니요	예	아마도
질병불안장애	아니요	예	아니요
전환장애	아니요	예	아마도
허위성장애	예	예	의학적 관심을 제외하고는 없음
폐병	예	아마도	예

신체증상장애	전환 장애	질병 불안 장애	인위성 장애
신체적 증상에 대한 과도한 생각, 감정, 행동	갑작스런 운동/감각기관 기능 변화	신체적 증상 없이 염려 또는 증상에 비해 심한 걱정으로 인한 공포	질병에 걸렸다는 믿음과 신념으로 신체적 증상을 만들어냄
2차 이득과 증세를 인정받으려는 경향이 강함 의도적 X 폐병 X	1차이득, 2차이득 얻을 수 있으나, 의도적 X, 폐병 X	병이 없다는 재확인에도 지속됨	동정, 관심을 위해 의도적으로 만들어 내나, 외적이득 없음 (폐병 X) 스스로 인지하지 못함
억압된 본능적 충동의 대치물이 증상으로 발현	억압된 불안, 갈등이 전환되어 증상으로 발현	공격성, 증오가 신체 호소로 발현	동정, 관심을 위해 환자의 역할을 모방

신체형 장애의 원인

- 원인은 불분명하나, 아래 요인들로 인해 유발될 수 있다.

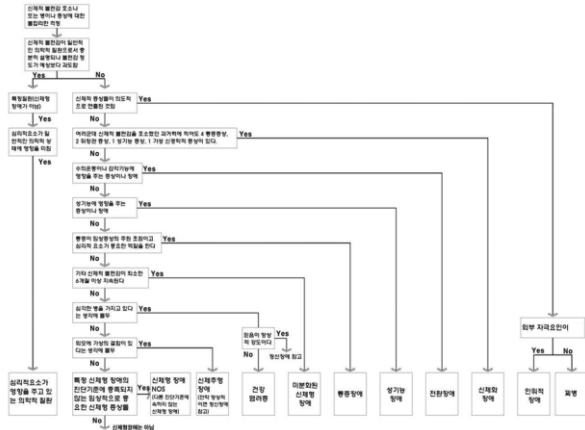
1. 신체 상황에 대해 과도하게 높은 주의를 기울임
2. 유전적, 생물학적 요인: 통증에 대한 높은 민감도
3. 가족의 영향: 유전적 영향 또는 환경적 영향
4. 부정적인 개인 성향: 질병과 신체 증상을 인지하는 방식. 좀 아파도 누구는 "이러다 말겠지"하지만 누군가는 "이렇다 죽는 것 아니야?"고 걱정한다.
5. 감정에 대한 주의 감소 및 감정 처리 문제: 감정적인 문제보다 신체 증상에 집중. 우울, 불안 등을 회피하려고 다른 곳에 집중하는 것
6. 학습된 행동: 질병 또는 고통을 겪은 경험으로부터 얻어진 요소 (특정활동에 대한 과도한 회피 등)

신체형 장애의 임상 특징

- 극심하거나 만성적인 고통
- 전환증상: 스트레스를 받았을 때 갑자기 증상을 호소
- 설명하기 어려운 복합적인 증상
- 잠재적 질병에 대한 지속적인 걱정
- 일반적인 상황에 대해 심각한 질병으로 인식
- 물리적 감각에 대해 두려움을 느낌

- 의학적 치료가 불충분하다고 느낌
- 신체를 손상시킬까 두려워 육체적 활동을 꺼림

※ 신체형 장애의 진단분류표: 참고만 하세요~



타질환과의 감별진단

1. 우울장애 및 공황장애

- 상당수의 신체관련장애 환자들이 우울장애, 불안장애, 공황장애 등의 정신장애를 겪는다.
- 이는 제대로 치료되지 않은 신체증상장애가 공황장애 및 우울장애로 진행할 수 있는 스펙트럼 상에 있거나 병존하는 것으로 본다.
- 신체화가 만성화되면 우울장애를, 증상이 심하고 예기불안이 동반되는 경우 공황장애를 의심한다

2. 화병

- 화병은 속상함, 분노, 증오, 우울감 등 정서적 증상과 함께 가슴통증, 답답함 등의 미분화된 신체화 증상이 동반된 증상으로, 환자들 대부분이 심인성임을 인식한다.
- 신체증상장애에 포함되는 것으로 볼 수 있다.

3. 신체질환

- 신체질환이 발견되었다 하더라도 신체증상관련장해를 배제하지 말아야하며, 역으로 신체질환이 발견되지 않았다고 해서 반드시 신체증상관련장애인 것은 아니다!
- 신체질환이 있더라도 상태에 비해 너무 과도한 증상을 호소한다면 신체증상관련장해를 끼고 있을 수 있다.

- 반대로 신체질환이 발견되지 않아도 꼭 신체증상관련장애인 것이 아니다. 기술의 한계로 발견을 못한 것일 수 있으니까.

1절. 신체증상장애(Somatic symptom disorder)

- 의학적으로는 신체적 질병이 없는데도 1개 이상의 신체적 증상에 대한 과도한 집착과 걱정을 6개월 이상 나타내는 경우
- 특징: **“뚜렷한 통증(통증장애)”**와 **“지속적인 상태”**

신체증상장애 진단기준

A. 현저하게 고통스러우며 일상생활에 심각한 혼란을 초래하는 하나 이상의 신체증상을 호소

B. 신체적 증상 또는 건강문제와 관련된 과도한 생각, 감정 또는 행동은 다음 중 적어도 하나에 의해 나타남

1. 증상의 심각성에 대한 불균형하고 지속적인 생각
2. 건강이나 증상에 대한 지속적으로 높은 수준의 불안
3. 이러한 증상이나 건강문제에 투입되는 과도한 시간과 에너지

C. 어떤 신체 증상이 끊임없이 존재하지는 않지만 증상을 보이는 상태는 지속됨.(일반적으로 6개월 이상)

예를 들어 보통으로 신체증상장애가 있다면 6개월 내내 1시간도 쉬지 않고 배가 아픈 것이 아닌 아팠다 나아졌다하는 상황이 6개월 이상 지속되면 C조건을 만족한다.

- 정도

- 경증: 기준 B의 증상 중 하나만 충족
- 중등도: 기준 B의 증상 중 둘 이상 충족
- 중증: 기준 B의 증상 중 둘 이상 충족하며, 여러가지 신체증상이 있거나, 하나 이상의 극심한 통증이 있는 경우

신체증상장애의 임상양상

- 30세 이전
- 4 통증 / 2 위장관계 증상 / 1 성적 증상 / 1 가성신경 증상
- 상호관련 모호
- 일관성 없음
- 극적으로 요란하고 다양하게 표현, 과장
- 의존적, 이기적, 상대방을 조작하려는 경향

경과 및 예후

- 만성적이며 호전과 악화를 반복.
- 대부분의 환자가 지속적으로 이러한 상태를 유지하며, 6-8년 후에도 신체증상장애로 진단
- 자살시도: 죽고자 하는 의도보다는 이차적 이득 및 타인에게 인정받으려는 경향이 강함

신체증상장애의 원인

1. 생물학적 원인

- 신체감각에 대한 주의력과 인지에 장애
- 기타 유전, 가족적 요인, 환경적 요인
- 최근 cytokine 연관설
- 우측반구의 지배를 받는 신체의 좌측에 다발

2. 기타 원인

- 행동이론: 부모의 영향 중시(부모의 가르침, 닮기, 인종적 관습)
- PD(성격장애): AVD(회피성), PAR(편집성), CPS(강박성), HST(히스테리성), ANT(반사회성)

2절. 전환장애(Conversion disorder)

- **신경학적 손상을 암시**하는 운동 기능과 감각 기능의 이상을 호소하지만 의학적으로 증상의 원인을 찾을 수 없는 경우
- 과거에는 히스테리 또는 히스테리 신경증이라고도 했다.(프로이트)

전환 장애의 진단 기준

- | |
|--|
| A. 하나 이상의 운동 또는 감각기능의 변화된 증상 |
| B. 증상과 신경학적 또는 의학적 질환으로 양립할 수 없음 |
| C. 다른 의학적 또는 정신질환으로 더 나은 설명을 할 수 없음 |
| D. 증상이나 고통이 현저한 고통 또는 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 기능 면에서의 장애를 야기하거나 의학적 검토를 타당하게 함. |

- 증상: 약화 또는 마비, 비정상적 운동(진전, 긴장 이상, 간대성 근경련, 보행장애), 연하 관련 증상, 언어 증상, 공격 또는 발작, 운동 또는 감각 실조, 특이적 감각 증상, 혼합 증상 → **주로 운동기능의 이상 또는 감각기능의 이상**
- 운동기능 이상: 신체적 균형이나 협응 운동의 균형상실, 신체 일부의 마비나 무감각 또는 기능저하나 국소적 쇠약, 발성불능, 연하곤란, 소변을 보지 못함
- 감각기능의 이상: 촉각, 통각상실과 같은 접촉 이상, 하부감각의 이상, 복시, 시력장애, 난청, 가성환각 등.
- 지속기간
 - 6개월 미만 → 급성 삽화
 - 6개월 이상 → 지속성
- 스트레스 인자: 심리적인 스트레스 인자가 있는 경우도, 없는 경우도 있음
- 전환장애 환자는 자신이 지닌 증상의 심각성에 비해 그다지 걱정하지 않는 무관심한 태도를 특징적으로 나타내기도 한다. **학생들이 이런 경우가 가끔 있음. 성인은 그닥.**

전환(conversion)이란?

- 프로이트로부터 유래.
- 불안과 심리적 갈등이 신체적 증상으로 전환된다(converted)라고 생각했다.
- 개인의 신체적 증상이 무의식적인 심리적 갈등을 상징적으로 해결하고 불안을 줄이고 갈등을 알아차리지 못하게 하는데 기인하고 있다(**1차이득**)는 가설에서 유래된 것
- 개인은 전환증상으로 인해 외부로부터 이익을 얻거나 힘든 의무나 책임을 벗어나는 **2차**

이득을 얻을 수도 있다.

전환장애의 임상양상

- 수의적 근육운동 및 감각기관의 갑작스런 기능 변화로 인한 장애. 마비, 시력상실, 함구증, 감각상실, 이상감각, 진전, 후궁반장, 가성의식상실, 히스테리성 졸도, 히스테리성 보행, 목식도 이물감, 장갑형 및 양말형 감각마비, 실명, 귀머거리. 시야위축, 경련. 간질양 발작

경과 및 예후

- 일반적으로 급성(서서히 심해지는 경우도 있음)
- 짧은 기간동안 지속되는 경우가 많음
- 입원환자들은 대개 2주 내에 증상이 완화되나 재발이 흔함
- 발병 당시 뚜렷한 스트레스 요인이 있고, 급격하게 발생되며 보통 이상의 지능을 가질수록 예후가 좋음

전환장애의 원인

1. 생물학적 원인

- 중추신경계의 어떤 장애: 대뇌피질과 망상체 사이에 정보교류의 feedback에 이상
- 뇌영상화연구(우세반구에 대사 저하와 비우세반구의 대사 증가 및 양반구간 정보소통의 장애)

2. 기타 원인

- 인격적으로 환자는 성적 미숙, 피암시성, 이기주의 등이 특징이다.
- 병전성격으로는 히스테리성 인격, 수동공격성 인격, 미숙한 인격, 분열성 내지 편집성 인격이 많다.

3절. 질병불안장애(illness anxiety disorder)

- 실제로 건강상에 문제가 없는데도 자신의 몸에 심각한 질병이 있다는 생각에 집착하며 과도한 공포와 불안을 **6개월 이상** 지속적으로 나타내는 경우(구. 건강염려증)

질병불안장애의 임상양상

- 특정 신체기관에 심각한 병에 걸렸다는 집착과 공포.
- 자기나름대로 의학적 용어사용, 타당성설명. 병든 장기중심으로 상상되는 한 많은 증상 호소.
- 불안, 우울 합병

질병불안장애의 원인

1. 신체적 원인

- 감각을 고통으로 감지하는 역치나 참을성이 낮다.

2. 기타 원인

- 사회적 학습모델: 환자는 sick role을함으로서 곤란한 상황에서 벗어나려는 경향을 보임.
- 사회적으로도 sick role은 책임과 의무로부터 도피. 우울증, 불안의 한 변형된 표현.

4절. 허위성(인위성) 장애(Factitious disorder)

- **단지 환자의 역할**을 하기 위해서 신체적·심리적 증상을 의도적으로 만들어 내거나 위장하는 경우. **동정과 관심을 유발하려는 목적만 있을 뿐**, 다른 어떤 외적인 이득(경제적 보상, 법적 책임을 회피)을 취하려는 의도가 없다는 점에서 **괴병과 다름**

특징

- 증상을 극적으로 호소하나 그 내용이 모호하고 주관적이며 일관성이 없다.
- 과거력에 대한 언급을 회피하고, 잦은 입원의 증거가 발견된다.
- 병원과 의학에 관련된 지식이 풍부하다.
- 입원 기간동안 환자를 찾는 방문객이 거의 없다.
- 검사 결과에서 문제가 발견되지 않으면 다른 증상을 만들어낸다.

- 의사가 정신과적 관점으로 접근하거나 인위성 장애로 파악하는 것을 눈치채면, 즉시 퇴원하여 다른 병원을 찾는다.

허위성 장애를 의심해야하는 상황

- 독특하고 극적으로 증상을 표현하는데 통상적인 의학·정신의학·정신의학 이해를 무시한다.
- 증상이 통상적인 치료나 약물로 적절하게 반응하지 않는다.
- 한 증상이 나오면 다른 증상이 갑자기 새로 엉뚱하게 나타난다.
- 검사를 받으려 하거나 증상 진술을 다시 하려는 욕구가 있다.
- 2차적 정보(가족이나 친구들로부터)를 주기 꺼려한다.
- 방대한 병력이나 여러 수술의 증거가 있다.
- 다수의 약 알레르기가 있다.
- 의료계 종사
- 방문객이 적다.
- 비정상적인 증상의 진행이나 치료에 대한 비정상적인 반응을 예상할 수 있다.

감별진단

- 진단에 있어 과거력의 정확한 조사가 필요하고, 환자의 진술 외에 보호자로부터 얻어지는 정보가 중요하다.
- 궤병: 궤병은 명백한 이차적 이득을 얻어내면 증상이 소실된다는 점에서 인위성 장애와 다르다. 또 궤병은 고통이 따르는 검사나 치료를 거부하지만, 인위성 장애는 환자로 인정받기 위해서라면 자해나 수술도 불사한다.
- 신체형 장애: 신체형 장애는 인위성 장애와 다르기 증상을 의도적으로 만들지 않는다.

5절. 신체형 장애의 치료

- 우선 철저한 신체검사 후 재검사 허용해주지 말 것. 불필요한 투약제한.
- 정신치료는 돌보는 태도로서 권위를 가지고 시행하는 감정이입적, 지지적 정신치료 효과적.(분석적인 치료는 별로) ← 환자에게 매섭게 뭐라하는 것보다 동가동가 해주는 것이 더 효과적이다.
- 의사-환자관계 중요. 견고한 신뢰관계 형성. 의사 한 사람이 주로 책임지고 정기적으로

일관성 있게 치료.

- 가족치료 중요. ← 환자 가족들의 고충도 중요하다. 가족도 잘 케어하고 환자의 상태를 잘 설명해서 환자와 가족과의 사이가 나빠지지 않도록 해줘야 한다.
- 이해, 관리, 수용적 자세 중요
- 한의학 신체증상적 접근이 효과적. 몸이 아프니 맘도 아프다.(氣의 활동성)
- 자율훈련법, 바이오피드백치료.

치료시 주의사항:

- 상상에 의한 병, 궤병이라든가, 정신병자 취급에 민감.
- 불명확한 진단명 남발주의. 간이안좋다? 심장이안좋다? ← 건강문제에 민감하기 때문에 이런 말 들으면 민감하게 반응한다.
- 신체증상은 감정의 표현이라는 것을 이해. 시인도 무시도 해서는 안됨.

⇒신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색** 밑줄
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색
- 이번주차는 품행장애까지 강조하였고, 방화광부터는 가볍게 보시면 됩니다.

[1] 해리장애

[DSM-5 범주]

해리장애(Dissociative Disorders)

- 해리성 정체성장애
- 해리성 기억상실
- 이인성/비현실감장애
- 달리 명시된 해리장애

해리성 둔주는 DSM-5에서 삭제되었으나 교과서에 있으니 같이 알아두자.

0절. 개요

해리장애 Dissociative Disorders

해리 (dissociation) 란 ?

- 解離 '풀어져서 분리되어 떨어져 나옴'
- **의식의 통합적 기능이 통일성을 상실**, 경험 중 일부가 의식을 통해서 접근 할 수 없게 됨.

기억, 정체성, 의식, 지각 등 나를 이루는 조각들이 떨어져 나가는 듯 함.

- 뇌손상이나 신체적 질병과 관련이 없다.
- **심리적 기능손상에서 옴.**
- 견디기 힘든 외상적 경험이나 심리적 쇼크가 너무 충격적이고 혐오스럽기 때문에 의식의 단절을 통해 어려운 상황을 회피하고 자신을 보호하기 위한 긴급 수단.
- 외부에서 작용하는 정신적 충격을 의식에서 경험하는 것을 방어하기 위한 수단, 내적 갈등에서 해방되는 수단.

해리장애의 핵심양상

- **의식, 기억, 주체성, 환경에 대한 지각의 상실**
 - 개인의 통합적 기능이 작용하지 못함
- 내가 무엇을 잃어버렸는지 알아차리지 못함

해리현상

: 기본적으로 외상경험에 대한 자기방어기전

- **뇌손상이나 질병과는 무관**

#해리장애의 종류

[DSM-4]

- 해리성 기억상실증 dissociative amnesia
- 해리성 둔주 dissociative fugue
- 해리성 정체성장애 dissociative identity disorder
- 이인성 장애 depersonalization disorder
- 기타 분류되지 않는 해리장애

[DSM-5]

- 해리성 둔주 범주 삭제.

- ① 해리성 정체감장애
- ② 해리성 기억상실증
- ③ 이인성/비현실감장애

- 의식, 기억, 행동 및 자기정체감, 환경지각의 통합적 기능에 붕괴가 일어나는 장애

(1) 해리성 기억상실증 (구. 심인성 기억상실증)

: 자신의 중요한 개인적인 과거경험을 기억하지 못하는 경우

영화에 많이 활용됨. 단순한 건망증이 아니라 특정한 트라우마 사건과 관련. 새로운 기억을 학습하는 능력은 남아있다.

cf) 해리성 둔주: 본래 해리성 기억상실증의 하위 요소였음. 기억을 잃어버린 채로 여행을 하는 듯 함. 기억 상실이 있을 후 한참동안 돌아오지 않음. 오랫동안 새로운 신분으로 지내게 되기도 함.

(2) 해리성 정체성 장애 (구. 다중인격장애)

: 한 사람 내면에 두 개 이상의 각기 다른 정체감을 가진 성격이 존재하는 경우
 지킬 앤 하이드, 킬미힐미, 아이덴티티 등. 나이, 성별 등이 다양한 인격 존재. 미국에서 사례보고가 증가 중. 첫 증상발현부터 진단까지 6-7년정도 오랜 기간이 걸림. 40대 후반에 잘 나타남.

(3) 이인증/비현실감 장애

: 자아 감각에 어떤 변화가 초래되어 평소와는 달리 자신의 경험이 매우 낯설게 느껴지거나 주변 환경이 예전과 달라졌다고 느껴지는 비현실감을 지속적으로 또는 반복적으로 경험하는 경우
 유체이탈해서 나를 관찰하는 듯한 느낌 등.

해리장애의 원인

Dissociative amnesia 해리성 기억상실증	상태 - 의존적 학습이론 (고통스럽고 마음에 큰 상처를 받았던 사건 당시의 감정상태가 너무 일상을 벗어난 것이어서 그 상태에서 학습된 정보는 기억하기 어려울 것) 기억상실은 1차적 방어기제 (정서적 갈등과 외적 스트레스를 다루는 방법으로서 해리현상, 의식을 변경), 2차적 방어 (억압, 부정)
Dissociative Fugue 해리성 둔주	고통스러운 감정적 경험 (결혼문제, 재정문제, 직업문제 등)으로 떠나고 싶은 강력한 심리적 동기가 있을 때 나타남. 경계형 인격장애, 히스테리형 인격장애, 분열형 인격장애때 잘 나타남
Dissociative identity disorder 해리성 정체성장애	원인은 미상. But 어린 시절에 성적 남용, 정신적 외상이나 신체적 폭행을 당했을 때 흔히 나타남. 간질과 관련이 있을 수 있다는 보고도 있으며, 뇌파 이상을 보이는 비율이 높음.

Depersonalization disorder 이인증장애	심리적, 신경학적, 전신질환 (예: 갑상선이나 췌장 등의 내분비장애) 등이 원인적 요인들임. 즉, 간질, 뇌종양, 감각박탈, 감정적 외상, 우울과 불안 등이 장애를 유발시키며, 흔히 심한 스트레스 (예: 교통사고) 후 설 때 잘 나타남
-------------------------------------	--

1절. 해리성 정체성 장애 (DID)

- 한사람에서 두가지 이상의 서로 다른 성격 특성이 나타나는 것. 하나의 인격이 태도, 행동, 자기상을 지배하며 마치 그때 다른 인격은 존재하지 않는 것 같다.
- 어린 시기의 심각한 성적, 정신적 외상이 관련이 높다고 보고.
- 한 인격으로부터 다른 인격으로 갑작스럽게 교대, 대개는 다른 인격에 대해 알지 못하며 다른 인격이 했던 일을 기억하지 못한다.
- 해리장애 중 예후가 가장 심각하고 대부분 만성적인 경과

ex) 빌리 밀리건

: 24개 인격을 가진 범죄자.

2절. 이인증

이인증 예시

- 며칠 전부터 몸이 이상해요. 오래 잤음에도 불구하고 눈을 감았다 뜬 기분만 들고, 피곤하고, 머리가 너무 지끈해요. 꿈도 항상 꾸는데 너무 생생해서 현실이랑 헛갈릴 정도예요. 꿈에서 자꾸 제가 아파요. 어느 날은 고열이 나고 정신과에서 공황장애 진단을 받기도 하고 가위도 심하게 눌리고 그랬어요.
- 걸어다니는 것도 어색하고 다른 차원에 있는 기분이 들어요. 다른 사람한테 조종당하는 기분? 모든게 낯설고 갑자기 불안해서 눈물도 나고, 뭔가 이상해요...
- 제가 열심히 찾아봤는데 이게 이인증? 비현실감? 이런거라는데 제가 이런건가요? 어떻게 해야 하나요?

이인증 증상의 4가지 영역 (현실검증력은 유지)

① 이인증 (De-personalisation)

자신이 자신으로부터 분리된 느낌

외부에서 관찰하거나, 로봇같이 자동으로 움직이는 느낌

② 비현실증 (De-realisation)

주변환경이 낯선 느낌이나, 비현실적으로 느껴지거나, 감각이 이상해진 느낌.

연극을 하는 것 같은 어색함

③ 무감각증 (De-somatisation)

감각이 덜 느껴지거나, 없어지거나, 변한 느낌, 육체이탈 같은 느낌

때로는 통증이 더 심하게 느껴짐

④ 무감정증 (De-affectualisation)

정서만증의 축소나 소실, 감정이 마른 느낌, 친근한 관계가 이상하고 서먹하게 느껴짐

정신분석적 입장에서 본 이인증/비현실감 장애

- MICHAL 등(2006), 자존감을 유지하려는 자기애적 조절의 실패에 의한 것이라고 설명
- 자신을 특별한 존재로 여기는 동시에 **타인의 인정을 중시하는 자기애적 성향**을 지닌 사람에게는 자신을 통제할 수 없다는 통제상실감이 자존감의 심각한 위협으로 작용, 즉 통제상실의 위협에 대한 자기애적 민감성은 이인증을 유발하는 취약성으로 작용
- 정서적 학대 경험한 경우, 타인과의 신뢰로운 관계를 경험하지 못하면 건강한 자기애를 형성하지 못한 채 통제상실에 대한 과도한 민감성을 가지게 된다.
- **성취가 과도하게 강조되는 양육 환경**, 자기애적 만족감을 제공하는 가족분위기에 서 독자나 재능 있는 아동으로 자란 사람들의 경우가 많았다.
- 타인의 인정을 중시하게 되면, 자신을 1인칭 관점에서 인식하기 보다 3인칭(중요한 타인)의 관점에서 바라보는 평가의 대상으로 인식하게 된다. (타인에 의해 부여된 이상화된 자기의 기준을 충족시키려고 노력)

- 이러한 과정 속에서 자신을 1인칭에서 바라보는 주관적 경험을 지속적으로 부정하게 되면서 점진적으로 부적절감과 통제상실감을 경험하게 되고 이는 자신을 낯설게 느끼거나 마치 기계가 되어 행동하는 것 같이 느끼게 되는 이인증을 촉발.

DOING과 BEING

- 이인증은 지나치게 칭찬받기를 바라는 잘생기고 똑똑한 자의 신경증이다.
- 폴 실더 (PAUL SCHILDER, 1939) -

- 이인증 : 외부세계와 자신이 동떨어져 있는 듯 실감하지 못하고 자기 자신의 'BEING' 에 대한 인식을 서서히 잃는 증상 호소

- 치료적 접근 : DOING이 아닌 BEING으로 인정받는 경험

DOING	BEING
accomplishing 성취하는	self aware 스스로 인지하는
reacting 반응하는	insightful 통찰력 있는
behavior driven 행동에 의해 이끌어지는	values driven 가치에 의해 이끌어지는
consciousness 의식하는	unconscious 의식하지 않는
driven by success 성공으로 이끄는	not afraid to fail 실패를 두려워하지 않는
changing 바뀌는	transforming 바뀌는
answering 응답하는	questioning 질문하는
answer to How '어떻게'에 대해 대답하는	answer to Why '왜'에 대해 대답하는

DOING과 BEING의 공존

- 공부하는 척하는 'DOING' 이 부모(세상의 기준)를 가장 기쁘게 한다.
- 나의 'DOING' 이 내 존재(BEING)의 가치를 좌우한다.
- 'DOING' 이 잘 되어가도(성공에 가까워져도) 내 'BEING'은 불안하다.
- 끝없이 'DOING' 하도록 요구 받는 세상의 기준 앞에서 지쳐간다.
- TO DO LIST에 매달리는 이유는? DOING을 통해 BEING을 살려내기 위해서였는지도

치료적 접근 - 자존감 다루기

- 통제감과 통제능력이 향상되도록 어떤 무의식적인 갈등이 이인증을 일으키는지에 대한 이해의 증가를 돕는다.
- 낮은 **자존감**과 그에 대한 과잉 보상의 노력은 부모의 과도한 요구를 충족시키지 못한 것일 수 있으므로 자존감의 문제를 우선적으로 다룬다.
- 낮은 자존감과 무능감을 지니게 만든 부모와의 아픈 경험을 재경험 하는 동시에 관련된 자기의 감정을 표출하여 정화되도록 돕는다.
- 불안 공포와 관련된 과도한 주의 집중에 대한 인지를 교정한다.
- 급성 기분장애(우울, 불안)와 관련된 요인을 치료한다

[2] 인위성 장애

[DSM-5 범주]

신체증상 및 관련 장애 (Somatic Symptom and Related Disorder)

- 신체증상장애
- 질병불안장애
- 전환장애
- 기타 의학적 상태에 영향을 주는 심리적 요인
- 인위성장애(Factitious Disorder)
- 달리 명시된 신체증상 및 관련장애

인위성 장애는 '신체증상 관련 장애' 범주에 포함되어 있다.

인위성 장애 Factitious Disorder

: **환자 역할을 하기 위해** 고의적으로 신체적, 정신적 증상을 만들어냄. 보호받고자 하는 무의식적 욕구나 피학적 성격.

앓고 있는 병이 없는데도 아프다고 거짓말을 하거나, 자해를 하기도 함. 관심을 끌려고 함.

■ 특징

- 1) 증상을 극적으로 호소하나 그 내용이 모호하고 주관적이며 일관성 없음
- 2) 과거력에 대한 언급을 회피, 잦은 입원의 증거

3) 병원과 의학에 관련된 지식이 풍부

4) 검사결과에서 문제가 발견되지 않으면 다른 증상을 만들어냄

5) 의사가 정신과적 관점으로 접근하거나 인위성 장애로 파악하는 것을 눈치채면, 즉시 퇴원하여 다른 병원

■ **대리인위성 장애 (=뮈하우젠 증후군)**: 자기가 돌보는 이에게 인위성 장애를 만들어냄.

아이가 아프다고 하면서 소아과에 들락거리는 어머니. 애완동물이 아프다는 주인 등. 간호하는 자신의 모습을 연출하기 위한 경우가 있음.

스티븐호킹의 와이프 일레인. 의도적으로 휠체어를 밀어 호킹의 손목을 부러뜨림.

■ 감별진단

- 1) **픽병** : 명백한 이차적 이득이 존재. 이득을 얻은 후에 증상이 소실됨. 고통이 따르는 검사나 치료는 거부
- 2) 인위성 장애는 환자로 인정받기 위해서라면 자해나 수술도 불사함
- 3) 신체형 장애 : 증상자체가 의도적으로 만들어지지 않는다.

#기타 정신과 장애

■ 신경쇠약

DSM-V-TR에는 없는 개념(감별되지않는 신체형장애)

불안장애, 우울장애와 중복> DSM-5에서는 병명이 없어짐.

ICD-10, Other neurotic disorders

■ 만성피로증후군

신경쇠약증에 포함되는 개념. 심한 피로감이 주증상
주요우울장애 범주. 무위,죄책감,자살시도 거의 없다

[3] 혼궤 昏厥

궤증의 정의

厥證은 鬱證의 대한 상대적인 개념

“厥證 氣上逆而陰陽失調 輕即四肢寒冷 重即人事不省” [東.辭]

궤증은 기가 상역해서 음양이 실조되는 것

“厥者逆也 氣逆即亂也 故忽眩仆脫絕 是名爲厥 …… 輕則漸蘇 重則即死 最爲急候”

[類經]“陰陽氣不相接即厥 熱厥補陰 寒厥補陽” [入門]

정의 : 陰陽失調 或氣血逆亂으로 因하여 卒然昏倒하여 暴不知人하며 或聾, 或不能言하고 或은 手足厥冷하며 或暴死 或一二日后에 知人하는 病症을 말하며 後遺症을 남기지 않는 일종의 救急(應急)疾患

음양실조, 기혈역란으로 인해 갑자기 쓰러지고 사람을 알아보지 못하고, 혹은 귀가 먹거나 말을 못 하거나 사지가 싸늘해지는 병증. 후유증은 남기지 않는다.

서의학적 이해 : 히스테리질환 - 전환장애, 저혈당성 혼수, 일사병, 기립성 저혈압, 고혈압성 뇌증, 약물중독에 의한 의식장애

내경에서의 궤증

내경에서 궤증에 대해 처음 기재함. 4가지 카테고리로 봄.

① 卒然昏倒, 暴不知人

- [素問.大奇論] “暴厥者不知與人言”

갑자기 쓰러져서 사람을 알아보지 못함

② 手足厥冷

- [靈樞.五亂篇] “清濁相干 亂于臂脛 即爲四厥”

③ 氣逆爲厥; 氣機升降失調 氣血運行逆亂

- [素問.生氣通天論] “大怒即形氣絕而血菀于上 使人薄厥”

- [素問.厥論] “厥或令人腹滿 或令人暴不知人 或至半日 遠至一日 乃知人者何也?”

陽氣盛於上 則下氣重上 而邪氣逆 逆則陽氣亂 陽氣亂則不知人也”

- [靈樞.五亂篇] “清氣在陰 濁氣在陽 營氣順脈 衛氣逆行 清濁相干 亂于臂脛 即爲四厥 亂于頭即爲厥逆 頭重眩仆”

④ 六經形證

- 巨陽之厥 則踵首頭重 足不能行 發爲胸仆
- 陽明之厥則癰疾慾走乎 腹滿不得臥 面赤而熱 妄見而妄言
- 盛則瀉之 虛則補之 不盛不虛 以經取之

궤증의 임상적 의미

① 突然昏倒 人事不省의 意味

② 手足逆冷의 意味

③ 六經之厥에 대한 구체적인 形證

궤증 진단

: 각종원인으로 인한 급성적이고 순간적인 의식장애

① 突然昏倒 人事不省

- 輕者 昏厥時間短
- 醒后 口眼喎斜, 失語, 半身不隨 등의 後遺症이 없다.

② 或手足逆冷이 主要症狀

- 面色蒼白或口脣青紫.
- 脈沉或細弱或沉微欲絕

궤증 병리

- 1) 七情鬱結(칠정울결)
- 2) 飲食不節(음식부절)
- 3) 炎熱酷暑(염열혹서)
- 4) 氣血俱虛(기혈구허)

가장 기본적인 병리변화는 陰陽失調로 氣機逆亂해서 神明을 어지럽히는 것
 주요 동기는 情志過極, 氣血耗傷, 久曝烈日, 食滯, 痰濁
 그중 情志過極이 가장 직접적인 병인
 뒷목잡고 쓰러지는 느낌

권증의 증후감별 -1

① 氣厥實證과 血厥實證의 鑑別

- 氣厥 面色蒼白, 手足逆冷;
- 血厥 面色紅赤, 口唇青紫

- 兩證病因基本相同, 臨床表現類似, 氣爲血之師이므로 氣血同病之證으로 발전
 기절은 얼굴이 창백하고 손발이 차가워짐. 혈절은 얼굴이 붉어지고 입술이 청자색이 됨.

② 氣厥虛證과 血厥虛證의 鑑別

- 氣虛暈厥每因 元氣虧虛, 陽氣消乏, 宗氣下陷, 清陽不升則 突然昏倒;
- 血虛暈厥則因 產后, 外傷, 大崩大吐, 失血過多, 氣隨血脫, 神機不運而暈厥

원인에서의 차이로 구분

類型	症狀	舌脈
實證	氣厥 서로 다투거나 몹시 화를 내다가 기가 위로 치밀어 올라 말을 못하며 까무러쳐 넘어지고 정신을 잃는다. 이를 악물고 호흡이 거칠며 四肢厥冷하기도 하다. 갑자기 너무 기뻐 하거나 근심과 수심으로 불안한 기운이 많아져 발생할 수도 있다.	舌苔薄白 脈沈或沈弦
	血厥 몹시 성을 내어 기가 막히고 피가 상초에 몰려 정신을 잃고 쓰러진다. 얼굴이 붉고 구순이 청자색이다. 五志의 火가 몹시 동하여 화가 피를 끌고 올라와 제 경락을 잃고 멋대로 돌게 된 것으로 심하면 피를 토하기도 한다.	舌質紅或暗紫 脈沈弦
虛證	氣厥 지나친 피로로 기가 상하거나 지나치게 울거나 놀라는 것 등의 정서장애로 기가 상하면 의식을 잃고 넘어진다. 얼굴이 창백하고 숨소리가 약하며 땀을 흘리고 싸늘해진다.	舌質淡 脈沈弱
	血厥 외상 또는 산후에 피를 많이 흘렸거나 갑자기 설사를 지나치게 한 것 등으로 陰血이 부족해지면 腦髓를 자양하지 못하기 때문에 갑자기 의식을 잃고 넘어지며 얼굴이 핏기가 없고 입술이 윤택하지 못하며 눈에 정기가 없다.	舌質淡白 脈細數

권증의 증후감별 -2 ★★

(1) 昏厥과 昏迷 : 突然昏倒하는 증상이 서로 비슷.

昏迷(혼미)는 다른 질병의 경과 중에 발생하며 이전에 중한 질병을 가진 경우가 많다. 의식을 잃는 시간이 비교적 길고 원인이 되는 질병에 따라 후유증을 남길 수 있다.

昏厥은 특별한 질병이 없는 사람에게서 발병하며 의식을 잃는 시간이 짧고 깨어난 후 후유증을 남기지 않는다.

(2) 昏厥과 中風 : 突然昏倒의 증상이 비슷.

中風은 口眼喎斜, 言語障礙, 突然昏倒, 不省人事 등을 나타내며, 의식이 회복된 후에도 실어, 반신불수 등의 후유증.

昏厥은 성인에서 많이 발생하고 정서적 요인과 관련이 많으며 깨어난 후에도 실어증, 반신불수 등의 후유증을 남기지 않음.

(3) 昏厥과 癇證

癇證은 발작성의 의식장애를 나타내며 발작시에 突然昏倒, 不省人事, 嘔吐涎沫, 兩目上視, 四肢抽搐 혹은 口中叫聲하고 시간이 지나면 깨어나게 된다. 청소년기에 많음. 반복적

昏厥은 발생시에 四肢抽搐, 口中叫聲 등이 없으며 치유된 후에는 반복적 발병하지 않는다.

(4) 昏厥과 眩暈 : 모두 昏仆의 증상. 仆 : 넘어질 구

眩暈은 어지럼증이 있어 서있기 힘들며 넘어질 것 같고 눈이 잘 보이지 않으나 의식 똑똑. 의식을 잃지 않음.

昏厥은 突然昏倒, 四肢厥冷이 주요 증상으로 의식을 잃게 된다.

✦ 궤증의 종류와 주요특징

氣厥	肝氣鬱結 氣機逆亂 蒙閉清竅而厥/氣虛下陷 清陽不升 腦海失養所致厥
血厥	血隨氣逆 上竅神明 清竅閉塞而致/血虛不榮 腦海失養而致暈厥
寒厥	陽氣虛衰感陰寒偏盛 血滯不通 陰陽之氣不相順接或不相維系而厥脫
熱厥	熱毒內陷 陰陽之氣不相接續而厥
痰厥	痰濁阻閉清竅而暈厥
食厥	飲食停滯 乘降失常而致
中惡	某種特殊環境或冒犯不正之氣 ex.일산화탄소 중독
酒厥	縱飲不節 其氣上冲而暈厥
色厥	縱淫不節 精竭于下 陽隨精暴脫. 症見: 男女同房, 發生暴厥

✦ 궤증의 변증논치

氣厥	蘇合香元을 풀어 먹여 정신이 들게 한 다음, 八味順氣散, 木香順氣散
血厥	六鬱湯, 通竅活血湯 / 人蔘養榮湯, 歸脾湯, 加味四物湯 등, 重症에 獨蔘湯合生脈散
寒厥	回陽救急湯, 理中湯, 四逆湯
熱厥	四逆散, 白虎湯, 大承氣湯, 升陽散火湯
痰厥	清火化痰煎, 加味二陳湯, 順氣導痰湯
食厥	생강, 소금 넣고 끓인 물(강염탕)로 토하게 하고 나서 加味六君子湯, 補和丸
中惡	蘇合香元, 備急丸
酒厥	葛花解醒湯, 對金飲子
色厥	清暑益氣湯, 竹葉石膏湯. 의식이 없을 때에는 蘇合香元이나 至寶丹을 사용

사역탕은 부자 건강 감초 등으로 양기부족, 허한증에 사용. 사역산은 몸을 따뜻한데 손발이 찬 증상.

궤증의 치방요점_참조

의식장애: 星香正氣散

경련발작: 藿香正氣散加味

마 비 성: 八味順氣散

진 전 성: 溫脾湯(歸脾湯+溫膽湯)

억 올 감: 六鬱湯加味, 分心氣飲

기타: 아로마요법, 향취요법, 침구치료

[4] 적응장애

[DSM-5 범주]

외상- 및 스트레스사건-관련장애 (Trauma-and Stressor-Related Disorders)

-외상후 스트레스 장애(PTSD)

-급성스트레스 장애(ASD)

-반응성 애착장애(Reactive Attachment Disorder)

-탈억제 사회관계장애(Disinhibited Social Engagement Disorder)

-적응장애(Adjustment Disorder)

적응 장애는 '외상 및 스트레스 사건 관련장애' 범주에 포함되어 있다.

개요

Adjustment?

1. 적응

■ 원래 생물학에서 종의 생존을 설명하기 위해 사용한 개념으로 해당 환경에서 가장 잘 적응하는 종이 거기서 살아남는다는 것을 의미

2. 심리학에서 적응의 개념

■ 개인이 사회적 물리적 환경에서 잘 지내거나 살아남기 위한 투쟁을 의미

3. 건강한 적응

■ 환경의 요구들을 제대로 인식하여 거기에 자신을 맞추고

- 그것이 바람직하지 않거나 불가능할 때 자신의 생각이나 환경을 변화시키며
- 외부세계의 조건이나 요구들에만 주의를 쏟지 않고 자신의 몸과 마음의 요구사항들에도 잘 반응하여 거기에 자신의 활동을 맞추고 바람직하게 성장해나가는 과정

ex) 사막여우와 북극여우의 생물학적 적응 차이

사막여우: 흉쪽한 몸, 큰 귀 (더위에 적응) / 북극여우: 지방이 많고 짧은 귀 (추위에 적응)

Development path of adaptation (적응의 5가지 패턴)

경로 1. 안정된 적응패턴

- 자신을 긍정적으로 바라보며 지속적으로 우수한 적응의 특징을 나타내는 유형
- 평탄하고 이상적인 적응 패턴

경로 2. 지속적인 부적응

- **만성적 환경문제**가 자신을 둘러싸고 있기 때문에 공격적이며 반사회적인 부적응 행동이 계속 유지되는 경향

만성적 환경문제: 시설기관에서 양육을 받은 경우, 가난한 환경, 가족들의 학대나 방임

만성적인 환경문제가 해결되지 않으면 부적응 상태가 계속 유지되며 세대 간에 대물림되는 경향이 있음(알코올중독, 폭력적인 성향 등)

적응수준이 빈약함.

경로 3. 부적응의 반전

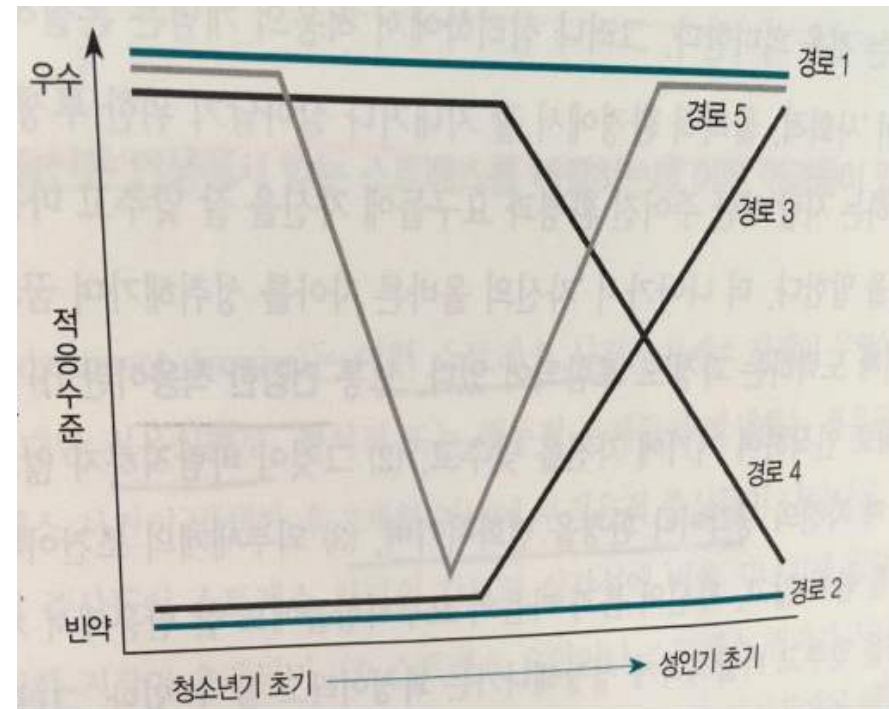
- 환경적으로 주어진 어떤 기회에 의해 또는 대오각성으로 인해 부적응 사슬을 끊고 긍정적 결과로 변모하는 경향

경로 4. 적응의 감퇴

- 청소년기 중 후기까지 잘 적응해 오다가 어떤 역경이 초래되어 적응이 퇴조되는 경우

경로 5. 일시적 부적응

- 일시적 마음의 중심을 잡지 못하고 주변의 유혹(게임 중독, 가짜)에 빠져들어 부적응이 초래되지만, 다시 적응 행동으로 복원되는 경우



출처: Compass 등 (1995)

+ 적응 장애로 산재 인정받는 경우도 있음. (롯데백화점 노조간부)

+양육을 온전하게 받지 못하면, 발달 단계에 맞는 과업을 이루지 못해 단계에 고착될 수 있고, 그 상태에서 스트레스를 받으면 오히려 퇴행하기도 한다.

+공다공증이 있는 사람은 같은 압력에도 공절이 일어날 수 있듯이, 스트레스에 취약한 사람들은 작은 스트레스에도 크게 반응하게 된다.

하지만 건강한 사람도 압력이 지속적으로 가해지면 공절이 발생하는 것처럼, 적응 장애도 정상적인 사람에게 발생할 수 있다.

+적응장애는 임상에서 진단이 자주 내려지는 흔한 장애이다.

적응장애 정의의 변천

- DSM-I : transient situational personality disorder (**일시적 상황**의 인격장애)
- DSM-II : transient situational disturbances (일시적 상황적 장애)
 - 내재된 인격결손이 없이, 어려운 상황이나 새로 숙련되어야 하는 환경적 요소에 잘 적응하지 못하는 상황들 **인격장애까지는 아님**
- DSM-III : 적응장애 처음 소개(1980년) 스트레스 사건에 대한 반응으로 심리적 증상이 발생한 상태. 구체적인 진단기준 열거
- DSM-IV, -TR : 스트레스 요인 혹은 그 결과가 소실되면 부적응적 반응이 6개월 이상 지속되지 않는 것으로 구체화. 6가지 아형으로 구분
- DSM-V : 외상 및 스트레스 사건 관련 장애의 (Trauma-and Stressor-Related Disorders) 하위 범주로 포함.

DSM-4에서는 모든 애도반응을 적응장애의 원인에서 제외하였으나, DSM-5로 개편되면서 사회문화적 맥락을 넘어서는 지나친 애도반응은 적응장애의 원인으로 본다.

외상 및 스트레스 사건 관련장애 (DSM-5) ★

- 외부세계에서 주어진 환경적인 스트레스 사건과 그에 대한 개인의 부적응적 반응

DSM-4		DSM-5: 외상 및 스트레스 관련 장애
불안장애 - 외상후 스트레스 장애 (Post traumatic stress disorder, PTSD) - 급성 스트레스 장애 (acute stress disorder, ASD)	▶	1. 외상 후 스트레스 장애 (PTSD) 2. 급성스트레스 장애 (ASD) 3. 적응장애 (Adjustment Disorder) 4. 반응성 애착장애 (Reactive Attachment Disorder) 5. 탈억제 사회관계 장애 (Disinhibited Social Engagement Disorder)
독립적인 범주 적응장애		
아동기 장애 - 반응성 애착장애 (reactive attachment disorder) - 탈억제성 사회적 관련 장애 (disinhibited social engagement disorder)		

외상 및 스트레스 사건 관련 장애 하위 범주 세부 설명

복습차원에서 보자하고 넘어감

- 정의: 충격적인 외상적 사건이나 스트레스 사건을 경험한 후 그 후유증으로 심각한 부적응적 증상들이 나타나는 장애

(1) 외상 후 스트레스 장애

- 어떤 충격적인 외상적 사건을 경험하고 난 이후에 그 후유증으로 1개월 이상 다양한 부적응적 증상들(사건에 대한 기억, 심상, 이미지, 플래시백의 자동적 침투 증상 및 회피행동)이 재경험되는 경우

(2) 급성 스트레스 장애

- 외상 후 스트레스 장애의 증상과 동등하지만 증상 기간이 3일 이상 1개월 이내로 짧은 경우

(3) 반응성 애착장애

- 양육자에게 애착 외상을 받아 양육자에 대해서 거의 항상 정서적으로 억제되고 위축된 행동을 나타내는 경우

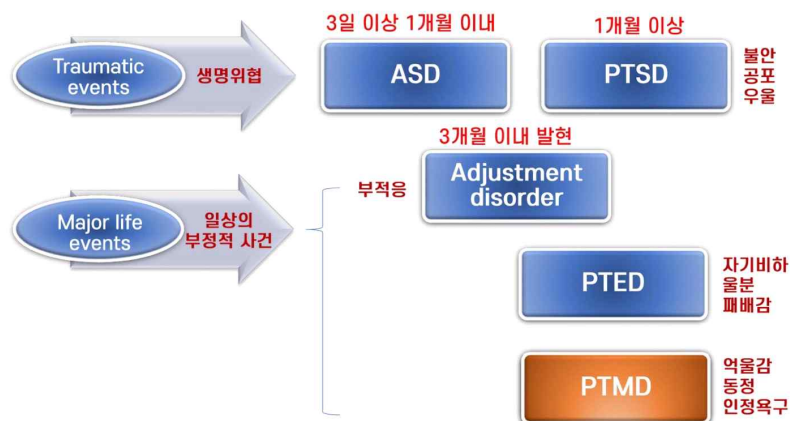
(4) 탈억제 사회관계 장애

- 애착 외상을 경험한 아동이 처음 본 사람을 아무 거리낌 없이 부적절하게 과도한 친밀감을 나타내거나 낯선 사람을 아무 주저함 없이 따라가려는 경우

(5) 적응장애

- 확인 가능한 어떤 스트레스 사건에 대한 적응실패로 정서적 또는 행동적 문제들이 발생하는 경우

Traumatic & Major life events



ptsd와 적응장애는 일어난 사건에서 차이가 있다.

■ Traumatic event로 인해 발생하는 질환

✓ Traumatic event: 생명이 위협될만한 사건 (생존 위협의 경험)

- 1) ASD(급성 스트레스 장애): 3일 이상 1개월 이내로 생긴 경우
- 2) PTSD(외상 후 스트레스 장애): 1개월 이상의 시기 이후에 생기고 증상이 지속된 경우

■ Major life event로 인해 발생하는 질환 ★

- 1) Adjustment disorder(적응 장애) : 3개월 이내에 발현한 부적응 상태
- 2) PTED(외상 후 울분장애) : 자기비하, 울분, 패배감을 특징으로 한다.
ex) 동독, 서독 통일 이후 동독 사람들의 문화적 울분, /만성적으로 대우를 받지 못하는 것에 대한 패배감. /직장 내에서의 관계, 갑질 문제
- 3) 화병 : 억울감이 있으며, 동정받길 원하고 인정욕구가 강하다.
PTMD : (외상 후 명절 증후군) 강령원 교수님이 만드신 말로 화병의 다른 표현

각론

1. DSM-5 적응 장애의 정의 ★★

- A. 인식 가능한 스트레스 요인에 대한 반응으로 **감정적 또는 행동적 증상이 스트레스 요인이 시작한지 3개월 이내에** 발달 **스트레스 요인이 있고, 이를 알고 있음.**
- B. 이러한 증상 또는 행동은 임상적으로 현저하며, 다음 중 한 가지 또는 모두에서 명백하다.
 - 1) 증상의 심각도와 발현에 영향을 미치는 외적 맥락과 문화적 요인을 고려할 때 스트레스 요인의 심각도 또는 강도와 균형이 맞지 않는 **현저한 고통**
 - 2) 사회적 직업적 또는 다른 중요한 기능영역에서 **현저한 손상**
- C. 스트레스와 관련된 장애는 다른 정신질환의 기준을 만족하지 않으며 이미 존재하는 정신질환의 단순한 악화가 아니다.
- D. 증상은 정상 애도 반응을 나타내는 것이 아니다.
- E. 스트레스 요인 또는 그 결과가 **종료된 후에 증상이 추가 6개월 이상 지속하지 않는다.**

다음의 경우 명시할 것

급성: 장애가 6개월 미만일 경우

지속성(만성): 장애가 6개월 이상 지속될 경우

2. 적응 장애의 아형 (Subtype)

- 1) 우울 동반 적응 장애: 우울한 증상 위주, 중증 우울증과 비교 타지로 전학을 가서 너무 낮설고, 소통할 대상도 없는 외로운 상황에 우울하고 가슴이 답답한 증상이 함께 나타날 수 있다. 이때 우울증보다는 우울 동반 적응 장애로 진단.
- 2) 불안 동반 적응 장애: 불안, 긴장 위주, 불안 장애와 감별
- 3) 우울과 불안이 혼재된 적응 장애: 우울과 불안 및 기타 정서 이상의 혼합상태
- 4) 행동 장애의 적응 장애: 학교생활을 게을리하거나, 싸우거나 사회규범 등을 위반. 행동 장애와 반사회성 인격장애와 감별 필요
- 5) 감정과 품행의 장애가 혼재된 적응 장애: 감정 장애와 행동 장애가 동시에 존재
- 6) 비특이성 적응 장애: 우울, 불안을 위주로 한 사회성의 위축, 부인하거나 치료적 위험도가 일치하지 않는 신체적 질병의 진단에 부적절한 반응을 포함한 형

3. 진단 특징 (Diagnostic Features)

- 인식가능한 스트레스 요인에 대한 반응으로 감정적 또는 행동적 증상이 존재하는 것이 적응 장애의 필수적인 특성이다. (진단기준 A)
- 스트레스 요인의 특징
 - 스트레스 요인은 단일의 사건(ex. 연인관계의 종결)이거나 다양한 스트레스 요인(ex. 현저한 직업적 어려움과 결혼생활 문제)이 있을 수도 있다.
 - 스트레스 요인은 반복적일 수도 있고, 지속적일 수도 있다.
 - ✓ 반복적 예시: 계절적인 업무상 위기, 성취감을 주지 못하는 성적 관계
 - ✓ 지속적 예시: 장애를 증가시키는 지속적으로 고통스러운 질병(암 진단), 우범지대 거주
 - 스트레스 요인은 한사람에게 영향을 줄 수도 있고 가족 전체 또는 더 큰 집단 또는 사회에 영향을 미칠 수도 있다. ex) 자연적인 대재앙
 - 어떤 스트레스 요인은 특정한 발달적 사건에 동반할 수 있다.
 - ex) 등교, 부모와 떨어지기, 부모에게 다시 들어가기, 결혼하기, 부모 되기, 직업적 목표를 이루는 것의 실패, 은퇴

- 적응 장애는 사랑했던 사람의 사망에 따라 애도반응의 강도, 질 또는 지속의 정도가 문화적, 종교적 또는 연령에 적절한 정상을 고려할 때, 정상적으로 기대되는 정도보다 지나칠 때 진단될 수 있음
- 더 특정한 애도와 관련된 증상의 모음은 지속성 복합 애도장애로 지정됨
- 적응장애는 자살시도와 자살완수의 위험성 증가와 연관이 있다.

4. 유병률 Prevalence ★

- 적응장애는 흔함
- 외래 정신건강 치료에서 적응장애를 주 진단으로 받은 사람은 대략 5%~20% 정도다.
- 병원 정신과 자문 환경에서는 종종 가장 흔한 진단으로 자주 50%에 이른다.
- 남녀의 비율은 정도 1:2
- 청소년, 독신 여성의 발생률이 높다.

5. 발달과 과정(Development and Course)

- 정의에 따르면 적응장애의 장애는 **스트레스 요인이 발생한 지 3개월 이내에 시작하고, 스트레스 요인 또는 그 결과가 종료된 후 6개월 이상 지속되지 않는다.★**
 ✓ 개월 수 중요!!! 종료 후 6개월 이상 지속된다면 우울증이나 불안장애 등 다른 질환으로 진단
- 만약 스트레스 요인이 급성적 사건(ex. 직장에서 해고)이라면 그 장애는 대개 즉시(= 며칠 이내) 시작하고 지속기간은 상대적으로 짧다. (= 몇 개월 이상 지속되지 않음)
- 만약 스트레스 요인 또는 그 결과가 지속 된다면, 적응 장애 역시 지속될 수 있으며 지속적인 형태가 될 수 있다.

6. 위험요인 및 예후 (Risk and prognostic Factors)

- 환경적으로 불리한 생활환경의 개인은 스트레스 요인을 높은 비율로 경험하고 적응 장애에 대한 위험성을 증가할 수 있다.

7. 문화적 요인 (Culture-Related diagnostic Issues)

- 스트레스 요인에 대한 개인의 반응이 부적절한지, 아니면 연관된 고통이 예상되는 것 이상인지 등의 임상적 판단을 하는 데에는 그 개인의 문화적 환경의 맥락이 고려되어야만 한다. 스트레스 요인의 본지, 의미, 경험과 스트레스 요인에 대한 반응의 평가는 문화에 따라 다양할 수 있다.
 개인의 기질 차이가 있으므로 다각적으로 봐야 한다.

8. 적응 장애의 기능적 결과 (Functional Consequences of Adjustment Disorders)

- 적응 장애와 관련된 주관적 고통 또는 기능 영역의 손상은 직장 또는 학교에서의 성과가 감소 되거나 사회적 관계의 일시적인 변화로 자주 발현된다. 장애는 일반적인 의학적 상태를 가지고 있는 개인에서 질병의 경과를 복잡하게 만들 수 있다.
 ex) 권고한 의학 요법에 대한 순응도 감소, 병원체류기간의 증가
 암 진단을 받은 후 이를 인정하지 않고 적극적인 항암치료나 여러 검사에 순응하지 않아 질병이 더욱 악화되는 경우

9. 원인과 스트레스 요인 (Cause and Stress Factor) ★

- 적응장애의 일차적 원인 : 스트레스 사건
- 그러나 적응 장애의 심각성은 스트레스 사건 자체의 강도와 비례하지 않는다.
- **개개인의 감수성에 따라 증상의 심각도와 지속시간이 다르다.**

공밀도가 좋은 사람이면 뼈에 압력이 가해져도 골절이 안 나타나지만 원래 뼈가 약한 사람들은 금방 부러지는 것처럼 스트레스에 취약한 사람들은 작은 스트레스에도 크게 반응하게 된다.

- 학업문제, 전학, 상급학교로 진학, 외국학교로 진출, 전공불일치, 따돌림, 가정의 경제적 악화, 사업실패, 빈곤, 애인의 변심, 실연, 부부갈등, 이혼, 대인관계의 갈등, 심각한 질병, 이민 등
- 이러한 상황들에 적절하게 대처하지 못하고 자신이 감당할 수 없다고 느껴 나타나는 부적응적 증상들이 초래될 때

★ 성인과 청소년 적응 장애의 유발인자들

청소년		성인	
스트레스 요인	%	스트레스 요인	%
학교문제	60	결혼생활 문제	25
부모로부터 거부	27	별거, 이혼	23
알코올, 약물	26	이사(이동)	17
부모의 별거, 이혼	25	재정적 문제	14
이성친구 문제	20	학교 문제	14
부모의 결혼생활 문제	18	직업 문제	9
이사(이동)	16	알코올, 약물	8
법적 문제	12	질병	6
직업 문제	8	법적 문제	6
기타	60	기타	81

Case 1

- 44세 회사원 3개월 전 회사에서 권고사직을 당한 후 기운이 없고 의욕이 없으며 사소한 일에도 짜증을 부리는 일이 많아짐 2개월 전부터는 불면, 밥맛도 없어짐
가슴이 늘 답답하고 두근거리며 잦은 한숨을 쉬게 되어 심전도 검사 받았으나 이상 무.
- 정신과 진료를 권고받아 내원하였는데 면담 상 기분은 우울하지 않다고 하였으나 주의 집중력이 많이 떨어져있고 절망적인 표정 이학적 검사상 이상 소견

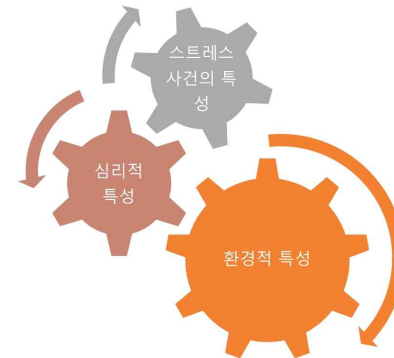
없었고 정신과적 기왕력도 없었음.

- '권고사직을 당한 후 갑자기 식욕이 없어지고 체중감소가 생겼으며 매사에 의욕이 없다' '가슴이 답답하고 복부에 통증이 있어 밤에 생긴게 아닌가' '친구를 만나면 무시당할 거 같아 늘 방안에서 누워 지낸다'

A. 3개월 이내에 권고사직이라는 인식 가능한 스트레스 요인으로 인해 생겼으며 증상이 지속되고 있음

= 진단명: 적응 장애 (우울한 기분이 동반된 적응 장애)

적응장애 원인들의 함수



- 스트레스 사건: 스트레스의 강도, 심각도, 지속 기간
 - 심리적 특성 : 성격특성, 자존감과 자신감, 감내력, 스트레스 대처 능력, 문제해결 능력
 - 환경적 특성 : 활용 가능한 자원 여부, 도움이 될 수 있는 주변 사람들의 지지와 격려
- ✓ 스트레스가 있어도 감내력이 있고 주변 사람들의 지지가 있으면 쉽게 극복할 수 있다.

10. 적응 장애의 치료

1) 지지적 심리치료 (ex. M&L 심리치료)

- 문제중심적 대처(problem-focused coping): 스트레스를 유발시키는 자극 자체를 변화시키려는 노력 / 스트레스를 일으키는 문제 자체를 해결할 수 있을 때
→ **stressor** 를 변화
- ex) 정보 얻기, 문제해결과 관련된 계획 세우기, 체계적으로 접근하기, 행동 취하기, 새로운 기술 배우기 등
- ✓ 시험 못본 경우 / 계획을 세우거나 족보를 구한다거나 친구한테 도움을 받는다거나 등등

- 정서중심적 대처(emotion-focused coping): 스트레스 자극으로부터 유발된 불쾌한 감정을 해소하려는 노력 / 문제가 해결될 수 없거나 다시 되돌릴 수 없을 때

→ 스트레스 지각에 **수반되는 감정을 관리**하는 데 초점

ex) 회피하기, 거리두기, 문제 자체를 부정하기, 유머 사용하기, 이완 요법, 운동, 용서, 흡연이나 음주, 약물

✓ 해결책은 아니지만 감정을 조절할 수 있음 (그러나 더 큰 문제를 초래하게 될 수도 있음)

문제해결 가능 여부를 판단하여 문제 중심적, 정서 중심적 대처를 선택할 수 있어야 한다.

해결 가능한 문제인데 정서적 지지만 한다면 그 상황에 계속 머무르게 된다.

바꿀 수 없는 것에는 정서 중심적 대처, 바꿀 수 있는 것에는 문제 중심적 대처를 적용.

평온의 기도 -라인홀드 니부어-

주여,

제게 바꿀수 없는 것들을 받아들이 수 있는 평온을 주시옵고

제가 바꿀수 있는 것들을 변화시킬 수 있는 용기를 주시옵소서

그리고 제게 그 둘을 구별할 수 있는 지혜를 주시옵소서

2) 인지치료

- 스트레스에 순응하기보다는 그것을 극복할 수 있다는 자신감을 길러주어야 함
- 스트레스 반응은 자신의 뜻에 따라 조절 가능
- 긍정적 독백 (ex. 실망하지 않는다, 절대로 포기하지 않는다, 나는 외롭지 않다, 나는 이겨낼 수 있다 등)

3) 집단 치료 및 가족 치료

4) 약물치료

- 적응 장애에 수반되는 부적응적 증상에 따라 항우울제, 항불안제, 수면제 등 소량. 단기간 동안만 사용

적응장애 치료의 권장사항들 ★

1. 중요한 질문은 “환자가 무엇에 대하여 부적응을 보이고 있는가”라는 것이다.
 - **스트레스 요인**이 없는 적응장애는 없음 ✓ **어떤 스트레스 요인이 있는지 확인해야함.**
2. 적응장애는 흔히 주요우울장애와 같이 뚜렷한 다른 장애로 이행하는 경우가 많다.
 - 정신상태의 변화와 증상에 유의하라
3. 대부분의 적응장애는 **일시적인 것**
 - 대개 필요로 하는 것은 세월이라는 약과 지지적 정신치료이다
4. 흔한 심리 사회적 스트레스 요인(암, AIDS, 만성요통, 대인관계의 분열)을 가진 환자는 유사한 스트레스 요인을 경험한 타인들과 지지적인 집단에 참여함으로써 종종 도움을 받음 ✓ 환우회, 기타 모임들
5. 정신과 약물은 주된 증상을 목표로 처방한다.
 - 불면증 : zolpidem 5~10mg. hs
 - 불안 : lorazepam 0.5~2.0mg. bid
6. 장기치료를 요하는 경우 다른 장애 (주요우울장애, 범불안장애)를 고려해야 하며 재평가와 이에 맞는 치료가 필요할 것이다.

11. 감별진단 (Differential Diagnosis)

1) 외상 후 스트레스 장애와 급성 스트레스 장애

- 적응 장애에서 스트레스 요인은 급성스트레스 장애와 외상 후 스트레스 장애의 진단기준 A로 정해져 있는 심각도와 유형에 비해 심각도가 다양할 수 있다.

■ 급성 스트레스 장애는 노출 후 3일부터 1개월까지만 나타날 수 있으며, 외상 후 스트레스 장애는 외상성 스트레스 요인이 발생하고 최소한 1개월이 지나기 전까지는 진단될 수 없다.

- 외상 후 스트레스 장애와 급성스트레스 장애의 요구되는 증상 개요는 그들을 적응 장애와 구별한다. 증상 개요와 관련하여 외상성 사건에 따라 개인이 급성 스트레스 장애나 외상 후 스트레스 장애의 진단 역치를 만족하거나 넘지 못하는 증상을 나타낼 때 적응 장애가 진단될 수 있다.

✓ 외상 후 스트레스 장애, 급성 스트레스 장애의 스트레스 요인은 교통사고, 화재 등 생존 위협 수준 / 적응장애는 비교적 일상적

2) 중증 우울증

- 우울한 증상이 비교적 심하며, 우울이 명료하고 자살관념과 행위가 심각한 경우. 생물학적 변화가 발생

3) 범불안장애

- 일반적으로 스트레스로 인하지 않은 경우가 많으며, 지속적이고 광범위하게 불안한 것이 동반된 자율 신경 증상 호소

4) PTED

	적응장애	PTED
공통점	식별 가능한 정신사회적 스트레스 요인, 부정적인 생활 사건 (적응장애를 일으킬 수 있는 스트레스 요인은 PTED에서도 발생할 수 있음)	
차이점	질병과 스트레스 요인 사이에서 인과적 관계를 볼 필요가 없음	그들이 경험했던 것의 직접적 결과로 인한 현재의 부정적인 상황과 사건을 볼 필요가 있음. 울분이 그 사건이 주는 부담감, 모욕감 혹은 좌절스러운 감정 때문에 발생하기에
	약 6개월 후에 호전, 시간이 한정되어 있는 것으로 이해	자발적 차도 경향을 보여주지 않음

5) 인격장애

- 어린 시기부터 시작되어 지속적으로 존재하는 것.
- 스트레스가 인격장애 형성의 주요 요인은 아니다.
- 환자는 인격장애나 고뇌와 관련이 없으나, 기본적으로 지속되어 성인에 이를 수 있고, 더 심한 경우 평생 가기도 함
- 인격장애 환자는 전형적으로 스트레스 상황에서 부적응적 방식으로 반응함

6) 사별 반응

- 상충으로 인하여 정서 반응이 명확하게 표현되는 것
- 문화 배경과 상응하는 것으로 지속시간은 6개월을 초과하지 않음

12. 동반 질환 (Comorbidity)

- 적응 장애는 대부분의 정신질환과 어떤 의학적 장애와도 동반할 수 있다.
- 적응 장애는 다른 정신질환이 스트레스에 대한 반응으로 일어나는 특정한 증상을 설명하지 않거나 하면 다른 정신질환에 추가적으로 진단될 수 있다.
- 적응장애는 의학적 질병에 흔히 동반되며 의학적 장애의 주요한 심리적 반응일수도 있다.

적응장애의 한의학적 치료에 대한 국내 외 선행연구

1) 군대 생활 부적응으로 급격한 체중 감소를 나타낸 七情吐 환자 치험 1례

✓ 칠정상이라는 한의학적 병리 이론으로 변증하여 치료

2) 이완 요법과 한방치료를 병행한 심담허겁형 칠정구기증 환자 1례의 증례 고찰

✓ 심정격 사용.

[5] 파괴적, 충동조절 및 품행장애

[DSM-5 범주]

파괴적, 충동조절 및 품행장애 (Disruptive, impulse-control and conduct disorders)

-적대적 반항장애

-품행장애

-반사회적 인격장애

-간헐적 폭발성 장애

-도벽증

-방화증

✓ DSM-4에서 충동조절 장애의 하위 범주였던 병적 도박과 발모광은 각각 물질 관련 및 중독장애, 강박 및 관련 장애라는 다른 항목으로 분류되었다.

0절. 개요

파괴적, 충동조절 및品行장애 (DSM-5)

- 정서와 행동을 통제하지 못해 발생하는 다양한 부적응적 증상

DSM-4: 충동조절 장애(impulse control disorder), 아동기 장애	DSM-5: 파괴적, 충동조절 및品行장애
충동조절장애 1. 병적 도박(pathological gambling) 2. 병적 방화 3. 병적 도벽 4. 발모광(발모벽)(trichotillomania) 5. 간헐적 폭발성 장애 또는 간헐적 폭발 장애 (Intermittent Explosive Disorder) 6. 미분류 충동조절 장애 (impulse control disorder, NOS)	1. 반항성 장애 또는 적대적 반항 장애 → 분류 이동 2. 간헐적 폭발성 장애 또는 간헐적 폭발 장애 3.品行장애 → 분류 이동 4. 반사회적 성격 장애: DSM-5에서 성격장애에도 동시 분류 5. 병적 방화 또는 방화증 (Pyromania) 6. 병적 도벽 또는 도벽증 (Kleptomania) 7. 기타 충동조절장애 (impulse-control disorder not otherwise specified) cf. • 병적 도박 → '물질 관련 및 중독성 장애'의 도박 장애 • 발모벽 → '강박 및 관련장애'
아동기 장애 •品行장애(Conduct Disorder) • 반항성 장애 또는 적대적 반항장애 (Oppositional Defiant Disorder)	
성격장애 • 반사회적 성격장애 (anti-social personality disorder)	

충동조절 장애의 개념

- 충동: 인간이 가지는 일종의 본능적 성향
 인간은 누구나 충동을 갖지만 전전두엽에서 충동을 조절할 수 있다.
- 충동이 너무 강하거나 자아의 억제 기능이 약화된 경우에 많은 문제를 일으킬 수 있는데 문제의 핵심은 '충동에 저항할 수 없다는 것'
- (충동조절 장애 환자는) 자기 자신이나 타인에게 해가 되는 행동을 반복하며 이런 충동과 욕구를 스스로 억제하거나 조절하지 못한다.
- 충동조절 장애의 특징
 - 충동적 행동을 하기 전 긴장이나 각성이 고조된다.
 - 행동으로 옮긴 후에는 일시적인 쾌감이나 다행감, 긴장의 해소를 경험
 신경계가 엄청나게 활성화됐다가 해결되기 때문
 - 충동적 행동은 대부분 자아 동질적이라 행위 후 자책, 죄책감 등이 없는 경우가 많다. 이로 인해 충동적 행동이 반복적으로 나타나게 된다.

충동조절장애	±	파괴적 행동장애
- 방화, 도둑질 등 충동을 자제하지 않고 바로 행동으로 옮겨 해결하려는 경향 - 공통적인 양상 - 자기 자신이나 타인에게 해가 될 만한 행동을 하려는 충동, 욕구, 유혹을 억제하지 못한다(충동을 의식적으로 억제할 수도 억제하지 않을 수도 있고, 그런 행동을 계획할 수도 계획하지 않을 수도 있다). - 충동적 행동을 저지르기 전까지 긴장감이나 각성상태가 고조된다. - 일단 행동으로 옮기면 쾌감, 만족감 또는 긴장에서의 해방감을 경험한다.		- 언어폭력, 적대행동, 폭력행동, 충동성, 비행 등 - 행실장애, 적대적 반항장애, 반사회적 성격장애 등 - 충동성파도 관련되나 충동조절장애는 파괴적 행동장애와 다른 특성도 가지고 있어 구별된다.
▼		▼
감정(정서) 조절에 보다 문제를 보이는 경우	중간 정도의 특성	행동조절에 보다 문제가 보이는 경우
간헐적 폭발성 장애: 대인관계 혹은 각종 상황이나 정신적 스트레스에 대해 지나친 분노폭발을 나타낸다.	적대적 반항장애: 정서조절 문제(분노 등) + 행동조절 문제(반항행동, 과도한 논쟁적 성향 등)	행실장애, 반사회적 성격장애

파괴적, 충동조절 및品行장애의 하위유형

하위유형	주요진단특징
1. 적대적 반항 장애	어른에게 불복종하고 거부적이며 적대적이고 반항적인 행동을 6개월 이상 지속적으로 나타내는 경우, 정서적 증세 포함
2. 간헐적 폭발성장애 분노조절장애	공격적 충동의 조절 실패로 분노 폭발, 가끔씩 심각한 파괴적 행동을 나타내는 경우. 연령은 6세 이상 <i>6살 이전에 이러한 양상을 보이는 것은 발달 과정에서 뇌의 기능이 미흡한 것.</i>
3.品行장애	타인의 권리를 침해하거나 사회적 규범 및 규칙을 위반하는 행동을 반복적이며 지속적으로 나타내는 경우 <i>ex) 사회적으로 문의를 일으키는 청소년들 (비행청소년)</i>
4. 방화증	자신의 기쁨이나 만족, 또는 긴장 완화를 위해 불을 지르고 싶은 충동을 억제하지 못해 1회 이상 고의적이며 의도적으로 방화를 하는 경우 <i>2차적 이득을 위해 불을 지르는 것이 아님.</i>
5. 도둑증	자신의 기쁨이나 만족, 또는 긴장완화를 위해 남의 물건을 훔치고 싶은 충동을 억제하지 못해 반복적으로 도둑질을 하는 경우 <i>가난해서, 물건이 필요해서 훔치는 것이 아님.</i>
6. 반사회 성 성격장애	- 타인의 인격과 권리를 침해하고, 사회의 규범이나 법을 무시하며, 무책임하고 폭력적인 행동을 반복적으로 나타내는 성격적 문제가 있는 경우. 증상은 15세 이전부터 시작되어 18세 이상의 성인에게 진단되고, 15세 이전에品行 장애를 나타낸 병력이 있어야 한다. - DSM-5는 반사회성 성격장애를 '파괴적, 충동조절 및品行 장애'의 범주에 하위유형으로 제목만 제시했고 (특히, 파괴적이며 충동조절의 실패 때문에) '성격장애'의 장과 함께 이중으로 분류하였음. 본격적인 내용은 '성격장애'에서 다루고 있다.

1절. 적대적 반항장애

1. DSM-5 적대적 반항장애의 진단기준 ★

A. 분노/과민한 기분, 논쟁적/반항적 행동, 보복적 태도의 양상이 적어도 6개월 이상 지속되고, 다음 중 적어도 4가지 이상의 증상이 존재한다. 이러한 증상은 형제나 자매가 아닌 적어도 한 명 이상의 다른 사람과의 상호작용에서 나타나야 한다.

분노 / 짜증내는 기 분	1. 자주 욕하고 화를 냄 (성질을 냄) 2. 자주 과민하고 쉽게 짜증을 냄 3. 자주 화를 내고 크게 분개함
논쟁적 / 반항적 행동	4. 권위자와의 잦은 논쟁, 아동이나 청소년의 경우는 성인과 논쟁함 5. 자주 적극적으로 권위자의 요구나 규칙을 무시하거나 거절 6. 자주 고의적으로 타인을 귀찮게 함 7. 자주 자신의 실수나 잘못된 행동을 남의 탓으로 돌림
보복성 (악의적인 복수 심)	8. 지난 6개월 안에 적어도 두 차례 이상의 악의에 차 있거나 앙심을 품음

■ 주의점

진단에 부합하는 행동의 지속성 및 빈도는 정상 범위 내에 있는 행동과 구별되어야 한다. 다른 언급이 없다면, 5세 이하의 아동인 경우에는 최소한 6개월 동안 거의 매일 상기 행동이 나타나야 한다. 5세 이상의 아동인 경우에는 6개월 동안 일주일에 최소한 1회 이상 상기 행동이 나타나야 한다. (진단기준 A8)

이런 빈도에 대한 기준은 증상을 기술하기 위한 최소기준을 제공한 것일 뿐이며, 반항적 행동이 동일한 발달 수준에 있고 성별이나 문화적 배경이 같은 다른 사람들에게서 전형적으로 관찰되는 것보다 더 빈번하고 높은지와 같은 다른 요인들도 고려해야 한다.

B. 행동장애가 개인 자신에게, 또는 자신에게 직접적으로 관련있는 사회적 맥락(ex. 가족, 또래 집단, 동료) 내에 있는 상대방에게 고통을 주며, 그 결과 사회적, 학업적, 직업적 또는 다른 중요한 기능 영역에서 부정적인 영향을 준다.

C. 행동은 정신병적 장애, 물질 사용장애, 우울장애 또는 양극성 장애의 경과 중에만 국한해서 나타나지 않는다. 또한, 파괴적 기분조절 부전 장애의 진단기준을 충족하지 않아야 한다.

■ 현재의 심각도 명시할 것:

경도: 증상이 한가지 상황(ex. 집, 학교, 직장, 또래 집단)에서만 나타나는 경우

중등도: 증상이 적어도 2가지 상황에서 나타나는 경우

고도: 증상이 3가지 이상의 상황에서 나타나는 경우

2. 진단 특징 (Diagnostic features)

■ **분노/과민한 기분, 논쟁적/반항적 행동 또는 보복적 특성**이 빈번하고 지속적인 것이다. (진단기준 A)

■ 적대적 반항장애에서는 부정적 기분 문제가 수반되지 않고, 행동문제만 보이는 경우도 종종 있다. 그러나 이 장애가 있는 사람들은 전형적으로 행동문제 뿐만 아니라 분노/ 과민한 기분 증상도 함께 보인다.

■ 이 장애의 증상은 전형적으로 성인과의 상호작용이나 개인적으로 잘 아는 또래들과의 관계에서 나타나는 경향이 있으므로, 임상 면담이나 검사 장면에서는 명백하게 드러나지 않을 수 있다.

■ 적대적 반항 장애를 가지고 있지 않은 사람들과 이러한 증상을 어느 정도 보일 수 있기 때문에 그러한 행동이 반항장애 증상에 부합하는 지를 결정하기 위해 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항들이 있다.

- 첫째, **지난 6개월 동안** 적어도 진단적 역치를 넘어서는 **4개 이상의 증상**이 존재해야 한다.

- 둘째, 그 행동은 연령, 성별, 문화적 조건이 같은 다른 사람들에게서 전형적으로 관찰되는 것보다 더 지속적이고 빈번해야 한다.

- 대부분의 시간에 화가 나 있고, 따지기를 좋아하며 모든 것에 대해 '안돼, 싫어'
- 규칙을 지키거나 지시를 따르고 싶어하지 않는다. 마치 약 올리는 것을 즐기는 것처럼
- 극단의 행동을 하고, 모든 것을 다른 사람의 탓으로 돌린다.
- 악의적인 복수심으로 타인을 괴롭힌다.
- 정작 본인은 불공평하다고 느끼고, 오해받고 있고, 흑사당한다고 생각한다. 다른 사람의 행동이나 의도를 적대적인 것으로 해석하는 경향이 있다.

3. 진단을 뒷받침하는 부수적 특징 (Associated Features Supporting Diagnosis)

■ 아동기 및 청소년기의 적대적 반항장애는 보호자가 바뀌어 아동에 대한 보살핌이 부족한 가정에서 또는 **엄격하거나 비밀관적이고 방임적인** 양육을 하는 가정에서 좀 더 흔히 발병한다.

■ 적대적 반항장애와 함께 보이는 장애로는 주의력 결핍 과잉행동장애(ADHD)와 **품행장애**가 있다. 동반 이환의 효과를 통제하고 나서도 적대적 반항장애는 자살 시도 위험의 증가와 관련되어 있다.

■ 품행장애보다는 덜 심각한 유형.

■ 품행장애는 '타인의 기본적 권리나 사회적 규범을 위배하는 행동패턴'이 특징적. 법적인 문제를 초래.

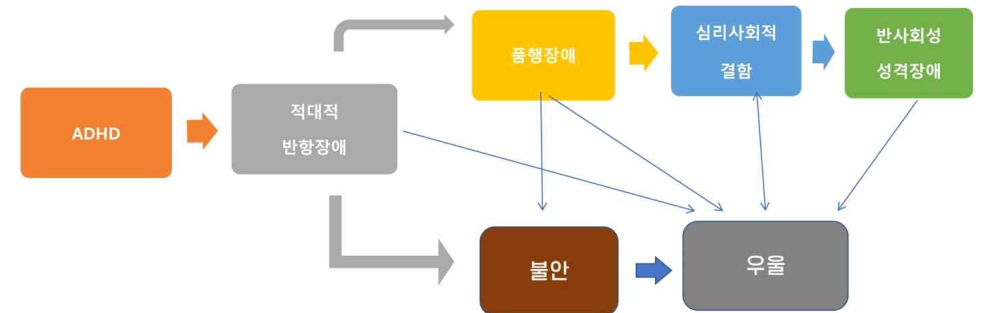
■ ~~품행장애와 적대적 반항장애 진단을 함께 내리진 않는다.~~

품행장애가 더 강한것이니까.

■ 발달적으로 볼 때 적대적 반항장애가 품행장애보다 2~3년 먼저 시작.

■ 적대적 반항장애는 ADHD로부터 발달되는 경우도 많다. 이후 우울증으로 진행하기도.

충동조절 장애의 상관관계



항상 이렇게 따라가는 것은 아님.

적대적 반항장애가 있어 겉으로 드러나는 증상이 과격하더라도 이것이 만성화되면 불안, 우울로 갈 수 있다.

4. 유병률 Prevalence

- 적대적 반항장애의 유병률은 1~11%, 평균 3.3%
- 남 : 녀 = 1.4 : 1
- 평균 발병연령 8세 남자아이가 더 빨리 시작
- 만 4세 : 고집이 세다 / 만 5세 : 벌칙 화를 낸다
/ 만 6세 : 시비걸고 싸움을 하며 짜증을 내거나 욕을 한다.
/ 초등 무렵 : 남을 괴롭히고 거짓말하며 심하게 분노

5. 발달과 과정 Development and Course

- 적대적 반항 장애의 첫 증상은 보통 취학 전에 나타나며, 초기 청소년기 이후에 발병하는 경우는 매우 드물다.
- 적대적 반항장애는 품행장애 뿐만 아니라 불안장애, 우울 장애로도 발전할 수 있다. 대부분 반항적이고, 논쟁적이거나 보복적인 증상은 품행장애의 위험요인이 되고 분노 및 과민한 기분 증상은 정서장애의 위험 요인이 된다.
- 장애의 징후는 발달 단계에 걸쳐 일관적으로 나타난다. 적대적 반항장애가 있는 아동 및 청소년은 성인으로서 성장하고 적응하는데 있어서, 반사회적 행동, 충동조절 문제, 물질남용, 불안 및 우울 등 수많은 문제를 보일 위험이 높다.
- 적대적 반항장애와 관련이 있는 많은 문제행동은 보통 취학전과 청소년기에 그 빈도가 증가한다. 따라서 발달 단계에 있는 아동이나 청소년들을 적대적 반항장애로 진단할 때는 그 나이 또래에서 보이는 정상적 수준의 행동 빈도와 강도를 고려하는 것이 중요

6. 위험 요인과 예후 Risk and Prognostic Features

- 기질적 : **정서 조절 문제**(높은 정서적 반응성, 낮은 좌절 인내력)와 관련된 기질적 요인은 적대적 반항 장애를 예측해 주는 요인이 된다.
- **환경적** : 적대적 반항장애가 있는 아동 및 청소년의 가정환경은 엄격하거나 비밀 관적이고 방임적인 양육을 하는 경우가 흔하며, 이러한 **부모의 양육 방식이 이 장애를 유발하는데 중요한 역할**을 한다.
- 심리특성: 강압이론(부적강화), 사회학습이론(행동모방)
- ✓ **강압이론**: 숙제 안해서 야단을 들음 → 화나서 소리 지름 → 이로 인해 숙제를 안하게 되면, 소리 지르면 숙제 안해도 되는 줄 앎

✓ **행동 모방**: 부모가 공격적이거나 화를 내면 자식이 이를 모방

- 유전적·생리적 : 다양한 신경생물학적 표지자(ex. 낮은 심박률과 피부 전도도, 감소된 기저 코르티솔의 반응성, 전두엽 피질 및 편도체 이상)가 적대적 반항장애와 관련이 있다. 그러나 방대한 연구도 품행장애와 반항장애 아동들을 구분해주지 못하였다. 따라서 적대적 반항 장애에만 특수한 표지자가 존재하는지 여부는 확실하지 않다.

7. 감별 진단

품행장애	품행장애와 적대적 반항 장애는 모두 성인이나 권위자(ex. 교사, 상사)와의 갈등을 초래하는 품행 문제들과 관련되어 있다. 적대적 반항장애의 행동은 품행장애의 행동에 비해 덜 심각하고 , 전형적으로 사람이나 동물에 대한 공격, 재산 파괴, 절도 또는 사기 행동을 포함하지 않는다. 아울러 적대적 반항 장애는 정서 조절의 문제(ex. 분노 및 과민한 기분)를 포함 하는데, 이는 품행장애의 정의에는 포함되지 않는다.★
주의력 결핍 과잉행동 장애	ADHD는 주로 적대적 반항장애를 동반한다. 적대적 반항장애를 추가적으로 진단하기 위해서는 타인의 요구에 따르지 않는 것이 전적으로 지속적인 노력이나 주의를 유지해야 하는 상황, 또는 가만히 앉아 있는 것이 요구되는 상황에서만 나타나는 것이 아니라는 점이 중요하다. (고의성 여부)
우울 및 양극성 장애	우울 및 양극성 장애는 부정적 정동 및 과민성과 관련되어 있다. 따라서 증상이 기분장애 기간에 국한해서 나타난다면, 별도로 적대적 반항장애가 진단되어서는 안 된다.
파괴적 기분 조절부전장애	적대적 반항장애와 파괴적 기분조절부전장애는 만성적인 부정적 기분 및 분노발작 증상을 공유한다. 그러나 분노발작의 심각도, 빈도, 만성화 정도는 적대적 반항장애에서보다 파괴적 기분조절부전장애에서 더 심하다. 따라서 적대적 반항장애의 진단기준을 충족하는 증상을 가진 아동 및 청소년 중 일부는 파괴적 기분조절 부전장애로도 진단할 수 있다. 기분장애가 파괴적 기분조절부전장애의 진단기준을 충분히 충족할 때는 증상이 적대적 반항장애의 진단기준을 모두 충족한다 하더라도 적대적 반항장애라고 진단 내리지 않는다.

간헐적 폭발장애	간헐적 폭발장애는 강한 분노와 관련되어 있다. 간헐적 폭발장애에서는 타인을 향한 심한 공격성 을 보이지만, 이는 적대적 반항장애의 정의에 포함되지 않는다.
지적 장애 (지적발달장애)	반항적으로 지시에 따르지 못할 수 있지만, 지적 능력에 비해 반항의 빈도, 강도, 정도가 현저하게 보이는 경우에만 적대적 반항장애 진단을 내릴 수 있다.
언어장애	적대적 반항장애 진단 시에는 언어적 이해력의 손상으로 지시를 따르기 어려운 경우를 배제
사회불안장애 (사회공포증)	적대적 반항장애는 사회불안장애에서 보이는 부정적 평가에 대한 두려움으로 인해 유발되는 반항과는 구별되어야 한다.
자폐스펙트럼 장애	언어적, 비언어적 소통방식이나 상호작용에 이상이 있고, 행동이나 관심사에 제한과 집착, 반복되는 행동 등의 자폐 스펙트럼 장애 특유의 증상으로 감별한다.

8. 진단-치료에서의 면담자세

- 치료적 동맹 : 환자 및 가족 각각.
 - 부모와 환자 사이 갈등 있는 경우, 치료자가 한쪽 편을 드는 인상을 주면 평가와 치료과정에 저항을 하게 됨.
- 비판하지 않는 중립적 태도
 - 잘못된 행동 인정하지 않기, 비난을 받는 듯이 느끼면 면담에 협조하지 않고 방어적이고 논쟁적인 자세를 취할 수 있음. 잘잘못 따지지 않고 환자 입장에서 느끼는 부정적 감정에 공감하며 접근.
 - 부모 양육 방식에 대해서도 사실 그대로 받아들이는 자세, 환자와 살며 느끼는 좌절, 분노감에 공감, 동맹 맺기
- 문제행동 뿐 아니라 강점, 자원, 지지적 인물, 환경적 특성(리소스) 탐색
- 아동과 보호자는 따로 면담하는 것이 바람직함
 - 보호자가 보고하는 내용이 아동을 비난하는 양상이 되어 아동이 상처를 받거나 흥분 할 수 있음.
- 아동이 부모의 지시를 따르지 않거나 못하는 이유 파악하기
 - 고의성 뿐 아니라 충동성, 부주의함, 청력이상, 언어 이해력 부족 등 다른 이유 일 수 있음.

- 학령전기, 청소년기에 주로 문제가 나타나므로, 진단 내리기 전에 정상 발달 수준에서 벗어나는 적대적 반항적 행동의 빈도와 강도를 평가

9. 치료

부모 교육	■ 양육기술훈련을 교육 ■ 일관성 있게 대할 수 있도록. <i>일관적이지 않으면 아이들이 혼란을 느끼기 때문</i> <i>화를 내고 반항하는 아이들도 스스로 불안해할 수 있으므로 컨트롤을 바랄 수 있으므로 일정한 틀을 가지고 아이를 통제해야 한다.</i> ■ 부모가 변해야 아이가 변한다. ■ 아이에게 유연성과 융통성, 좌절을 견디는 힘, 충동 억제능력을 길러줘야 한다.
약물 치료	■ 약물치료가 효과적인 경우 : 충동적, 공격적 행동으로 자신과 타인에게 위험한 경우. ■ 주의력 집중이 되지 않아 치료에 협조하기가 어려운 경우. ■ 우울 장애 등 다른 정신장애가 동반되는 경우. ■ 약물의 종류 - 기분 안정제(극심한 공격적 및 품행장애 행동 치료에 사용.) - 리튬, 카마제핀 : 기분이 들뜨고 흥분상태, 과대사고 등을 나타내는 조증에서 보이는 심각한 공격성과 충동성 치료에 사용 - 중추신경 자극제 : 거짓말, 과다요구, 불복종, 충동적 행동의 호전 <i>한의학적으로 억간산을 줄 수 있다.</i>

10. 동반질환

- ADHD가 있는 아동 청소년 및 성인 집단에서 모두 적대적 반항장애의 비율이 상당히 높는데 이는 아마도 기질적 위험 요인을 공유. 예후가 더 나쁨.
- 또한, 적대적 반항 장애는 종종 품행 장애를 보이기 이전에 발생하는데 이러한 경향성은 주로 아동기 발병 아형에서 가장 흔하게 나타남
- 적대적 반항장애를 가진 사람들은 불안장애나 주요 우울장애를 보일 위험도 높음 = 주로 분노, 과민한 기분 증상 때문
- 언어장애 학습장애는 적대적 반항장애의 전구증상이 되거나 동반 위험이 높음.

11. 경과 및 예후

- 전형적으로 6세 전후 발병, 상당기간 지속
- 조기 발병, 증세 심한 경우品行장애로 이행될 위험성이 높고 예후가 나쁨.
- 조기에 발병한 ADHD와 적대적 반항장애가 공존하는 경우品行장애로 이행할 위험이 더 높아지고 더 심각한 양상을 보임.
- 2/3은 3년이 지나면 적대적 반항장애를 벗어남.

Case

- 7세 아동이 화를 잘 낸다는 이유로 부모와 함께 진료실에 내원.
- 아동은 양치질, 숙제하기 등에 대해 어머니가 내리는 일상적인 지시에도 '내가 왜 해야 하느냐고 따지고 대들면서 말을 듣지 않았음.
- 학교에서 옆에 앉은 또래가 놀다가 실수로 아동의 발을 살짝 밟았는데 심하게 화를 내고 '내 발을 밟았으니 너도 당해 보라며 하루 종일 그 또래 아이를 따라다니며 괴롭혔다. 아동은 자신의 기분이나 행동에 대해 어머니나 또래 아이 탓을 하면서 자신은 아무 잘못이 없다고 하였다.
- 아동의 이런 기분과 행동들은 1년 전부터 거의 매일 반복되었다. 아동의 이런 증세 때문에 어머니는 아동의 양육을 매우 힘들어했고 학교에서 또래와 관계가 나빠 학교 생활에 어려움이 많았다.

2절. 간헐적 폭발장애

= 분노조절 장애

Q. 화가 날 때 매우 과격해지는 경우가 많은가?

정신과적 분노 장애 종류

간헐적 폭발장애	언어적 공격이나 상해를 입히지 않는 신체 공격이 3개월간 1주일에 2회 이상 발생하거나 폭발적 행동이 12개월간 3회 보이는 경우. 6세 이상.
양극성 장애	비정상적으로 들뜨거나 과민한 기분이 1주일간 거의 매일 지속. 목표를 이루기 위한 행동이 방해받으면 분노로 이어짐.
경계성 성격장애	실제 또는 상상 속에서 <u>버림받지 않기</u> 위해 미친 듯이 노력함. 현저한 기분 반응으로 불안이 수시간~수일 계속. 분노 대상은 주로 애인이나 배우자. <i>경계성 성격 장애의 경우 버림받는 거에 대한 두려움이 죽음에 대한 두려움과 맞먹는다.</i>
적대적 반항장애	분노와 과민한 기분, 보복이 6개월 이상 지속. 형제나 자매가 아닌 한 명 이상 다른 사람에게 자주 분노하고 반항적 행동을 함.
파괴적 기분조절부전장애	폭언이나 공격행위가 자극에 비해 강도와 지속 시간이 극도로 비정상적. 분노 발작이 1주일에 3회 이상. 대부분 시간 동안 화가 나 있는 상황.

1. DSM-5 간헐적 폭발 장애 진단기준

A. 공격적인 충동을 통제하지 못해서 보이는 반복적인 행동 폭발로, 다음의 항목 중 하나를 특징적으로 보인다.

1. 언어적 공격성(ex. 분노발작, 장황한 비난, 논쟁이나 언어적 다툼) 또는 재산, 동물, 타인에게 가하는 신체적 공격성이 3개월 동안 평균적으로 일주일에 2회 이상 발생함. 신체적 공격성은 재산 피해나 재산파괴를 초래하지 않으며, 동물이 나 다른 사람에게 상해를 입히지 않음.

2. 재산 피해나 파괴 그리고 / 또는 동물이나 다른 사람에게 상해를 입힐 수 있는 신체적 폭행을 포함하는 폭발적 행동을 12개월 이내에 3회 보임.

B. 반복적인 행동 폭발 동안 표현된 공격성의 정도는 정신 사회적 스트레스 요인에 의해 촉발되거나 유발되는 정도를 심하게 넘어선 것이다.

C. 반복적인 공격적 행동폭발은 미리 계획된 것이 아니며(ex. 충동적이거나 분노로 유발된 행동), 유형적인 대상에만 한정된 것이 아니다(ex. 돈, 권력, 친밀함).

D. 반복적인 공격적 행동폭발은 개인에게 현저한 심리적 고통을 유발하거나 직업적 또는 대인관계 기능에 손상을 주거나 경제적 또는 법적 문제와 관련된다.

E. 생활 연령은 적어도 6세 이상이다. (또는 6세에 상응하는 발달 단계 수준)

F. 반복적인 공격적 행동폭발이 다른 정신 질환으로 더 잘 설명되지 않으며(예. 주요 우울장애, 양극성 장애, 파괴적 기분조절부전장애, 정신병적 장애, 반사회성 성격장애, 경계성 성격장애), 다른 의학적 상태(ex. 두부외상, 알츠하이머병)나 물질(ex. 남용 약물, 치료 약물)의 생리적 효과로 인한 것이 아니다. 6~18세 아동의 경우 적응 장애로 보이는 공격적 행동을 이 진단으로 고려해서는 안 된다.

2. 진단 특징 Diagnostic Features ★

■ 통제할 수 없는 분노 폭발(공격적 발작)을 보이는 시기가 있는데, 그 결과로 다른 사람이 다치거나 기물이 파괴된다. 공격성이 선을 넘어버리고 이해할 수 없을 정도로 심하다.

- 주로 가까운 주변 사람들의 사소한 자극에 의해 폭발적 행동.
- **충동적이거나 분노에 기반을 둔 것이어서 갑작스럽게 나타나므로 전구기가 없다.**
- 보통 30분 이내로 종결되며 스스로 진정.
- 폭발성 행동을 하기 전에 심한 긴장상태를 경험. 공격적으로 행동 이후에는 긴장감이 풀리며 안도감. 행동을 몹시 후회, 당황.
- 자신의 폭발성 행동에 대해 합당한 이유를 대지 못함.
- 이러한 행동으로 인해 친구나 동료로부터 배척, 적응의 실패, 대인관계 문제, 직업상실, 이혼, 법적인 문제 등이 초래됨.

Case 1

- 46세 배관공 P씨. 3년 전 결혼해 비교적 행복한 결혼생활. 나이 차이가 14살 나는 부인. 가끔 부부싸움을 했는데 최근 들어 p씨가 성질이 폭발하는 날이 잦아짐. 한번은 완전히 자제력을 잃고 소리를 지르며 옷장문을 부순 적이 있었다.
- 부인이 늦게 들어오거나 하면 폭발하며 화장대 유리를 부순 적도 있다. 며칠 전에는 부인의 화장을 보고 P씨는 심한 긴장감을 느끼며 치밀어 오는 공격적 충동을 자제하지 못하고 폭발했다. 집안의 물건이 하나둘씩 부서짐. 부인이 말리려했지만 소용이 없다.
- 짧은 시간 동안의 폭발적 행동이 끝나면, p씨는 자신의 행동을 기억했고, 자책과 후회를 하고 부인한테 그렇지 않겠다고 빌었다. 어떤 약물도 복용하지 않았으며 특별한 의학적 문제x

Case 2

- 27세 남자 A는 군복무를 마치고 대기업에 올해 입사를 하였다. 대학을 다닐 때도 기업이나 국가에서 공모한 프로젝트에 참여하여 상금으로 학비를 스스로 해결하기도 하였다. 직장에서도 기획 능력이 뛰어나 인정을 많이 받고 있다.
- A는 일상적인 업무를 볼 때는 사람들에게 친절하고 자신의 의견도 잘 이야기 하지만 상사나 동료로부터 자신의 의견과 다른 의견을 들으면 참지 못하고 심하게 언쟁을 하며 상대를 비난하기도 하고, 자신의 머리카락을 손으로 쥐어 뜯으며 '악'하는 소리를 크게 지르기도 한다. 그래도 화가 풀리지 않으면 책상에 있는 물건을 바닥에 던지기도 한다. 심하게 흥분하다가도 약 15분이 지나면 차분해져서 스스로 상대방에게 찾아가서 정중하게 사과하고 다시 차분하고 밝은 모습으로 사람들을 대한다.

- 입사 후 지속적으로 1주일에 2-3번 이상 사소한 일로 다른 사람들과 마찰이 있게 되면서 주변 사람들도 A를 점차 멀리하게 되었다. 처음에는 같은 신입 사원들 사이에서만 화를 심하게 내는 양상이었으나 최근 2개월 전부터는 상사에 게도 자주 심한 분노를 표현하기도 하여 징계를 받기도 하였다. 여러 차례 징계 후에도 스스로 조절하지 못하는 모습이 자주 보여 최근 입사 6개월만에 사직을 권유 받았다.

3. 유병률

- 미국에서 간헐적으로 폭발장애의 1년 유병률은 약 2.7%다. (협회의 정의)
- 간헐적 폭발장애는 50세 이상의 장년층에 비해 35~40세 이하의 사람들에서 더 흔히 보이며, 고등학교 교육 이하의 교육수준이 많다.
- 남자가 여자보다 더 어린 나이에 발병, 남자가 여자보다 1.4-2.3배 많음

4. 진단을 뒷받침하는 연관 특징

- 기분장애(단극성), 불안장애 그리고 물질사용장애가 간헐적 폭발장애와 관련이 있다. 그러나 전형적으로는 간헐적 폭발장애가 발병한 이후에 기분장애(단극성), 불안장애 및 물질 사용 장애가 발병한다.

5. 발달과 과정

- 반복적이고 충동적이며 문제가 되는 공격행동은 대개 아동기 후반이나 청소년기에 시작되며, 40세 이상의 사람들에게서 처음 나타나는 경우는 드물다. 간헐적 폭발장애의 핵심 특성은 전형적으로 이 장애가 수년에 걸쳐 지속된다는 점이다.
- 환자의 93%는 우울, 43%는 불안을 함께 나타내는 경향. (부정적 감정을 참는 것과 관련된 스트레스 관리 기술에 결함이 있기 때문)
- 간헐적 폭발장애의 경과에서 충동적인 공격적 행동폭발이 반복되는 삽화로 나타날 수 있다. 이 장애는 수년에 걸쳐 만성적이고 지속적인 경과로 나타난다. 또한 이 장애는 주의력 결핍 과잉행동장애, 파괴적이고 충동적인 품행장애 (ex. 품행장애, 적대적 반항장애)의 존재 여부와 관계없이 상당히 흔히 발생한다.

6. 위험요인과 예후

- 환경적 생애 초기 20년 동안 신체적, 정신적 외상을 경험한 사람들은 간헐적 폭발장애를 보일 위험성이 증가되어 있다.
- 유전적, 생리적 일차 친족에게 간헐적 폭발장애가 있는 경우 이 장애를 보일 위험이 높다. 쌍생아 연구에서도 충동적인 공격성에 미치는 유전적 요인이 상당히 큰 것으로 밝혀졌다. 신경생리학적 관점에서 간헐적 폭발장애는 세로토닌 이상과 관련된다. 또한, 전반적으로 볼 때 뇌 영역에서 특히 변연계(전대상 회로)와 안와전두피질 부분의 이상과 관련된다.
- 분노 자극에 대한 편도체의 반응을 기능자기공명영상(MRI)으로 본 결과, 건강한 사람들에 비해 간헐적 폭발 장애가 있는 사람들에게서 분노 자극에 대한 편도체의 반응이 더 크게 나타났다.

편도체: 분노 자극에 대한 반응이 나타나는 화재경보기 같은 것

7. 기능적 결과

- 간헐적 폭발장애의 결과로 흔히 사회적(ex. 친구 및 친척의 상실, 불안정한 결혼), 직업적(ex. 좌천, 실직), 재정적(ex. 기물 파손), 법적 문제(타인이나 소유물에 대한 공격적 행동의 결과로 인한 민사소송, 폭행으로 인한 형사고발)가 발생한다.

8. 감별진단

파괴적 기분조절부전장애 ★	■ 간헐적 폭발장애와 대조적으로 파괴적 기분조절부전장애는 충동적인 공격적 행동폭발 사이에 거의 매일 부정적 기분 상태(즉, 과민성, 분노)를 지속적으로 보인다는 점이 특징적이다. ■ 반복적이고 충동적이며 문제가 되는 공격적 행동폭발의 발병이 10세 이전일 때만 파괴적 기분조절 장애가 진단될 수 있다. ■ 즉 18세 이후 처음 발병하는 경우에는 파괴적 기분조절 부전장애 진단이 내려질 수 없다. 달리 말하면, 이들 두 장애는 상호 배타적이다.
반사회성 성격장애 또는 경계성 성격 장애	■ 반사회성 성격장애나 경계성 성격장애가 있는 사람들도 반복적이고 충동적이며 문제가 되는 공격성 행동폭발을 자주 보인다. 그러나 반사회성 성격장애나 경계성 성격장애에서 보이는 충동적인 공격성 수준은 간헐적 폭발 장애가 있는 사람의 충동적인 공격성 수준보다 낮다.

섬망, 주요 신경인지장애 및 다른 의학적 상태로 인한 성격변화, 공격형	■ 공격적 행동폭발이 다른 의학적 상태(ex. 공격적 행동폭발을 특징으로 하는 성격변화와 관련 있는 뇌 손상, 복하부분 뇌전증)이 생리적 효과에 의한 것이라면 간헐적 폭발 장애로 진단하지 않는다. ■ 신경학적 검사에서 비특이적 이상 (ex. 가벼운 징후)과 EEG(= 뇌파도)에서의 비특이적인 변화가 간헐적 폭발 장애에서도 나타날 수 있다. 그러나 충동적인 공격적 행동폭발이 의학적 상태로 더 잘 설명되지 않는 경우에만 간헐적 폭발장애 진단을 내릴 수 있다.
물질 중독 또는 물질 금단	■ 충동적인 공격적 행동폭발이 거의 항상 물질(ex. 알코올, 펜시클리딘, 코카인 및 기타 자극제, 바비투레이트, 흡입제)로 인한 중독이나 금단 증상과 관련이 있는 경우에는 간헐적 폭발 장애로 진단하지 않는다. ■ 그러나 <u>물질 중독이 금단 기간 이외에도</u> 충동적인 공격적 행동 폭발이 충분히 많이 발생하고, 그러한 행동에 대해 독립적으로 임상주의 주의가 요구될 때에는 간헐적 폭발장애로 진단을 내릴 수 있다.
주의력결핍 과잉행동장애, 品行장애, 적대적 반항장애 또는 자폐스펙트럼장애	■ 아동기에 발병하는 장애들 중에서 어느 한 가지 장애를 가진 사람에게서도 충동적인 공격적 행동폭발이 관찰될 수 있다. ■ ADHD가 있는 사람은 전형적으로 충동적이므로 충동적인 공격적 행동폭발을 보일 수 있다. ■品行장애가 있는 사람들도 충동적인 공격적 행동폭발을 보이는데, 진단 기준에 의하면 그러한 공격성의 형태가 치밀하고 약탈적이다. ■ 적대적 반항장애에서 보이는 공격성은 분노 발작과 권한 촉발 자극에 대한 반응이라는 점이 특징적이다. ■ 간헐적 폭발 장애의 진단기준 A~E를 모두 충족하는 사람과 비교했을 때 앞의 장애들 중 하나 이상의 과거력이 있는 사람들에게서 충동적인 공격성 수준이 더 낮게 보고된다. 따라서 진단기준 A~E까지를 모두 충족하고 충동적인 공격적 행동 폭발에 대해 독립적으로 임상주의 주의가 요구된다면 간헐적 폭발장애를 진단내릴 수 있다.

9. 동반질환

- 우울장애 불안장애 및 물질 사용 장애에는 간헐적 폭발장애가 함께 보이는 경우가 흔하다.
- 또한, 반사회성 성격장애나 경계성 성격장애 및 파괴적 행동을 수반하는 장애(ex. ADHD,品行장애, 적대적 반항 장애의 과거력이 있는 사람들의 경우에는 간헐적 폭발 장애가 동반 이환될 위험이 더 크다.

10. 치료

- 인지행동 치료
- 정신치료: 집단치료, 가족치료
치료의 목표: 충동적인 분노 폭발을 하기 전에 자신의 감정이나 생각을 인식하고 말로 표현하게 하는 것
- 약물 치료 : 리튬, 항경련제 등(공격적 행동을 줄인다고 보고)

3절.品行장애 Conduct Disorder

1. DSM-5品行장애의 진단기준

- 品行장애: 다른 사람의 기본적인 권리를 침해하고 연령에 적절한 사회적 규범 및 규칙을 위반하는 지속적이고 반복적인 행동 양상. *뉴스에 나오는 비행청소년*

A. **지난 12개월 동안 다음의 15개 중 적어도 3개 이상에 해당. 지난 6개월 동안 적어도 한 개 이상의 기준에 해당.**

사람과 동물에 대한 공격성	1. 자주 다른 사람을 괴롭히거나, 위협하거나, 협박함. 2. 자주 신체적인 싸움을 감. 3. 다른 사람에게 심각한 신체적 손상을 입힐 수 있는 무기 사용(ex. 방망이, 벽돌, 깨진 병, 칼, 총) 4. 다른 사람에게 신체적으로 잔인하게 대함. 5. 동물에게 신체적으로 잔인하게 대함. 6. 피해자가 보는 앞에서 도둑질을 함. (ex. 노상강도, 소매치기, 강탈, 무장강도) 7. 다른 사람에게 성적 활동을 강요함
재산 파괴	8. 심각한 손상을 입히려는 의도로 고의적으로 불을 지름. 9. 다른 사람의 재산을 고의적으로 파괴함. (방화로 인한 것은 제외)
사기 또는 절도	10. 다른 사람의 집, 건물 또는 자동차를 망가뜨림. 11. 어떤 물건을 얻거나 환심을 사기 위해 거짓말을 자주 함. (즉, 타인을 속임) 12. 피해자와 대면하지 않은 상황에서 귀중품을 훔침. (부수거나 침입하지 않고 상점에서 물건 훔치기, 문서 위조)
심각한 규칙 위반	13. 부모의 제지에도 불구하고 13세 이전부터 자주 밤늦게 까지 집에 들어오지 않음. 14. 친부모 또는 양부모와 같이 사는 동안 밤에 적어도 2회 이상 가출, 또는 장기간 귀가하지 않은 가출이 1회 있음. 15. 13세 이전에 무단결석을 자주 함.

B. 행동장애가 사회적, 학업적 또는 직업적 기능영역에서 임상적으로 현저한 손상을 초래한다.

C. 18세 이상일 경우, 반사회성 성격장애의 기준에 부합되지 않는다.

- 다음 중 하나를 명시할 것

- 312.82(F91.2) 아동기 발병형: 10세 이전에 적어도 한가지 증상을 보이는 경우
- 312.89(F91.2) 청소년기 발병형: 10세 이전에는品行 장애의 특징적인 증상을 전혀 충족하지 않는 경우다.
- 312.89(F91.9) 명시되지 않는 발병:品行 장애의 진단기준을 충족하지만, 첫 증상을 10세 이전에 보였는지 또는 10세 이후에 보였는지에 대한 정보가 없어서 확실히 결정하기 어려운 경우다.

- **친사회적인 정서 결함의 동반 여부를 확인할 것 ★**

친사회적 정서결함

: 다양한 대인관계나 사회적 상황에서

(1) 후회나 죄책감 결여 (2) 냉담(공감의 결여) (3) 수행에 대한 무관심 (4) 피상적이거나 결여된 정서

냉담: 나의 행동이 다른 사람에게 미치는 영향보다, 나에게 미치는 영향에 더 관심.

수행에 대한 무관심: 학교 성적 등에 관심이 없고, 성적이 잘 안오더라도 남 탓 함.

- 4가지 중 2가지 이상이 지난 12개월 이상 지속적으로 나타나는 경우

→ 친사회적 정서결함 동반여부를 위해서는 주변인들의 정보가 필수

- ✓ 친사회적인 정서란? 인간과 인간으로서 친하다는 사회성을 동반한 정서. 그러려면 자신이 잘못된 행동에 대해서는 후회할 수 있어야 하며, 공감을 할 수 있어야 한다.

- 현재의 심각도를 명시할 것

- 정도: 진단을 충족하는品行의 문제가 있더라도,品行 문제의 수가 적고, 다른 사람에게 가벼운 해를 끼치는 경우(예. 거짓말, 무단결석, 허락 없이 밤늦게까지 집에 들어가지 않는 것, 기타 규칙 위반)이다.

- 중등도: 품행 문제의 수와 다른 사람에게 끼치는 영향의 정도가 '경도'와 '고도'의 중간에 해당되는 경우(예. 피해자와 대면하지 않는 상황에서 도둑질하기, 공공기물 파손)다.
- 고도: 진단을 충족하는 품행 문제가 많거나, 또는 다른 사람에게 심각한 해를 끼치는 경우(예. 성적 강요, 신체적 잔인함, 무기 사용, 피해자가 보는 앞에서 도둑질, 파괴와 침입)다.

2. 유병률

- 품행장애는 시골보다는 도시. 반사회성 성격장애나 알코올 의존의 부모. 사회경제적 수준이 낮은 계층에서보다 높게 발생
- 대략 전체 아동인구의 3~10%, 18세 이하 남성의 6~16%, 여성의 2~9%. 남성이 여성보다 3~10배 더 많음

3. 진단 특징 Diagnostic Features

- 10세 이전 발병(아동기 발병형) / 10세 이후(청소년기 발병형) / 불특정형
- 부모, 법규, 규칙, 다른 사람의 권리 또는 감정에 거의 또는 전혀 존경을 표하지 않는다.
- 나쁜 행실은 거짓말부터 무기 사용까지 다양함.
- **죄책감이나 후회가 없고** 항상 '다른 사람의 탓'으로 돌림.
- 약자를 괴롭히고, 친구들과 싸우거나, 이유 없이 학교를 결석하고, 흡연, 음주 및 약물 남용, 공공기물 파괴, 시가와 절도. 비행을 일삼는 문제아.

4. 진단을 뒷받침하는 부수적 특징

- 품행장애가 있는 공격적인 사람들은 특히 모호한 상황에서 타인의 의도를 실제보다 좀 더 **적대적이고 위협적**이라고 잘못 해석하는 일이 빈번하기 때문에 자신의 공격적인 반응이 합리적이고 정당하다고 생각한다.
- 좌절에 대한 낮은 인내력, 과민성, 분노 발작, 의심, 처벌에 대한 둔감성, 자극 추구, 무모함을 포함하는 부정적 감정성과 자기조절의 어려움과 같은 성격 특질이 품행장애에서 흔히 동반된다.
- 특히 여자 청소년의 경우에는 **물질 오용**이 이 장애와 관련이 있는 경우가 더 흔하다.

- 품행장애가 있는 사람들의 자살 사고, 자살 시도 및 완수율은 예상 수치보다 더 높다.

5. 발달과 과정

- 품행장애는 보통 중기 아동기에서 중기 청소년기 사이에 처음으로 증상이 현저하게 드러난다.
- 16세 이후 발병하는 경우는 드물다. 대략 남자는 10~12세, 여자는 14~16세에 시작.
- 많은 경우 가벼운 정도의 품행장애는 성인기에 이르면 완화. 품행장애로 진단된 아이들의 **1/3은 성인이 되어 반사회성 성격장애**의 진단기준을 충족.
- 품행장애의 1/3은 읽기장애, 지능수준 (특히, 언어 영역)이 낮다. 불안, 우울증을 함께 나타내는 경우가 많다.
- 품행장애가 있는 아동 및 청소년은 이후 성인이 되었을 때 기분장애, 불안장애, 외상후 스트레스 장애, 충동조절 장애, 정신병적 장애, 신체증상 장애 그리고 물질관련 장애를 보일 위험이 높다.
- 품행장애가 있는 사람이 성인이 되었을 때 공격성, 재산 파괴, 사기, 규칙 위반 등을 계속 보이고 동료 그리고 아이들을 대상으로 폭력을 행사하는 일이 직장이나 가정에서 관찰되는 경우에는 반사회적 성격장애를 고려할 수 있다.

6. 위험요인과 예후

기질적	■ 까다롭고 통제하기 어려운 유아 기질, 보통 수준 이하의 인지 기능, 특히 <u>언어성 IQ</u>의 저하가 기질적 위험 요인에 포함된다. 유전적 취약성.
환경적	■ 가족 수준에서의 위험 요인에는 부모의 거부와 방임, 비밀관적 양육 방식, 엄격한 훈육, 신체적 또는 성적 학대, 감독의 부족, 초기에 보육시설에 거주한 경우, 보호자가 자주 바뀌는 경우, 대가족, 부모의 범죄, 가족 내 특정 정신 병리(ex. 물질관련장애)가 포함된다. ■ 지역사회 수준에서의 위험 요인에는 또래의 거부, 비행집단에 연루된 경우, 이웃의 폭력에 노출된 경우가 포함된다. 이 2가지 위험요인은 모두 아동기 발병형에서 더욱 심각하고 흔한 경향이 있다.

유전적, 생리적	- 유전 및 환경적 요인이 모두 품행장애에 영향을 준다. 친부모나 양부모 또는 형제자매에서 품행장애가 있는 아동의 경우에 품행 장애 발병위험이 증가한다. - 친부모가 심한 알코올 사용장애, 우울장애나 양극성 장애, 조현병이 있거나 친부모 이전에 ADHD나 품행장애 과거력이 있었던 아동의 경우 이 장애의 발병이 더 흔한 경향이 있다. - 품행 장애가 없는 사람들과 비교해서, 정서 조절이나 정서 처리와 관련된 뇌 영역, 특히 뇌의 복측전전두피질과 편도체를 포함하는 전두측두엽-변연계 회로에서 구조적이고 기능적인 차이가 있다는 것이 품행장애가 있는 사람들에게서 일관되게 언급되고 있다. 그러나 뇌영상 결과들이 이 장애의 진단적인 지표가 되지는 않는다.
경과의 변경인자	아동기 발병형이나 “제한된 친사회적 정서” 명시자에 해당된 사람에게서 품행장애가 더 오래 지속되는 경향이 있다. 또한 품행장애의 위험성이 지속된다면 물질 남용이나 ADHD의 동반 이환도 증가한다.

7. 기능적 결과

- 품행장애는 정학이나 퇴학, 직장 적응 문제, 법적인 문제, 성적으로 전염되는 질환, 계획하지 않은 임신, 사고나 싸움으로 인한 상해 등을 야기할 수 있다. 이런 문제로 인한 정상적인 학교생활 및 가정생활을 지속하기 어렵다.
- 품행장애는 종종 이른 시기의 성적 행동, 음주, 흡연, 불법적인 물질 사용 및 무모하고 위험한 행동의 발생과 관련이 있다. 품행장애가 없는 사람에 비해 장애가 있는 사람들에게서 사고도 더 높게 발생한다. 품행장애는 아동 정신건강 시설에서 특히 법의학적 실제에서 아동의 치료를 위해 흔히 의뢰되고 진단되는 사유가 된다.

8. 감별진단

적대적 반항장애	품행장애와 적대적 반항장애는 모두 성인이나 권위자와의 갈등을 초래하는 품행 문제와 관련이 있다. 적대적 반항장애의 행동은 품행장애의 행동에 비해 덜 심각하고, 전형적으로 사람이나 동물에
----------	---

	대한 공격, 재산 파괴, 절도 또는 사기 행동을 포함하지 않는다. 아울러 적대적 반항장애는 정서 조절의 문제(ex. 분노, 과민한 기분)를 포함하는데, 이는 품행장애의 정의에는 해당되지 않는다. 적대적 반항장애와 품행장애의 진단기준을 모두 충족하는 경우에는 두 진단을 모두 내릴 수 있다.
주의력 결핍 과잉행동 장애	ADHD가 있는 아동들도 파괴적일 수 있는 과잉행동 및 충동적 행동을 보일 수 있지만, <u>그러한 행동 자체가 사회적 규준을 위반하거나 타인의 권리를 침해하지 않기 때문에</u> 진단기준을 충족하지 않는다. ADHD와 품행장애의 진단 기준을 모두 충족하는 경우에는 두 진단을 모두 내릴 수 있다.
우울 및 양극성 장애	- 과민성, 공격성, 품행 문제는 주요 우울 장애나 양극성 장애 또는 파괴적 기분조절 부전 장애가 있는 아동이나 청소년에게서도 발생할 수 있다. - 기분장애에서 보이는 행동문제와 품행장애에서 보이는 품행 문제 패턴은 경과에 따라 구분할 수 있다. 구체적으로 보면, 품행장애가 있는 사람은 기분장애가 없는 기간 동안에도 상당한 수준의 공격적 또는 비공격적 품행 문제를 보인다. - 즉, 품행장애는 과거력상 기분장애가 발생하기 이전에 품행장애가 있었거나, 공존 상태인 경우에는 계획적인 품행 문제가 있고, 강렬한 정서적 각성상태 기간 동안 품행 문제가 발생하지 않는다. 품행장애와 기분장애의 진단기준을 모두 충족하는 경우에는 두 진단을 모두 내릴 수 있다.
간헐적 폭발 장애	- 간헐적 폭발장애는 <u>강한 분노와</u> 관련된다. 그러나 간헐적 폭발장애는 충동적인 공격성만 보이고, <u>계획적이지 않으며</u>, 어떤 것(ex. 돈, 권력, 위협)을 얻기 위한 방편으로 행동 문제를 저지르지는 않는다. - 또한 간헐적 폭발장애에서는 품행장애의 비공격적인 증상을 포함하지 않는다. 만약 이 두 장애의 진단기준을 모두 충족하는 경우에는 반복적이고 충동적인 행동폭발이 별도로 임상상의 주의가 요구되는 경우에 한해서만 간헐적 폭발장애를 진단할 수 있다.

적응 장애	- 다른 특정 장애의 진단기준을 충족하지 않는 임상적으로 현저한 품행문제가 정신사회적 스트레스 요인이 시작된 것과 명백히 관련이 있고, 이 스트레스 요인의 종결(또는 스트레스 요인의 결과)이 6개월 내에 해결되지 않았을 때, 적응장애(품행장애 동반 적응장애 또는 정서 및 품행장애 함께 동반 적응장애)의 진단을 고려해야 한다. - 품행장애는 사회적, 학업적, 또는 직업적 기능 영역과 손상과 관련이 있는 품행 문제가 반복적이고 지속적인 양상으로 나타날 때만 진단할 수 있다.
-------	--

9. 동반질환

- ADHD와 적대적 반항장애는 모두 품행장애를 가진 사람에게 흔하며, 이런 경우 예후는 더욱 나쁘다.
- 반사회성 성격장애와 관련된 성격 특징을 보이는 개인은 다른 사람의 기본 권리를 자주 침해하거나 연령에 적절한 사회적 규범을 위반하며, 이런 행동 양상은 품행장애의 진단 기준을 충족한다.
- 또한 품행장애는 다음의 정신질환 중 하나 이상과 공존할 수 있다. '특정학습장애, 불안장애, 우울 또는 양극성 장애 그리고 물질 관련 장애'
- 읽기나 다른 언어적 기술과 같은 학업 성취가 연령과 지능 수준에서 기대되는 것에 비해 종종 낮은 편이며 특정 학습장애나 의사소통 장애의 부가적인 진단이 타당할 수 있다.

#CASE

품행장애 딸을 가진 엄마의 인터뷰 질적연구 인터뷰

품행장애를 가진 딸을 바라볼 때 자신 때문에 딸이 그런 것 같고, 삶이 늘 롤러코스터를 타는 것처럼 불안하다. 딸이 사고치고, 가출하고, 도둑질하고, 결석 문제로 경찰서, 학교에서 전화가 온다. 엄마로서 잘하지 못한다는 두려움을 가지고 있다. 아이가 초등학교 3학년 때부터 많이 싸우고, 맞기도 하고 아빠의 외도, 이혼 등 가정 불화가 많았다. 스스로 아이를 포기할까봐 겁이 난다.

#아이를 키울 때 참고할 수 있는 시

다이아나 루먼스의 "만일 내가 다시 아이를 키운다면"

만일 내가 다시 아이를 키운다면 먼저 아이의 자존심을 세워주고 집은 나중에 세우리라.	만일 내가 다시 아이를 키운다면 더 많이 아는 데 관심 갖지 않고 더 많이 관심 갖는 법을 배우리라.
아이와 함께 손가락으로 그림을 더 많이 그리고 손가락으로 명령하는 일은 덜 하리라.	자전거도 더 많이 타고 연도 더 많이 날리리라 등산을 더 많이 뛰어나고 별들도 더 오래 바라보리라.
아이를 바로잡으려고 덜 노력하고 아이와 하나가 되려고 더 많이 노력하리라.	더 많이 께안고 더 적게 다투리라 도토리 속의 딱딱나무를 더 자주 보리라. 덜 단호하고 더 많이 긍정하리라
시계에서 눈을 떼고 눈으로 아이를 더 많이 바라보리라.	힘을 사랑하는 사람으로 보이지 않고 사랑의 힘을 가진 사람으로 보이리라.

4절. 방화광 Pyromania

1. 진단기준

- 진단기준 321.33(F63.1)

- 1회 이상의 **고의적이고 목적** 있는 방화가 존재한다.
- 방화 행위 전의 **긴장 또는 정서적 흥분**이 나타난다.
- 불에 대한 그리고 불과 연관된 상황적 맥락에 대한 **매혹, 흥미, 호기심 또는 매력** (ex. 방화용품, 그것의 사용, 방화 결과)을 가지고 있다.
- 불을 지르거나 불이 난 것을 목격하거나 참여할 때의 기쁨, **만족 또는 안도감**이 나타난다.
- 방화는 금전적 이득, 사회, 정치적 이념의 표현, 범죄행위 은폐, **분노나 복수심 표현**, 생활 환경 개선, 망상이나 환각에 대한 반응 또는 손상된 판단력의 결과(ex. 주요신경 인지장애, 지적장애(지적발달장애), 물질장애)에 **기인된 것이 아니다.**
방화광의 방화는 단순히 자신의 충동을 해소하기 위한 행동!
- 방화는 품행장애, 조증 삽화 또는 반사회성 성격장애로 더 잘 설명되지 않는다.

✓ 송혜문 방화

송혜문 방화범은 억울감의 표출로 불을 낸 것이기 때문에 방화광으로 보기 어렵다. 방화광은 화재 자체를 즐긴다.

2. 진단 특징

- 병적 방화의 필수 증상은 **고의적이고 목적이** 있는 수차례의 방화 삽화가 존재하는 것이다(진단기준 A).
- 이 장애가 있는 사람은 방화 전에 **긴장감이나 정서적인 흥분**을 경험한다(진단기준 B).
- 불에 대한 그리고 불과 연관되는 상황에 대한 **매혹, 흥미, 호기심 또는 매력**이 있다(ex. 방화용품, 그것의 사용, 방화 결과)(진단기준 C).
- 이 장애가 있는 사람은 이웃집에 불이 나면 언제나 “구경꾼”이고 때로는 가짜 경보를 누르기도 하고, 불과 관련 있는 시설, 용품, 그리고 소방관들을 보면 기쁨을 느낀다. 그들은 지역 소방서에서 시간을 보내기도 하고, 소방서와 관련을 맺기 위해 방화를 하기도 하며 심지어는 소방관이 되기도 한다.
- 이 장애가 있는 사람들은 불을 지르거나 그 효과를 목격하거나 참여할 때 기쁨과 만족감을 느끼고 긴장이 완화되는 것을 경험한다(진단기준 D).
- 병적 방화는 금전적 이득, 사회 정치적 이념을 표현, 범죄 행위 은폐, 분노나 복수심 표현, 생활환경 개선 망상이나 환각에 대한 반응, 또는 손상된 판단력의 결과(ex. 주요신경인지장애, 지적장애)에 기인된 것이 아니다.(진단기준 E)
- 방화가 품행장애, 조증삽화 또는 반사회성 성격장애로 더 잘 설명되는 경우에는 이 진단을 내리지 않는다(진단기준 F).
- **재발적이고 계획적인 방화, 방화 전의 긴장 또는 각성의 경험, 불에 대한 매료와 황홀, 방화와 그 여파로 인한 희열과 안도감을 경험하는 것.**

#CASE

- K씨는 불을 지르면 동네가 소란스러워지는 데서 묘한 쾌감을 느낌. 소방차는 요란하게 사이렌을 울려대고, 소방관들은 불을 끄느라 이리저리 뛰어다니고, 경찰관은 범인을 잡느라 분주하다.
- 자신이 한 일에 대해 사회가 떠들썩하게 반응하자 큰일이라도 한 것처럼 뿌듯해함. 이런 까닭으로 그는 잡힐 줄도 모르게 태연하게 불구경을 했다.
- 방화는 그가 사회에 대해 보여줄 수 있는 과시적 도구, 특정인의 재산을 해치려는 뜻은 없고 다만 사회의 태도를 변화시키는 것이 그의 목적

방화광들의 특징 (관련 인터뷰, 연구)

- 대다수의 방화범이 내성적이고 소극적이며 경제적 하류층이다. 남과 어울리지 못하고, 함께 문제를 풀지 못하는 사회적 장애가 있다. (방화범 55명을 인터뷰한 박형만 박사)
- 남다른 편집증(의심, 의부증이나 의처증, 누군가 자신을 공격할 것이라 생각, 피해의식)
- 분열적 장애성(타인과 관계 끊고 고독을 즐김, 혼자 해결, 방화전에 술을 마시기도 함)
- 방화는 어른의 자폐증 같은 것

3. 진단을 뒷받침하는 부수적 특징

- 병적 방화자는 방화를 하기 위해 **사전에 충분한 준비**를 한다. 그들은 방화로 인해 생명을 잃는 것이나 재산 손실에는 관심이 없고 재산을 파괴함으로써 만족감을 얻는다. 이러한 행동은 방화자나 타인에게 재산피해나 법적 문제를 일으키고 신체적 손상을 초래하며 생명을 잃게 되는 경우도 있다.
- **충동적으로** 방화를 저지르는 사람들(병적 방화가 있을 수도, 없을 수도 있다.)은 현재 또는 과거에 **알코올 사용장애**를 앓은 경우가 흔하다.

4. 감별진단 간단하게 언급하고 넘어감

- **기타이유로 인한 의도적 방화** : 병적 방화를 진단하기 전에 방화의 다른 원인을 진단에서 배제하는 것이 중요하다. 의도적인 방화는 이득, 방해 공작 또는 복수를 위해 보일 수도 있고, 범죄를 숨기기 위해, 정치적 성명을 위해(예. 테러나 저항행위), 또는 주의를 끌고 인정받기 위해(예. 눈에 띄기 위한, 도움을 받기 위한 방화) 저지를 수도 있다. 또한, 아동기에 발달적인 실험의 일환으로 나타날 수 있다. (예. 성냥이나 라이터, 불을 가지고 놀기)
- **기타정신질환** : 품행장애, 조증삽화 또는 반사회성 성격장애의 일부로, 또는 망상이나 환각에 대한 반응으로 (예. 조현병에서) 방화를 하거나, 다른 의학적 상태 (예. 뇌전증)의 생리적 효과에 기인된 것일 때는 병적 방화를 진단x 또한, 주요신경인지장애, 지적장애 또는 물질 중독과 연관된 판단력 손상으로 인한 방화도 병적 방화로 진단 내릴 수 없다.

5. 동반 이환

- 물질사용장애, 도박장애, 우울 및 양극성 장애, 다른 파괴적, 충동조절 및品行장애는 병적 방화와 높은 동반 이환을 보인다.

5절. 절도광 Kleptomania

1. 진단기준

- 진단기준 312.32(F63.2)
- A. 개인적인 용도로 쓸모가 없거나 금전적인 가치가 없는 물건을 훔치려는 충동을 저지하는데 반복적으로 실패한다.
- B. 훔치기 직전에 고조되는 긴장감이 나타난다.
- C. 훔쳤을 때 기쁨, 만족감 또는 안도감이 있다.
- D. 훔치는 행위를 분노나 복수를 표현하거나 망상이나 환각에 대한 반응으로 하는 것이 아니다.
- E. 훔치는 행위가品行 장애, 조증삽화 또는 반사회성 성격장애로 더 잘 설명되지 않는다.

2. 진단 요점

- 물건이 목적이 아니라 훔치는 행동이 목적
물건이 갖고 싶어서가 아님. 부자집 사모님이 절도광 있을 수도 있음.
- 병적 도벽의 필수 증상은 개인적인 용도로 쓸모가 없거나 금전적으로 가치가 없는 물건임에도 불구하고 훔치려는 충동을 저지하는데 반복적으로 실패하는 것이다. (진단기준 A).
- 개인은 훔치기 전에 주관적인 긴장감이 고조되는 것을 경험하고(진단기준 B), 훔친 후에는 기쁨, 만족감, 안도감을 느끼게 된다(진단기준 D).
이 때문에 반복적으로 절도를 하게 되고, 행동이 강화된다.
- 品行 장애, 조증삽화, 반사회성 성격장애에 의해 더 잘 설명되지 않는다(진단기준 E).
- 물건이 개인적으로 전혀 가치가 없고 충분히 지불할 능력이 있고, 심지어 훔치고 나서 남에게 주거나 버리면서도 훔친다. 훔친 물건을 모으거나 몰래 다시 돌려주는 경우도 간혹 있다.

- 이 장애가 있는 사람들은 즉시 체포될 위험이 있을 때는 훔치는 행위를 피하려고 하겠지만 보통 도둑질을 미리 계획하지 않고 체포위험에 대해서도 충분히 고려하지 않는다. 타인의 보조나 협력 없이 도둑질을 한다.

3. 진단을 뒷받침하는 부수적 특징

- 병적 도벽이 있는 사람들은 훔치고 싶은 충동을 억제하고자 하며, 이런 행동이 잘못되고 비상식적이라는 점을 인지하고 있다. 그들은 자주 체포될 것을 염려하며, 도둑질에 대해 우울해하거나 죄책감을 느낀다. 세로토닌, 도파민, 아편계를 포함한 중독 행동과 관련된 신경전달 물질경로가 병적 도벽과 관련된다.
잘못된 것을 인지하고 체포도 염려하지만, 막상 절도를 할 때는 충동을 절제하지 못해 즉흥적이게 된다.

4. 유병률

- 병적 도벽은 상점에서 물건을 훔치는 행위로 체포된 사람들 중 4~24%에서 나타난다. 일반 표본에서의 유병률은 약 0.3~0.6%로 매우 드물다. 남성에 비해 여성의 유병률이 높다. (남:여 = 1:3)

5. 발달과 과정

- 병적 도벽의 발병연령은 다양하게 보고 되고 있으나, 보통 청소년기에 시작된다.
- 이 장애는 아동기, 청소년기 또는 성인기에서 모두 시작될 수 있으나, 성인기 후기에 발생하는 경우는 드물다.
- 병적 도벽의 경과에 대한 체계적인 정보는 거의 없으나, 3개의 전형적인 경과가 기술되고 있다. (1) 산발적인 단기 삽화에 긴 관해기간, (2) 도벽기간이 긴 삽화와 관해기간, (3) 기복이 있는 만성적인 경우다.
- 상점에서 물건을 훔치는 행위로 인해 여러 번 유죄 판결을 받더라도 이 장애가 수년간 지속될 수 있다.

6. 감별진단

통상적인 도둑질	병적 도벽은 통상적 도둑질이나 상점에서 물건을 훔치는 것과는 구분되어야 한다. 통상적인 도둑질(충동적이거나 계획적인)은 계획적인 행위이고, 물건의 유용성이나 금전적인 가치에 의해 절도가 동기화된다. 일부 개인, 특히 청소년들의 경우 반항성의 일환으로 또는 통과의례로 과감하게 도둑질을 하는 경우가 있는데, 만일 병적 도벽의 다른 특징적인 양상이 없다면 이 진단은 내려지지 않는다. 상점에서 물건을 훔치는 것은 비교적 흔하지만 병적 도벽은 매우 드물다.
피병	형사고발을 피하기 위해 병적 도벽증상을 가장할 수 있다.
반사회성 성격장애와品行장애	반사회성 성격장애와品行장애는 반사회적 행동의 일반적인 양상에 의해 병적 도벽과 구분된다.
조증 삽화, 정신병적 삽화 및 주요신경인지장애	병적 도벽은 조증 삽화 동안 일어나거나, 망상이나 환각(ex. 조현병에서)에 대한 반응이나 주요 신경인지장애에 기인된 결과로 일어날 수 있는 의도적이거나 무심코 저지른 도둑질과는 구별되어야 한다. <i>절도량은 망상으로 인한 것이 아닌 훔치는 행동 자체에 목적이 있는 것!</i>

7. 동반이환

- 병적도벽은 충동 구매 뿐만 아니라 우울 및 양극성 장애(특히 주요우울 장애) 불안 장애 섭식장애(특히 신경성 폭식증), 성격장애, 물질사용장애(특히 알코올 사용장애) 그리고 다른 파괴적 충동조절 및品行장애와 관련될 수 있다.

6절. 병적 도박 (gambling disorder)

1. 특징

- 시간이 지날수록 도박에 거는 액수가 커짐(내성)+도박을 못하게 할 경우 우울, 불안, 안절부절 등(금단증상) → DSM-5 물질 관련 및 중독 장애
- 남자에게서 압도적. 유병률 4%
- 유발인자 : 15세 이전 부모의 사망, 별거 등으로 인한 부모의 상실, 부모로부터 부적절한 양육, 사춘기에 도박행위를 해볼 기회가 있었던 경우, 돈이나 물질에만 높은 가치관을 두는 가정적 분위기
- 병적 도박 : 직업적인 도박, 사교적인 도박, 조증삽화와 감별.
- 남자에서는 사춘기, 여자에서는 중년기에 흔히 시작

2. 진단 기준

DSM-5 진단기준 : 12개월 동안 4가지 이상

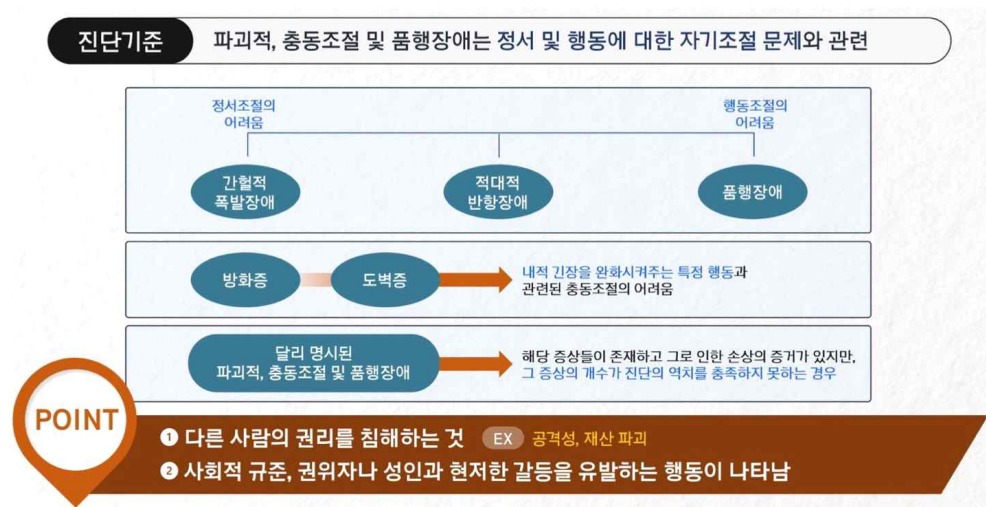
- 도박액수 증가: 도박을 하면서 원하는 흥분을 얻기 위해 사용하는 돈의 액수가 늘어납니까?
 - 도박을 중지하면 과민해짐: 도박을 줄이거나 중지하려고 할 때 안절부절 못하거나 과민해집니까?
 - 도박 중지하는데 실패함: 도박을 줄이거나 중지하려고 노력하는 데 반복적으로 실패합니까?
 - 도박에 집착함: 도박에 집착합니까?
 - 손실을 쫓아감: 돈을 잃고 난 후 다음 날 다시 도박을 합니까?
 - 거짓말을 함: 얼마나 도박을 많이 하는지 숨기기 위해 거짓말을 합니까?
 - 관계 상실: 도박 때문에 중요한 관계, 일자리, 또는 기회를 잃습니까?
 - 돈을 빌림: 도박으로 야기된 절망적인 경제 상태에서 벗어나기 위해 돈을 빌립니까?
- 경도 : 4-5개 / 중등도 : 6-7개 / 고도 : 8개 이상

7절. 발모광 (Trichotillomania)

#특징

- 자신의 머리 등의 털을 뽑는 충동을 억제하지 못하는 장애
- 강박적 집착과 반복행동이 주 증상 → **강박 및 관련장애에 포함**
- 비교적 여자에게 흔함
- 생물학적으로 세로토닌 장애, 복합적인 스트레스 환경과 관련
- 자신의 털을 뽑고싶은 충동에 대해 저항하지만, 결국 억제하지 못하는 상황의 반복
- 감별: 원형탈모, 남성형 탈모, 만성 원형 홍반성 루프스, 모공 편평태선, 모낭염, 가성원형 탈모, 점액성 탈모증, 망상이나 환각에 의한 발모

충동조절 장애 정리



- 파괴적, 충동조절 및 품행장애는 정서와 행동에 대한 자기조절에 문제가 있는 것
- 정서조절에 어려움이 있는 것은 간헐적 폭발장애
- 행동조절에 어려움이 있는 것은 품행장애
- 그 사이에서 정서조절과 행동조절의 어려움이 둘 다 있는 경우 적대적 반항장애
- 방화증과 도벽증은 내적 긴장을 완화시켜주는 행동과 관련된 충동조절이 어려움

[6] 정신신체의학

여기서부터 정말 낱립으로 수업하셨습니다(10분만에 다나감) 편하게 보세요~

- 정신신체의학(서양의학적 개념) = 심신증(한의학적 개념)
- 오장관련 증후 = 한의학적 치료 수단

[DSM-5 범주]

신체증상 및 관련장애

(Somatic Symptom and Related Disorder)

- 신체증상 장애(Somatic Symptom Disorder)
- 질병불안장애 (Illness Anxiety Disorder)
- 전환장애(Conversion Disorder)
- 기타 의학적 상태에 영향을 주는 심리적 요인
- 인위성 장애 (Factitious Disorder)
- 다리 명시된 신체증상 및 관련장애

1. 개요

- 정신신체장애 (Psychosomatic medicine)
- 정신(psyche)과 신체(soma)의 상호작용
- 1818년 Heinroth 불면증, 정신신체장애

심신일여

- 신체질병상태는 정신적 증상을 동반하여 나타날 수 있고, 한편 정신적 요인은 여러 신체장애의 유발요인으로 작용하거나 그 진행, 악화, 회복지연, 그리고 재발에 영향을 끼친다.

2. DSM-5 진단기준

/ 기타 의학적 상태에 영향을 주는 심리적 요인

A. 의학적 증상이나 상태(정신질환 외의)가 존재한다.

B. 심리적 혹은 행동적 요인이 다음과 같은 방식 중 하나로 의학적 상태에 악영향

을 준다.

1. 심리적 요인들과 의학적 상태의 발생, 악화 혹은 회복 지연과의 밀접한 시간적인 연관성을 볼 때, 요인들이 질병의 경과에 영향을 줌
 2. 요인들이 의학적 상태의 치료를 방해함(예, 나쁜 순응도)
 3. 요인들이 사람에게 확실히 알려진 추가적인 건강 상의 위험이 됨
 4. 요인들이 기저의 병태생리에 영향을 주고, 증상을 유발하거나 악화시키며, 혹은 의학적 관심을 필요하게 함
- C. 진단기준 B의 심리적이고 행동적 요인들이 다른 정신질환으로 더 잘 설명되지 않는다. (ex. 공황장애, 주요우울장애, 외상 후 스트레스 장애)

3. 정신신체장애의 개념

- 정신적 요소들이 적어도 부분적으로 기여하여 **신체 기능 또는 구조의 장애를 초래하는 경우**
- 신체증상장애와의 차이점 (명확히 구분되진 않음)
 - 1) 분명한 기질적 병리(예. 귀양성 장염) 또는 잘 알려진 병태생리 과정(예. 편두통)이 존재함.
 - 2) 신체적 증상으로 인한 일차적 이득이 없고 오히려 불안과 고통이 증가 됨
 - 3) 증상이 자율신경계의 지배를 받는 기관이나 내장 장기에 나타남
 - 4) 정신적 원인이 장애 발생에 부분적으로 기여하나, 내적 갈등 또는 정신적 욕구의 상징성은 드물게 나타남

4. 정신신체장애의 원인

1) 생물학적 요인

- 자율신경계, 내분비계, 면역계 등에서 스트레스 반응으로 카테콜아민, 스테로이드 호르몬, 기타 면역 물질들이 작용
- 스트레스와 신체기능 간의 관계

2) 정신적 요인

- 과거의 부정적 경험, 부정적 자아상, A형 성격, 갈등과 스트레스를 다루는 대응 전략 등이 관여

3) 사회문화적 요인

- 생활의 변화에 따른 스트레스 등

5. 스트레스 stress

- 스트레스원 Stressor에 의해 초래되어 항상성이 변화된 상태
- 반드시 나쁜 일만이 아니고 결혼이나 승진과 같이 좋은 일도 항상성에 부담을 준다.
- 부정적 생활사건과 관련된 스트레스 : 고통 distress
- 긍정적 생활사건과 관련된 스트레스 : 최적 스트레스 estress

5가지 스트레스요인

- 1) 급성 한시적 스트레스 (대중 앞 발표, 암산하기)
- 2) 짧은 자연적 스트레스 (시험-일상에서 단기간 도전적 상황)
- 3) 연속적 스트레스 사건 (배우자와 사별, 주요자연재해)
- 4) 만성 스트레스 (치매 배우자 돌보기, 신체장애를 동반한 외상 경험)
 - ✓ 끝나는 것이 명확하지 않은 것들
- 5) 장래 스트레스(어린 시절 학대 경험, 전쟁 시 동료의 죽음 목격!)

- 대뇌는 스트레스 요인을 지각하면 '각성' 하며, 그것이 생체에 위협적인지 평가한다.
- 이때 평가에 영향을 미치는 변수들은 신체적인 것(연령, 성별 등), 정신적인 것(성격, 기질, 기존 정신병리 등), 사회환경적인 것(사회적 지지 및 경제적 상태...) 등이 있다.

- 평가 결과에 따라 대응방법 (의식적 대응전략 및 무의식적 방어기제)들을 선택하게 된다. 선택된 대응방법에 따라 감정반응(불안, 우울, 분노 등)이 동반된다.
- 각성과 감정반응은 자율신경계, 내분비계, 면역계 등의 변화를 야기하여 장애가 발생
- 스트레스 사건에 대한 주관적 인식 : 생리적 스트레스 반응에 개인차가 존재
- 생체가 스트레스를 인지할 경우 교감신경계와 시상하부-뇌하수체-부신축을 활성화시켜 여러 반응을 유발한다.

6. 스트레스에 반응하는 2가지 주요 시스템

- 자율신경계와 HPA 축은 뇌의 변연계, 전두엽피질, 편도체, 시상하부 등에 의해 조절

1) 자율신경계: 면역반응 조절자

- 스트레스에 대한 급성반응 시 교감신경계를 통해 공격-회피반응 자극 / 부교감 신경계는 신체가 항상성을 유지하도록 과도한 면역반응을 억제

2) HPA 축: 코티졸 방출 조절

- 뇌하수체(CRH, 바소프레신) -> 뇌하수체(ACTH) -> 부신(코티졸)

+ 스트레스에 대처 하다보니 생긴 행동변화(알코올 사용, 수면패턴 변화 등)

7. 코티솔 (=스트레스 호르몬)

코티솔 증가	너무 적은 코티솔
- 인지수행 손상 / 면역기능저하 - 갑상선 기능 위축 / 상처 치유 서행 - 혈당 불균형-고혈당 / 뼈 밀도 감소 - 혈압상승 / 근육 부피 감소 - 복부 비만 증가 / LDL 증가 - 심장마비 / HDL 감소 - 뇌졸중 / 다양한 건강문제 초래 - 수면 방해	- 브레인 포그 / 피로감 - 가벼운 우울증 / 수면방해 - 낮은 갑상선 기능 / 저혈압 - 혈당 불균형-저혈당/ 저조한 면역기능 - 염증

8. 대표적인 정신신체 질환

해당 부분 읽어보라고 하시고 쪽욱 넘기셨습니다.

ppt 3강 127~141p 이니 궁금하신 분들은 ppt참고하세요

9. 정신 신체장애의 치료

- 세심한 신체적 검사 실시가 우선시
- 대증치료와 전인적 치료가 필요하다.
- 정신 신체장애의 치료에서 중요한 점은 어느 한쪽의 방법에 치우치지 않고 폭넓은 치료법을 환자의 특성에 따라 잘 절충해 활용하는 것이다.
 - 이 때 내과적 치료와 정신과적 치료가 밀접하게 연계되고 통합된 형태로 이루어지는 것이 최상이다.
- 목표 : 병의 진행방지, 합병증 방지, 이차적 이득의 차단, 적응능력 증진, 신체적 지지기능 향상, 궁극적으로는 병의 근치
- 집단 치료: 병에 대한 두려움을 줄이고 치료적인 도움을 받을 수 있다. 가족 치료는 환자를 포함한 가족들이 가족 안의 역동을 변화시켜 서로의 부담을 줄이고 적응할 수 있도록 돕는다.
- 약물 치료 :가능하면 습관성이 생기지 않도록 최소 용량을 최소시간에 걸쳐 쓴다
- 행동 의학적 치료 :스트레스 관리, 인지적 대처, 행동 수정, 교육으로 이루어진다
 - 치료의 목표: 생리적 각성상태의 조절방법 익히기, 인지적 대처기술의 개발, 위험요소 감소, 적응적 행동을 늘리고 비적응적 행동을 줄이기
- 이완요법: 호흡연습, guided imagery, 점진적 근육이완법, progressive muscle relaxaion, 자가훈련법
- 바이오 피드백: 바이오 피드백 기기를 사용해서 환자 스스로가 자신의 생리 신호의 문제를 인식하게 한 후 이완요법을 활성화시켜 치료

[7] 심신증

- 심신증 = 정신적인 원인으로 발생하는 신체질환

1. 심신의학 ; 칠정이 주요 원인이 되는 신체증상

- 천인상응, 심신일여: 인체의 소우주, 인간의 자연과의 적응관계
- 신형일체: 오장-오신-칠정 스트레스의 관련성
- 간장혼, 심장신, 비장의, 폐장백, 신장지 : 오장에 각 정신작용을 결부
- 神爲一身之君主, 心爲君主之官: 심장에 깃든 神
- 肝在之爲怒, 心在之爲喜, 脾在之爲思, 肺在之爲悲與憂, 腎在之爲恐與驚 : 칠정과 오장과 연결 → 정신기능의 구체적 현상 ✓ 오지상승요법 사용
- 희상심 노상간 사상비 우상폐 공상신
- 怒則氣上 喜則氣緩 悲則氣消 恐則氣下 驚則氣亂 思則氣結 寒則氣收 熱則氣泄 勞則氣耗: 감정 스트레스와 내장의 생리기능과의 상관성
- 기의 변화가 기허, 기울, 기 순환장애, 혈허, 오장의 허실, 담 화 병적요인 유발

2. 심신증

- 넓은 의미에서 한의학 모든 질환이 심신증
- 칠정이 주요 원인이 되는 신체증상들
- 현대의학 - 환원적이고 기계적 시각, 환자의 인간적 상황을 경시. 진단명이 없으면 치료 접근이 어렵다.
- 환자를 한 사람의 인간으로 전인적으로 파악하는 심신의학적 관점과 환자의 심리적인 요소를 가려내는 것이 중요

1) 신체질환의 심리적 요소

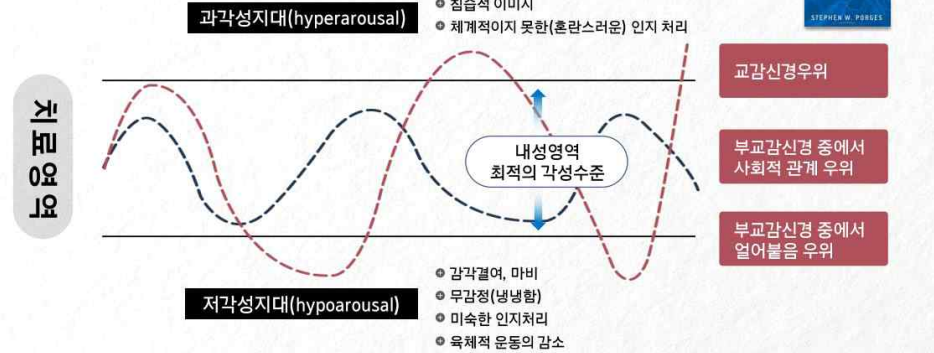
- 모든 환자의 심리에 공통되는 기본증상 : 불안과 공포
- 생체가 위험에 처하면 불안, 공포, 분노 등의 감정과 함께 교감신경기능항진을 중심으로 한 생리적 변화가 일어난다.
- 경우에 따라 부교감신경계도 기능이 항진되어, 때로는 교감신경기능보다도 우선하는 경우가 있다. (동시에 작용하기도)

내성영역(Window of Tolerance)

M&L Psychotherapy

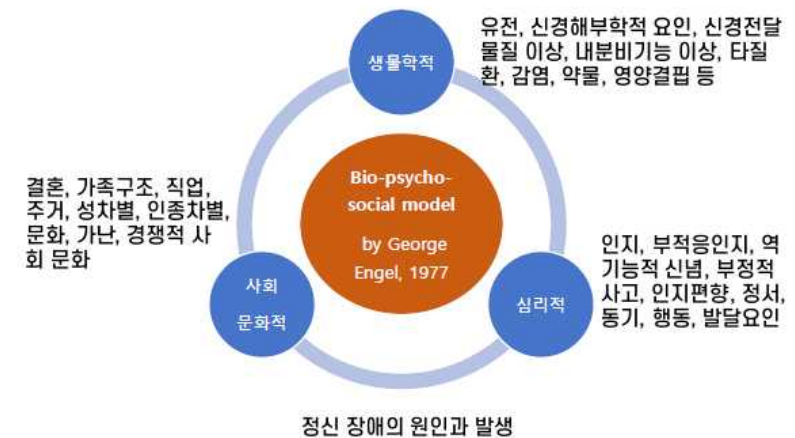
치료목표

'내성영역 확장'



교감신경 항진 = 과각성 지대 / 부교감 신경 항진 = 저각성 지대
과각성 지대와 저각성 지대의 사이인 내성영역을 확장하는 것이 중요!

생물심리사회 모델 (biopsychosocial model)



심신의학에서는 정신장애의 원인을 전인적 관점에서 다각도로 관찰한다!

2) 心身證과 神經症 ★★

이 파트에서는 이것만 알아두면 됩니다.

	심신증(psychosis)	신경증(neurosis)
정신 증상	약	강
신체 증상	일정한 기관에 고정, 때로 기질적 변화까지 有	많은 기관에 다발
병리 과정	- 심리적 스트레스에 대한 직접적 반응 - 스트레스를 무의식적으로 방어한다든지 도피한다든지 하지 않고 견디어내고 있는 도중에 발병	- 심리적 갈등, - 불안을 무의식적으로 방어하여 생기는 것 - 심리적 스트레스에 대한 왜곡된 부적응 상태 - 발병의 기제를 불안이나 갈등에 의한 것으로 생각하지 않고, 의사나 다른 사람에게 의존하여 그것을 치료받기를 희망함

+ 심신증과 히스테리의 구별

(히스테리: 신경증에 속하면서 일정한 신체부위에 고정되어 증상 발현)

히스테리	심신증
의지력으로 변화시킬 수 있는 운동 감각기에서 증상이 발생	불수의한 자율신경 지배하의 기관에서 증상이 발생.
정신적인 불안과 갈등이 신체증상의 발현과 동시에 소실	불안과 갈등이 소실되지 않고, 그것에 수반하여 생기는 신체증상이 주가 된다.
질병도피의 경향이 강하다	견디어내고 있는 경향

3) 세부 병증

피부계	① 多汗, 盜汗(心汗, 手足汗) ② 髮落(脫毛) ③ 搔癢 ④ 牛皮癬(신경성피부염)
근골격계	① 肩臂痛 ② 項強證 ③ 背痛證 ④ 氣腰痛 ⑤ 振顫 ⑥ 痛風
호흡기계	① 氣嗽 ② 氣喘
순환기계	① 心痛(挂心痛, 悸心痛, 七情心痛) ② 氣鬱脇痛 ③ 七情動血(신경성출혈)
소화기계	① 便秘와 泄瀉 ② 呃逆 ③ 噎膈 ④ 反胃 ⑤ 吞酸 ⑥ 噯氣 ⑦ 嘔吐
구강영역	① 口瘡(口破) ② 齒痛 ③ 弄舌
이비인후과	① 喉痞
안과	① 안검의 開閉不全 ② 안검하수 ③ 안검경련(目瞤) ④ 眼疲勞
신, 비뇨기계	① 氣淋 ② 陽痿
내분비대사계	① 癰瘤(甲狀腺腫) ② 消渴
신경계	① 두통 ② 현훈 ③ 癱木 ④ 不語(痰塞不語, 大驚不語)

표 언급 안하심!

4) 치료

- 심신증은 정신과 의사, 내과 의사 등이 서로 협조하여 치료
- 심신증 초기: 적극적 내과적 치료가 우선 + 지지
- 적극적 정신과 치료는 내과적 치료에 효과 없거나/ 만성화/ 정신장애가 우선이 되거나/ 정신장애가 심각하거나
- 심신증 환자가 처음 병원에 왔을 때에는 정신치료를 거부하는 경향이 있다.
- 정신치료는 다른 정신과 환자보다도 서서히 주의 깊게 시작되어야 한다.

자문조정 정신의학 consultation-liaison psychiatry

- 정신과와 타과 간의 협조 관계

1) 자문 consultation

- 타과 의사가 자신이 진료하는 환자에 대해 정신과적 평가 및 치료를 정신과 의사에게 의뢰함으로써, 정신과 의사가 이에 응하는 행위로서 일회적이며, 일방적인 의미가 내포.

2) 조정 liaison

- 환자의 전인적인 건강관리를 위해 정신과 의사가 타과 의사나 전문가들과 지속적인 상호 협조 관계를 유지하면서 공공의 노력을 기울이는 것.
- 자문정신과 : 다른 과의 환자, 보호자, 의사, 간호사, 직원 사이 중재자 역할

[8] 오장관련 증후

- 정서, 심리상태(칠정)의 변화가 오장에 영향을 주어 신체적인 증상으로 나타난다.
- 오장의 생리기능이 정상이면 정신 활동도 정상

1. 五臟神의 의미

- 오장신의 의미
- 사람의 감각, 의식, 기억 등의 정신활동이 오장의 기능 중 하나이며, 정신·심리 상태가 오장의 생리기능과 밀접하게 관련되어 있다.
- 정서·심리 상태의 변화가 오장에 영향을 주어 신체적인 증상으로 나타난다.
- 오장의 생리기능이 정상이면 정신 활동도 정상, 오장의 생리기능에 이상이 있으면 정신 활동에도 이상 발생한다.

2. 정신 증후

- 1) 심: 심화항성, 담화요심, 심혈어조, 심간열성(정신과의 광증, 윤회), 심음부족(경계정충, 불안)
- 2) 간: 간기울결, 간화항성(怒), 간울담결, 심담허겁, 간풍내동
- 3) 비: 비실건운, 脾不藏意(사려과다)
- 4) 폐: 호흡기능 저하
- 5) 신: 기억력 감퇴, 노년 정신장애

✏️ 신경정신과학 공지사항

- 후반부 사상의학 부분은 교수님께서 시험에 안 나온다고 하셔서 써머리하지 않았습니다. 살펴보면 알겠지만 다 사상의학 수업 때 한 내용입니다.

✏️ 신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**

- 강조: **빨간색 밑줄**

- 말없이 지나간 부분: 회색

- 참고: **갈색**

- DSM 진단 기준은 중요하지 않습니다. 진단기준을 한 번 읽어보면 각 인격장애가 어떤 느낌인 감이 오실 것 같아서 맨 앞에 적어둔 것이니 한 번 쓱 읽어보세요.

✓ B군(극감변): 극적이고, 감정적(충동적)이고, 변덕스럽다.

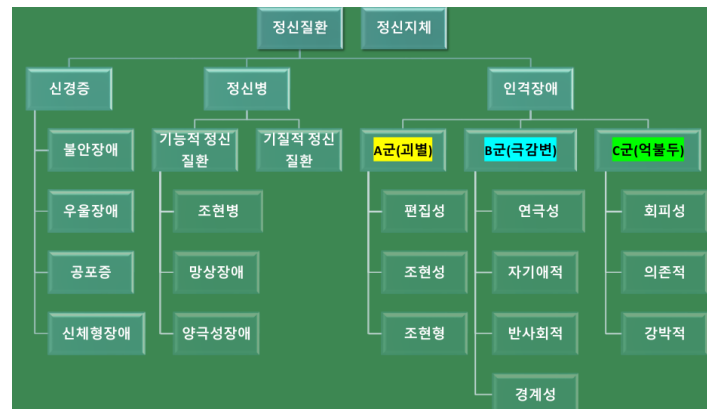
✓ C군(억불두): 억압되어 있고, 불안하고, 두려워한다.

신경증 VS 정신증

	신경증	정신증
현실판단력	정상	뚜렷한 손상
주요한 장애나 문제	불안장애, 우울증	정신분열증
자기 상태에 대한 이해(병식)	있음	없음
사회적 적응상태	경미한 문제	심각한 문제
주요 치료 방식	외래치료, 방문치료	입원치료

[1] 성격장애

정신장애



- 정신질환과 정신지체는 구분해야 한다.

✓ 정신지체: IQ가 떨어지는 것

- 기질적 정신질환: 뇌의 기질적 병변으로 발생한 정신질환

- 신경증은 악화되면 정신병으로 넘어가기도 한다.

- 인격장애

✓ A군(괴별): 괴이하고 별나다. + 냉담하다.

신경증 VS 인격장애

인격장애	신경증
자아 동질적 - 본인은 괴롭지 않은 경우가 많으며, 불안감이 적고 직접행동으로 나타나는 경향이 있다. ✓ 다른 사람이 힘들다. - 인격장애는 대체적으로 자아 동질적이어서 병식이 없다. But 경계성 인격장애는 특이하게 자아 이질적이어서 정동이 불안하다.	자아 이질적 - 본인이 괴로워한다. ✓ 우울과 불안 때문에 힘들어 한다.
환경 변형적 - 자신의 증상이 사회에 미치는 영향을 인식하지 못하며, 치료의 필요성을 못 느낀다. - 타인에게 피해를 많이 주는 편이다. - 대인관계, 사회생활 등의 인격의 광범위한 범위에서 나타난다. - 환경이 문제라고 생각하는 것	자기 변형적 - 치료를 희망하는 경우가 많다. - 자신에게 피해가 많은 편이다. - 인격의 일부분이 관여, 대인관계 양상이 인격장애에 비해서 상대적으로 일과성이다. - 내가 문제라고 생각하는 것

- 자아 이질적: 사고, 욕동, 정동, 혹은 행동 등이 자아와 조화를 이루지 못하는 상태. 내가 내 마음을 편하게 느끼지 못함

인격장애(Personality disorder)

- 인격(성격, personality): 내부, 외부 환경에 적응하는 독특한 방식
- 정신장애: 무난한 현실적 적응을 하던 사람에게 어떤 **부정적 사건**¹이 계기가 되어 발생
- 인격장애: **어린 시절부터** 서서히 발전해 **성인기에 개인의 성격으로 굳어진 심리적 특성**이 **부적응적 양상**을 나타내는 경우

일반적 인격장애(General personality disorder)

- 내적경험과 행동의 지속적인 유형이 개인이 속한 문화에서 기대되는 바로부터 **현저하게 편향**²되어 있다. 이러한 형태는 다음 중 2가지(또는 그 이상)에서 나타난다.
 1. 인지(즉, 자신과 다른 사람 및 사건을 지각하는 방법)
 2. 정동(즉, 감정반응의 범위, 불안정성, 적절성)
 3. 대인관계 기능
 4. 충동 조절
- 지속적인 유형이 **개인의 사회 상황의 전 범위에서 경직되어 나타난다.**
- 지속적인 유형이 사회적, 직업적, 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 손상을 초래한다.
- 유형은 안정적이고 오랜 기간 동안 있어 왔으며, **최소한 청년기 혹은 성인기 초기부터 시작된다.**
 - ✓ **기간:** 환자의 증상이 적어도 초기 성인기(반사회성 인격장애는 15세 이전³)부터 나타났는지 확인. / 환자가 18세 미만이라면 현재 보이는 증상이 적어도 12개월 이상 지속되었는지 확인 필요함. (어린 나이에는 진단 내리지 않는 것을 고려)
- 지속적인 유형이 다른 정신질환의 현상이나 결과로 더 잘 설명되지 않는다.
- 지속적인 유형이 물질(예, 남용약물, 치료약물)의 생리적 효과나 다른 의학적 상태(예, 두부 손상)로 인한 것이 아니다.

유병률

- 병원 입원한 환자의 60% 정도 경계성 인격장애
- 감호시설 등에서는 50% 정도 반사회적 인격장애
- 일반 인구의 10-15% 정도가 DSM-4-TR에 제시하는 인격장애의 한 기준에 부합.
- 인격장애는 동시에 두 가지 이상이 추정되기도 함.

진단

- 인격장애를 진단하기 위해서는 그 **개인의 장기간의 기능 양상**을 반드시 평가하여야 하고, 특징적인 성격 특질이 **성인기 초기 전까지는 명백하게 나타나야 한다.**
- 성격 특질은 특정 스트레스 상황이나 좀 더 일리적인 정신상태에서 드러나는 개인적 특성과는 구별
- 일반적으로 **1회 이상의 면담**을 시간 간격을 두고 가지는 것이 필요하다.
- 인격장애를 특징짓는 **개인적 특성을 환자는 문제시하지 않기 때문에(자아동조적⁴)** 평가는 복잡해질 수 있다.
- 많은 사람에서 서로 다른 집단(ABC군)에 속하는 인격장애가 동반되어 나타나는 것을 흔하게 볼 수 있음
- 환자가 하나 이상의 인격장애 진단기준을 충족할 때, 임상가는 각각의 인격장애 진단을 내려야 한다.
- 인격장애의 몇몇 유형(특히, 반사회성 및 경계성 인격장애)는 나이가 들어감에 따라 완화되거나 관해되지만, 다른 인격장애에서는 이런 경향이 나타나지 않기도 한다(예, 강박성 및 조현성 인격장애)
- **성인 중반 이후 혹은 노년기에 발병한 성격의 변화는 반드시 다른 의학적 상태나 발견하지 못한 물질 사용 장애로 인한 인격장애의 가능성에 대해 철저한 검사가 이루어져야 한다.** (치매 등)

¹ 스트레스의 장기간 노출, 트라우마 경험 등

² 인격장애의 요소들이 정상인에게서도 나타나지만, 장애를 가진 사람들에게 더 두드러지게 나타난다.

³ 반사회성 성격장애는 다른 성격장애보다 청소년기에 나타나는 경향이 있다.

⁴ 자아동조적: 스스로 자신의 행동이 문제를 일으킨다는 것을 알지 못함. "그건 세상 이 잘 못된 거예요"

정신분석적 요인

1. **Freud**: 인격특징은 하나의 정신성적 발달단계에 고착되어 있는 것과 연관됨.

- 구강기는 음식을 다른 사람에 의존해서 받기 때문에 구강기에 고착되면, 수동적이고 의존적인 구강기 특성을 나타냄
- 항문기 동안 화장실 훈련을 강하게 훈련받으면 고집스럽고, 인색하고, 너무 양심적인 (강박적인) 항문기 특성을 나타냄

2. **Wilhelm Reich**: 사람의 인격적 특징은 개인의 **방어기제**⁵에 의해 크게 결정된다고 하였음.

- 편집성 인격장애 환자에서는 투사의 방법을 사용
- 분열성 인격장애 환자에서는 회피의 방어 기제를 사용
- 방어기제가 효과적으로 작용할 때 인격장애 환자는 불안, 우울, 분노, 수치, 죄책감, 다른 정동을 억누르게 됨.

3. **내부 대상관계**: 인격장애자들은 내적대상관계 유형에서 나오는 특정 인간관계로 정의됨

- 대상 관계 이론: 현재의 인간관계는 과거에 형성된 인간관계를 보여주는 것으로 생애 초기에 형성된 양육자와의 관계가 자신과 타인을 이해하고 관계를 형성하는 기본 틀로 작용한다는 이론
- 내적 표상: 주 양육자와의 상호작용에 의해 무의식적으로 발생, 양육자와의 관계에 문제가 있을 때 이것이 인격장애로 발전할 수 있다. 두 가지 내적표상이 있다.
 1. 자기표상: 대상에 반응하고 행동하는 자기 자신에 대한 이미지
 2. 대상 표상: 자기와 관련하여 가지게 되는 타인에 대한 심리적인 이미지

방어기제

- 인격장애 환자가 가장 지배적이거나 경직된 방어기제가 특징적임에도 불구하고, 각각의 환자들은 다양한 방어기제를 사용함.

1. 해리(Dissociation)

- 해리 또는 부인은 불쾌한 감정을 기분 좋은 것으로 교체하는 것임.
- 정서는 극적이고 얇은 경우가 많다.

- 자주 해리되는 사람에서는 종종 극적이고 얇은 정서를 나타낸다. 히스테리성 인격장애.
- 자주 해리되는 사람은 불쾌한 감정을 소화할 수 있는 능력이 부족하기 때문에 그렇다.
- 사실을 직면하기보다는 **부인된 감정에 대하여 공감**하면서 원래의 주제를 스스로 이야기할 수 있도록 하는 것이 좋다.
- 환자가 해리시킨 감정이 무엇인지 알아보는 상담이 필요하다.

2. 고립(Isolation)

- 바람직하지만 성과가 없을 것 같은 정서적인 낭비를 억제하기 위한 방어기제
- 상실, 실망 등에서 자기를 보호하기 위해 애초에 기대와 노력을 포기함으로써 방패를 만든다.
- Ex) 남편이 바람을 뺐을 때 "남자는 원래 다 그래요."라고 말하는 것
- 강박성 인격장애로 분류되는 세심하게 관리되고, 정돈된 사람의 특징
- 세심하고 체계적이고 이성적인 설명에 잘 반응한다.

3. 분리(Splitting)

- 분리는 환자의 감정이 양가적이고, 좋음과 나쁨 두 가지(흑백논리)로 분리됨.
- 마음의 방 그리기 하면 정말 가운데 딱 잘라 좋고, 나쁜 것으로 나눔
- 이러한 방어적 행동은 병실에서 매우 파괴적이고, 궁극적으로 병원 직원들이 이 환자에게 돌아서게 된다. 만약 직원들이 이러한 과정을 예상하면, 이를 직원 미팅에서 논의하고, 환자에게 부드럽게 사실을 직면시키고, 그 어떤 사람도 모두 좋거나 모두 나쁘지 않다고 직면시키고, 분리된 현상을 효과적으로 다룰 수 있다.

4. 환상(Fantasy)

- 조현성 인격장애 환자는 괴짜의, 고독한, 이미지를 상상함, 특히 상상 속 친구 이미지로써 안정감을 느끼는 특징을 많이 나타냄.
- 치료사들은 비사회적인 이러한 환자들이 **친근함(라포)에 대한 공포**가 있는 것을 이해해야 한다. 그러므로 그들에 대하여 비판하거나 그들을 거부함으로써 퇴짜맞았다는 느낌을 느끼게 하기보다는 조용하고, 지지해주고, 상호적인 반응을 요구하지 않고 관심을 보여주어야 한다. **가까워짐에 대한 환자의 공포를 인지하고, 그들의 괴짜스러운 방식을 존중하는 것 또한 치료이고 유용하다. 속도 조절과 지속적인 지지가 필요하다.**

⁵ 스트레스에 대처하는 방법. 잘못된 방어기제로 인격장애가 발생한다. 잘못되었어도 효과

적으로 작동한다면 본인은 편하다.

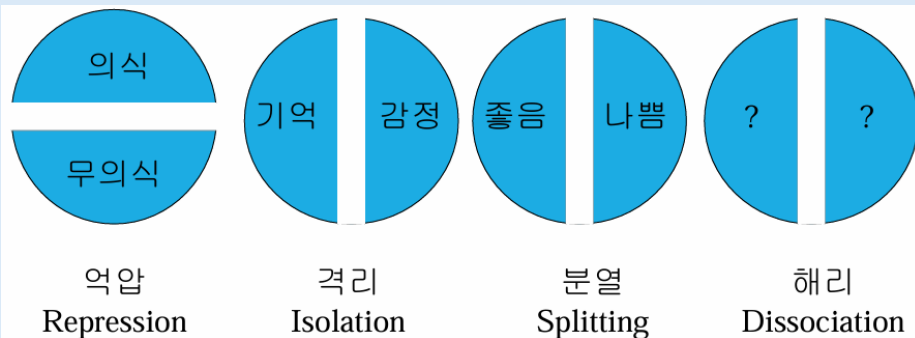
5. 투사(Projection)

- 투사는 환자가 그들의 알아채지 못한 감정을 타인에게 떠넘기는 것
- 환자들이 과도한 흡잡기와 비판에 대한 민감하게 반응하는 것에 대해서는 논쟁해서는 안 된다.
- 치료자는 편집적인 환자에게 그들의 감정과 지각에 대하여 전적인 신뢰를 보여주고, 환자의 불만에 대하여 논쟁하지 말고, 그들이 의심하는 것에 대하여 동의하거나 강화시켜서는 안 된다. 치료자는 진정한 동기와 감정에 대하여 이야기함으로써 환자와의 동맹관계를 강화시키기 시작해야 한다.

6. 수동공격성(Passive Aggression)

- 수동공격적인 성향을 가진 사람들은 그들의 분노를 그들 자신에게로 향하게 방어한다.
- 이러한 현상은 자꾸 미루는 것, 바보스러운 행동, 화를 돋우는 행동으로 나타난다.
- 치료자는 환자가 자신의 분노를 환기시키도록 도와야 함.

● 둘로 나누는 방어기제들



- 둘로 나누는 방어기제에는 원칙이 존재한다.

1. 공존이 안된다.
2. 어느 한쪽은 가려진다.

- 억압: 무의식의 생각이 의식으로 올라오지 못하도록 누르는 것
- 격리: 마음에서 기억과 감정을 나누는 것. 충격적인 경험을 아무렇지 않게 말함.
- 분열: 좋고 나쁨을 딱 갈라버리는 것. 뭐는 너무 좋고, 뭐는 너무 싫음.
- 해리: 내가 감당할 수 없는 것을 마음 속에서 미성숙하게 갈라버린 것. 자신은 뭐가 갈라졌는지도 모름.

7. 행동화(Acting Out)

- 행동화는 환자가 즉각적으로 의식하지 못한 소원 혹은 분쟁을 행동화함으로써 동반되는 생각 혹은 정동을 **의식화하는 것을 피할수 있음.**
- 행동은 의식의 밖에서 일어나기 때문에, 행동화는 죄책감을 동반하지 않고 나타날 수 있음.
- 임상가는 환자가 자기 조절을 상실했다는 것을 알아차리고, 환자의 주의를 끄는 것이 가장 중요하다. 환경에 따라서 임상가는 "당신이 계속 소리를 지르면 내가 당신을 어떻게 도울 수 있죠?" 또는 환자의 통제 상실이 더 심해지면, "만약 당신이 계속 소리를 지르면 나는 떠날 겁니다."라고 한다.
- 인터뷰하는 사람이 진심으로 환자에게 무서움을 느낀다면 단순히 떠나거나 필요하다면 병동 인력이나 경찰로부터 도움을 받아야 한다.

8. 투사적 동일시

- 주로 경계성 인격장애에서 나타나고, 3가지 단계로 구성되어 있다.
 1. 자기의 어떤 부분을 다른 사람에게 투사한다. (주로 부정적인 부분)
 2. 투사하는 사람은 타인이 투사된 대로 행동하기를 강압한다.
 3. 투사를 받는 사람과 투사자는 동일한 감정을 느낀다.(동일시가 강화됨)

인격장애의 분류

Cluster A (suspicious, odd)	괴상하고, 별난, 냉담함. 편집성(paranoid), 조현성(schizoid), 조현형(schizotypal)
Cluster B (dramatic)	극적이고, 감정적(충동적)이고, 변덕스러움. 경계성(borderline), 반사회성(antisocial), 히스테리성(histrionic), 자기애성(Narcissistic)
Cluster C (anxious)	억제되어있고, 불안해보이고, 두려워함. 강박성(obsessive-compulsive), 의존적(dependent), 회피성(avoidant)

[2] A군 인격장애

- 괴상하고, 별나고, 냉담함
- 철수되고 냉담하고 의심 많고 비이성적임.
- 종류: 편집성(paranoid), 조현성(schizoid), 조현형(schizotypal)

편집성 인격장애(Paranoid Personality Disorder)

편집성(망상성) 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 타인의 동기를 악의에 찬 것으로 해석하는 등 **타인에 대해 광범위하고 전반적인 불신과 의심**을 하며, 초기 성년기에 시작되어 다양한 상황에서 나타나며, 다음 중 네 개(또는 그 이상)를 충족시킨다.

1. 충분한 근거없이 다른 사람이 자신을 관찰하고 해를 끼치고 속인다고 의심한다.
2. 친구들이나 동료들의 충정이나 신뢰에 대한 정당하지 못한 의심에 사로잡혀 있다.⁶
3. 어떠한 정보가 자신에게 나쁘게 이용될 것이라는 확실하지 않은 두려움 때문에 다른 사람에게 비밀을 털어놓기를 꺼린다.
4. 호의적인 말이나 사건 속에서도 숨겨진 의도나 위협적인 의도를 읽어내려 한다.
5. 지속적으로 원한을 품는다. 즉, 모욕이나 상처 줌, 혹은 경멸을 용서하지 않는다.
6. 다른 사람들은 그렇게 느끼지 않는데도, 자신의 성격이나 명성이 공격당했다고 느끼고 즉시 화를 내거나 반격한다.
7. 확실한 증거 없이, 부인이나 연인의 순결성을 반복적으로 의심한다.

B. 위 증상들이 정신분열병, 정신병적 양상을 보이는 기분장애, 혹은 기타 정신병적 장애의 경과 중에만 나타나서는 안 되고, 일반적인 의학적 상태의 직접적, 생리적 효과에 의한 것이 아니어야 한다.

주의: 기준이 정신분열병의 발병 이전에 합당하였다면 '병전'을 추가한다. 즉, '편집성 인격장애 (병전)

편집성 인격장애의 특징

• Key point

의심이 많고 쉽게 기분이 상한다. 대체로 친한 사람이 거의 없고, 별 뜻 없는 말 속의 숨은 의미를 읽으려 할 수 있다.

1. 근거 희박한 불신과 의심

- 가장 큰 특징은 과도한 의심과 불신이고, 타인의 행동을 고의로 비하하고, 악의적이고, 위협적이고, 속이려고 하는 것으로 해석한다.

2. 질투가 심하고 권력과 서열을 중시

- 배우자 또는 성적 파트너의 정절에 대하여 의심한다.
- 약해보이고, 결여되어 보이는 사람은 무시한다.

3. 감정표현은 제한

- 정동적으로 제한되어 있고, 정서가 없는 것처럼 보인다.
- 그들은 자신이 이성적이고 객관적이라고 생각하며 자랑스러워한다.

4. 스스로 치료를 찾는 경우가 드물다. 배우자나 고용주에 의해서 치료를 의뢰받는다.

5. 역학

- 일반 인구 유병률은 0.5~2.5%, 입원 환자 10-30%, 외래 2~10%
- 여자에 비해 남자가 더 흔히 진단받음.

6. 정신과 면접에서는 편집성 인격장애 환자는 매우 격식을 차리고 정신과적 도움을 찾으려 온 것에 대해 당황한 듯하게 행동한다.

7. 사고내용은 투사, 편견의 증거를 보여줌

- 그들이 받아들이 수 없는 충동과 사고를 다른 사람에게 돌림 → 편집성 인격장애

편집성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)

- 취약한(Vulnerable)

2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)

- 적군(Adversaries)

3. BELIEFS(신념)

- 세상은 위험하다. 그리고 내가 나 자신을 보호해야만 한다.

⁶ 왜 나한테 잘해주지?

- 나는 나 자신만 오로지 믿을 수 있다. (no one else)

4. THREAT(위협)

- 모두 다(EVERYONE!!!!)

5. STRATEGY(위협에 대한 전략)

- 누구도 믿지 않는다. 사회적으로 고립되자(social isolation)

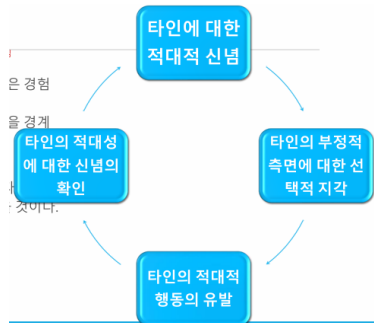
6. AFFECT(정동)

- 적대적(Hostile), 불안한(anxious), 불쾌한 (dysphoric)

치료적 관점

1. 기본적 신뢰(basic trust)의 결여

- 어린 시절에 부모로부터 가학적인 양육을 받은 경험(부모를 믿지 못하는 것에서 시작되어 굳어짐)
- 자신과 타인에 대한 가학적 태도를 내면화
- 자신을 보호하기 위해서 타인의 공격과 속임을 경계



2. 3가지 기본적 신념(Beck과 Freeman(1990))

- 사람들은 악의적이고 기만적이다.
- 그들은 기회만 있으면 나를 공격할 것이다.
- 긴장하고 경계해야만 나에게 피해가 없을 것이다.

치료

- 치료 원칙: 신뢰와 인내
- 치료자와 내담자 간의 신뢰 관계 형성
- 방어적으로 반응하기보다 솔직하고 개방적인 자세로 신뢰감 심어주기

- 내담자의 감정을 잘 수용하는 것이 중요

- 왜곡된 감정을 선불리 지적하고 수정하려는 노력은 오히려 내담자를 긴장시키고 방어적인 태도를 유발
- 친밀감이나 온정을 표현하는 것은 편집성 경향 자극하므로 삼가는 것이 좋다.(긴 시간이 필요함)

- 집단 심리치료에 잘 맞지 않는다.(행동치료와 사회기술훈련을 못 견딤)

- 망상은 현실적으로 다루어져야 하지만 반드시 환자를 모욕을 주지 않으면서 부드럽게 다루어야 한다.

CASE

- 34세 남성
- 면담이 진행되는 동안, 사람들이 자신에게 거짓말을 하고 있고, 자신이 속고 있다고 확신할 수 있는 증거라면서 거의 매일 일어나고 있는 상황에 대해 이야기함.
- 소수의 친구들과 '피상적으로만' 어울렸고 이전의 친구와 연인들이 자신을 배신했던 정확한 순간들을 기억해 냄.
- 직장에서 극도로 꼼꼼했고, 자신의 일을 남에게 대신하게 하지 않는 등, 업무 완수에 어려움을 겪었음. 직장의 고용주들은 그에게 지나치게 규칙, 목록, 자잘한 것에 초점을 맞춘다면서, 좀 더 우호적일 필요가 있다고 말해옴
- 여러 해 동안 수많은 직업을 두루 거침, "저는 해고당한 횟수만큼 그만둔 적도 많았다."고 방어했음
- 외상, 과거 물질 사용에 관한 문제, 두부 외상이나 의식상실에 대한 심각한 병력 x
- 검사 당시 조리 있게 말했고, 지각장애의 증거 x, 적극적인 자살생각 또는 살해 생각x

1. 편집성 인격장애: 장기간 지속되어 왔고 경직되어 있는 역기능적 패턴-지속적인 불신과 의심
2. 강박성 인격장애: 완벽주의와 통제에 대한 집착. 융통성이 없고 다른 사람에게 일을 맡기지 못함

조현성(분열성) 인격장애(Schizoid Personality Disorder)

조현성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. **사회관계에서의 고립양상과 대인관계에서의 제한된 감정표현이 광범위한 양상**으로 나타나고, 이런 양상이 성인기 초기에 시작되어 다양한 상황에서 드러나며, 다음 중 4개(혹은 그 이상)의 항목을 보인다.

1. 가족의 일원이 되는 것을 포함하여, 친밀한 관계를 바라지도 즐기지도 않는다.
2. 거의 항상 혼자서 하는 활동을 선택한다.
3. 다른 사람과 성 경험을 갖는 일에 거의 흥미가 없다.
4. 만약 있다고 하더라도, 소수의 활동에서만 즐거움을 얻는다.
5. 직계 가족 이외 가까운 친구나 마음을 털어놓는 친구가 없다.
6. 타인의 칭찬이나 비평에 무관심해 보인다.
7. 냉담, 고립, 혹은 단조로운 정동을 보인다.

B. 장애가 정신분열병, 정신증적 양상을 동반하는 기분장애, 기타 정신장애 혹은 광범위 성 발달 장애의 경과 중에만 나타나는 것이 아니며, 신경과적 또는 다른 일반적인 의학적 상태의 직접적, 생리적 효과로 인한 것이 아니어야 한다.

주의: 만약 정신분열병의 발병 이전에 지니고 있던 인격 특성이 위에 제시된 진단 기준에 맞으면, '병전'이라고 괄호 안에 써준다. 예: 분열성 인격장애(병전)

조현성 인격장애의 특징

• Key point

사회적 관계를 거의 고려하지 않고 정서의 범위가 제한되어 있으며, 비판이나 칭찬에 무관심한 듯 보임. 혼자 있으려 하며, 친밀한 관계(성적 관계를 포함)를 피함.

1. 평생 동안 **사회적으로 고립**
 - 괴짜스럽고, 소외
 - 고립되어 할 수 있거나 적은 사람과 접촉할 수 있는 일을 좋아함
2. **다른 사람과의 상호관계에서 불편감을 느낌**
 - 정신과적 면접에서 거의 눈을 마주치지 않고, 면접을 빨리 끝내고 싶어함.
 - **다른 사람들과 정서적 유대를 필요로 하지 않음**
 - 성적 생활은 오직 환상 속에서만 존재하고, 무기한으로 성적으로 성숙하는 것을 미룰 수 있다.

3. 내성적이고, 제한되어 있는 정동

- 정동은 매우 제한적이고, 냉담하고, 부적절하게 심각하고, 무관심함.
- 기저에는 공포가 있음

4. 현실검증능력, 감각기능, 기억력 정상

5. 역학

- 일반인구의 5%
- 남:여 = 2:1 비율 정도

6. 스트레스 받으면, 단기 정신병적 삽화(몇분~몇시간)를 경험하기도한다.

7. 편집성 인격장애는 흔히 조현형 인격장애 및 또는 기타 조현형 스펙트럼 장애와 동반이 환

- 편집성 인격장애는 조현병의 전구체는 아니고, 증상들 역시 조현병의 전구 국면을 나타내지 않음. 편집성 인격장애에서의 사고패턴은 일반적으로 망상장애와 유사함.

조현성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(**자신을 어떻게 보는지**)

- 색다른(Different), 빈(Empty)

2. VIEW OF OTHERS(**타인을 어떻게 보는지**)

- 가치 있기보다는 골치거리
- 자유에 대한 장애물

3. BELIEFS(**신념**)

- **관계(relationships)는 문제투성이다.**
- **삶은 혼자 있는 것이 덜 복잡하다.**
- 나는 충분한 공간이 필요하다.

4. THREAT(**위협**)

- 규정준수(Compliance)
- 상황을 더 복잡하게 만드는 문제(complications)

5. STRATEGY(**위협에 대한 전략**)

- 고립(Isolation)

6. AFFECT(**정동**)

- 밋밋함(Flat, not to be confused with depressed)

치료적 관점

1. 타인과 관계를 맺는 능력에 결함

- 자기표상이 통합되지 못한 채 자신이 누구이며 무엇을 원하는지를 확신하지 못하고, 이로 인해 타인과의 관계형성에 어려움을 초래함.

2. 부정적 자기개념과 대인관계 회피에 관한 사고

- "타인과 그들의 반응이 중요하지 않으며 무시해도 된다"
- 적대적 형태가 아니라 "상관하지 마라. 내버려 두라"는 것으로서 다른 사람들과 거리를 유지하려는 행동이 나타남.
 - "나는 혼자 있는 것이 낫다."
 - "아무도 나를 간섭하지 않았으면 좋겠다."
 - "다른 사람들과 관계를 맺으면 문제만 일어난다."
 - "주위에 사람들만 없다면 인생은 별로 복잡하지 않을 것이다."
 - "다른 사람들로 부터 거리를 유지하는 것이 낫다."
 - "나는 사회 속의 무리에 끼어들기에는 부적절한 사람이다."

치료

- 치료목표: **사회적 고립에서 벗어나고 사회적 상황에 효과적으로 적응하도록 돕는 것(사회적응)**

- (1) 내담자가 사회적 상황에서 철수하려는 경향을 줄이고,
- (2) 생활 속에서 즐거움을 경험하도록 도우며
- (3) 정서적 경험의 폭과 깊이를 서서히 확대, 심화시키고
- (4) 인간관계를 형성하고 유지하는 기술을 습득하도록 노력해야 한다.

- 치료자는 적극적이고 참을성이 있어야 하며, 환자의 사생활을 존중하고, 비침투적이어야 한다.

- 신뢰가 발전하면 분열성 환자들은 앞일에 대한 두려움, 환상, 상상친구에 대한 과잉, 치료자와 융합될 것 같은 참을 수 없는 의존에 대한 공포를 호소한다.

- 사회기술을 증진시키고 새로운 대인관계를 형성하도록 돕는 집단치료가 도움이 된다.

- 집단치료장면에서, 분열성 인격장애 환자들은 오랜 기간동안 조용할 수 있다. 그렇더라도 그들은 점점 참여하게 되므로, 환자들은 다른 집단 멤버에 의한 공격에 보호되어야 한다.

조현형(분열형) 인격장애(Schizotypal Personality Disorder)

조현형 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 친밀한 대인관계에 대한 고통, 그러한 관계를 맺는 제한된 능력에서 드러나는 사회적 대인관계에서의 손상, 인지적·지각적 왜곡, 기이한 행동 등 광범위한 양상이 성인기 초기에 시작되며, 여러 가지 상황에서 나타나는데, 다음 중 5개(또는 그 이상) 항목을 보인다.

1. 관계사고(관계 망상은 제외)
2. 행동에 영향을 미치는, 하위문화의 기준에 맞지 않는 괴이한 믿음이나 마술적 사고(예: 미신, 천리안에 대한 믿음, 텔레파시나 육감, 소아나 청소년에서 보이는 기이한 환상이나 집착)
3. 신체적 착각을 포함한 유별난 지각 경험 (**거시증 등**)
4. 괴이한 사고와 언어(예: 애매하고, 우회적이고, 은유적이고, 과도하고 상세하게 묘사되거나 또는 상동증적인)
5. 의심이나 편집적인 사고
6. 부적절하거나 메마른 정동
7. 괴이하고, 엉뚱하거나 특이한 행동이나 외모
8. 직계 가족 이외 가까운 친구나 마음을 털어놓을 수 있는 사람의 부재
9. 과도한 사회적 불안이 친밀해져도 줄어들지 않음 이는 자신에 대한 부정적인 판단 때문이라기보다는 편집적인 두려움 때문이다.

B. 장애가 정신분열병, 정신증적 양상이 있는 기분장애, 기타 정신증적 장애, 또는 광범위성 발달장애의 경 과 중에만 나타나는 것이 아니다.

주의: 만약 조현형 인격장애가 정신분열병의 발병보다 먼저 있었다면 괄호에 '병전'이라고 쓴다. 예: 분열 형 인격장애(병전)

조현형 인격장애의 특징

• Key point

다른 사람들에게 독특하고 이상해 보이기 때문에 대인관계가 매우 어려움. 가까운 친구가 없고 사회적 상황을 불편해함. 의심, 비밀상적인 지각이나 사고, 엉뚱한 언어, 부적절한 정동을 보일 수 있음.

1. 사고, 행동, 외모에서 기이함

2. 마술적인 사고, 기이한 관념

- 미신을 믿거나 예지력을 주장하고, 다른 특별한 사고와 통찰력을 갖고 있다고 믿음
- 내적세상은 생생한 상상 관계와 아이와 같은 공포와 환상으로 가득차있다.

3. 관계사고

- 우연한 사고나 외부적 사건이 자신에게 특별하고 놀라운 의미가 있다고 잘못 해석

4. 착각

- 지각적 착각 혹은 거시증을 인정할 수 있고, 다른 사람들이 나무처럼 보이거나 다 똑같이 보인다고 인정하기도 함

5. 자신의 감정을 알지 못하고, 타인의 기분 특히 분노와 같은 부정적인 정서를 알거나 민감하지 못함. ex. 23세 몸집 작은 조현형 여성, 위협 인식 못하고 문신 있는 남자한테 덤벼들어 버림.

6. 대인관계가 적고, 고립되어 있음.

7. 환자들의 의사소통 방식이 비정상적이기 때문에 과거력을 듣는데 어려움이 있다.

8. 역학

- 일반 인구에서 대략 약 3%
- 남자에게 약간 더 많다.
- 장기연구에서 분열형 인격장애의 10%가 자살을 저지른다.

9. 스트레스 상황에서는 분열형 인격장애 환자들은 정신병적 증상을 나타낼 수 있지만, 대개 매우 짧다.

10. 분열형 인격장애는 조현병 환자의 병전 성격으로 보는 임상가도 있다.

조현형 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)

- Outsider, 결함이 있는(defective)

2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)

- 이상하고 무섭지만 사회적 접촉에 대한 욕구(조현성과 차이점)

3. BELIEFS(신념)

- "나는 적합하지 않다." "나는 위협으로부터 나 자신을 보호해야 한다."
- "모든 것에는 이유가 있다. 우연히 일어나는 일은 없다."

4. THREAT(위협)

- 세상(이해할 수 없기 때문)

5. STRATEGY(위협에 대한 전략)

- 사회적 고립(Social isolation)
- 환상적 사고로 후퇴(Retreat into delusional ideas)

6. AFFECT(정동)

- 불안, 우울

치료적 관점

1. 유전적 소인

- 대인관계로부터의 철수, 인지적-지각적 왜곡, 사고와 행동의 혼란
- 조현성 < 조현형 < 조현병 (조현성보다 조현형이 조현병과 가깝다.)

2. 유아기에 경험한 부모와의 불안정한 애착관계

3. 독특한 사고와 다양한 인지적 왜곡

- "나는 결함이 많은 사람이다."
- "사람들과 관계를 맺는 것은 매우 위험하다."
- "나는 사람들이 나를 좋아하지 않는다는 것을 알고 있다."
- "나는 다른 사람이 무슨 생각을 하는지 다 안다."
- "내가 느끼는 감정은 앞으로 무슨 일이 벌어질지를 미리 알려주는 신호이다."

치료

- 조현형 인격장애 치료의 원칙은 조현성 인격장애와 다르지 않다.
- 그러나 임상가는 조현성 인격장애보다 더욱 민감하게 다루어야 한다.
- 이러한 환자들은 사고가 기이하고, 소수의 종교 활동, 오컬트⁷에 심취해있다. **치료자는 그들의 활동에 조롱하지 않아야 하고, 그들의 믿음 혹은 활동을 판단하지 않아야 한다.**

⁷ 오컬트: 과학적으로 해명할 수 없는 신비적, 초자연적 현상. 또는 그런 현상을 일으키는

[3] B군 인격장애

- 극적이고, 감정적(충동적)이고, 변덕스러움.
- 극적이고 감정적이며 관심을 끌려고 함. 기분은 대개 깊이가 얇고 불안정함. 종종 강렬한 대인관계 갈등을 보이기도 함.
- 종류: 경계성 (borderline), 반사회성 (antisocial), 히스테리성 (hystionic), 자기애성 (Narcissistic)

반사회성 인격장애(Antisocial Personality Disorder)

반사회적 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 타인의 권리를 무시하거나 침해하는 광범위한 행동 양식이 15세 이후에 시작되고, 다음 중 3개(또는 그 이상) 항목을 보인다.

1. 법에서 정한 사회적 규범을 지키지 못하고, 구속당할 행동을 반복하는 양상으로 드러난다.
2. 개인의 이익이나 쾌락을 위한 반복적인 거짓말, 가명을 사용한다거나 타인들을 속이는 것과 같은 사기
3. 충동성 또는 미리 계획을 세우지 못함
4. 빈번한 육체적 싸움이나 폭력에서 드러나는 과흥분성(자극과민성)과 공격성
5. 자신이나 타인의 안전을 무시하는 무모성
6. 일정한 직업을 갖지 못하거나 채무를 청산하지 못하는 행동으로 드러나는 지속적인 무책임성
7. 자책의 결여, 타인에게 상처를 입히거나 학대하거나 절도 행위를 하고도 무관심하거나 합리화하는 양상으로 드러난다.

B. 연령이 적어도 18세 이상

C. 15세 이전에 발생한 품행장애의 증거가 있어야 한다.

D. 반사회적 행동이 정신분열병이나 조증 삽화 경과 중에만 나타나는 것이 아니어야 한다.

반사회성 인격장애의 특징

• Key point

- 무책임하고, 때로는 범죄가 되는 행동이 아동기 또는 초기 청소년기의 무단결석, 가출, 잔혹성, 싸움, 파괴성, 거짓말, 절도로 시작됨.
- 성인들은 범죄 행위에 더하여 빚을 지거나 무책임하게 행동하기도 하고, 무모하거나 충동적으로 행동하기도 하며, 자신의 행동에 대한 후회를 보이지 않음.

1. 사회적 규범을 따르지 못한다.

- 거짓말, 무단결석, 가출, 도둑질, 싸움, 물질 남용, 범법행위가 전형적인 환자의 **아동기 (6-12세)**에 시작되는 경험

- 사회 규범을 따르지 않고 생활 전반에 걸쳐 타인의 권리를 무시하고 침해하는 범죄적 또는 반사회 규범적 행동을 하는데, **범죄자와 같은 의미는 아니다.**

- **범죄행동: 물론 반사회성 인격장애 환자에서 나타날 수 있지만 무엇을 얻기 위한 행동이며 경직되고 부적응적이고 지속되는 인격 특성을 동반하지 않는다.**

- 자신의 반사회적 행동에 대해 **원래 하려던 바**가 아니었다고 설명함

2. 미래에 대한 심사숙고 또는 자신과 타인에 미칠 영향을 생각하지 않고 순간적으로 어떤 일을 결정한다.

3. 자신의 행동 결과에 대해 거의 자책x, **후회가 없고 양심이 결여되어 있다.**

4. 망상이나 비논리적 사고가 없으며, **오전한 현실검정능력과 언어지능을 가지고 있다.**

5. 종종 정상으로 보이고, 오히려 매력적이고 환심을 살 수 있다.

- 반대 성을 가진 임상가에게 다채롭고, 유혹하는 성격적인 면을 보여주나 동성은 마음대로 조절하려고 하며 요구가 많다.

- 사기꾼: 극도로 **다른 사람을 조종**

6. 역학

- 12개월 유병율은 0.2~0.3%

- 알코올 사용 장애 가진 남성(70% 이상)과 감옥에 있는 인구(75%)에서 가장 높다.

- 남성에서 더 흔하다.

- 나이들(예. 40대)과 함께 현저히 감소 완화된다.

반사회성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)

- 우월함(Superior), 걱정이 없음(unconcerned)

2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)

- 잘속음(Suckers), 열등함(inferior), 목적달성을 위한 수단(means to an end)

3. BELIEFS(신념)

- "사람들은 공격당하기 위해 그곳에 있었다."
- "내가 뭔가를 원한다면, 나는 그것을 얻기 위해 필요한 모든 것을 해야 한다."
- "만약 사람들이 자신을 돌볼 수 없다면, 그것은 그들의 문제다."
- 나는 나쁜 결과에 대해 걱정할 필요가 없다. 일을 회피할 수 있다

4. THREAT(위협)

- ???

5. STRATEGY(위협에 대한 전략)

- 원하는 것을 취함(Take what you want.)

6. AFFECT(정동)

- 짜증, 목표를 차단당하면 분노

치료적 관점

1. 거칠고 거절을 잘하며 지배적인 부모의 태도가 아동을 공격적이고 반사회적으로 만든다.

- 어린 시절의 신체적 학대 경험, 교사로부터의 낙인 경험, 대가족, 범죄자인 부모나 형제, 거칠고 엄격한 부모나 수동적이고 무관심한 부모, 부모 간의 갈등이 반사회적 성격특성을 증가시킨다.

2. 정신분석적 입장

- 반사회성 성격이 어머니와 유아 간의 관계형성의 문제에 기인한다.
- 기본적 신뢰가 형성되지 못하여 폭력적이고 파괴적인 방법으로 타인과 관계를 맺으려는 시도
- 타인의 입장에서 감정을 느끼는 공감능력이 발달하지 못하여 타인에게 상처를 입히는 것에 대한 불안이나 죄책감을 느끼지 못한다.
- 초자아가 발달하지 못해 도덕성이 부족하고 타인에 대한 배려의식이 결여되어 있다.

3. 인지적 입장

- "우리는 정글에 살고 있고 **강한 자만이 살아남는다**"
- "힘과 주먹이 내가 원하는 것을 얻는 최선의 방법이다."
- "들키지 않는 한 거짓말을 하거나 속여도 상관없다."
- "다른 사람들은 약한 자들이며, **당해도 되는 존재들이다.**"
- "내가 원하는 것을 이루기 위해서는 **어떠한 행동도 정당화될 수 있다.**"

- "내가 먼저 공격하지 않으면 **다른 사람들이 먼저 나를 공격할 것이다.**"

- "다른 사람이 나를 어떻게 생각하는지는 중요하지 않다."

치료

- 행동치료적 접근이 중요하다.

- 대부분 법원의 명령이나 중요한 사람에 의해 강제로 의뢰되는 경우가 많다.

- **내담자가 치료에 대한 진정한 동기를 지니고 있지 않기 때문에 치료가 어렵다.**

- 반사회성 인격장애자는 권위적 인물에 대해 저항하는 경향이 있으므로, **치료자는 중립적이고 수용적인 태도를 유지해야 하며 치료적 관계를 형성하는 것이 중요하다.**

- 심층적 심리치료보다는 **구체적인 중립적 부적응적 행동을 변화시키는 행동치료적 접근이 더 효과적이라고 알려져 있다.**

- 치료를 시작하기 전에, **확고한 제한**이 필수적이다.

- 치료자들은 환자의 **자기 파괴적인 행동**을 다루는 방법을 찾아야 한다.(**남을 쉽게 생각하듯 자기자신도 쉽게 생각함**)

- 반사회성 인격장애로 발전하지 않도록 문제아동이나 비행청소년에 대한 조기개입과 부모 교육을 통해 **예방적인 노력**을 기울이는 것이 중요하다.

경계성(경계선) 인격장애(Borderline Personality Disorder)

경계성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 대인관계, 자아상 및 정동에서의 불안정성, 심한 충동성이 광범위하게 나타나며, 성인기 초기에 시작하여 여러 가지 상황에서 일어난다. 다음 중 5가지(또는 그 이상) 항목을 보인다.

1. 실제적이거나 가상의 유기를 피하기 위한 광적인 노력
주의: 진단 기준5에 열거한 자살 또는 자해 행위는 포함되지 않음
2. 극적인 이상화와 평가 절하가 반복되는, 불안정하고 강렬한 대인관계 양식
3. 정체감 혼란: 심각하고 지속적인, 불안정한 자아상 또는 자아 감각
4. 자신에게 손상을 줄 수 있는 충동성이 적어도 2가지 영역에서 나타난다(예: 낭비, 성관계, 물질 남용, 무모한 운전, 폭식)
주의: 진단 기준5에 열거한 자살 또는 자해 행위는 포함되지 않음
5. 반복적인 자살 행동, 자살 시늉, 자살 위협, 자해 행위

6. 현저한 기분의 변화에 따른 정동의 불안정성(예: 간헐적인 심한 불행감, 과민성, 불안 등이 수 시간 정도 지속되지만 수 일은 넘지 않음)
7. 만성적인 공허감
8. 부적절한 강렬한 분노 또는 분노를 조절하기 어려움(예: 자주 울화통을 터뜨림, 항상 화를 내고 있음, 자주 몸싸움을 함)
9. 일과성으로, 스트레스에 의한 망상적 사고 또는 심한 해리 증상

경계성 인격장애의 특징

• Key point

- 충동적이고 자신에게 해가 되는 행동들(성적인 모험, 현명하지 못한 소비, 물질남용이나 과도한 음식섭취)을 함.
- 정동이 불안정하고 종종 강렬하고 부적절한 분노를 보임.
- 공허하거나 지루하다고 느끼며, 버림받는 것을 필사적으로 피하려 함.
- 자신이 누구인지가 불확실하고 안정적인 대인관계를 유지할 수 있는 능력이 결여되어 있음.

1. 신경증과 정신병의 경계

2. 불안정한 정동, 행동, 대상관계, 자아상

- Mood swings(감정기복)이 매우 심하다.
- 자기 파괴적인 행동을 반복적으로 나타냄(자해)
- 다른 사람의 도움을 구하기 위해, 분노를 표현하기 위해, 또는 압도하는 정동으로부터 스스로 무감각해지기 위해, 그들의 손목을 긋거나 다른 신체부위를 절단(행동화)

3. 떠들썩한 대인관계

- 가까운 사람들(ex. 연인)에게 의존적이고, 이러한 관계가 좌절되면 그들의 가까운 친구에게 엄청난 분노를 표현할 수 있다.
- 혼자되는 것을 견딜 수 없어서 연대를 정신없이 찾는다. 외로움을 누그러뜨리기 위해, 짧은 기간동안이라도 낯선 사람을 친구로 받아들이거나, 성적으로 난잡하게 행동한다

4. 만성적인 비어있는 느낌과 지루함, 자아감각에 대한 결여

5. 짧은 기간 정신병적인 삽화⁸기간을 갖기도 한다.

6. 역학

- 인구의 1~2% 경계성 인격장애
- 여성이 2배 정도 많음

경계성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)

- 불안정(Unstable), 깨지기 쉬움(fragmented), 무기력한 피해자(helpless victims)

2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)

- 모든 삶 속 문제의 원인이자 대담

3. BELIEFS(신념)

- 나는 사랑받지 못할 존재이다.
- 내 욕구를 충족시키고, 나를 위해 강해지고, 나를 돌봐줄 사람은 없다.
- 나 스스로 대처할 수 있는 게 없다.
- 나는 의존할 누군가가 필요하다.

4. THREAT(위협)

- 버려짐(Abandonment)

5. STRATEGY(위협에 대한 전략)

- 사랑의 요구함, 사랑을 시험함

6. AFFECT(정동)

- 분노, 우울, 불안

치료적 관점

1. 정신분석적 입장

- 유아기의 분리-개별화 단계에 고착됨
- 정상적인 애착 안에서 건강한 분리가 일어날 수 있다. 애착이 안정적이지 못하다면 분리가 잘 이루어지지 않아 독립을 하지 못한다. 이러면 엄마가 사라지고 자신이 버림받는 것을 두려워하게 된다.
- 엄마가 사라지고 자신이 버림받게 되는 것에 대한 강렬한 두려움을 경험하는 유아기의 위기를 반복적으로 재경험
- 아이는 안정되고 통합된 자아상과 엄마상을 내면화하지 못한다.

⁸ 정신병적 삽화: 와해된 언어, 와해된 행동, 환시, 환청 등

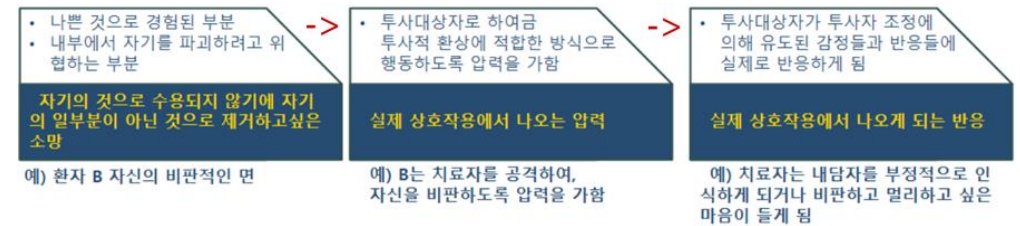
- 좋은 엄마와 나쁜 엄마가 사실은 동일한 존재라는 것을 수용하지 못한 채 분리(splitting)의 방어기제를 통해 엄마에 대한 양극적인 표상(좋다/나쁘다)을 분리하여 지니게 된다.
 - 불안정한 엄마상은 결국 불안정한 자기상을 초래한다.
 - **투사적 동일시**(projective identification): 자신의 받아들이지 못하는 면을 다른 사람에게 투사하고, 다른 사람은 투사된 역할을 하게 되고, 두 사람의 역할은 일치하게 된다.
 - 분리(splitting): 좋은 사람은 이상화시키고 나쁜 사람은 무가치화시킴
2. 경계선 인격장애자의 72%는 언어적 학대, 46%는 신체적 학대, 26%는 성적학대, 76%가 부모의 양육태만, 74%가 18세 이전에 부모의 상실이나 이별을 경험.(양육과정이 경계성 인격장애에 크게 영향을 미친다.)

투사적 동일시

- 자신이 감당하지 못하는 내적 상태, 감정, 내적 메시지 등을 타인으로 하여금 실행하도록 만들어버리는 무의식적인 조종 같은 것이다.
- 일상에서 주로 흔하게 만나게 되는 투사적 동일시는 예를 들면, 통제적인 사람-의존적인 사람 사이
- 의존성이 있는 사람은 누군가에게 계속 자기 대신 결정하게 만들고, 사소한 것도 정하지 못하여 일일이 확인하고 의지하는 태도를 가진다.
- 의존성이 강렬한 이들의 내적 상태: "나 혼자서는 아무것도 할 수 없어. 나는 혼자서는 무가치한 존재야."
- 하지만 이런 내적 상태를 스스로 인정하고 다룰 힘이 없어서 상대로 하여금 자신이 그런 사람임을 확인시켜주게 만든다.
- 상대로 하여금 결국 자신을 무시하게 만들고 나면 결국 '거봐, 나는 이렇게 저 사람에게 무시당하는 가치 없는 사람이잖아.'라며 더 깊이 자신의 내적상태를 황폐하게 만듦.
- 또다시 누군가 없이는 스스로 살 수 없는 사람임을 스스로 증명해내려는 듯이 지속적으로 투사적 동일시를 반복
- 유발반응: 돌봄
- 투사적 동일시를 멈추게 하기 위해서는 내가 스스로 이런 생각을 하고 있다는 사실을 깨닫게 해줘야 한다.

투사적 동일시의 예

- 환자B: (따지듯이) 당신들 정신과 의사들이란 사람을 판단하기만 좋아해, 난 당신이 무슨 생각하건 눈곱만큼도 관심이 없어요!
- 여기서 B는 자신의 비판적 태도를 투사하여 치료자에게 전가하고 있음. 비판적이고 까다로운 검열관 같은 것은 자기 자신임에도 이를 치료자의 마음 상태라고 절대적으로 믿고 있음. 그렇기에 B는 이런 태도로 치료자가 '계획하고 있는' 공격에 대하여 선제공격을 감행하고 있는 것
 - 이때 치료자에게 불러일으켜지는 반응: 환자에 대해 호감도 안 생기고, 쉽게 판단하게 되고, 굳이 애써서 환자를 돌보고 싶은 마음이 들지 않게 됨. 이것은 바로 B가 믿고 있는 바로 그러한 사람처럼 느끼게 되는 정서적 반응인 셈이다. → 투사적 동일시 실현



치료적 관점

1. 인지적 입장

- "세상은 위험하며 악의에 가득차 있다." → 세상에 대한 부정적 믿음
- "나는 힘없고 상처받기 쉬운 존재이다" → 삶에 대한 불안과 두려움, 다른 사람에게 의존적
- "나는 원래부터 환영받지 못할 존재이다" → 불안정한 관계, 버림받는 것에 대한 두려움
- **흑백논리적 사고**
 - '천사 아니면 악마'
 - '수용 아니면 거부'
 - '천국 아니면 지옥'
 - '의존 아니면 공격'
 - 극단적인 흑백논리적 사고로 인해 강렬한 감정변화와 극단적인 행동을 보이게 된다.

2. 심리치료는 환자와 치료자 모두에게 어렵다.

- 환자는 쉽게 퇴행하고, 충동적으로 행동하고, 쉽게 불안정하고, 분석하기 어려운 긍정적인 전이 혹은 부정적인 전이에 고착된다.
- 치료자는 환자의 충동과 분노폭발을 조절하고, 비판과 거부에 대한 과민함을 감소시키기 위해 행동치료를 사용함.
- 특히 비디오 테입 다시보기를 통한 사회기술훈련은 환자가 그들의 행동이 타인에게 어떤 영향을 미치는지 보도록 도와줌으로써 대인관계 행동을 증진시킴.

변증법적 행동치료

- 극과 극의 마음을 오가는 것을 중간지점으로 찾아가게 도와주는 방법
- 일주일에 한 번 개인 심리치료와 집단 기술 훈련 회기
- 모델링, 교육, 행동 연습, 피드백, 코칭 등과 같은 기술 훈련 과정과 과제를 매우 강조

1. 마음챙김 기술

- 지금 이 순간에 머무르면서 충분한 경험을 하는 것
- 자신을 있는 그대로 바라보는 것이 가능해지므로 자아존중감을 높이는데 도움

2. 고통감내 기술

- 고통스러운 상황의 영향으로부터 완화시키는 새로운 방법을 알려준다
- 고통스러운 상황에서 주의를 다른 곳으로 돌리는 방법, 자기위안, 그저 온전하게 상황을 받아들이는 방법, 신체를 이완하는 방법

3. 정서조절기술

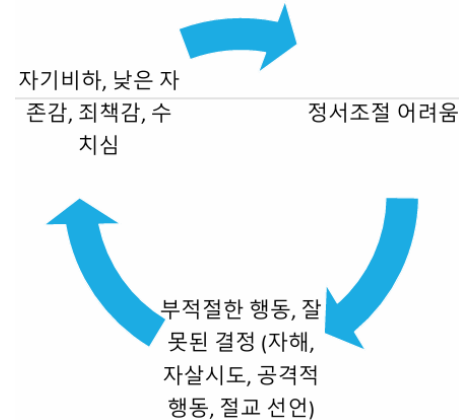
- 자신의 감정을 보다 분명하게 알아차리도록 도우며 압도적인 감정에 휩쓸려가지 않고 그런 감정을 관찰하도록 도와 자신이나 타인에게 파괴적인 방식의 행동을 하지 않고 감정을 조절하도록 한다.
- 감정조절이 잘 되지 않는 여러가지 상황들을 분석하고 이런 상황에서 할 수 있는 대처방법들을 고민하고 일상생활에서 이용한다.

- **마음의 방: 압도적인 감정에 휩쓸리지 않는 힘을 길러주는 것**

4. 대인관계 효과성 기술

- 원하는 것을 얻는 것, 대인관계를 원만하게 유지하는 것, 자아존중감을 유지하는 것
- 자신의 자아존중감을 유지하면서 일관성 있고 유익한 관계를 유지하는 데 어려움을 지닌 사람들에게 도움이 된다
- 부정적인 결과를 만들어내는 스스로의 대인관계 패턴이 어떤지 확인하고 자기 주장하

는 법, 거절하는 법, 갈등이 있을 때 타협하는 법 등



마음헤아리기치료(MBT): 정신화 작업

- 내 마음과 상대방의 마음이 어떻게 흘러가고 있는지를 헤아릴 수 있는 능력을 향상시키기 위한 치료
- 생각이나 감정반응이 시작된 마음속의 출발점과 그것이 흘러온 과정을 이해하는 것
- 나에게 지금 떠오른 생각, 감정, 충동 등을 머릿속에 붙잡아두고 그 생각이나 감정이 어떤 자극으로부터 시작되었고 중간과정이 어떻게 흘러가서 지금의 생각이나 감정으로 이어졌는가를 되짚어 생각해보는 것
- 마음 헤아리기(정신화): 아이의 출생 후 아주 원초적인 단계에서부터 애착 대상인 부모가 아이의 마음을 알아차리고(교감) 이를 상호작용으로 표현해주는 것
- 부모가 아이의 마음을 잘 헤아려서 울고 있는 아이의 욕구(밥, 똥 등)를 잘 실행시켜준다면 아이는 자신의 마음에 대해 잘 알 수 있고 부모로 인해 만족감을 느낄 수 있다.
- 부모가 아이의 마음을 잘 헤아리지 못한다면 아이는 '내가 우는 이 감정은 뭐였지?'라고 혼란스럽게 되고 만족감을 느끼지 못하며, 이질적 자아가 들어오게 된다.

Ex) "아빠, 엄마, 나 요즘 너무 힘들어요" 라는 말에 "네가 뭐가 힘들어? 네가 힘든 것은 힘든 게 아니야" → (아이의 마음속) 내 맘 몰라주는 부모님 원망스러워 + (한편으로는) '아 내가 힘들면 안되는 거구나, 힘들어하는 내가 이상한 거구나' = 양가적인 마음, **정신화에 실패한 이질적 자아, 나도 내가 싫어요.**

- 두 마음 중 하나를 선택해야 하는 것이 아닌 두 마음 다 내 마음 안에 있고 있을 만하니가 있는 것이라고 인정한 후 그렇다면 거기서 어떻게 나아가는 것이 좋을지 고민하는

것이 치료이다.

전이초점정신치료(Transference-Focused Psychotherapy)

- Otto Kernberg의 대상관계이론을 기반으로 경계성 인격장애 치료를 위해 정신역동심리 치료를 수정한 것
- 두가지 과정으로 이루어진다.

1. **밝힘(clarification)**: 전이를 전통적인 심리치료에 비해 더욱 직접적으로 분석하는 것이다. 직접적으로 분석하기 때문에 치료자는 그의 비뚤어짐을 빠르게 알아차릴 수 있다.
2. **직면(confrontation)**: 치료자는 이러한 전이의 비뚤림이 대인관계를 어떻게 방해할 수 있는지를 보여준다.

- 밝힘과 직면의 과정을 통해 내가 자동화 사고를 어떻게 갖고 있었는지, 그리고 그것이 내 삶을 얼마나 불안하게 만들고 있었는지 알게된다.

- 경계성 인격장애 환자들의 특징인 분리가 불안을 방어하기 위해 사용된다.
- 만약 치료가 성공적이면, 분리를 사용할 필요가 감소하고, 대상관계가 호전된다.

Ex) 지난 번에 영희씨는 그 남자가 너무나도 매력적이고 훌륭하고 자신을 세심하게 잘 살피준다고 이야기하셨어요. 그런데 오늘은 너무도 형편없고 믿을 수 없고 냉정하다고 말하고 있군요. 잠시 생각해 봅시다. 이 두 가지 말을 놓고 보면 무슨 생각이 나죠? 이 두 가지를 어떻게 연결시킬 수 있을까요?

- 교수님은 치료자가 환자에게 직접적으로 알려주는 것이 효과적인지 의문이 든다고 하신다. 누가 지적해서 알려주기 보다는 스스로 깨닫고 해결할 수 있도록 돕는 것이 더 좋다고 생각하심.

CASE

- 33세 여성 우울 기분, 만성적 자살사고, 사회적 고립, 낮은 수준의 개인 위생 상태에 대한 치료를 받기 위해 내원
- 지난 6개월간 자신의 아파트에 칩거하면서, 대부분의 시간을 침대에 누운 채 인스턴트 식품을 먹고, TV를 시청하며, 온라인 쇼핑을 통해 지불 능력을 초과하는 액수의 물건을 구입하면서 지냈음.
- 학교생활 내내 고립감을 느꼈고, 우울 기분이 재발되곤 했음.
- 고등학교 때는 공부를 잘했으나, 대학에서는 룸메이트와 대학교수에 대한 실망 때문에 중퇴했음.

- 직장상사들이 바보천치들이고 얼핏보면 대단해 보이는 것 같지만, 자세히 보면 모두 한결같이 꼬여 있기 때문에 계속해서 일을 그만두게 되었음.
- 차라리 죽는 것이 낫겠다고 지속적으로 생각한 적이 있었고, 수차례 자신을 칼로 살짝 그었던 일이 있었음.
- 자신이 대체로 풀이 죽어있고 우울하다고 했으나, 1~2일 동안 지속되는 조증을 10 여 차례 겪었다고 했음. 조증 증상이 나타날 때면, 기운이 펄펄 났고, 안절부절못했으며, 밤을 꼬박 새곤 했고, 그러다가 다음 날에는 '추락'하여 12시간 동안 깊은 잠에 빠지곤 했음.
- 17세부터 정신과 치료를 받았고, 약물 과다복용으로 세 차례 정신과 병동에 입원한 적 있음.
- 면담을 마칠 무렵, 면담자가 시계를 보자, 그녀는 "아니 벌써 지루하세요?"라고 소리 지르며 화를 냈음.

→ 경계성 인격장애, 기분부전장애

- 정서불안, 분노 통제 곤란, 불안정한 대인관계, 정체성 장애, 자해행동, 공허감
- 경계성 인격장애가 있는 사람들은 흔히 우울증, 양극성 장애 증상들을 나타냄.
- 주요우울장애 진단기준에도 부합됨.(경계성 인격장애와 우울장애 동반이환 흔함.)
- 경계성 인격장애 환자는 비난성인 반면, 인격장애를 동반하지 않은 상태의 우울증의 전형적인 집착은 죄책감과 자기비난임.

히스테리성(연극성) 인격장애(Histrionic Personality Disorder)

히스테리성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 광범위하고 지나친 감정 표현 및 관심끌기의 행동 양상이 성인기 초기에 시작하여 여러 가지 상황에서 나타나며, 다음의 5개(또는 그 이상) 항목을 보인다.

1. 자신이 관심의 중심이 되지 못하는 상황에서 불편해한다.
2. 다른 사람과의 행동에서 흔히 상황에 어울리지 않게 성적으로 유혹적이거나 도발적인 행동이 특징적이다.
3. 빠른 감정의 변화 및 감정 표현의 천박성(淺薄性)을 보인다.
4. 자신에게로 관심을 끌기 위해서 지속적으로 육체적 외모를 사용한다.
5. 지나치게 인상적으로 말하면서도 세부내용은 없는 대화 양식을 갖고 있다.
6. 자기 연극화, 연극조, 과장된 감정 표현을 한다.

7. 피암시성이 높다(예: 타인 또는 환경에 의해 쉽게 영향을 받음).⁹
 8. 대인관계를 실제보다 더 친밀한 것으로 생각한다.

히스테리성 인격장애의 특징

• Key point

- 과도하게 감정적이고, 모호하며, 관심을 간절히 원하며, 자신의 매력에 대해 끊임없이 확인받기를 원함.
- 자기중심적이고 성적으로 유혹적일 수 있음.

1. 흥분되고, 정서적이고, 다채롭고, 극적으로, 외향적으로 행동함

- 주의-찾기 행동(attention-seeking behavior)
 1. 관심의 중심이 되지 않거나 칭찬이나 승인을 받지 못하면 분노, 눈물, 비난을 격정적으로 표현함.
 2. 유혹적 행동이 흔함.
 3. 인정에 대한 욕구가 끝이 없음.

2. 타인과의 깊은 관계에서 어떤 역할(ex. 희생자 역할 or 공주 역할)을 수행하며, 관계가 피상적

- 깊고, 장기간 지속되는 애착 관계를 유지하지 못한다.

3. 대체로 인지검사는 정상

4. 역학

- 약 1~3%의 유병율
- 정신과적 임상에서 10~15%
- 신체화 장애와 알코올 사용 장애와 연관 있음
- 여성에게 더 자주 나타남
- 나이가 들에 따라 증상이 줄어듦

치료적 관점

1. 정신분석적 입장

- 오이디푸스 갈등에 기인: 엄마의 애정부족에 실망을 느끼고 자신의 의존 욕구를 충족시켜줄 대상으로서 아빠에게 집착하며 아빠의 주의를 얻기 위해 애교스럽고 유혹적이

며 과장된 감정표현 양식을 습득

- 남근기에 고착된 사람은 성적으로 유혹적이며 노출증적이고 감정이 풍부하며 자기중심적인 성향이 있음

2. 인지적 입장

- 나는 부적절한 존재이며 혼자서 삶을 영위하는 것은 너무 힘들다.
- 나를 돌봐줄 사람들을 찾아야 한다.
- 모든 사람으로부터 사랑을 받아야 한다.
- 내가 행복하려면 다른 사람의 관심과 애정이 절대적으로 필요하다.
- 나는 다른 사람의 사랑을 독점적으로 가장 많이 받아야 한다.
- 나는 재미있고 다른 사람에게 즐거움을 주는 사람이어야 한다.
- 내가 원하는 것을 얻으려면 다른 사람이 즐겁거나 감탄하도록 만들어야 한다.
 - 적극적으로 관심과 애정을 추구. 애정을 얻기 위한 방법으로 외모, 애교나 유혹, 과장된 표현, 재미있는 행동을 주로 사용하게 된다.

치료

1. 내적감정 명료화

- 히스테리성 인격장애 환자들은 종종 그들의 진정한 감정을 느끼지 못한다. 그들의 내적 감정을 명료화시키는 것이 치료과정에서 중요하다.(히스테리성 인격장애자들은 자신의 진정한 감정의식이 저하되어 있으므로, 자신의 내적감정을 명료화하는 것이 중요하다.)

- 주변의 눈치는 잘 살피며 감정의 영향을 많이 받지만 정작 자기자신의 감정을 잘 알아차리지는 못한다.

2. 대인관계 문제에 초점

- 애정을 얻기 위해 외모, 성, 유혹, 불평, 위협 등의 방법을 사용하여 타인을 조종하려 하지만 이러한 대인관계 방식이 일시적인 효과를 거둘 수 있을지는 몰라도 장기적으로는 타인의 애정을 잃는 결과를 초래하게 된다.
- 애정을 얻을 수 있는 적절한 현실적인 방법을 습득시킨다.

⁹ 피암시성: 타인의 암시를 받아들이고 그에 따라 행동하는 경향

CASE

- 50세 여성
- 허리 통증 때문에 죽을 지경으로 호소하며 응급실 내원함.
- 허리 통증은 며칠 전 수년간 일해 온 가족 소유의 식품점에서 넘어지면서 생긴 것이라고 하였음. 그녀는 낙상한 일과 이 사건이 어떻게 수년 전에 낙상했던 일을 떠올리게 하는지에 대해 장황하게 설명함. 당시 그녀는 신경외과 전문의를 찾아갔는데 담당 의사는 그녀에게 휴식을 취하라는 말과 함께 NSAIDs를 처방하였음. 그녀는 의사로부터 버려진 느낌이 들었고, 전혀 배려받고 있다는 느낌이 들지 않았다고 말했음. 넘어진 일과 관련된 사건들에 대해 이야기하는 동안 울기 시작했음.
- 자살에 대해서는 남편에게 교훈을 주기 위한 단순한 위협이었다고 하였음. 남편이 자신에 대해 동정심을 보이지 않았고, 넘어진 이후에도 지지적이지 않았기 때문이라고 하였음. 면담자가 자살의 가능성에 대해 관심을 표하자 미소를 지으며 "그렇게 심각한 것인 지 잘 몰랐네요, 다시는 그렇게 하면 안되겠네요"라고 말하며 어깨를 들썩이며 웃었다. 남편은 환자가 자살에 대해 "마치 다른 사람들이 날씨에 대해 불평하는 것처럼 말한다. 내가 걱정하게 하려고 애쓰지만 더 이상 효과가 없다"라고 말했음.
- 응급실에서 '웃을 잘 입은 여성'이라고 말해준 남성 레지던트에게 추파를 던졌음.

→ 히스테리성 인격장애

- 시선의 중심이 되지 않는 경우의 불편감, 유혹적 행동, 강렬하지만 변화무쌍 하고 피상적인 정서성, 시선을 끌기 위한 신체적 외모의 사용, 자기극화 및 연극조, 관계를 실제보다 더 친근한 상태로 간주하는 경향성
- 눈물과 쾌활함 사이를 급속히 오감.
- 유혹적인 태도, 응급실에서조차 신체적 외모에 대해 관심을 보임.

자기애성 인격장애(Narcissistic Personality Disorder)

자기애성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 과장성(환상이나 행동에서), 칭찬에 대한 욕구, 감정이입의 결여 등의 광범위한 양상이 성인기 초기에 시작되어 다양한 상황에서 나타나며, 다음의 5개(또는 그 이상) 항목을 보인다.

1. 자신의 중요성에 대한 과장된 지각을 갖고 있다(예: 자신의 성취나 재능을 과장함, 뒷받침할 만한 성취도 없으면서 최고로 인정되기를 기대함).
2. 끝없는 성공, 권력, 탁월함, 아름다움, 또는 이상적인 사랑에 대한 환상에 사로잡혀 있다.
3. 자신이 특별하고 독특하다고 믿고, 특별한 사람이나 상류층의 사람들만이 자신을 이해할 수 있고, 또한 그런 사람들(혹은 기관)하고만 어울려야 한다고 믿는다.
4. 과도한 찬사를 요구한다.
5. 특권의식을 가진다. 예를 들면, 특별대우를 받을 만한 이유가 없는데도 특별대우나 복종을 바라는 불합리 한 기대감을 가진다.
6. 대인관계가 착취적이다. 예를 들면, 자기 자신의 목적을 달성하기 위해 타인들을 이용한다.
7. 감정이입 능력이 결여되어 있다. 타인들의 감정이나 요구를 인정하거나 확인하려 하지 않는다.
8. 자주 타인들을 질투하거나 타인들이 자신에 대해 질투하고 있다고 믿는다.
9. 거만하고 방자한 행동이나 태도를 보인다.

자기애성 인격장애의 특징

• Key point

- 자만심이 강하고 종종 질투심을 느끼거나, 성공에 대한 환상에 몰두되어 있고, 그들 자신의 문제의 특별함에 대해 몰두함.
- 특권의식과 동정심의 결여로 인해 다른 사람들을 이용함.
- 비판을 강하게 거부하고 지속적인 관심과 찬양을 원함.

1. 자기를 과대평가함

- 자신 스스로를 특별하다고 생각하고, 특별한 대접을 받기를 원한다.

2. 공감 능력이 결여

- 공감 능력을 보이지 않고, 그들의 이기적인 목표를 얻기 위해 공감하는 척 가장한다.
- 3. **자존감이 약하고** 작은 비판에도 취약함
 - 다른 사람이 그들을 비판하면 분노하거나 비판에 대해서 완전히 무관심을 표한다.
 - 깨지기 쉬운 자존감 때문에 우울감에 빠지기 쉽다.
- 4. 역학
 - 자기애성 인격장애 1~6%
 - 미, 힘, 젊음에 가치를 두기에 노화를 견디기 힘들어해서 **다른 인격장애보다 중년의 위기가 크다.**

자기애성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)
 - 우월함(Superior), 특별함(special)
2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)
 - 낮은 평등(less equal), 하인들 (servants), 위협(threat)
3. BELIEFS(신념)
 - 나는 특별하고 다른 사람들은 내가 얼마나 특별한지 알아야해.
 - 누구의 필요도 나의 필요를 방해해서는 안돼
 - 내가 마땅한 존경을 받지 못하거나 내가 받을 자격이 없다면 참을 수 없어/
4. THREAT(위협)
 - 평범하게 되는 것
5. STRATEGY(위협에 대한 전략)
 - 특별 대우를 요구, 타인을 시기
6. AFFECT(정동)
 - 분노

치료적 관점

1. 프로이트
 - **병적인 자기애: 유아기적 자기애**에 고착되어 성인이 되어서도 여전히 사랑의 대상이 자기 자신에게 집중되는 경우

2. Kohut: **유아기의 웅대한 자기상에 대한 좌절경험이 없거나 또는 좌절경험이 너무 심하면 자기애성 인격장애로 발전될 수 있다.**

3. 인지적 입장

- "나는 매우 특별한 사람이다"
- "나는 너무나 우월하기 때문에 특별한 대우를 받고 특권을 누릴 자격이 있다."
- "인정, 칭찬, 존경을 받는 것은 매우 중요한 일이다"
- "내가 당연히 받아야 할 존경이나 특권을 받지 못하는 것은 참을 수 없는 일이다."
- "사람들은 나를 비판할 자격이 없다"
- "나 정도의 훌륭한 사람만이 나를 이해할 수 있다."

치료

- **나르시스트 환자가 무리한 요구를 한다면 공감해주면서 적절한 선을 그어주는 것이 효과적이다. 이것까지는 해드릴 수 있지만 그 이상으로는 해드릴 수 없어요~**

1. Kohut

- 전이현상을 잘 활용
- **내담자의 욕구를 충분히 공감하고 이해해주는 것이 중요!** 공감, 이해를 안 해주면 오히려 계속 물고 늘어진다. 반대로 공감, 이해를 해주면 이것 가지고 날을 세우는 않는다.
- 내담자가 공감, 이해를 받게 되면 어린 시절에 받은 자존감의 상처를 회복할 수 있게 되어 자기애성 성격특성이 완화됨.

2. Kenberg

- 자신의 부정적이고 열등하며 수치스러운 점들을 받아들이 수 없기 때문에 이를 무의식 속에 묻어두고 대신 자신의 긍정적이고 우월한 점들을 자꾸 생각하고 과시하려는 경향
- **두 가지 양극화된 자신의 측면을 스스로 통합할 수 있도록 하는 것이 치료 목표**

3. 인지행동치료

- 웅대한 자기상: 우월하지 않으면 완전히 무가치한 것으로 생각하는 이분법적 사고경향
- 평가에 대한 과도한 예민성: 자신에 대한 타인의 평가에 적당한 관심을 기울이고 그에 대한 감정반응을 조절할 수 있도록 유도

- 공감의 결여: 타인의 감정에 대한 자각을 증진시키고 공감적 감정을 활성화시키며 이
기적인 착취행동을 수정하도록 유도

- 치료자는 사소한 지적에도 민감한 환자의 특성을 기억해야 한다.
- 집단치료가 어떻게 타인과 나눌 수 있는 가를 배우는데 좋고, 공감반응을 발달시키는데
좋다고 한다. **자신의 편협한 생각이 틀렸다는 것을 느끼며 자기애적 인지를 고쳐야 하
는데 이때 집단치료가 효과적이다.**

[4] C군 인격장애

- 억제되어 있고, 불안해보이고, 두려워함
- 불안하고 긴장하며, 종종 과잉통제적인 경향이 있음
- 종류: 강박성(obsessive-compulsive), 의존적(dependent), 회피성(avoidant)

회피성 인격장애(Dependent Personality Disorder)

회피성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 사회활동의 제한, 부적절감, 그리고 부정적 평가에 대한 과민성 등이 광범위하게 나
타나고, 성인이 초기에 시작되어 여러 가지 상황에서 나타나며, 다음의 4개(또는 그
이상) 항목을 보인다.

1. 비난, 야유, 또는 거절이 두려워서 대인관계가 요구되는 직업 활동을 회피한다.
2. 호감을 받고 있다는 확신이 서지 않으면 타인과 연루되는 것을 꺼린다.
3. 창피와 조롱을 당할까 두려워서 친밀한 관계를 제한한다.
4. 사회 상황에서 비난이나 거절당할 것이라는 생각에 사로잡혀 있다.
5. 자신이 부적절하다고 느끼기 때문에 새로운 사람과 만날 때는 위축된다.
6. 스스로를 사회적으로 무능하고, 개인적인 매력이 없으며 열등하다고 생각한다.
7. 찢찢매는 모습을 들킬까봐 두려워서 새로운 일이나 역할을 하기를 심하게 꺼린다.

회피성 인격장애의 특징

• Key point

- 소심하고 비판에 쉽게 상처를 받기 때문에 다른 사람들과 얽히게 되는 것을 주저함.
- 감정을 드러내거나 바보같이 보이는 행동을 해서 당황하게 되는 것에 대한 두려움을
갖기도 함.
- 가까운 친구가 없을 수 있고, 일상적인 과업 외의 일을 맡는 것에서 위험을 과도하게
지각함.

1. **거부에 대하여 극도로 민감**하고, 이로 인해 사회적 소외를 보인다.

- 면접자와 이야기하는 것에 대해 불안함.
- 이 장애를 갖고 있는 사람들은 **사회적 공포증**의 과거력을 갖고 있거나 현재도 갖고
있는 경우가 많다.

- **감정적인 모습, 바보 같은 모습을 보이는 것에 대한 두려움이 있다.**

2. **이면에는 대인관계를 강하게 원하는 특징**이 있음

- 사회적 참여에 대한 강렬한 욕구
- 비판이 없는 수용을 원한다
- **혼자 있고 싶어하는 분열성 인격장애 환자와 달리 사회적 상호작용을 원한다.(But 상
처받을까봐 주저함)**

3. 흔히 **열등감**을 갖고 있다.

4. 역학

- 유병률 2~3%

회피성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(**자신을 어떻게 보는지**)

- 사회적으로 서투름(Socially inept), 학술적, 일적으로 무능력함(incompetent in academic
and/or work situations)

2. VIEW OF OTHERS(**타인을 어떻게 보는지**)

- 잠재적으로 비판적(critical), 흥미없음(uninterested), 품위를 떨어뜨림(demeaning)

3. BELIEFS(**신념**)

- 나는 별로고 쓸모 없고 가치 없고, 사랑스럽지 않다.
- 나는 불쾌한 감정을 참을 수 없다.
- 만약 사람들이 날 가까이한다면, 그들은 '진짜 나'를 발견하고 나를 거절할 것이며 그

것을 참을 수 없을 것이다. 따라서 위험한 개입으로부터 멀리하는 것이 최선이다.

4. THREAT(위협)

- 거부(Rejection), 비하(demeaned), 모욕(humiliation), 밝혀짐(found out)

5. STRATEGY(위협에 대한 전략)

- 회피

6. AFFECT(정동)

- 불쾌감(Dysphoria): 불안, 슬픔

치료적 관점

- 기질적으로 수줍고 억제적인 경향
- **위협에 대한 과도한 생리적 민감성**: 교감신경계의 역치가 낮아서 사소한 위협적 자극에도 교감신경계가 과도하게 활성화된다.
- 정신분석적 입장: **수치심**-자신에 대한 부정적 자아상과 관련
- 인지적 입장: **자신이 부적절하고 무가치한 사람이며 타인과의 관계에서 거부당하거나 비난당할 것이라는 믿음**
 - “사람들이 나를 바보로 생각할거야”
 - “역시 나는 매력이 없어”
 - “다른 사람이 나를 비판할지 몰라”
 - “그들은 나를 싫어할거야”
 - 타인이 분명한 호의를 보이지 않으면 거부나 비난으로 해석하는 이분법적 사고
 - 타인의 긍정적인 반응은 무시하고 부정적인 언급은 중시하는 의미확대 및 의미축소
 - 부정적인 증거에만 주의를 기울이는 정신적 여과

치료

- 진료에서 **환자와의 유대관계**를 공고히 하는 것이 중요함
 - 점차 신뢰관계(Rapport)가 형성되면 환자의 거절에 대한 두려움에 수용적인 태도를 보이는 것이 좋다.
 - 대인관계 및 사회생활에서의 기술을 숙제로 낼 때는, 실패로 인해 환자의 낮은 자존감이 재차 강화되지 않도록 신중할 필요가 있다.
- 집단치료는 환자가 거부에 대한 민감성이 어떻게 그들과 타인에게 작용하는지를 이해하는데 도움이 된다.

1. 정신역동적치료

- 수치심의 기저에 깔려 있는 심리적 원인을 살펴보고 과거 발달과정에서 경험한 일들과의 관련성을 탐색한다.
- 자신의 가족을 보호하려는 내적 소망과 그들을 미워하고 원망하고 싶은 욕구 사이에서 갈등을 경험하기 때문에 내담자는 저항을 나타낼 수 있다. **치료자는 변함없는 지지와 수용적인 자세를 유지함으로써 내담자의 저항을 극복하는 것이 중요하다.**

2. 인지행동치료

- 불안과 긴장을 스스로 조절할 수 있는 **긴장이완이나 복식호흡 훈련** 등을 실시하고 **사회적 상황에 대한 점진적 노출**
- 사회적 상황에서 자연스럽게 대처할 수 있는 **대인관계 기술을 훈련**

- 3. **Assertiveness training**(적극성 치료): 타인의 권리와 감정을 존중하면서 자기주장을 표현할 수 있도록 돕는 개입기술. 환자가 그들의 욕구를 자유롭게 표현하고 자신감을 증진시키는데 좋다.

의존성 인격장애(Dependent Personality Disorder)

의존성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

A. 보호받고 싶어하는, 광범위하고 지나친 욕구로 인하여 복종적으로 되고 상대방에게 매달리고, 헤어짐을 두려워하며, 성인기 초기에 시작되며, 여러 가지 상황에서 나타나고, 다음 중 5개(또는 그 이상) 항목을 보인다.

1. 타인의 많은 충고와 보장이 없이는 일상적인 일도 결정을 내리지 못한다.
2. 자신들의 인생에서 매우 중요한 영역까지도 책임져 줄 수 있는 타인을 필요로 한다.
3. 지지와 칭찬을 상실할 거라는 두려움이 크기 때문에 타인, 특히 의지하고 있는 사람에게 반대 의견을 말하기가 어렵다.
주의: 현실적인 보복의 두려움은 포함되지 않는다.
4. 자신의 일을 혼자서 시작하거나 수행하기가 어렵다(동기나 활력의 부족보다는 판단과 능력에 대한 자신감이 부족하기 때문이다).
5. 타인의 보살핌과 지지를 얻기 위해 무슨 행동이든 다할 수 있다. 심지어는 불쾌한 일도 그렇게 하여 보호만 얻어낼 수 있다면 자원해서 한다.

6. 혼자 있으면 불편하고 무력해지는데, 그 이유는 혼자서 해나가다가 잘못될 것 같은 심한 두려움을 느끼기 때문이다.
7. 친밀한 관계가 끝났을 때 필요한 지지와 보호를 얻기 위해 또 다른 사람을 즉시 찾는다.
8. 스스로를 돌봐야 하는 상황에 처하게 된다는 데 대한 두려움에 비현실적으로 사로잡혀 있다.

의존성 인격장애의 특징

• Key point

- 타인의 승인에 대한 욕구가 너무나 강해서 독립적인 결정을 내리지 못하고, 과제를 시 작하기가 어려움.
- 이들은 다른 사람이 틀렸다는 것을 알고 있더라도 그 사람들의 의견에 동의할 수 있음.
- 버림받는 것을 두려워하고 혼자 남게 되었을 때 무력함을 느끼며, 관계가 끝나면 불행 해짐.
- 비판에 쉽게 상처를 받고 다른 사람의 호의를 얻기 위해 심지어 좋아하지 않는 일이라도 자원해서 함.

1. 광범위하게 의존적이고, 순종적인 행동 패턴
2. 자신의 욕구를 다른 사람의 욕구보다 경시하고,
3. 다른 사람이 그들의 삶의 중요한 부분에 책임을 지도록 하고, 자신감이 결여되어 있고, 혼자 있을 때 강렬한 불편감을 경험한다.
 - 그들이 의존할 타인을 찾는다. 그래서 그들의 인간관계는 비뚤어져 있음.
 - 신체적, 정신적 학대받는 경우 많음
 - 의존성은 히스테리성 인격장애와 경계성 인격장애 환자에서도 주요한 요소
 - 의존성 인격장애는 한 사람과 장기간 관계를 유지함.
4. 프로이드의 구강 의존성 인격(구강기에 고착되어 있다.)
 - 의존성, 비관성, 성에 대한 공포, 자기-의심, 수동성, 피암시성, 인내심 없음
5. 역학
 - 유병율은 0.6%
 - 만성적인 신체적 질환을 아동기에 앓았던 사람들이 이 장애에 더 취약함.
6. 치료에 대한 예후는 양호

의존성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)
 - 도움이 필요함(Needy), 약함(weak), 무기력함(helpless), 무능력함(incompetent)
2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)
 - 보호자(Caretakers), 관리인(protectors), 능숙한 사람(super-competent)
3. BELIEFS(신념)
 - 나는 무능력하고 이 세상에 혼자 있어.
 - 나는 살아남기 위해 다른 사람(특히 강한 사람)이 필요해
 - 사랑받지 못한다면 나는 행복할 수 없어
4. THREAT(위협)
 - 거부(Rejection), 버려짐(abandonment)
5. STRATEGY(위협에 대한 전략)
 - 관계 구축, 안전을 위해 본인 욕구 억제
6. AFFECT(정동)
 - 불안(관계가 끊길러움), 우울(관계가 끝남), 행복(관계가 좋음)
 - 정동이 관계 의존적이다.

치료적 관점

1. 부모의 과잉보호
 - 부모가 아이에게 무의식적인 적개심이나 죄의식을 느끼는 경우에도 반동형성을 통해 과잉보호를 하게 되며, 아동 또한 자신의 공격성과 적개심을 방어하기 위하여 겉으로는 의존하고 복종하는 행동을 나타낼 수도 있다.
2. 구강기 성격(oral character): 의존성, 혼자됨에 대한 불안, 비관주의, 수동성, 인내심 부족, 언어적 공격성
3. 인지적 입장
 - “나는 근본적으로 무력하고 부적절한 사람이다”
 - “나는 혼자서는 세상에 대처할 수 없으며 의지할 사람이 필요하다.”
 - 의존대상을 만족시키는 데 주의를 기울이고 관계를 악화시킬 수 있는 갈등은 회피
 - 흑백논리적 사고
 - 독립적인 존재로 혼자 살아가는 것에 대한 두려움은 결국 극단적인 의존적 삶을 선택

택하게 한다.

- 어떤 일을 매우 잘하지 못하면 전적으로 잘못된 것으로 판단하여 자신을 무능하고 무력한 존재로 평가

치료

- 의존성 인격장애의 치료는 종종 성공적이다.
- 치료자는 그들의 감정이 얼마나 병리적이건 간에, **환자들의 애착에 대한 정서를 존중**하는 것을 보여줘야 한다.
- 의존적인 내담자를 치료하기 위해서 치료자는 내담자와 의존적인 관계를 맺어야 하지만 내담자가 점차로 치료자의 도움을 필요로 하지 않는 독립적인 사람이 되도록 도와야 한다.
- 내담자는 치료자의 인정을 받기 위해 독립적인 삶으로 변화하고 있는 듯이 나타낼 수 있다. 치료자는 이러한 피상적 변화를 치료 효과가 나타나고 있는 것으로 생각할 수 있으나 실은 **치료자에 대한 의존성이 심화**되고 있는 것일 수 있다.(주의사항)
- 치료자는 내담자의 의존적 태도에 자신의 자기애적 소망이 촉발되어 내담자와의 의존적 치료 관계를 즐기거나 오히려 강화할 수도 있다.
- 내담자의 의존적 소망을 좌절시킴으로써 유발되는 내담자의 분노와 공격을 적절하게 잘 다룰 수 있어야 한다
- **자율(autonomy): 타인으로부터 독립적으로 행동하는 동시에 타인과 친밀하고 밀접한 인간관계를 유지할 수 있음. 이를 잘 가르쳐야 한다.**
- 문제해결기술이나 의사결정기술을 습득하게 한다.
- 표현하는 자기주장훈련이나 의사소통 훈련. **나의 감정과 욕구를 잘 표현할 수 있게 훈련해야 한다. 누군가를 만족시키기 위한 것이 아닌 자기자신을 위한 이야기를 하는 훈련을 해야한다.**
- 치료와 관련된 여러 가지 사항에 대한 결정, 치료회기에서 다룰 주제의 선택, 문제해결 방법의 탐색과 결정 등을 내담자에게 위임

강박성 인격장애(Obsessive-Compulsive Personality Disorder)

강박성 인격장애 DSM-IV-TR 진단기준

- A. 정리정돈, 완벽주의, 마음과 대인관계의 통제에 집착하는 광범위한 행동 양식으로서, 이런 특징은 융통성, 개방성, 효율성의 상실이라는 대가를 치르게 한다. 초기성인기에 시작되어 여러 상황에서 나타나며, 다음 가운데 4개(또는 그 이상) 항목을 보인다.
1. 세부 사항, 규칙, 목록, 순서, 구도, 시간 계획이나 형식에 집착하여, 일의 큰 흐름을 잃고 만다.
 2. 일의 완수를 방해하는 완벽주의를 보인다(예: 자신의 지나치게 엄격한 표준에 맞지 않기 때문에 계획을 완료할 수 없다).
 3. 여가 활동과 우정을 나눌 시간도 희생하고 지나치게 일과 생산성에만 몰두한다(분명한 경제적 필요성 때문이 아니다).
 4. 도덕, 윤리 또는 가치문제에 있어서 지나치게 양심적이고, 고지식하며, 융통성이 없다(문화적 또는 종교적 배경에 의해서 설명되지 않는다).
 5. 닳아빠지고 무가치한 물건을, 감상적인 가치조차 없을 때라도 버리지를 못한다.
 6. 타인이 자신의 방식을 그대로 따르지 않으면 타인에게 일을 맡기거나 같이 일하기를 꺼려한다.
 7. 자신과 타인 모두에게 인색하다. 돈은 미래의 재난에 대비해서 저축해야 한다고 생각한다.
 8. 경직성과 완고함을 보인다.

	강박성 인격장애(OPCD)	강박장애(OCD)
특징	- 과도한 통제와 융통성 결여가 특징적인 부적응적 행동패턴	- 실질적인 강박사고, 강박행동
수집 행동	- 질서와 완결성에 대한 욕구, 중요한 것을 잃을까봐 몹시 두렵다. - 원해서 수집행동을 한다. - 이러한 행동이 긴장감과 이완곤란을 동반 + 시간 소모적, 고통을 야기, 과도하게 반복적, 의식적이면 OCD의 진단기준에 부합될 수 있음.	- 짐스러운 강박적 의식, 오염에 대한 강박적이고 비합리적인 두려움이 원인 - 수집행동이 전형적으로 원하는 것이 아니고 고통을 야기하는 것으로 잘라낸 손톱이나 썩은 음식과 같이 특이한 잔해를 모으는 걸로 이어짐

- 수집행동은 예시로 든 것으로 만약에 증상으로 수집행동이 있다면 저런 특징을 보인다는 말입니다.

강박성 인격장애의 특징

• Key point

- 완벽주의와 경직성이 이 사람들의 특징임.
- 일중독자들이며, 우유부단하고, 과도하게 꼼꼼하며, 세부사항에 다른 사람들이 자신의 방식으로 일하도록 고집함.
- 감정을 표현하는데 어려움을 보이고, 관용이 부족하며, 더 이상 필요가 없는 가치 없는 물건들을 버리지 못함

1. 완벽주의와 유연하지 않음

- 규칙, 규율, 정리정돈, 세세한 것, 완벽한 성취에 집착함
- 규칙은 그대로 지켜져야 하고, 규칙을 깨는 것을 견디지 못함
- 규칙과 절차가 확실치 않으면 결정에 장시간이 소모되고, 이로 인해 개인의 능력이 제대로 발휘되지 못하게 된다

2. 제한적인 정동

3. 제한적인 대인관계 기술

- 격식을 차리고, 심각하고, 유머감이 없음. 사람들을 소외감을 느끼게 만들고 협력하지 못함.
- 안정적인 결혼생활과 직업적 성취를 할 수 있지만, 친구가 매우 적다.

4. 방어기제: rationalization(합리화), isolation(고립), intellectualization(주지화), reaction formation(반동 형성), undoing(취소)

5. 역학

- 2~8% 유병률
- 남성에서 흔함.
- 첫째 아동에서 가장 흔하게 진단됨

강박성 인격장애 환자의 관점

1. SELF-VIEW(자신을 어떻게 보는지)

- 자신과 타인에 대한 책임감(Responsible for themselves and others 종종 서투른/무능한 셀프의 핵심 이미지(Often core image of selves as inept / helpless)

2. VIEW OF OTHERS(타인을 어떻게 보는지)

- 너무 격의 없음(Too casual), 종종 책임감 없음(often irresponsible), 제멋대로(self-indulgent), 무능력함(incompetent)

3. BELIEFS(신념)

- 나는 압도되어 진다.
- 나는 종종 기본적으로 구조화가 안된 사람이다(그래서 시스템을 만드려함)
- 나는 시스템이 없으면 모든 것들이 다 분산될 것이다.
- 내가 여기서 실패한다면 나는 사람으로서 실패한다.

4. THREAT(위협)

- 결함(Flaws), 실수(mistakes), 혼란(disorganization), 결함(imperfections), 조절상실(loss of control)

5. STRATEGY(위협에 대한 전략)

- 완벽하기, 모든 것을 통제하기

6. AFFECT(정동)

- 불안, 성급함, 실패 시 우울함

치료적 관점

1. 정신분석적 입장

- **항문기적 성격(anal character):** 규칙성, 완고성, 인색함, 정서적 억제, 자기회의, 강한 도덕 의식

2. 부모의 과잉통제적, 처벌적인 양육방식

- 부모에게 처벌당하지 않고 인정받기 위해서는 철저하게 자신을 통제해야 하며 실수를 허용하지 않는 완벽주의를 추구하게 된다.
- **좀처럼 만족하지 않는 부모의 모습이 엄격한 초자아로 내면화되어, 일에 몰두하는 성취지향성과 더불어 도덕적인 고지식함**

3. 인지적 입장

- "나는 나 자신뿐만 아니라 내 주변 환경을 완벽하게 통제해야 한다."
- "나는 실수를 하지 않아야만 가치 있는 존재이다."
- "실수는 곧 실패이다"

- "모든 행동과 결정에는 옳고 그름이 있다."
- "구체적이고 명확한 규칙이나 절차가 없으면 나는 아무것도 할 수 없을 것이다"
- 흑백논리적 사고: 완벽 아니면 실패
- 파국화: 실패에 대한 강한 두려움
- 의미확대나 의미축소: **잘한 것은 작게, 못한 것은 크게**

치료

- 다른 인격장애 환자들과 달리, 강박성 인격장애 환자는 종종 그들의 고통을 알아차리고, 치료를 받으러 스스로 오기도 한다.
- 정서적 표현을 잘 하지 않고 경직되어 있으며 대인관계를 중요하게 생각하지 않는 경향이 있기 때문에 치료적 동맹관계를 형성하기가 어렵다.
- 치료초기에 **긴밀한 정서적 유대관계를 성급하게 형성하려고 시도하는 것은 오히려 부정적인 결과를 초래할 수 있다.**

1. 정신역동적 치료목표: **지나치게 엄격한 초자아를 수정하는 것**

- 분노, 증오, 의존과 같이 수용할 수 없는 감정을 배제하려 하기보다는 이러한 감정을 자신의 일부로 통합하고 자신이 불완전한 인간임을 수용하도록 유도한다.

2. 인지행동치료: 내담자가 호소하는 현재의 문제에 초점을 맞추어 구체적인 목표를 세우고 하나씩 해결해간다.

[5] 달리 명시되는 인격장애(Other Specified Personality Disorder), 기타

수동 공격성 인격장애(Passive-Aggressive Personality)

- 특정 인격장애의 진단 기준에는 부합되지 않지만, 하나 이상의 인격적 특징이 나타나고 임상적으로 심각한 고통이나 1가지 이상의 주요한 영역(예: 직업이나 사회)에 기능 장애를 일으키는 경우
- 공식적인 진단기준은 없음에도, 이러한 인격장애를 지닌 사람은 흔하다.
- 은밀하게 의사방해, 일을 미루기, 완고함, 비능률적임.
 - 일을 미루고, 충분한 수행을 주저하고, 지연에 대한 변명을 찾고, 그들이 의지하는 사

람들에게서 잘못을 찾고, 의존적인 관계로부터 그들 자신을 해방시키는 것을 거부함.

- **기저의 분노를 수동적으로 표현함.**

- 그들의 만족보다는 **억울함**에 더 빠져있기 때문에, 그들은 삶에서 즐거움을 찾는 데 목표를 두지 않는다.

- 스스로를 의존적인 위치에 있도록 한다.

- 대부분 불안해보이고, 우울해보임.

- 신체적 불편감이 다양하게 많았음.

- 치료

- 치료세션은 환자가 의존하려는 욕구를 표현하는 **치료자에 대하여 억울한 감정을 표현하는 전장**이 된다.
- 치료자는 기저의 분노를 인식하고 다루어 주어야 한다.
- 치료자는 수동공격적 행동의 일련양상이 나타나면 직면시켜주어야 한다.

우울성 인격장애(Depressive Personality)

- 평생동안 지속되는 우울한 스펙트럼에 빠져있음.

- 비관적이고, 무쾌감증, 의무에 쌓여있고, 자기의심적, 만성적으로 불행함.

- 낮은 자존감

- 자기 비판적이고, 자신의 일을 폄하하는 경향을 보임

- 우울한 특성의 7개 군 분류(Hagop Akiskal)

1. 조용하고, 내성적이고, 수동적이고, 적극적이지 않음.

2. 우울하고, 비관적이고, 심각하고, 재미없음.

3. 자기비판적이고, 자기비난함.

4. 다른 사람에 대해 의심이 많고, 비판적이고, 감사함을 표현하지 못함

5. 양심적이고, 책임감 있고, 자기수양적임

6. 음울하고 걱정이 많음.

7. 부정적인 사건에 집착하고, 불충분한 느낌이 있고, 개인적인 단점에 집착함.

- 우울인격장애 환자들은 기분부전장애와 주요우울장애의 위험을 가지고 있음

- 치료

- 현실검정능력은 정상이기 때문에 통찰지향심리치료(insight-oriented psychotherapy)에 반응한다.

- 인지치료는 환자가 그들의 낮은 자존감과 비관주의를 이해하는데 도움을 준다.
- 집단치료와 대인관계치료 또한 유용하다.

의학적 상태로 인한 인격 변화

- 뇌의 구조적인 손상은 인격변화의 원인이 될 수 있다.
- 기존의 인격의 특징이 확대 강화되거나, 기존의 패턴으로부터 변화를 보인다.
- 인격변화에 앞서 기질성 질환의 증거가 분명해야 한다.
- 두부손상이 가장 흔한 원인이다.
- 뇌종양과 뇌졸중이 특히 측두부와 전두부에 나타나는 것 또한 흔한 원인이다.

Medical Conditions Associated with Personality Change

- Head Trauma
- Cerebrovascular diseases
- Cerebral tumors
- Epilepsy(particularly, complex partial epilepsy)
- Huntington's disease
- Multiple sclerosis
- Endocrine disorders
- Heavy metal poisoning(manganese, mercury)
- Neurosyphilis(신경매독)
- Acquired immune deficiency syndrome(AIDS)

동반이환 질환을 위한 감별(Screening for comorbid disorders)

- 모든 인격장애에서는 alcohol과 drug 관련 문제 높음.
- 자살시도 위험이 높음.
- 사회적, 직업적 문제가 많음.
- 축1장애-불안장애, 기분장애 환자가 인격장애를 갖고 있으면 예후가 좋지 않음을 인지해야 함.
- 반사회성 인격장애: 알코올의존, 우울장애
- 경계성 인격장애: 알코올의존, 약물의존, 기분장애, 불안장애, PTSD

- 히스테리성 인격장애: 알코올의존, 신체화 장애
- 회피성 인격장애: 사회공포증

인격장애의 일반적인 치료 기준

- 인격장애자는 자아동조적 특징으로 인해, 문제가 자신이 아니라 주변 세상에 있는 것처럼 행동하며, 태도와 행동은 쉽게 변하지 않는다.
- 치료 과정에서 요구가 많고, 자신의 생활 속에 있는 병적인 대인관계와 유사한 방식으로 치료자와의 관계를 형성하기 쉬우며, 원하는 바가 이루어지지 못하면 적대감과 분노를 일으키기도 하므로, 치료자는 적대 감정의 행동화에 주의하여야 한다.
- 치료자는 환자에게 일방적으로 뭔가를 하는 것이 아니라, 환자와 함께 하는 자세를 가져 환자로 하여금 스스로에 대한 조절감을 느끼게 하여 치료에 능동적 참여를 유도하며, 지속적이고 안정적인 틀을 장기적으로 유지하도록 한다.
- Evidence based psychotherapy
 - 경계성 인격장애: 변증법적행동치료(Dialectic Behavioral therapy), 전이초점치료(transference-focused therapy), 마음헤아리기 치료(Mentalization-based treatment), 도식중심치료(Schema-focused therapy)가 효과적임.

⇒신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색** 밑줄
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색
- 이번주차는 국립재활원 이교은 선생님 녹강으로 진행되었습니다. 19에서도 같은 방식으로 진행된 것 같은데 시험에도 출제되었습니다.

[1] 수면장애 수면관련증후 및 夢

1절. 수면의 구조

수면의 전기생리학

1) NREM Sleep (non-rapid eye movement)

: 일반적인 잠들어있는 상태.

: 맥박, 호흡, 혈압, 몸을 유지하는 근육 긴장도가 깨어있을 때보다 낮아져있음.

• stage 1~4 :

높은 단계로 갈수록 깊은 수면

깨어있을때 뇌는 베타파를 보내는데 잠이 들수록 빈도수가 낮아져 서파가 나옴

Beta	깨어있을 때
Stage 1	Theta
Stage 2	Spindle (12-14Hz), K-Complex. 기본적인 파형은 <i>theta</i> 파이나 빈도수가 갑자기 높아지거나 불안정한 양상을 보임
Stage 3	slow(Delta) wave. 서파. Delta파가 50% 미만
Stage 4	slow(Delta) wave. 서파. Delta파가 50% 이상
Stage3, Stage4에서 이상이 발생하면	sleep walking, 몽유병, 야경증, 야뇨증 등

2) REM sleep (rapid eye movemet)

: 몸은 자고 있지만 뇌파는 깨어있는 **paradoxical sleep**.

맥박 호흡 혈압이 요동치는 상태.

근긴장도는 거의 없는 near-total paralysis of the skeletal muscles 상태

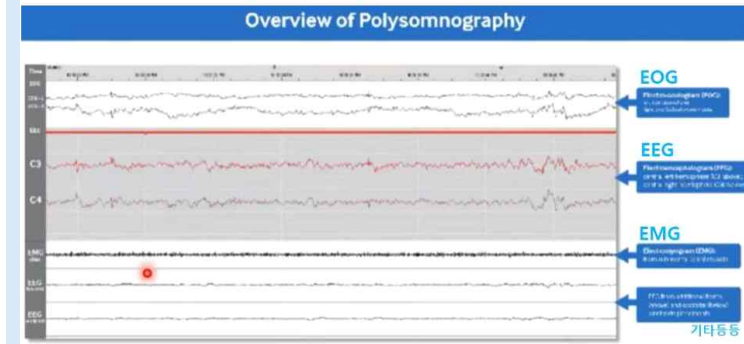
:**Dreaming** - 꿈을 꾸는 상태

렘수면 상태에서 깬 환자의 60-90%가 꿈을 꿴다고 말함.

수면다원검사 (Polysomnography)

- electroencephalogram (EEG) - 뇌파 측정
- electro-oculogram (EOG) - 눈의 움직임 측정
- electromyogram (EMG) - 근육 긴장도 측정

장비들을 붙이고 하룻밤을 잔다.



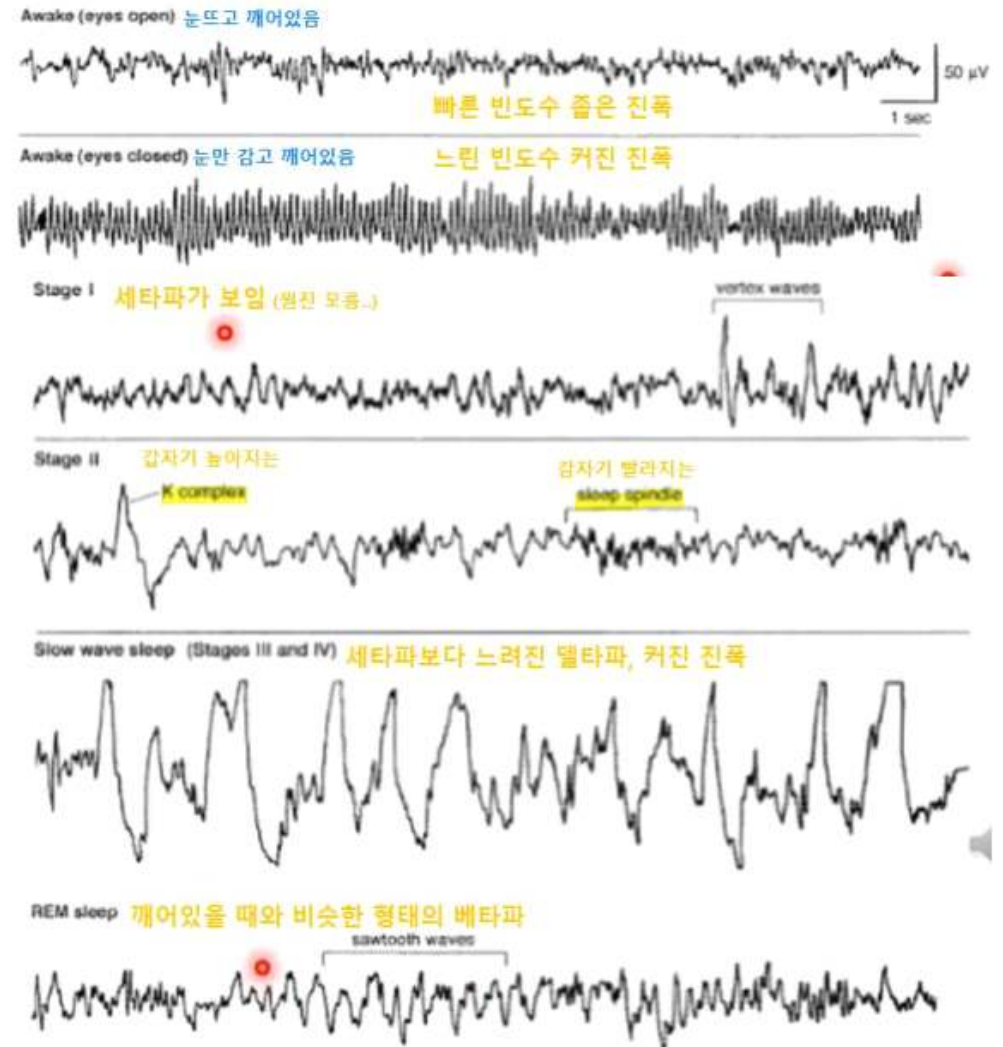
검사결과 예시

	EEG 50 μ V 1 second	EOG	EMG
Wake	beta waves alpha waves	eye movements	(high)
Stage 1	theta waves	slow rolling eye movements	(moderate)
Stage 2	K-complex spindle theta waves	no eye movements	(moderate)
SWS	delta waves	no eye movements	(moderate)
REM	sawtooth waves	bursts of eye movements	(low)

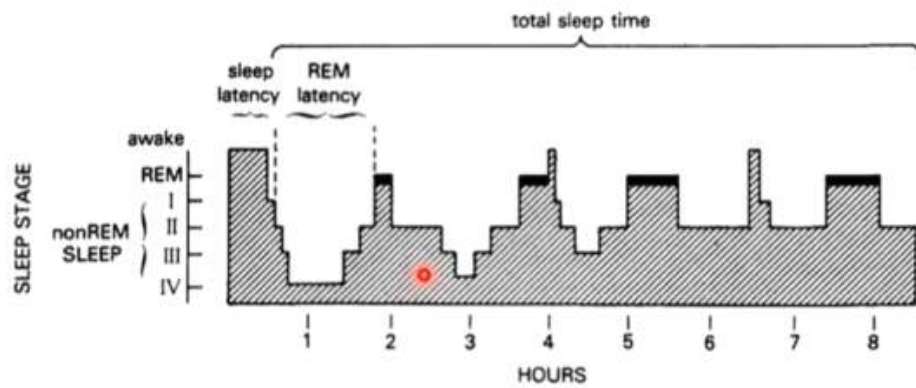
다음 페이지에서 자세히

amplitude : 진폭 / voltage : 전압

	Electroencephalogram	Electrooculogram	Electromyogram
Wakefulness	• <u>Low voltage, mixed frequency activity</u> (주로 베타파) • Alpha(8~13Hz)activity with eyes closed 잠 안자고 눈만 감아도 베타파에서 더 느려진 알파파가 나옴	Eye movements and eye blinks	<u>High tonic activity and voluntary movements</u>
NREM sleep			
Stage 1	• Low-voltage, mixed frequency activity • <u>Theta(3~7Hz)activity, vertex sharp waves</u>	slow eye movemets	Tonic activity slightly decreased from wakefulness
Stage 2	Low-voltage, mixed frequency background with <u>sleep spindles (12~14Hz bursts)and K complex</u> (negative sharp wave followed by positive slow wave)	None	<u>Low tonic activity</u>
Stage 3	<u>High amplitude(≥ 75 V) slow waves(≤ 2Hz) occupying 20~50% of epoch</u>	None	Low tonic activity
Stage 4	High amplitude slow waves occupying >50% of epoch	None	Low tonic activity
REM sleep	• <u>Low-voltage, mixed frequency activity</u> 깨어있을 때와 거의 동일한 뇌파 • Saw-tooth waves, theta activity and slow alpha activity	<u>REMs</u> (rapid eye movements)	<u>Tonic atonia</u> with phasic twitches 근긴장도는 거의 X



수면 사이클 (Cyclical Nature of Sleep)



- Sleep latency : 침대에 누워서 잠이 들 때까지 시간
- REM latency : 수면이 들고 첫 번째 렘수면까지 드는 시간. 약 1~2시간
- 사이클이 반복됨. 보통 4~5번 정도 렘수면 반복
- 기면병 환자는 REM latency가 10분에서 20분 정도밖에 안되는 것이 특징

수면 조절 기전 (Sleep Regulation)

1) Homeostatic : 항상성. **잠을 못자면 잠이 오는 것**

2) Circadian

- 하루 24시간 주기에 맞추어 밤이 되면 잠이 오는 것.
- 뇌에 있는 SCN(Suprachiasmatic Nucleus, 시교차 상핵)에 Pacemaker가 있고, 멜라토닌에 의해서 조절됨

65세 이상 노인에게 **졸피뎀을 처방하기 어려워 멜라토닌을 처방하기도 함**

3) 심리적 상태

- 인지적이고 생체적 각성을 낮춰주는 중요한 인자
- 3개월 이하 불면장애는 acute하다고 보고 그 이상은 chronic으로 봄. 만성일 경우 중요한 요인이 심리적 상태임.

연령대별 수면패턴

- 신생아
 - 렘수면이 전체 수면의 50% 이상 차지
 - 1-2 보통 시간이 걸리나 신생아 때는 거의 기면병 환자처럼 잠들자마자 렘수면
 - 점차 나이 들면서 rem latency는 길어지고 렘수면의 비율은 적어짐

• 청소년기 ~ 성인기

NREM (75%)	
Stage 1	5%
Stage 2	45%
Stage 3	12%
Stage 4	13%
REM(25%)	

렘수면이 25% 차지
Stage2가 가장 높은 비율을 차지

• 노인

서파수면과 렘수면 감소하며 수면의 질도 감소됨

노인의 수면장애는 **생리적인 현상**

2절. 수면장애 분류

수면장애 분류 ICD-10

- ICSD-3(2014년발표)의 진단적 분류를 많이 포함함.

• 기질적 수면장애 Organic sleep disorder

• 비기질적 수면장애 Nonorganic sleep disorder

수면곤란 Dyssomnias	수면구조는 같으나 구조 내에서 수면양, 수면질, 수면시간의 이르고 늦음 등에 문제가 생긴 경우 - insomnia, hypersomnia, disorder of the sleep-wake schedule
사건수면 Parasomnias	수면구조에 비정상적인 일, 변수가 발생한 경우 - sleepwalking, sleep terrors, nightmares

F51 코드 (비기질적 수면장애)

수면곤란 Dyssomnias	① F51.0 Nonorganic insomnia - 불면증 ② F51.1 Nonorganic hypersomnia - 과다수면 ③ F51.2 Nonorganic Disorder of the Sleep-Wake Schedule - 수면스케줄이 꼬인 경우
사건수면 Parasomnias	④ F51.3 Sleepwalking(Somnambulism) - 걸어다님 ⑤ F51.4 Sleep Terrors(Night Terrors) - 소리지르는 등 자율신경계 항진 ⑥ F51.5 Nightmares - 렘수면 중 악몽 ⑦ F51.8 Other Nonorganic Sleep Disorders - 렘수면 중 비정상적 이벤트들 ⑧ F51.9 Nonorganic Sleep Disorder, Unspecified

G47 코드 (기질적 수면장애)

- ① G47.0 Disorders of initiating and maintaining sleep[insomnias]
- ② G47.1 Disorders of excessive somnolence [hypersomnias]
- ③ G47.2 Disorders of the sleep-wake schedule
 - Delayed sleep phase syndrome
 - Irregular sleep-wake pattern
- ④ G47.3 Sleep apnoea 수면 무호흡증
 - central
 - obstructive
- ⑤ G47.4 Narcolepsy 기면증 and cataplexy 급발작
- ⑥ G47.8 Other sleep disorders
 - Kleine-Levin syndrome
- ⑦ G47.9 Sleep disorder, unspecified

DSM 분류

① DSM-4에서는 primary, secondary로 구분하였으나, DSM-5에서는 크게 구분하지 않음.

- Ex) Primary insomnia → insomnia disorder
- sleep disorders related to another mental disorder, sleep disorder related to a general medical condition 없어짐

→ 구분하지 않고 수면장애 증상 자체를 보고 치료하고자 함. 불면증상을 위주로 하되 .이와 관련된 정신과적 장애나 신체질환이 있는지 약물 때문인지 등은 세부항목에 명시

② Breathing-Related Sleep Disorders에 하위분류 생김

③ Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders에 새로운 하위분류 생김

- jet lag type 삭제됨

→ ②, ③은 DSM-IV의 Dyssomnias가 좀 더 세분화 된 양상으로 볼 수 있음

④ *Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder, **Restless Legs Syndrome이 DSM-IV 에서는 Parasomnia NOS에 속한 하위분류였으나 DSM-5에서는 독립됨.

*원래 REM 수면상태에서는 근긴장도가 거의 없어 움직일 수 없는데 이상이 생겨 움직임

**잠드려고 할 때 다리가 저리고 불편해 잠을 잘 자지 못하는 상태

DSM-IV	DSM-5
1. Primary Sleep Disorders a. Sleep Dyssomnias ↳ Primary hypersomnia ↳ Primary insomnia ↳ Narcolepsy ↳ Breathing-related sleep disorder ↳ Circadian rhythm sleep disorder ↳ Dyssomnia NOS b. Parasomnias ↳ Nightmare disorder ↳ Sleep terror disorder ↳ Sleepwalking disorder ↳ Parasomnia NOS 2. Sleep Disorders Related to Another Mental Disorder 3. Other sleep disorders a. Sleep disorder due to... [indicate the general medical condition] b. Substance-induced sleep disorder	1. Insomnia Disorder 2. Hypersomnolence Disorder 3. Narcolepsy 4. Breathing-Related Sleep Disorders: a. Obstructive Sleep Apnea Hypopnea b. Central Sleep Apnea ↳ Idiopathic central sleep apnea ↳ Cheyne-Stokes breathing ↳ Central sleep apnea comorbid with opioid use c. Sleep-Related Hypoventilation 5. Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: a. Delayed sleep phase type b. Advanced sleep phase type c. Irregular sleep-wake type d. Non-24-hour sleep-wake type e. Shift work type f. Unspecified type 6. Parasomnias a. Non-Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorders: ↳ Sleepwalking type ↳ Sleep terror type b. Nightmare Disorder c. Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder d. Restless Legs Syndrome 7. Substance/Medication-Induced Sleep Disorder

ICSD 분류 (International Classification of Sleep Disorder)

- DSM은 수면의학을 전문으로 하지 않은 정신건강의학과 의사와 일반 의사를 위한 분류
- ICSD는 수면전문가 집단의 의견과 과학적 연구 성과를 반영하여 수면 전문가용으로 마련된 분류

ICSD-2	ICSD-3
Insomnia 1. Adjustment insomnia 2. Psychophysiological insomnia 3. Paradoxical insomnia 4. Idiopathic insomnia 5. Insomnia due to mental disorder 6. Inadequate sleep hygiene 7. Behavioral insomnia of childhood 8. Insomnia due to drug or substance 9. Insomnia due to medical condition 10. Insomnia not due to a substance or known physiological condition, unspecified 11. Physiological (organic) insomnia, unspecified	Insomnia ① Chronic insomnia disorder ② Short-term insomnia disorder primary와 secondary로 나뉘어져 있던 불면증이 하나의 chronic insomnia로 합쳐짐
Sleep-Related Breathing Disorders	Sleep-related breathing disorders ① Obstructive sleep apnea (OSA) syndromes ② Central sleep apnea syndromes ③ Sleep-related hypoventilation disorders ④ Sleep-related hypoxemia disorder
ICSD-2	ICSD-3
Hypersomnias of Central Origin (Not Due to a Circadian Rhythm Sleep Disorder, Sleep-Related Breathing Disorder, or Other Cause of Disturbed Nocturnal Sleep)	Central disorders of hypersomnolence ① Narcolepsy type 1 ② Narcolepsy type 2
Circadian Rhythm Sleep Disorders	Circadian rhythm sleep-wake disorders ① Delayed sleep-wake phase disorder ② Advanced sleep-wake phase disorder ③ Irregular sleep-wake rhythm disorder ④ Non-24-hour sleep-wake rhythm disorder ⑤ Shift work disorder ⑥ Jet lag disorder
Parasomnias	Parasomnias ① REM-related parasomnias ② REM-related parasomnias
Sleep-Related Movement Disorders	Sleep-related movement disorders ① Restless legs syndrome ② Periodic limb movement disorder

1. 일차적 불면증 Primary Insomnia (DSM-5 Insomnia Disorder)

= 뚜렷한 의학적, 정신적 질환이나 물질의 생리적 영향과 관련이 없는 불면증

- 성인의 1년 유병률 : 30~45% (매우 높음)
- DSM-5에서 insomnia disorder로 바꾼 이유: 이전에는 불면증의 원인을 밝히고 치료하는데 집중했다면, 최근에는 불면증 자체를 독립적인 상태로 보고 증상자체를 치료하는데 집중한다

일차성 불면증의 3종류

- ① onset insomnia: 잠들기 힘든 불면증
- ② maintenance insomnia: 수면 유지 장애. 잠드는데에는 문제가 없는데 중간중간 계속 각성되어 수면의 질이 하락하는 불면증
- ③ termination insomnia: 너무 일찍 깨는 불면증. 노인이나 우울증 환자에게 多

진단기준 (DSM-4 -> DSM-5)

- A. 적어도 1개월 이상(→ 일주일에 3일 이상, 3개월 이상 지속됨) 수면의 시작이나 유지의 어려움 또는 현저한 원기가 회복되지 않는 수면을 주소로 한다.
- B. 수면장애 (또는 관련된 낮 동안의 피로)는 임상적으로 유의한 고통 또는 사회적 직업적 또는 다른 기능상의 중요한 부분에 장애를 초래한다.
- C. 수면장애는 단지 수면발작, 호흡관련 수면장애, 일주기 수면 리듬장애 또는 수면 관련장애의 경과 중에 나타나는 것이 아니다.
- D. 장애가 단지 다른 정신장애(예: 주요 우울장애, 범불안장애, 섬망)의 경과 중에 나타나는 것이 아니다.

→공존하는 정신질환과 의학적 상태가 현저한 불면증 호소를 충분히 설명할 수 없다.

다음의 경우 명시할 것: 비수면장애 정신질환 동반이환 동반 / 기타 의학적 상태 동반 이환 동반 / 기타 수면장애 동반

E. 장애가 물질 (예: 남용 물질, 약물 투약) 또는 일반적 의학적 상태의 직접적인 생리적 영향에 의한 것이 아니다.

초록색 글씨가 DSM-5에서 변화된 내용!!

비수면장애 정신질환이 동반된 불면장애

다음 정신질환에서 불면증이 많이 동반 됨.

① 주요우울 삽화

- 불면증은 우울장애에서 가장 흔한 증상.
- 수면문제는 우울증의 초기 증상 중 하나임
- 특히 우울한 노인에게서 나타남
- 심각한 우울증에서 terminal insomnia가 특징임

너무 일찍 깨서 새벽에 우울이 심해짐

② 외상 및 스트레스 관련장애

- 진단기준에서 하나의 증상으로 수면문제가 있음.

③ 공황장애

- 수면중에 공황발작이 일어날 수 있음

④ 적응장애

- 특정한 스트레스에 대한 반응으로 불안과 우울을 보인 환자들은 특별한 스트레스 원 혹은 그날에 있었던 사건에 대해 걱정하며 깨어 있는 상태로 누워있게 됨.

⑤ 신체증상장애

- 신체화 증상이 있는 많은 환자들은 특히 수면초기와 수면중간 불면증을 호소함.

⑥ 인지장애

- 대부분의 치매 환자들은 어느 정도 수면문제가 있음 밤에는 각성하여 돌아다닐 수 있고 낮 동안에는 각성수준이 감소됨

⑦ 조증 경조증 삽화 ,

- 24시간동안에 조증과 경조증 환자들은 기분이 들떠 있을 때 전형적으로 평소보다 덜 잠.
- 그러나 조증과 경조증 환자들은 불면증에 대해서 호소하지 않음.
- 걱정하는 것은 그들의 가족과 친구들임.

⑧ 조현병

- 발병시 밤이 깊어질 수록 망상 환청 혹은 불안에 심하게 압도됨 , .
- 조현병 환자들은 총 수면시간은 일정하지만 밤에 잠을 이루지 못하고 아침이 되어 서야 잠이 들기 때문에 낮이 되어야 일어남.

⑨ 강박성 성격장애

2. 일차성 수면과다 Primary Hypersomnia (DSM-5 Hypersomnolence Disorder)

- 특발성 과수면증은 낮졸림증은 심하나 기면병의 진단기준을 충족하지 못하는 경우 진단
- 특별한 치료 방법X. 낮잠을 규칙적으로 자두는 행동요법 티칭
- 약물치료 : modafinil(Provigil), amphetamines (부작용 多)

진단기준 (DSM-4 -> DSM-5)

A. 적어도 한 달 이상(또는 재발이라면 그 이내의) 지속되는 거의 매일 일어나는 지속되는 수면 삽화나 낮동안의 수면 삽화를 특징으로 하는 과도한 졸림을 주소로 한다.

→A. 주요 수면시간이 7시간 이상임에도 불구하고 과도한 졸림(과다수면)을 호소하며, 다음 중 한 가지 이상의 증상을 호소한다.

1. 동일한 날에 반복적인 수면기를 보이거나 혹은 반복적으로 깜박 잠들
2. 하루에 주요 수면삽화가 9시간 이상 지속되나 피로 해소가 되지 않음(예: 개운하지 않음)
3. 갑자기 깬 후에 완전히 각성 상태를 유지하기 어려움

B. 과다수면이 일주일에 3회 이상 발생하고 적어도 3개월 이상 지속된다.

B. 과도한 졸림은 임상적으로 유의한 고통 또는 사회적 직업적 또는 다른 기능상의 장애를 초래한다.

C. 과도한 졸림은 불면증에 의하여 더 잘 설명되지 않으며 다른 수면 장애 (예: 수면발작, 호흡관련 수면장애, 일주기 리듬 수면장애, 또는 수면 관련 장애)의 경과 중에만 나타나는 것이 아니고 불충분한 수면의 양으로 설명되지 않는다.

D. 이 장애는 다른 정신 질환의 경과 중에만 나타나는 것이 아니다

→다음의 경우 명시할 것

정신질환 동반, 물질사용장애 포함. 의학적 상태 동반, 다른 수면장애 동반

E. 이 장애는 물질 (예: 남용약물 약물 투약) 또는 일반적 의학적 상태의 직접적인 생리적 영향에 의한 것이 아니다.

초록색 글씨가 DSM-5에서 변화된 내용!!

수면과다의 종류

1) Kleine-Levin Syndrome → 입상에서 거의 볼 일 X

- 초기 청소년기 남자에게서 발생
- : (남:여=2:1 or 3:1 / 여자에서 발생할 때 증상이 더 심하게 나타남)
- first attack이 10~21살 사이에 나타남
- 삽화가 수일에서 수 주간 나타나고 일년에 10회정도 나타남.
- (18-hour to 20-hour sleep periods) 과도한 졸림
- 폭식
- 과도한 성욕
- 충동조절이 잘 안됨
- 이유없이 시작되고 종종 그냥 사라짐

2) 월경과 관련된 과다수면증

- 전형적으로 월경전 1주정도 지속되고 월경시 증상 소실,
- 내분비계 검사 시 특징적인 이상 관찰 X
- 경구피임약이 효과적인 것으로 보아 호르몬 불균형에 의해 발생하는 것으로 추정

3) 특별성 과다수면증

- 기면증과 연관된 증상 X
- 수면형태 정상
- EEG sleep pattern이 수면박탈된 후 수면을 취하는 정상인과 같음
- 원인은 아직까지 밝혀진 바 없으나 중추신경계로 추정

3. 기면병 Narcolepsy

진단기준

① 과도한 수면

- **sleep attacks**: 잠이 들 상황이 아닌데 갑자기 잠이 드는 것
- ex: 먹을 때, 이야기 할 때, 운전할 때, 성행위할 때 등
- 과다수면장애 환자들이 종종 경험하는 정신의 혼미함과는 대조적으로 잠을 자고 일어나면 상쾌함

② 수면시작하고 10분 이내에 REM sleep 나타남

- REM sleep: **hypnagogic and hypnopompic hallucinations** (수면에 들 때나 수면에서 깨어 있을 때 환각이 보임), **cataplexy**(몸에 힘이 빠짐), **sleep paralysis**
- **Cataplexy**(탈력발작): 근골격계에 갑자기 힘이 빠져 턱이 빠지거나, 머리가 툭 떨어지거나 무릎에 힘이 빠지는 등의 마비 증상이 나타남. 50~60%의 기면증 환자에서 동반됨. 강한 감정의 경험은 cataplexy를 유발시킬 수 있음

기면병 환자들이 자주 다치는 이유

- sleep paralysis**: 주로 오전에 일어날 때 발생함. 환자는 깨어 있지만 움직일 수 없음. 보통 10분 미만으로 지속됨. 기면병환자가 아닌 경우에도 sleep paralysis만 단독으로 짧게 나타나는 경우는 있음.

✓ 야간 수면다원검사와 함께 주간 수면잠복기반복검사를 시행하여 평균 수면잠복기 8분 이내, sleep onset REM 2회 이상 관찰 시 진단

기타 특징

- 스트레스 혹은 정서적 경험 (보통 농담과 웃음과 같은 긍정적인 것)으로 인해 발생할 수 있음
- 흔하지 않음 (2000명당 1명)
- 청소년기 혹은 성인초기. 30세 이전에 주로 발생
- 각성을 유지하게 해주는 신경펩타이드인 농도 감소와 연관 orexin/hypocretin 有

치료

- Hypocretin/orexin에 대한 치료가 현재로서는 불가능하기 때문에 치료가 존재하지 않음
- 관리가 주가 됨
- 낮에 규칙적으로 30~45분간 낮잠을 자게 하는 것
- 각성제 : methylphenidate, amphetamine
- **Modafinil** : $\alpha 1$ -adrenergic receptor agonist
- 주간의 졸림에 효과적 의존성 ↓
- cataplexy에 효과가 없는 편
- *cataplexy*이 있는 기면증 환자는 *Modafinil*과 *SSRI*를 동시에 활용
- **SSRI-REM sleep-suppressant properties**
- cataplexy감소- imipramine, fluoxetine

4. 호흡관련 수면장애 Breathing-related Sleep Disorders

Central type/ obstructive type / mixed type으로 나뉘나 obstructive type이 대부분이다.

폐쇄성 수면 무호흡증 Obstructive Sleep Apnea Hypopnea ★

임상에서 흔히 관찰

- 수면 중 호흡노력은 하지만 상기도가 폐쇄됨으로써 생기는 무호흡증
- episode of sleep apnea: cessation of breathing for 10 seconds or more during sleep
- 동반 임상양상: excessive sleepiness, snoring, obesity, restless sleep, nocturnal awakening, morning dry mouth, morning headaches, heavy nocturnal sweating
- 잠은 쉽게 들지만 중간에 자주 깨고 잠을 깊게 못 자고 낮에 졸림
- 수면유지장애와 반드시 감별
- 동반질환
- 고혈압: 60.1%
- 비만: 30.5%
- 당뇨: 32.9%
- 심혈관질환(뇌졸중 등) : 5.7%

• 수면다원검사를 통해 진단 → 급여화

- 무호흡- 저호흡 지수(apnea-hypopnea index, AHI): 호흡이 멈추는 무호흡이나 호흡이 저하되는 저호흡이 최소 10초이상 되는 횟수가 시간당 몇회 있었는지 나타내는 지수 심각도 평가함

• 치료

- 잠자는 자세를 바꾸거나, 호흡을 저하시키는 알코올, 수면제(BZD사용시 무호흡이 심해지는 경우가 있어 주의가 필요함), 진정제는 피함
- weight loss
- surgical intervention: uvulopalatopharyngoplasty, tracheostomy
- **지속적 상기도 양압술**(continuous positive airway pressure CPAP) : 특수마스크를 사용하여 일정하게 적절한 압력으로 공기를 기도로 불어넣는 것. 불편함.

Central Sleep Apnea 임상에서 복일이 없으니 넘어감

- periodic failure of CNS mechanisms that stimulate breathing
- OSA와 수면다원검사 결과 양상이 비슷하지만, 무호흡시 호흡하고자 하는 복부 흉부 팽창 노력이 나타나지 않음
- 무호흡 삽화에 이어 한동안 빠른 과호흡이 나타나는데 이때 억제된 호기가 뿔어져 나옴
- Idiopathic CSA - CSA comorbid with opioid use
- Cheyne-Stokes Breathing: 일회 호흡량이 주기적으로 점점 세지다가 약해지는 변동양상

#Sleep-Related Hypoventilation 임상에서 복일이 없으니 넘어감2

- 화학수용기와 brain stem의 신경 네트워크가 적절한 신호를 보내는데 실패하여 호흡이 약아지는 것.
- 대개 동반된 의학적 및 신경학적 장애 약물사용 물질사용장애 등에 의해 더 자주 발생함
- Idiopathic Hypoventilation - Congenital Central Alveolar Hypoventilation
- Comorbid Sleep-Related Hypoventilation: consequence of a medical condition(폐질환, 신경근육이나 흉벽장애, 치료약물 (benzodiazepine, opioids)

5. 일주기리듬 수면-각성장애 Circadian Rythm Sleep Disorders

- 원하는 수면시간대 수면시간과 실제 잠자는 시간 사이의 어긋남.
- delayed sleep phase type, shift work type, Jet lag type, unspecified type.
 - DSM-5: delayed sleep phase type, advanced sleep phase type, irregular sleep-wake type, non-24-hour sleepwake type, shift work type, and unspecified type.
 - delayed sleep phase type: 2시간 지연됨. '올빼미', '야행성인간'
 - shift work type: 밤시간대에 일하는 사람
 - Jet lag type: 비행시차
- 수면각성 패턴 때문에 아직 잠이 오지 않을 상황을 불면증으로 오인하여 수면개시 장애로 오진할 수 있음 → 평소 수면 스케줄 등을 확인하여 감별진단 필요
- 이러한 상황을 단순한 불면증으로 진단하면 약물치료를 하더라도 효과가 잘 나타나지 않음.
- 단계적으로 수면-각성 일정 조정하는 것, 일어나는 시간을 맞추는 것이 좋음
- melatonin
- Light therapy : 빛을 통해 시차를 조절함.

6. 수면이상증 Parasomnias

- 수면기간동안 나타나는 이상 사건.
 - wakefulness : body and brain are active
 - NREM sleep: body and brain are much less active
 - Sleep terror disorder / Sleepwalking disorder
 - REM sleep: atonic body with an active brain
 - Nightmare Disorder / Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder

Non-REM 수면 각성 장애(NREM Sleep Arousal Disorders)



이 그림을 기억해 두자.

1) Sleep walking 몽유병

- delta sleep(stage 3, 4)에서 발생(깊은 잠), 주로 첫 1/3 기간에 주로 발생.
- 깨지않은 상태로 잠자리를 벗어나 이상행동을 보임.
- 단순한 행동이나 언어는 구사하나 섬세한 행동이나 복잡한 대화는 불가능
- 낮의 각성상태와 달리 주변 환경에 주의집중력을 기울일 수 없기 때문에 위험함.
- sleepwalking하는 환자를 깨우는 것은 매우 어렵고, 깨어나면 혼돈을 겪기 때문에 깨우기보다 부드럽게 환자를 다시 침상으로 데리고 가는 것이 좋음.
- 소아에서는 흔하고 4~8세 사이에 가장 많이 나타나고. 청소년기를 지나면서 대개 자연스럽게 소실됨. 소아에서는 치료대상은 아니다.

2) Sleep Terrors 야경증

- delta sleep(stage 3, 4)에서 발생, 주로 첫 1/3 기간에 주로 발생
- 잠자다가 무서운 소리를 지르거나 심한 자율신경항진 증상을 보임 (심장박동 증가, 땀 흘림, 숨을 급하게 쉴)
- 쉽게 정신을 못 차리고 지남력장애 등 혼돈상태에 머물러 있음.
- 몇몇 성인들은 일부 이를 기억해내지만 대부분의 환자들은 다음날 아침에 이에 대한 기억이 없음
- 소아에서 많이 발생하고 대개 수면발달과정에서 나타나는 것으로 특별한 치료 필요하지 않음

▶ 위 두 가지가 성인에서 나타나는 경우엔 심한 정신병리를 수반할 가능성이 있으므로 정신과적 평가가 필요함

악몽장애 Nightmare Disorder

- 수면중 생생한 꿈을 꾸게 되면서 불안이 증가하다고 잠을 깨게 되는 장애
→인구의 절반정도가 한번 이상 악몽을 경험하나 장애로 진단 시에는 악몽 경험 수, 악몽삽화가 있을 때 보이는 환자의 반응을 추가적으로 고려

- REM sleep에서 발생 수면중반이후 (주로 새벽) 에 많이 발생
- 자율신경항진은 있으나 sleep terror만큼 심하지 않음
- 꿈내용을 생생하게 기억함 sleep terror과 다름
- 3~6세 소아에서는 10~50% 정도에서 나타날만큼 흔함
- Traumatic events가 있으면 발병확률 ↑
- 치료: REM sleep 억제하는 TCA, Benzodiazepine

REM수면 행동장애 (REM Sleep Behavior Disorder)

- REM sleep에 있어야할 atonia(sleep paralysis)가 소실되면서 난폭하고 복합적인 행동이 나타나는 것. REM 수면에서는 원래 몸을 움직일 수 없는데 몸을 움직이는 것!
- 꿈내용을 행동화(acting out) 하는 것.
- 보통 이 환자들은 눈을 감고 있음 →sleep walking과 다른 점
- 남성이 압도적으로 많음. 50대 이상에서 일반적으로 발병
- REM수면행동장애 환자들 중 약 절반은 루이소체 치매, 파킨슨병, 다계통 위축증 중 하나로 발전할 수 있음 →상급기관에 의뢰해야함.
- 치료 : Clonazepam (Klonopin)

하지불안증후군 Restless Legs Syndrom

- 다리에 매우 괴로운 불편감이나 근질거리는 또는 스멀거리는 것 같은 이상한 감각을 느낌으로 인해 다리를 움직이고 싶은 충동이 생겨 잠을 잘 이루지 못함
- 잠들기 전에 시작되는 경향이 있음. 저녁이나 밤에 심해져서 잠을 잘 자지 못함
→ 수면개시장애 & 수면유지장애와 감별 요
- 가만히 있을 때 심하게 느껴지며 계속 다리를 움직이거나 걸으면 좀 나아짐,
- 걷기, 스트레칭, 문지르기, 실내운동용 자전거 타기로 안도감을 느낌
- 감별진단: 하지경련, 관절통/관절염, 근육통, 말초신경병증, 약물로 유발된 좌불안
석

- 여성에 많고 나이 들면서 증가함 (5~10%유병율)
- 경도의 폐쇄성 수면무호흡증은 때때로 주기성 사지 운동증 같아 보일 수 있음
- secondary RLS: Uremia, neuropathies, and iron and folic acid deficiency anemias. -ferritin level을 반드시 확인 철 결핍 확인 필요
- fibromyalgia, rheumatoid arthritis, diabetes, thyroid diseases, COPD와 연관 됨
- 도파민과 관련이 있다고 하지만 명확하지 않음
- Dopamine agonist (pramipexole (Mirapex)(level A), ropinirole (Requip)(level B)), dopamine precursors (levodopa)(level C), benzodiazepines, opiates, antiepileptic drugs (gabapentin [Neurontin](level A)), pregabalin(level B).
- 금주. 마사지. 족욕. 운동.

주기성 사지운동장애 (Sleep-Related Movement Disorders - Periodic Limb Movement Disorder) (ICSD)

- nocturnal myoclonus : 수면을 취하는 동안 다리를 툭툭 터는 행동이 반복되어 수면의 질이 저하
- brief, stereotypic, repetitive, nonepileptiform movements of the limbs, usually the legs
- 0.5 to 5 seconds in duration and occur every 20 to 40 seconds.
- 유전적요인, 철분 대사과정 이상, 도파민 기능이상 등이 원인으로 제기됨
- 도파민 농도를 저하시킬 수 있는 항정신병 약물이나 항우울제의 사용
- 철분결핍을 일으킬 수 있는 빈혈, 출혈, 임신 및 출산, 만성 신부전 등
- 연령이 증가할수록 증가함.
- RLS(하지불안증후군)와 약물치료가 동일함. (dopamine agonist)

7. 약물 유발 수면장애

Substance(/Medication) Induced Sleep Disorder

1) Alcohol → 불면증 환자 오면 알코올 반드시 확인(술에 의존하여 잠에 들진 않는지)

- 불면형
- 급성중독상태- 즉각적인 진정효과
- 초기에는 stage 3,4(NREM sleep) 증가. REM sleep 감소
but 후기에는 stage 3,4(NREM sleep) 감소, REM sleep 증가.
→후반기 동안 수면의 연속성 방해 분절된 수면 호소
- 호흡관련 수면 장애 악화

2) Caffeine

- 용량 의존적으로 불면증

3)Opioids

- 급성 단기 사용시 졸림 수면깊이증가 REM수면 감소
- 지속적으로 투여하면 내성이 생겨 불면증 호소
- 호흡저하 효과 동반 sleep apnea 악화

4) Hypnotics, anxiolytics

- 졸림의 증가 각성의 감소 ,
- 만성적인 사용은 내성 유발, 결과적으로 다시 불면증 유발
- Parasomnia-benzodiazepine과 관련
- 갑작스럽게 중단 시 rebound insomnia 유발

8. 다른 정신질환과 동반하는 수면장애

Sleep Disorders Related to Another Mental Disorder

① 주요우울장애 major depressive disorder

- insomnia
- 잠들기가 어렵고 자주 깬 ,
- 서파수면 감소
- 새벽에 일찍 깨어 불쾌한 감정을 느낌
- REM density증가 ,REM latency 단축

② 조증상태 - 수면감소

③ 조현병에서

- 급성에서는 불면증 자주 동반
- 만성에서는 특징적인 불면증 나타나지 않음

④ 우울증초기, 비전형적인 우울상태, bipolar disorder의 depressive state에서 과다수면 자주 나타남.

3절. 한의학에서의 수면, 수면장애

• 음양설: 수면과 각성의 기본원리를 제시

- [영추 구문편] 陽氣盡 陰氣盛 則目瞑 陰氣盡 而陽氣盛 則寤矣

양기가 다하고 음기가 성하면 눈을 감고, 음기가 다하고 양기가 성하면 눈을 뜨게 된다.

• 위기운행설: 수면의 본질을 제시

- 日中에 양경을 25주, 야간에 음경과 오장을 25주

- [영추 대혹론] 衛氣之行 晝行於陽即目張而寤 夜行於陰即 目瞑而寢

• 신주설(神主說): 수면도 인체의 생명활동의 한 형식이라는 것에 대한 설명

- 신불능안기사하면(신이 안정되어있지 못하면) 불매, 다몽의 증상이 발생

夢

- 꿈을 꾸지 않는 상태가 건강한 상태
- 여러 가지 원인으로 인해 장부와 영위혼백이 혼란스러워져서 잠을 잘 때 편안치 않고 꿈을 꾸게 된다.
- 오장의 허실에 따라 꿈의 내용이 다르게 나타난다.
- 오장의 기능과 오행의 특성에 기초
- ex) 음기가 성하면 두려워하는 꿈, 양기가 성하면 불에 타는 꿈 등

不眠 (失眠, 不寐, 少寐, 無眠, 少睡, 不得臥, 不得眠)

- 양성음허(영추 대혹론), 비위불화(소문 역주론)하면 잠을 잘 못 잔다.
- 치료방제: 산조인탕, 황련아교탕 / 주사, 호박 등 중진안신 약물

不眠의 변증논치

- 허증: 혈허, 음허, 기허
- 실증: 간화, 담화

1) 사결불수 (思結不睡)

- 思慮勞倦傷心脾 思則氣結 (생각이 너무 많아 심비가 상하고)
- 心下痞, 胸悶, 太息 / 食慾不振, 不食而不飢, 食不化 四肢沈重而無力
- 治法: 補益心脾
- 治方: 歸脾湯(귀비탕), 壽脾煎 香附子八物湯

2) 영혈부족 (營血不足)

- 血虛
- 怔忡, 易疲勞, 眼精疲勞, 眩暈, 項強, 頭重, 頭痛, 身體痛, 便秘
- 治法: 補血安神
- 治方: 補血安神湯(보혈안신탕), 七福飲, 養心湯

3) 음허내열 (陰虛內熱)

- 精血不足, 肝膽相火動, 心火盛, 心腎不交
- 怔忡, 潮熱, 上氣, 盜汗, 惡寒, 頭重, 眩暈, 耳鳴, 口乾, 口苦, 津少

- 治法: 滋陰清火

- 治方:

心火 : 天王補心丹(천왕보심단), 補血清火湯, 清心蓮子湯(청심연자탕)

肝經鬱火: 加味逍遙散(가미소요산) 抑肝散 (억간산)

腎水不足: 三一腎氣丸(삼일신기환) 十二味地黃湯

心腎不交: 二神交濟丹(이신교제단)

4) 심담허겁 (心膽虛怯)

- 痰鬱結

- 善恐, 易驚, 胸悶 或胸痛, 驚悸, 多夢

- 治法: 養心溫膽

- 治方: 加味溫膽湯(가미온담탕), 祛痰清神湯

5) 담연울결 (痰涎鬱結)

- 痰火

- 驚悸, 怔忡, 頭痛, 連眼痛, 眩暈, 惡心, 或嘔逆, 胸悶, 或咽喉不仁

- 治法: 祛痰清神

- 治方: 祛痰清神湯(거담청신탕) 清心導痰湯(청심도담탕)

6) 위중불화 (胃中不和)

- 소화가 잘 안되어 나타나는 불면

- 消化不良

- 心下痞滿, 飽悶, 食後倒飽, 或脹滿하며, 噯氣 食則嘔吐 不慾食

- 治法: 消滯和中

- 治方: 香砂養胃湯(향사양위탕), 平陳健脾湯, 大和中飲

多眠, 嗜眠 (多臥, 嗜臥, 善眠, 嗜睡, 多睡, 多寐)

- 음기가 성하고 양기가 쇠하면 나타난다. (영추 구문편)
- 髓海부족으로 인함(영추 해론)
- 간열 (소문 자열편)
- 濕盛으로 인하므로 평위산을 써서 濕困脾土를 치료 (천금방)
- 비위병과 관련해 승양익위탕 처방 (동원집서)

多眠 변증논치

1) 虛證 : 脾氣虛弱(香砂六君子湯), 氣血不足 (人蔘養榮湯), 腎精虧乏 (左歸丸)

2) 實證 濕濁困阻, 痰濁阻滯(導痰湯), 肝膽熱盛

3) 감별진단

- 昏迷: 不省人事, 神志不清, 意識喪失
- 厥證: 陰陽失調, 突然昏倒, 不省人事, 四肢厥冷
- 昏睡: 神昏欲睡, 譫語, 身熱煩躁, 痰壅氣粗

기타 수면 및 꿈과 관련된 병증

1) 다몽 (喜夢, 善夢, 夢多, 夢寐不寧)

-꿈이 많아서 숙면을 못하고 항상 수면 부족감을 느끼며 피로감을 호소. 불면증과 겹하여 나타남.

- 원인: 장부허손(심, 간, 신) 음양실조, 간상, 심신불교

2) 夢魘 (몽염)

- 무서운 악몽이나 위기에 처하는 꿈을 꾸고 잠꼬대를 하거나 놀라서 잠을 깨게 되는 것

- 원인 : 정신쇠약 장부허손 담열혈어

3) 夢遊 (睡行, 夢行, 夜遊)

- 특별한 이유 없이 수면 중에 기상하여 활동하고 깨어난 후에는 그
에 대해 자각하지 못하는 증상

- 원인: 품부부족 소아에 칠정울결 성인에 음식노권

4) 夢驚 (睡驚, 夜驚, 夢惕, 夢寐驚悸)

- 수면 중에 악몽으로 경척불안 침성경규하며 깨어나서는 분명히 기억하지 못하는
상태

- 원인: 허다실소

5) 夢語

- 수면 중에 자각하지 못한 상태에서 말을 하는 병증

- 원인: 열사

6) 夢交 (夢接內, 夢與鬼交, 夢與邪交, 與鬼交通)

- 수면 중에 실제 상대 없이 성교하는 꿈을 꾸는 것.

깨어난 후에는 정신황홀하고 피로와 무력감을 느끼는 병증

- 원인: 칠정울결과 장부허손

7) 夢遺 (夢接內, 夢失精, 夢泄, 夢泄精, 遺精, 遺泄)

- 남자에게 수면 중에 정액이 저절로 외설되는 증상

- 원인: 허증 (신허), 실증 (간경울열, 심화, 습열)

8) 遺尿(遺溺 夜尿 尿床)

- 수면 중에 소변이 유실돼 깨어난 후에 알게 되는 현상

- 원인: 방광부적과 허, 간경습열

9) 齠齒 (계치)

- 수면 중에 자각하지 못하는 상태에서 이를 가는 현상

- 원인: 허한 것 보다는 실열에 의해서

10) 鼾眠 (한면)

- 氣道不暢에 의해 수면 중에 나타나는 코골이 현상

4절. 불면장애 진단, 치료

불면증 진단

자세한 병력청취

- 발생시기

- 양상: 잠이 들기가 어려운지, 중간에 자주 깨는 것인지, 수면각성패턴(낮잠을 자는
지) 근무시간/일주기리듬 (교대근무, 시간이 앞으로 당겨지거나 뒤로 늦춰져 있지 않
은지)

- 같이 자는 사람으로부터의 정보: 자는 동안 주기적으로 다리를 차는지 자는 동안
숨이 멎는지

- 불면증 유발할 수 있는 최근의 스트레스 사건이 있었는지

- 동반질환

+ 침대에 있는 시간 대비 실제로 자는 시간이 얼마나 되는지(수면 효율), 수면 도중 몇 번이나 각성하는지.

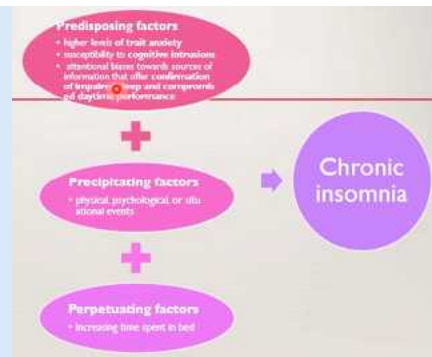
기타 검사 → 필요에 따라..

- 혈액검사(blood count, thyroid, hepatic and renal parameters, c-reactive protein, hemoglobin ferritin, vitamin B12,) 심전도, 뇌파, CT/MRI, 생체리듬 마커 (멜라토닌, 심부체온 등)

3-P Model of Insomnia

- ①불면증을 잘 유발하는 요인
(불안한 기질, 인지적인 침투의 취약성 등)
- ②트라우마 이벤트
- ③불면증을 유지시키는 요인
(침대에 오래 누워있음)

3가지가 합쳐지면 만성적인 불면증이 된다.



수면관련검사

1) 활동기록계 (actigraphy)

- 수면-각성 주기가 불규칙하거나 일주기 리듬 수면각성장애가 의심될 때
표준화 되어 있지 않아 객관적으로 보기 어려우나, 수면일지와 비교해 임상에서 활용하기도 함.

2) 수면다원검사 (polysomnography)

우리가 할 수 있지는 않다.

- 주기성 사지운동증이나 수면무호흡증 기면병 등이 의심될 때.
- 치료에 잘 반응하지 않는 불면증
- 직업적으로 불면증이 위험을 초래할 수 있는 경우 (직업 운전수 등)
- 객관적인 수면지표와 주관적인 불면증 사이에 큰 차이가 있을 것으로 의심되는 경우(paradoxical insomnia)

3) 수면잠복기 반복검사 (Multiple sleep latency test MSLT)

기면증이 의심될 때

- 수면다원검사 기기를 이용하여 주간의 수면잠복기를 반복 측정함으로써 주간의 과도한 졸음을 객관적으로 측정하는 검사임

수면지표

약어	수면지표	한글용어
SOL	Sleep onset latency	수면잠복기
TIB	Time in bed	총 침상시간
TIB/d	Time in bed during 24 hours	하루 총 침상시간
TST	Total sleep time	총 수면시간
SE	Sleep efficiency	수면효율
WASO	Wake after sleep onset	입면후 각성시간
NOA	Number of awaking	수면중 각성 횟수
PTB	Duration from administration of pills to bedtime	수면제 복용 후 잠자리에 들 때까지 시간
PTS	Duration from administration of pills to sleep onset time	수면제 복용 후 입면까지 걸리는 시간
PTW	Duration from administration of pills to wake up time	수면제 복용 후 아침 기상까지 걸리는 시간

빨간색 글씨들은 불면증 환자들을 문진하거나 팔로우업할 때 확인하면 좋다!

수면일기 (Sleep diary)

- 전날밤의 수면에 대해 다음 날 아침 직접 기록함.
- 취침시간, 기상시간, 수면잠복기, 야간 각성빈도

1) 장점

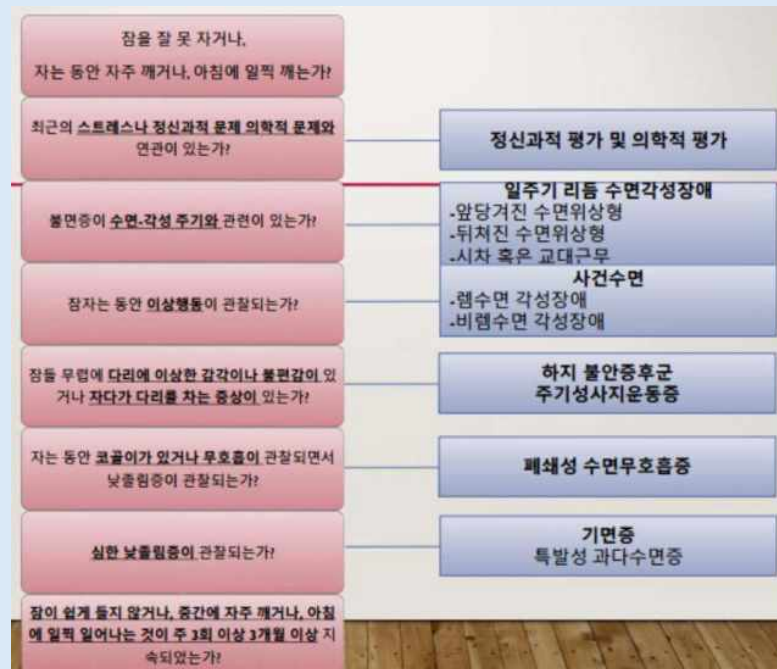
- 매일매일 기록하게 되므로 지난 기간 동안 평가하는 설문지보다는 기억 오류의 영향을 상대적으로 덜 받음.
- 개인의 수면패턴을 정량적으로 산출할 수 있기 때문에 불면증 치료 전후를 평가하는데 매우 유용함.

2) 단점

- 매일 아침 기록하지 않으면 자료가 누락되어 부실해질 수 있음.
- 오히려 수면일기를 작성하는 것 때문에 불면증이 악화될 수 있음.

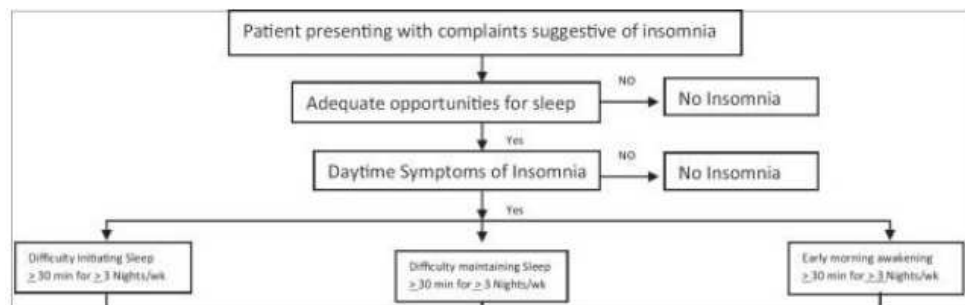
+ 불면증 진단 설문도구 중 severity 체크를 위해 ISI가 가장 많이 사용됨.

불면증 진단 프로세스



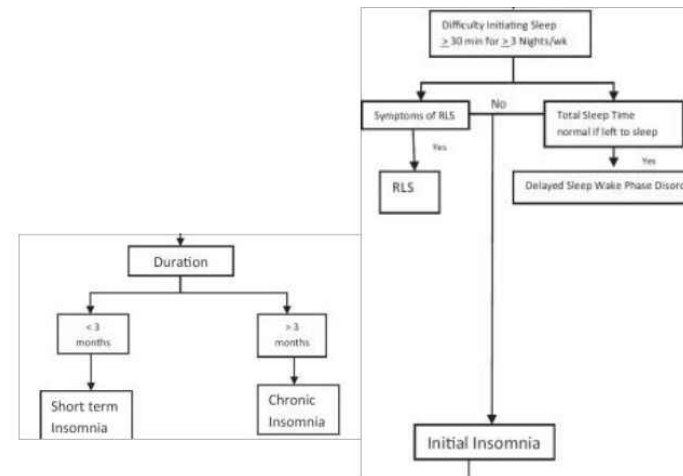
빨간 칸에 있는 질문들을 통해 질환들을 하나씩 rule-out함

불면증 진단 알고리즘



- 1) 충분한 수면을 취할 기회가 있었는데도 잠을 못 잤는지?
- 2) 주간에도 영향을 미치는지?
- 3) 수면 개시하는데 문제? 유지에 문제? 너무 일찍 깨는지? 로 분류

3-1) Initial Insomnia (개시문제)

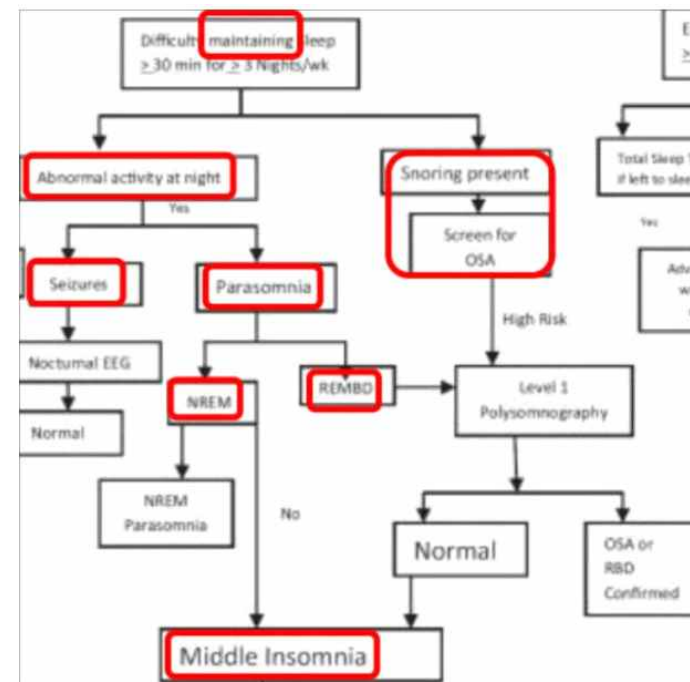


- 3개월 이하는 acute, 이상은 chronic으로 분류

- 하지불안증후군을 감별하고, 수면 스케줄이 밀려있는지 감별.

- 3개월 이하의 경우 트라우마 이벤트가 있는지 확인

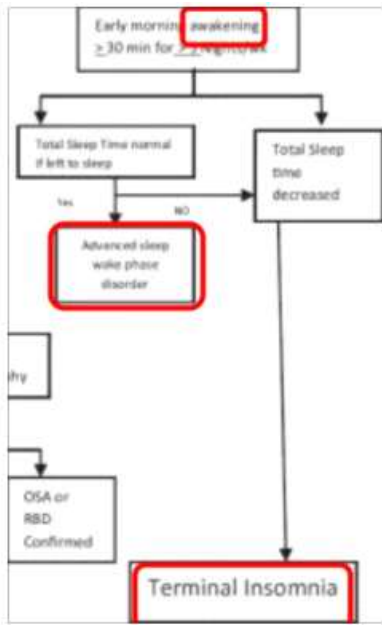
3-2) Middle Insomnia (유지문제)



- 3개월 이하 acute, 이상 chronic 동일

- Seizure인지 Parasomnia인지 렘인지 코골이 때문은 아닌지 등등 감별하고 다 아니면 수면 유지장애가 있는 불면증으로 진단

3-3) Terminal Insomnia (너무 일찍 깨)



- 3개월 이하는 acute, 이상은 chronic으로 분류

- 수면 스케줄이 너무 앞으로 간 것인지 확인, 아니면 불면증.

불면증 치료

인지행동치료 (CBT)

• 불면증을 만성화시키는 인지적 오류를 바로잡고 + 불면증을 고착화시키는 잘못된 행동의 요소를 고치는 행동치료적 기법이 결합

→ 불면증을 만성화시키는 요인은 인지적 오류가 가장 크다!

• 성인 불면증의 일차치료 권장(strong recommendation)

- 약물치료 의존 및 남용의 문제 >수면제 사용 전 CBT적절히 활용해야 함
- Short-term benefits 약물치료와 유사함
- 약물보다 효과가 더 지속됨. 치료종료후 효과가 36개월까지 지속됨.
- adverse effects 보고된 바 없음

• 제한점

- 수면위생교육만 단독으로 사용하면 유의한 효과 없음.
- 아직까지 어떤 인지치료와 어떤 행동치료가 결합되어야 효과가 더 좋은지에 대한 연구결과 없음.
- 그러나 인지행동치료의 여러요소 결합이 불면에 효과적인 접근으로 보임.
- CBT가 효과적이라면 환자가 여러회기(5~7회) 치료를 받아야하고 사고와 행동을 수정하는데에 열린 자세로 받아들일 수 있어야 함.
- 그러나 일반의에게 불면증으로 찾아오는 환자는 'quick fix'를 원하기 때문에 CBT를 적용하기 어려움이 있음 .

~이하 1)~5): 인지행동치료의 구성 ~

1) 수면위생교육(sleep hygiene education)

- 수면에 영향을 미치는 요소를 점검하고 수면을 위한 건강한 습관을 만들기 위해 교육을 시행하는 것
- 만성 불면증 환자의 경우는 이미 수면위생에 대한 지식을 갖고 있는 경우가 많으며 수면위생교육만으로는 의 효과를 기대하기 CBT 어려움.
- 지식을 갖고 있으나 실제로는 불면증을 악화시키는 병적 행동을 지속하면서 예외적인 상황을 정당화하는 경우도 있음.

- 반대로 너무 강박적으로 수면위생을 지키려고 하는 나머지, 불안과 심리적 신체적 과도한 각성이 지속되면서 불면증이 해결되지 않는 경우도 있음.
- 1~2가지 변화 가능한 환경 혹은 생활습관을 선정
- 너무 많은 생활습관의 변화 혹은 복잡한 규칙은 실패하기 쉽다

수면위생 예시

- ① 다음날 피곤하지 않을 정도만 주무십시오. 잠자리에 누워있는 시간을 줄이면 수면의 질이 높아질 수 있으나 잠자리에 누워있는 시간이 너무 길면 잠이 얕아지고 자주 깨게 됩니다.
- ② 아침에 규칙적인 시간에 일어나는 것이 중요합니다 이는 밤에 잠드는 시간을 규칙적으로 만드는데 매우 중요합니다.
- ③ 매일 적당한량의 운동을 지속하는 것은 잠을 잘 자는데 도움이 됩니다. 그러나 어찌다 한 번 운동을 열심히 했다고 해서 잠을 자는데 도움이 되지는 않습니다.
- ④ 자는 동안 심한 소음은 잠을 방해하기 때문에 조용한 환경을 만드는 것이 좋습니다.
- ⑤ 침실이 너무 더우면 잠을 방해합니다. 너무 추운 경우에도 마찬가지입니다. 침실에 덩거나 춥지 않도록 온도를 유지하십시오.
- ⑥ 배가 고프면 잠에 방해가 됩니다. 우유나 스낵과 같은 간단한 음식을 드시는 것이 도움이 됩니다.
- ⑦ 일시적인 수면제는 도움이 되지만 장기적인 수면제 사용은 피하는 것이 좋습니다.
- ⑧ 저녁에 카페인 들어간 음료를 마시는 것은 잠을 방해합니다.
- ⑨ 술은 잠을 빠르게 들게는 하지만 중간에 자주 깨도록 만듭니다.
- ⑩ 잠에 들기 위해 너무 애를 쓰지 마십시오. 잠이 오지 않고 긴장이 되고 힘들 때에는 차라리 너무 환하지 않게 불을 켜고 독서를 하거나 음악을 듣는 것이 수면에 도움이 됩니다.

2) 수면제한법 (sleep restriction therapy)

- 불면증 환자들이 수면시간을 확보하기 위해 비정상적으로 노력하는 것을 환자의 실제 수면시간을 고려하여 제한하는 방법.
- 수면일지 혹은 활동기록계를 통해 환자의 수면시간을 확인하고 환자의 수면효율을 고려하여 목표 수면시간 및 기상시간을 결정함.
- 환자의 수면효율을 높이기 위해 총 침상시간을 점진적으로 줄이거나 제한함.
- 목표수면효율인 85%에 이르기까지 총 침상시간을 매주 15분 또는 30분씩 줄여나감
- 침대에서 잠들지 못하고 깬 상태로 많이 누워있는 유형에 적절함.
- 4시간 이하로 제한하지 말 것
- 환자에게 주간 졸림증상에 대해 경고해야함.
- 낮잠자는 것을 막아야 함.
노인의 경우에는 30분 낮잠은 허용할 수 있음

3) 자극조절 (stimulus control therapy)

- 수면에 관한 잘못된 형성된 조건화를 잠이 들기 용이한 건강한 습관과 연관시키는 행동치료법 기법
- 잠자리 혹은 침실은 잠을 자는 공간으로 활용하고 수면을 방해하는 활동은 침실 밖에서 하도록 함.
- 잠자리에서 TV시청, 업무와 관련된 행동, 인터넷이나 휴대폰 사용은 하지 않도록 함.
- 수면잠복기가 충분히 조절되지 않은 상태에서 자극조절법이 강조되면 환자의 불안이나 긴장도가 높아져 불면증이 더 심해지기도 하므로 주의해야 함.

- ① 졸릴 때에만 자리에 누우십시오.
- ② 잠이 오지 않으면 10분 내지 15분 정도 후에 다시 일어나십시오
- ③ 거실에 앉아서 스탠드만 켜 놓고 책을 읽거나 음악을 듣거나 하십시오.
- ④ 졸리면 다시 잠자리로 들어가서 잠을 청하십시오.
- ⑤ 2~4 과정을 반복하십시오.
- ⑥ 기상시간을 일정하게 유지하십시오.
- ⑦ 잠자리는 잠을 자는 용도로만 사용하십시오.
- ⑧ 낮잠은 피하는 것이 좋습니다 정 졸린다면 30분 이내로만 주무십시오.

4) 이완요법 (relaxation technique)

- 만성 불면증을 앓고 있는 환자의 경우 자율신경계 조절기능 저하로 인해 긴장상태가 동반되는 경우가 많음.
- 신체적인 증상- 두근거림, 좌불안석, 두통, 감각예민 등을 동반하는 경우 이러한 신체적인 이완을 병행하는 것이 치료에 도움이 됨.
- 각각의 환자에게 알맞은 이완기술을 찾는 것이 중요함.
- **Progressive muscle relaxation** : 5~6초간 긴장 후 20~30 초간 이완. 머리에서부터 발끝까지 시행함. 긴장과 이완의 차이를 알아차리게 하는 것이 중요함.
- **Guided imagery**: 온화하고 편안한 장면을 상상하도록 함
- **Breathing exercises** : 호흡연습을 적어도 하루에 20분이상 2주간 연습하도록 함. 호흡연습이 어느정도 익숙해지면 침상에서 30분간 시행하도록 함. 실패하면 그 다음날 시행하도록 함. 주의할 점은 이 호흡훈련이 수면실패와 연관되지 않도록 해야 함.

복식호흡법

- ① 편안한 자세로 눕거나 앉아서 두 눈을 감으십시오
 - ② 왼쪽 손은 배 위에, 오른쪽 손은 가슴에 올려놓으십시오 ,
 - ③ 약 5초간 코로 천천히 가능한 한 깊게 숨을 들이 쉬면서 배를 최대한 내미십시오.
 - ④ 배가 부풀어 오르는 것을 느끼면서 숨을 들이마시되, 가슴이 움직이지 않도록 하십시오.
 - ⑤ 숨을 최대한 들이마신 상태에서 1초 정도 숨을 멈춥니다
 - ⑥ 약 5초간 천천히 숨을 끝까지 내칩니다
 - ⑦ 한 번 시행시 5분간, 하루 중에 자주 시행하시기 바랍니다.
- 잘 안될 수 있다 굳이 안되는걸 강요하진 말자

- Biofeedback

5) 인지치료

- 불면증에 대해 과도하게 걱정하거나 불면으로 인한 건강상, 심리적인 이유들이 부각되어 생기는 불안에 대한 자동화사고를 점검하고 교정하는 치료
- 잠에 대한 잘못된 역기능적 사고들이 오히려 잠을 더 못 자게 하는 원인이 됨.
- **수면시간에 대한 강박적인 집착**
ex) 낮에 기운을 차리고 일을 잘하려면 8시간은 자야한다
- **잠을 잘 이루지 못하는 상황에 대한 파국화 사고**
ex) 충분히 잠을 못 자면 다음날 낮에 기능을 거의 할 수 없다

수면에 대한 역기능적인 사고의 예

- 하루에 8시간은 자야한다
- 부족한 잠은 어떻게 해서든지 보충해야 한다
- 잠을 잘 못 자면 건강을 해칠까 걱정된다
- 잠을 잘 못 자면 이튿날 생활을 망치게 될 것이다
- 잠을 영영 통제하지 못하게 될 것이다

광치료

- 빛 자극을 통해 우리몸의 생체시계는 24시간 명암주기(light-dark cycle)에 맞추어 동조화된 리듬을 나타냄 >일주기리듬의 위상변화
- 계절성 우울장애에 효과입증됨
- 노인에서 인지기능향상과 치매노인에서 수면 행동문제를 줄여줌 ,
- 불면증을 포함한 일주기리듬 수면각성장애, 알츠하이머병에서 수면증상에 대한 광치료 메타분석 결과 광치료가 전반적 수면증상을 유의하게 개선시킴.
- 2000~10000lux의 광치료를 30분에서 2시간정도 수일간 진행할때 치료적 효과 나타남
- 부작용: 안구건조증, 안구 충혈감, 두통, 불안, 초조감 등이 보고되지만 경미할 뿐 더러 대부분 임상적으로 문제가 되지 않음

운동요법

- 수면항상성의 강화 및 일주기리듬의 안정화에 도움이 됨
- 메타분석 결과: 규칙적인 운동이 총 수면시간, 수면잠복기, 수면효율, 입면후 각성시간 등 수면지표 및 수면의 질 척도에서 모두 긍정적인 효과가 있었음.
- 불면증 유형에 따른 운동요법의 적용에 관한 세분화된 연구가 필요함

#약물요법

- 인지행동치료를 적용하기가 어렵거나 적용하더라도 효과가 없을 경우 약물적 치료 적용

종류	주로 사용되는 용량
1. Benzodiazepine	
① Flurazepam*	15~30mg
② Triazolam*	0.125~0.25mg
③ Flunitrazepam*	1mg
④ Brotiazolam*	0.25mg
⑤ Clonazepam	0.5mg
2. Non-benzodiazepine GABA modulator(z-class)	
① Zolpidem immediate-release*	5~10mg
② Zolpidem controlled-release*	6.25~12.5mg
③ Eszopiclone*	1~3mg
3. Antidepressant	
① Trazodone	25~50mg
② Mirtazapine	7.5~30mg
③ Amitriptyline	10~30mg
④ Doxepin*	3~6mg
종류	주로 사용되는 용량
4. Antihistamine	
① Doxylamine*	25mg
② Diphenhydramine*	25~50mg
5. Melatonin	
① Prolonged-release melatonin*	2mg
6. Antipsychotics	
① Quetiapine	25~50mg
② Olanzapine	2.5~5mg

- 졸피뎀을 가장 많이 씀.
- 안티히스타민은 사실 불면장애에 권고되진 않음
- 최근에는 멜라토닌계열이 많이 사용됨
- 안티사이코틱도 가끔 사용되는데 권고되진 않음

1) Benzodiazepine

• GABA(중추신경계의 가장 흔한 억제성 신경전달물질)와 GABA-A receptor간 결합을 촉진시킴

-GABA receptor α -1: 수면과 관련>Z class(non-benzodiazepine drug)

-GABA receptor α -2:근이완효과, 정신운동기능저하, 항경련효과 관련

• Flurazepam*, Triazolam*, Flunitrazepam*, Brotiazolam*,
+Clonazepam, estazolam, temazepam, quazepam /
lorazepam, diazepam, etizolam

- Long-acting (flurazepam [Dalmane], quazepam[Doral]): 수면유지장애

- short-acting (triazolam [Halcion]): 수면개시장애

• AASM Clinical practice guideline for the pharmacologic treatment of chronic insomnia in adults: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline(2017):

-BZD이 수면잠복기를 감소시키고 총수면시간을 늘리며 수면 중 각성을 줄이고 수면의 질을 높인다는 연구결과가 있음.

• ESRS European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia(2017):

-4주 이하 단기간 치료에서 BZD효과가 있으나 장기간 사용시 그 효과가 충분히 입증되지 못하였으며 부작용 가능성이 높아 장기 처방은 권장되지 않으며 매일 복용하는 환자들의 경우 필요시 간헐적으로만 복용하도록 교육할 것을 강력히 권고하고 있음.

•ACP Management of chronic insomnia disorder in adults: a clinical practice guideline from the American College of Physicians (2016):

-만성불면증의 효과는 충분한 근거가 없는 상태로 일반 BZD적으로는 사용이 권고되지 않고 불면증에 대한 인지행동치료가 충분히 효과를 거두지 못한 경우 제한적으로 단기간만 사용하도록 권장하고 있음.

•BZD 부작용

-낮졸림증, 운동실조, 어지럼증 및 인지기능저하

-Triazolam: 전향성 기억상실을 유발하거나, 기존에 뇌 병변이 있는 환자들에게서 공격적 행동을 증가시킴.

- 장기간 사용시 내성 및 의존 중단시 금단증상이 생길 수 있고 특히 triazolam과 같은 반감기가 짧은 약제에서 더 흔함 , .

- 노인에서 인지기능이 저하될 수 있고 섬망을 비롯하여 근이완 효과에 따른 낙상과 골절 등의 부작용 발생 가능성이 높음. 또한 치매의 위험성 증가와 관련이 있다는 연구결과가 있으므로 노인에서 사용에 주의해야함.

- 수면무호흡증이 동반된 환자에서는 BZD의 사용이 무호흡을 악화시킬 수 있으므로 주의 필요함.

•한국판 불면증임상진료지침 불면증의 진단과치료 대한신경정신의학회 임상진료지침 위원회 권고안 (2019)

- **BZD 사용은 4주 이하의 단기간으로 제한할 것을 권고**

2) Z-CLASS DRUG

= Non-benzodiazepine hypnotics

- GABA receptor α -1에만 선택적으로 결합하여 수면효과가 나타냄.

- Zolpidem immediate-release*, Zolpidem controlled-release*, Eszopiclone* / zaleplon

- **우리나라 2016년도 보고상 가장 많이 처방되는 수면제가 zolpidem**이며 처방건수도 점점 증가하는 추세임

- 연구결과 zolpidem의 사용이 수면잠복기를 감소시키고, 총 수면시간을 증가시키며, 수면 유지에 도움을 주고 수면의 질을 개선시킴.

- 불면증상이 심할경우에만 간헐적으로 zolpidem을 복용할 경우 부작용이 적어 안전하면서도 정기적으로 복용하였을 때와 비슷한 정도로 수면잠복기를 단축시키고 총 수면시간을 늘리며 수면의 질을 개선시키는 것으로 나타남.

•zolpidem 부작용

:두통 어지럼증 졸림 BZD에 비해 상대적으로 부작용이 덜함.

-수면보행증이나 수면관련식이장애 등의 사건수면, 기억상실, 환각, 자살위험성 증가

등

-내성, 의존, 금단

-노인에서는 부작용 우려로 인하여 용량 감량하여 처방.

•AASM Clinical practice guideline for the pharmacologic treatment of chronic insomnia in adults: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline(2017):

-성인에서 수면 개시 및 수면 유지장애가 있는 경우 zolpidem 사용을 제안하고 있음

• ESRS European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia(2017):

- **4주 이상 장기간 사용은 권고되지 않으며 매일 복용하기 보다는 필요시 간헐적으로만 복용하는 것이 바람직함**

• ACP Management of chronic insomnia disorder in adults: a clinical practice guideline from the American College of Physicians (2016):

- zolpidem이 수면잠복기와 총 수면시간을 늘리는 효과가 있으나 장기간 사용의 이득과 위험성에 관련된 근거 자료가 부족하므로 4~5주 이하의 단기간 사용을 제안함

•한국판 불면증임상진료지침 불면증의 진단과치료 대한신경정신의학회 임상진료 지침위원회 권고안 (2019)

3) ANTIDEPRESSANTS

• TCA는 최근 통증이나 수면조절 목적으로 사용되고 있음 .

• Trazodone, Mirtazapine, Amitriptyline, Doxepin*

• Trazodone

-보통 25~50mg의 저용량에서 off-label로 수면제로 사용되고 있음.

- 수면개시장애보다는 **수면유지장애**에 좀 더 도움이 되는 것으로 보임.

- 부작용: 두통, 기립성, 저혈압 등의 부작용이 있으나 남용의 문제는 상대적으로 덜하기 때문에 BZD의 남용이나 의존이 걱정되는 경우에 선택해 볼 수 있음.

•Mirtazapine

- 우울증이 같이 동반된 경우 사용할 수 있는 약제
- 부작용: 과도한 진정효과, 체중 및 식욕증가, 입마름 등

• Doxepin

- 메타분석 결과 수면개시 장애에는 효과가 관찰되지 않았으며, 수면유지 장애에 효과적인 것으로 분석됨
- 설사, 낮졸림증과 두통의 부작용이 보고되어 있으나 BZD나 z-drug에 비해 부작용 측면에서 장점이 있고 낙상의 위험이 상대적으로 적어 노인에게 처방 장점이 있음.

4) MELATONIN

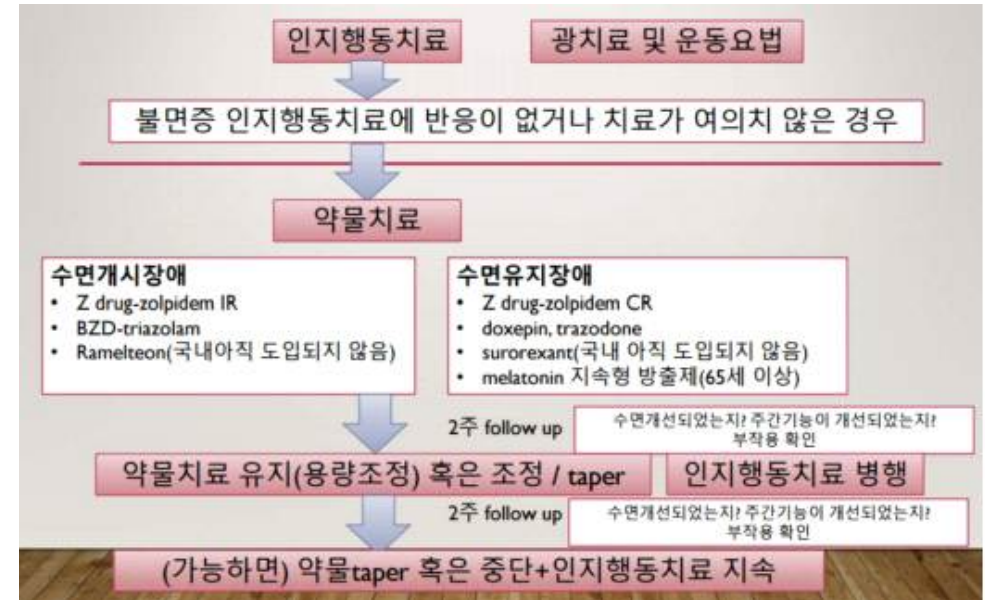
- 연령이 증가함에 따라 의 합성이 감소하고 melatonin , melatonin 농도의 최고 점이 낮아지는 경향이 관찰되는데 이로 인하여 일주기 리듬이 약화되고 불면증상이 발생할 수 있음.
- 노인 불면증 치료에 특히 효과적일 수 있음

- Prolonged-release melatonin(**circadin**): 우리나라 2014년부터 55세 이상 불면증 환자에게 사용 승인됨. 잠자리에 들기 2시간전에 복용하도록 권장함.

우리나라에서 많이 사용되고 있음

- 치료 반응률이 26~47%로 낮고, 다른 수면제에 비하여 효과가 즉각적이지 않고 약물가격도 상대적으로 높음.
- 처음 약물 시작할 때 최소 3주 이상은 지속적으로 복용해야 함.
- 인지기능저하나 낙상 등의 부작용이 적고 반동성 불면이나 의존, 내성 및 금단증상이 적어 노인인구나 암 환자등에 적용

- Ramelteon(melatonin receptor agonist): 미국FDA 승인, AASM(2017)진료지침에서 수면개시 불면증에 사용 권고하고 있으나 우리나라에서 아직 허가되지 않음



taper: 약물 양을 줄임. 2주에 25% 정도로 점진적으로 함.

#When to Refer

OSAHS(폐쇄성 무호흡증)이나 RLS(하지불안증), narcolepsy, 앞서 설명한 사건수면 등 증상이 나타날 경우 상급기관의 세밀한 검사 가 필요할 수 있으니 상급기관에 의뢰해야 함

5절. 불면증 한의임상진료지침

불면장애 한의표준임상진료지침 V2.0(2021)- 대한 한방신경정신과학회

대상 인구집단: 성인 원발성 불면장애 (만 19세 이상)

한약치료

성인 원발성 불면 환자의 불면증상 개선에 한약을 고려할 수 있다. (C/Moderate)

검색된 모든 한약 처방 중 한국의 임상에서 실제 사용에 선호되는 처방 위주로 근거

를 정리하였고 증성약과 같은 임상현실과 괴리가 있는 처방은 연구대상에서 배제함.

13개의 다빈도 처방 13

: 歸脾湯加減(귀비탕가감), 溫膽湯加減(온담탕가감), 黃連溫膽湯(황련온담탕), 酸棗仁湯加減(산조인탕가감), 交泰湯加減(교태탕가감), 血府逐瘀湯(혈부축어탕), 和胃安神湯(화위안신탕), 龍膽瀉肝湯(용담사간탕), 加味桂枝甘草龍骨牡蠣湯(가미계지감초용골모려탕) 柴胡疏肝散(시호소간산), 解鬱安神方加減(해울안신방가감), 逍遙散加減(소요산가감), 天王補心丹(천왕보심단)

이후 피피티 읽으셨는데 읽으신 부분만 정리하겠습니다. 다 읽고 싶으시면 18 써머리 사진 참고하세요

1) 귀비탕가감 (C/Moderate)

귀비탕은 근심과 생각이 지나쳐 심과 비를 상하여 건망, 정충이 생긴 것을 치료한다. 심비양허변증에 해당하는 가슴두근거림, 건망증, 정신피로, 안색이 좋지 않고 입맛이 없으며 식후 헛배가 부르는 증상 등에 효과가 있다.

2) 온담탕가감 (C/Moderate)

온담탕은 매사에 잘 놀라고, 꿈꾸는 것과 잠드는 것이 일정하지 않으며, 허번하여 잠을 잘 이룰 수 없는 증상에 사용한다. 그 외 심담허겁 변증에 해당하는 잘 놀라고 악몽을 꾸고 잠에서 잘 깨며, 복부가 답답하고 입이 쓰고 음식생각이 없고 입에서 점조한 가래 많은 증상이 있을 때 효과가 있다.

3) 산조인탕가감 (C/Moderate)

산조인탕은 잠을 못 자거나 지나치게 많이 자는 증상을 치료한다. 간혈휴허변증에 해당하는 어지럽고 귀울림이 있으며 안색이 창백하고 시야에 흐리고 밤에 잘 보지 못하며, 팔다리가 저리고 뻣뻣하고 관절의 움직임이 원활하지 못하고 손발의 떨림, 근육의 떨림 증상이 있을 경우 효과적이다.

4) 소요산가감 (C/Moderate)

간비불화, 간기울결 변증에 해당하는 잠을 못자고 꿈이 많으며 안색이 창백하거나 위황한 증상, 몸이 피로하고 팔다리에 힘이 없으며 복부가 창통하고 쉽게 화가 나는

증상에 효과적이다.

다른 약들은 양방 약과의 병행치료에서 B/moderate를 받은 반면, 소요산가감은 병행치료에 관한 연구가 부족

5) 혈부축어탕 (C/Moderate)

어혈이 흥부를 막거나, 기기울체로 인한 증상을 치료한다. 불면의 기간이 길고, 초조하여 안정되지 못하고 밤에 놀라는 꿈을 많이 꾸고 가슴에 통증이 있고 통증이 고정되어 있으며, 혀에 어반이 있는 등의 증상이 있을 때 효과적이다.

침구치료

주치료 혈위: 백회, 사신총, 신정, 안면, 신문, 내관, 신맥, 조해, 삼음교, 족삼리, 태충

1) 전침: 소밀파를 활용하고 자극강도는 환자가 참을 수 있는 정도로 시행.

2) 이침

이혈위: 신문, 심, 신, 피질하, 교감

해당 혈위의 피내침을 매일 3-5차례, 매 회 1-2분씩 자극한다.

2-3일간 유침하며 한쪽 귀에 번갈아가며 시술한다.

당뇨 환자에게 피내침은 좋지 않을 수 있다.(감염위험)

이외 약침, 뜸도 사용가능.

명상치료

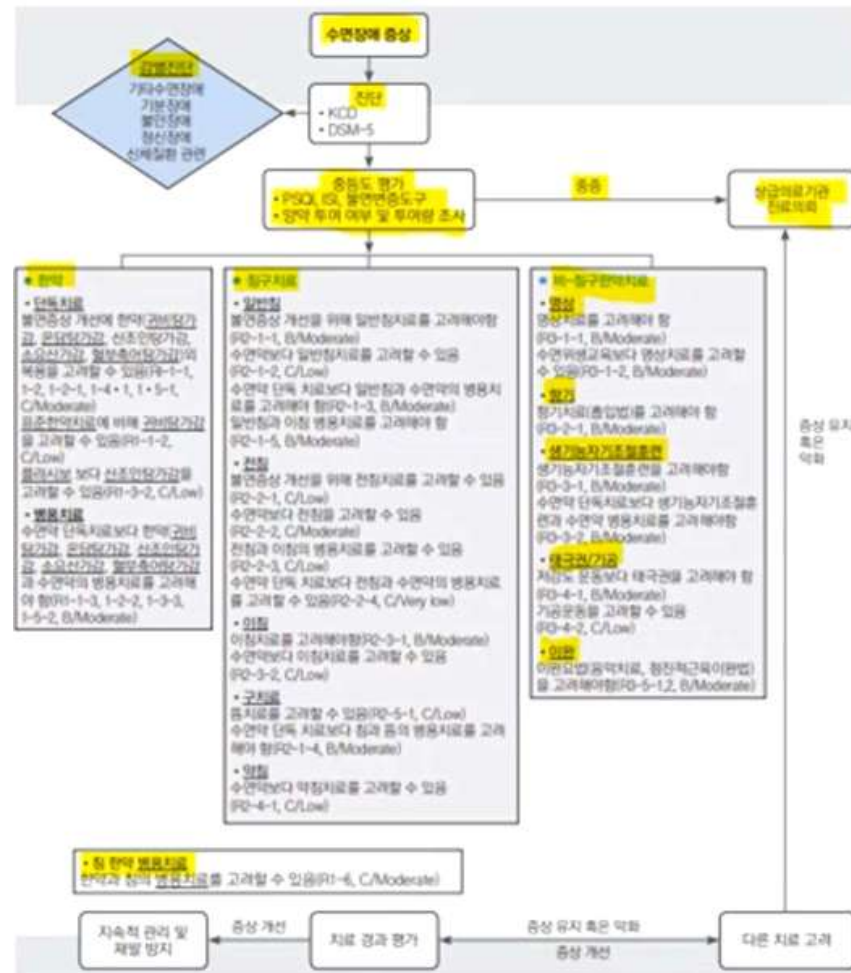
MBSR과 MBCT외에도 변증법적 행동치료(DBT), 수용전념치료(ACT)등이 있다.

향기치료

라벤더, 베르가못, 오렌지 정유를 1:1:1 비율로 혼합하여 흡입기를 사용해 흡입한다. 1% 라벤더(라벤더 정유 0.1mL를 포도씨유 10mL에 희석)를 램프를 사용하여 흡입한다.

베타파 감소훈련, 알파파 훈련, SMR파 훈련 등이 있다.

정리



단순한 한가지 치료에만 의존해서는 안됨.
종합적인 치료가 요구됨.

✎ 신경정신과학 SUMMARY 공지사항

- 과제: 건포도 명상을 한 소감 적어서 구글클래스에 올리기. 간단하게 적으라고 하셨습니다.

✎ 신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: [파랑](#)
- 강조: [빨간색](#) 밑줄
- 말없이 지나간 부분: 회색

[1] 섭식장애

1절. 섭식장애 개요

음식남녀(飮食男女)

- [예기]: “음식과 남녀는 인간의 가장 큰 욕구”
- 혐의의 식욕: 인간의 본성, 생명유지
- 광의의 식욕: 사랑, 의존, 대인관계를 포함한 정신적인 요소를 포함
- 음식 거부: 모성에 대한 거부 혹은 사랑의 거부이기도 함
- 거식증: 단순히 다이어트의 차원이 아닌, 정신분석/무의식적인 차원의 심오한 의미로 볼 수 있음
- 음식은 칼로리, 생존유지 뿐 아니라 사회 문화적인 의미를 갖고있음
- 신경성 식욕부진증(단순히 말라야겠다X)
 - ① 특별한 존재이고자 하는 필사적인 시도
 - ② 부모의 기대에 순응하여 길러진 자기자신에 대한 공격
 - ③ 청소년기에 막 발생하려고 하는 진정한 자기의 주장(먹는 것을 스스로 조절 = 자기 주장)
 - ④ 신체와 동일시되는 적대적인 어머니상에 대한 공격
 - ⑤ 자신의 욕망에 대한 방어(정신분석적 관점)
 - ⑥ 타인을 탐욕스럽고 무기력하게 느끼도록 만들려는 노력과 같은 다양한 무의식적 동기들이 관련되어 있다.

섭식장애의 최근 추세

- 거식증은 사망률이 10%로 굉장히 높음 / 더불어 치료하려는 의지가 없음.
- 18년에 비해 22년에 섭식장애 환자 30~40% 증가
- 10대, 20대 어린 연령층에서 상당한 증가폭을 보임.
- 특히 거식증에서는 10대 이하가 97.5% 증가
- 국내섭식증 환자 추이 2017년 8168명 → 2021년 1만 900명
- 이 중 여성이 총 8833명, 연령 20-29세 여성이 2248명
- 섭식장애 수는 실제보다 적게 잡히는 편
- 섭식장애 유병률: 인구 3% / 21년 기준 국내 5174만명 중 3%면 155만명

섭식장애의 하위유형

	하위유형	주요 진단 특징
Feeding 급식장애 :유소아기	이식증 Pica	먹으면 안되는 것(예:종이, 풀, 치약, 흙, 머리카락 등)을 1개월 이상 습관적으로 먹는 경우
	반추장애	먹은 음식물을 반복적으로 되씹거나 토해내는 행동을 1개월 이상 습관적으로 나타내는 경우
	회피적/제한적 음식섭취장애	심각한 체중저하와 영양결핍이 나타나도록 음식을 먹는 것에 대해 관심이 없고, 먹는 것을 가급적 회피하고, 먹더라도 매우 제한적으로만 먹는 경우
Eating 섭식장애 :청소년기 성인기	신경성 식욕부진증	체중증가와 비만에 대한 극심한 두려움 때문에 음식섭취를 현저하게 감소시키거나 거부함으로써 체중이 비정상적으로 저하되어 있는 경우
	신경성 폭식증	짧은 시간 내에 많은 양의 음식을 먹는 폭식행동과 이로 인한 체중증가를 막기 위해 보상행동(구토, 이뇨제, 설사제, 관장약 사용 등)을 반복적으로 나타내는 경우
	폭식장애	신경성 폭식증과 마찬가지로 폭식행동을 나타내지만, 보상행동은 하지 않는 경우

- DSM-4에서는 섭식장애만 다루었는데 DSM-5에서는 유소아기의 급식장애가 추가되었다.

미분류형 급식 및 섭식장애

1. 여성의 경우, 신경성 식욕부진증의 진단기준을 충족시키지만, 규칙적 월경이 있는 경우
 - DSM-4까지는 신경성 식욕부진증의 진단기준에 월경관련 징후가 있었음
2. 신경성 식욕부진증의 진단기준을 충족, 체중감소가 있지만 현재의 체중이 정상 범위
3. 신경성 폭식증의 진단기준을 충족, 폭식과 부적절한 보상행동이 2주일에 1회 미만, 또는 기간이 3개월 미만일 경우(폭식, 보상행동이 진단기준에 미달)

4. 정상 체중의 사람이 **소량의 음식**을 먹고 부적절한 보상행동을 정기적으로 하는 경우(**먹는 양이 진단기준에 미달**)
5. 많은 양의 음식물을 반복적으로 씹고 내뱉으나 삼키지는 않는 경우
6. 야식증후군: 자다가 깨서 먹거나, 저녁식사 후 자기 전에 많이 먹는 것이 매일 반복되는 것(night eating syndrome)

2절. 이식증(pica)

- 당신의 아이가 흙, 풀처럼 먹으면 안 되는 물질을 먹곤 하는가?
- 먹으면 안 되는 것(흙, 종이, 형겔, 끈, 치약, 풀, 비누, 머리카락 등)을 최소 1개월 이상 습관적으로 먹는 경우

DSM-V 이식증 진단기준

- A. 비영양성 물질이나 먹지 못할 것을 최소한 **1개월** 이상 지속적으로 먹는다.¹
- B. 이러한 행동이 개인의 발달수준에 부적절하다.²
- C. 먹는 행동이 문화적으로나 사회적으로 허용된 관습의 일부가 아니다.³
- D. 만약 먹는 행동이 다른 정신장애(ex. 지적장애, 자폐 스펙트럼 장애, 정신분열증)의 경과 중에만 나타난다면, 이 행동은 별도의 임상적인 관심을 받아야 할 만큼 충분히 심각한 것이어야 한다.

특징

- 영양상태 불량, 빈혈, 전해질 불균형, 기생충 감염, 장폐색, 치아손상, 경련성질환 등 발병 가능
- 이식증 환자의 30%는 납중독 (납중독 → ADHD, 지적장애, 경련성질환 유발 가능)
- 주로 4세 미만
- 지적장애를 동반 지적장애가 심할수록 이식증 빈도 ↑
 - 이식증으로 지적장애가 발생할 수 있고, 지적장애가 이식증을 유발할 수 있다.

¹ 한두 번 먹는 것X

² 18~24개월까지는 호기심이 많기 때문에 시도할 수 있다. But 36개월 이상인 아이들이 먹

원인

- 지적장애, 자폐스펙트럼 장애와도 관련
 - 자폐: 감각들이 특별하게 발달되어 있음. 미각적으로 이상이 있을 경우 이식증이 나타날 수 있다.
- 부모의 관심부족, 감독소홀, 경제적 빈곤, 열악한 가족관계, 아동의 발달지체, 영양결핍(철분결핍)

치료

- 원인규명, 양육환경이 좋지 못해 잘못된 식습관 행동을 고쳐줄 사람이 없는 경우
- 정신사회적 스트레스 완화, 환경치료, 행동치료, 가족상담 등 다양한 측면에서 접근
- 부모에 대한 교육이 중요
- 부모의 관심, 돌봄 등 정서적인 양육이 가장 좋은 치료

3절. 반추장애(Rumination disorder)

- 당신의 아이가 정상적으로 음식을 삼키는데 어려움이 있는가?
- 음식을 반복적으로 토해내거나 되씹는 행동을 1개월 이상 지속적으로 나타내는 경우

DSM-V 반추장애 진단기준

- A. 최소한 **1개월** 이상 반복적인 음식역류(되씹기나 되삼킴, 또는 뱉음에 의해 나타날 수 있음)
- B. 이러한 반복적인 역류가 위장이나 다른 신체적 질환(식도역류, 유문협착)으로 인한 것이 아닐 경우
- C. 신경성 식욕부진증, 신경성 폭식증, 폭식장애, 또는 회피적/제한적 음식섭취 장애의 경과 중에만 나타나는 것이 아니어야 함
- D. 만약 먹는 행동이 다른 정신장애(ex. 지적장애, 다른 신경발달장애)의 경과 중에만 나타난다면, 이 증상은 별도의 임상적인 관심을 받아야 할 만큼 충분히 심각한 것이어야 한다.

는 시도를 한다면 부적절하다.

³ Ex. 산낙지

● CASE: 머리를 자주 돌리며 흔들어 대는 유아

- A양은 21개월로 태어날 때 체중은 2.8kg(정상체중)이었다. 임신 중 어머니는 심한 입덧을 자주 했고, 주위 사람에게 짜증을 많이 냈으며, 하루 중 음식 섭취가 매우 제한적이었고 많이 먹지도 못했다. A양은 9개월까지 모유를 먹었으나 먹는 양은 적었다.
- 어머니는 모유를 먹이는 동안 갈증이 심해서 매일 많은 양의 물을 마셨다. A양은 16개월까지 설사를 자주 하고 토하는 일이 많아 집 근처 소아과를 여러 번 다녔으나, 증상이 좋아지지 않자 큰 병원에 입원을 했다. 검사결과 위장기능에는 별 문제가 없는 것으로 나타났다.(생리적 구조일 수도 있다.)
- A양은 흔히 머리를 뒤로 젖히고 등에 힘을 주며 자주 토하고 삼킨 음식의 일부를 입안으로 올리고 다시 씹거나 뱉기도 하고, 삼키기도 했다. 먹을 것을 주면 많이 먹었지만, 곧 토하고 금방 배고파서 보채며 울곤 했다. 치료자는 A양의 지적 장애가 의심된다고 정신평가를 받아볼 것을 권유했다.(일부로 토를 유발시키는 증상. 고통스러워 보이지만 스스로 쾌감을 얻기도 하고 주위의 관심을 받아 긍정적 강화가 발생한다.)

자기자극행동(self-stimulating behavior)

- 음식의 역류를 일으키기 위해 머리를 뒤로 젖히고, 등에 힘을 줘서 몸을 휘게 하고, 입에 옷이나 손수건 등을 넣는 행동
- 반추를 통해 자기자극 및 자기만족을 느끼기 때문에 반추행동을 하는 동안 불편함을 느끼지 못함.
- 체중감소, 탈수, 저항력 감소, 영양실조, 성장지연, 심하면 사망
- 지적장애 있는 아동에서 높게 나타난다.
- 유아기~성인기 사이에 나타날 수 있으며, 유아기일 경우 보통 생후 3~12개월 사이 자연적으로 회복되나 증상이 심한 일부 유아는 경과가 상당기간 지속되기도 한다.
- 머리 돌리기, 머리 부딪히기, 몸 흔들기, 머리털 잡아당기기 등의 다른 행동 장애 동반

원인

- 신체적 질환: 식도역류, 위장계 감염, 유문협착
- 지적장애
- 심리적 요인: 부모의 무관심, 정서적 자극의 결핍, 심한 스트레스 등

치료

- 보통 자연스럽게 소실되나 그렇지 않으면 생명을 위협할 수 있어 신속하게 치료해야 한다.
- 신체적 구조 이상이 있는 경우 역류 방지 위한 외과적 처치
- 행동치료, 부모교육
- 아이와 긍정적인 정서적 관계 맺기

4절. 회피적/제한적 음식 섭취 장애

- 당신의 아이가 어떤 음식들에 대해 불안해하고 회피하려고 하는가?
- 음식이나 먹는 것에 대해 전혀 관심이 없고, 먹는 것을 가급적 회피, 매우 제한적 식사로 인한 심각한 부적응적 증상이 초래되는 경우

DSM-V 회피적/제한적 음식 섭취 장애 진단기준

- | |
|---|
| A. 적절한 영양, 에너지의 필요가 지속적으로 좌절되는 섭식 또는 급식장애. 다음 중 한 가지 이상의 증상을 나타낸다. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 심각한 체중 감소 2. 심각한 영양 결핍 3. 위장관 급식 혹은 경구 영양 보충제에 의존 4. 심리사회적 기능에 현저한 방해 |
| B. 장애는 구할 수 있는 음식이 없거나 문화적으로 허용되는 관습에 의해 더 잘 설명되지 않는다. |
| C. 신경성 식욕부진증이나 신경성 폭식증의 경과 중 나타나는 것이 아니고, 사람의 체중이나 체형에 관한 장애의 증거가 없어야 한다. |
| D. 의학적 상태로 인한 것이 아니고, 다른 정신질환으로 더 잘 설명되지 않는다. 만약 이 섭식 장애가 다른 상태나 질환과 관련하여 발생한다면, 섭식 장애의 심각도는 일반적으로 나타나는 것보다 심해야 하거나 별도로 임상적 관심을 받아야 할 만큼 심각한 것이어야 한다. |

● CASE: 씹어 먹는 것을 매우 싫어하는 아이

- E군은 현재 3세인데, 잘 먹지를 않아 영양실조로 병원에 입원한 경우였다. 먹은 뒤에 토하는 경우도 많아 음식에 대해 매우 까다로운 아이였다.
- 음식에서 냄새가 난다고 먹지 않고, 음식이 너무 차갑다고 먹지 않고, 뜨겁다고 먹지 않았다. 어머니가 맛있는 것을 만들어 주어도 씹을 때 입이 아프다고 먹지를 않았다. 억지로 먹이지도 못했다. 한 번은 음식을 먹다가 질식하여 병원 응급실로 데리고 간 적도 있었다.

특징

- 음식의 특성에 따라 먹는 것 회피, 매우 제한적 식사, 먹는 동안 상호작용 잘 안됨
- 정서적으로 무감각, 위축, 발달지체 / 수면시간 불규칙
- 음식 회피 정서장애: 불안, 우울, 양극성 장애 등 정서적문제와 관련
- 유아나 아동기 초기에 흔히 나타나지만 청소년기에도 발생가능
- 대부분 시간이 지나면서 장애에서 벗어나지만 심하면 성인기까지 지속
- 원인 질환 살펴보고, 인지행동치료 등이 효과적

원인과 치료

- 불안장애 자폐 스펙트럼 장애, 강박 장애, ADHD가 있는 아동에서 이 장애가 발생할 위험이 높음
- 부모가 불안이나 정신적 문제를 가지고 있을 때 아동의 발병위험이 높아짐.
- 부모의 아동학대나 방치, 공격적 태도로 음식을 주거나 음식거부에 대해 화를 내고 신경질적으로 반응하는 경우 더 악화
- 치료: 원인적 질환(식도 역류, 위장장애의 과거력)이 있는지 살펴보고, 인지행동치료 등이 효과적

5절. 신경성 식욕부진증(Anorexia nervosa)

- 다른 사람들이 당신이 너무 말랐다고 생각하는데도, 스스로는 뚱뚱하다고 느끼는가?
- 체중 증가와 비만에 대한 극심한 두려움 때문에 음식섭취를 현저하게 감소시키거나 거부함으로써 체중이 비정상적으로 저하되어 있는 경우
- 신경성 식욕부진증 환자에게 있어 살 찌는 것에 대한 공포는 죽음의 공포와도 비견되며

억지로 음식을 먹이면 환자는 극심한 공포를 느낀다.

- **빠말라족, 프로아나(pro-anorexia)**

- ① 음식섭취를 제한함으로 심각한 저체중 상태가 초래
- ② 심각한 저체중임에도 체중증가와 비만에 대한 극심한 두려움 또는 체중증가를 방해하는 지속적인 행동
- ③ 체중과 체형(몸매)을 왜곡하여 인식, 체중과 체형이 자기평가에 지나친 영향을 미치거나, 또는 현재의 체중미달에 대한 심각함을 지속적으로 부정
- ④ 이로 인해 심각한 부정응적 증상들이 초래

DSM-V 신경성 식욕부진증 진단기준

- A. 필요한 것에 비해 **에너지 섭취(음식섭취)를 제한**함으로써 나이, 성별, 발달수준, 신체 건강에 비추어 심각한 저체중 상태가 초래된다. 심각한 저체중이란 최소한의 정상수준에 미달하거나 기대 수치 이하의 체중 미달을 의미한다.
- B. 심각한 **저체중임에도 불구하고 체중증가, 비만에 대한 강한 공포**를 가지고 있거나 또는 체중증가를 방해하는 지속적인 행동을 나타낸다.
- C. **체중과 체형을 왜곡하여 인식**하고, 체중과 체형이 자기 평가에 지나친 영향을 미치며, 현재의 체중미달에 대한 심각성을 지속적으로 인식하지 못한다.

- 세분할 것

1. 제한형: 지난 3개월 동안 폭식이나 먹은 음식을 배출하는 행동을 반복적으로 하지 않은 경우. (ex. 스스로 유도하는 구토나 하제, 이뇨제, 관장제의 오용이 없다.)
2. 폭식 및 하제 사용형: 지난 3개월 동안 폭식이나 먹은 음식을 배출하는 행동을 반복적으로 한 경우 (예. 스스로 유도하는 구토, 또는 하제, 이뇨제, 관장제의 오용)

- 현재의 심각도 구분

- 경도(mild): BMI 17kg/m² 이상
- 중등도(moderate): BMI 16~16.99kg/m²
- 중증도(severe): BMI 15~15.99kg/m²
- 최중증도: BMI 15kg/m² 미만

DSM-4와 DSM-5의 진단기준 변화

- DSM-4까지는 신경성 식욕부진증의 진단기준에 월경관련 징후가 있었으나 남성, 폐경, 피임약 복용 등 적용할 수 없는 사례가 있어 삭제되었다.
- DSM-4에서는 Refusal, 즉 음식을 자발적으로 거부한다는 용어를 사용했는데 DSM-5에서는 Restriction of energy intake (에너지 섭취 제한)으로 용어를 변경하였다.

● CASE: 발레를 공부하는 매우 마른 여학생

- 고등학교 진학 후 43kg로 체중이 빠짐
- 날씬해져야겠다고 생각, 음식을 보면 혐오스러움. 발레선생님도 자신이 살찐다고 질타한다고 느낌
- 식탁에서 먹어도 화장실에 가서 토해 내는 경우 多
- 최근 몇 달 월경 X, 자주 어지럽고 피곤
- 아워어가는 자신의 모습을 보며 만족스러워하며, 더 살을 빼야겠다고 생각함

섭식행동의 동기와 보상조절 체계

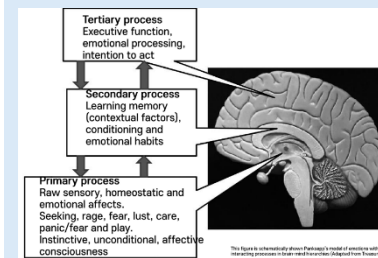
- 원함, 열망, 음식에 대한 극단적 갈망 등의 '포상체계'에는 도파민 회로가 관여
- 충동 만족을 위한 반사행동, 선호행동, 쾌락행동 등에는 아편제제와 대마초제제가 관여
- 쾌락체계는 단순히 식욕 촉진뿐 아니라, 개체의 행동 선택을 관장하는 광범위한 유기적 기관이다.
- 쾌락체계에서는 예상되는 보상과 얻을 수 있는 즐거움 및 기대에 근거하여 행동을 결정
- 섭식장애에서는 섭식과 관련된 동기 행동을 조절하는 체계에 이상
- 비만의 경우, 반대로 이 동기가 유발의 매개가 되며, 보상으로서의 음식에 대한 민감성이 증대되어 있음
- 섭식장애 전반에서 세로토닌 체계의 이상이 시사되며, 비만의 경우 도파민이 매개하는 보상체계의 영향이 있다.

특징

- 불안해하는 모습, 내향화하는 경향, 위협에 대한 높은 민감성이 발병 전부터 많이들 나타난다.
- 특히 사회 불안 양상이 두드러짐
- 가족의 특성일 수도 있음. (유전적 or 후성 유전학적으로 결정)

- 섭식장애의 병리 행동들의 상당수는 인지적 조절신경성 식욕부진증에서 배측인지체계(dorsal cognitive system), 즉 후측 미상핵(dorsal caudate), 해마(hippocampus), 측두 배 외측 전전두 및 전측대상회(parietal dorsolateral prefrontal and anterior cingulate) 등의 기능적 이상은 이환기 및 회복기에서 나타남
- 신경성 식욕부진증에서는 하향식 조절이 증가. 정서적으로 억제되어 있음(→나의 감정이 지금 어떤지 모름)
- 대식증은 하향식 조절 감소

하향식 조절



- Primary process: 뇌간. 항상성을 유지하는 등 우리가 본능적이고, 기본적으로 느끼는 감정 영역
- Secondary process: 변연계. 기억, 컨디셔닝, 감정
- Tertiary process: 대뇌 피질, 실행 기능, 행동, 계획. 삼차적 정서처리
- 하향식 조절: 대뇌피질이 아래쪽으로 조절하는 것

섭식장애와 정서이상

- 급성기에는 불안, 우울, 좌절, 감내력이 저하됨
- 회피, 억압 등의 비효율적인 정서 조절
- (사회적으로 철회되어 있어) 얼굴, 시선을 덜 응시하는 등 정서적 회피
- 눈빛 속 마음 읽기 과제 수행능력결핍
- 사회성이 굉장히 떨어지며 사회적을 고립되어 있는 경우가 많다.(약간 자폐와 비슷함)
- 섭식장애 환자의 정서적인 삶의 중심은 음식, 체중, 체형에 있다. 이러한 사회적, 정서적 기능의 이상은 섭식장애가 발생하기 전에 나타나 병후에도 지속되는 것으로 보인다. 그러므로 섭식장애 환자의 진료시 병전 애착관계, 경쟁/협동 등에 대한 태도, 마음 이론, 자기 표상 등 정서적 측면에 대한 이해가 필요하다.
- 섭식장애는 감정표현 불능증과 함께 나타나는 경우가 많음: 섭식장애 환자들은 자신의 정서를 잘 인지하지 못하고 또 인정하지 못한다. 그래서 섭식장애는 내 감정을 먼저 잘 알아주는 것이 우선순위가 되어야 한다.

● 베니 존슨의 사례: 거식증과 결핍

“그리고 너는 나의 강박관념, 빼만 양상히 남을 때까지 너를 사랑해. 그리고 애나는 삶을 영망으로 만들지 거식증의 나날처럼” (Silverchair - Ana's song)

(참고) Ana = 거식증(Anorexia)

- 베니 존슨은 뒤죽박죽인 자신의 삶 속에서 스스로의 통제력을 시험하고자 음식을 조금만 먹기로 했다.
 - 그는 처음에는 성취감을 느끼며 자기 삶의 통제력을 느꼈다. 하지만 몇 달 뒤에는 적게 먹지 않으면 안되는 지경에 이르렀다.
 - 그는 삶의 통제력을 얻고자 밥을 적게 먹기 시작했지만 결국 통제력을 잃고 말았다.
 - 베니 존슨의 인터뷰: 많은 사람들은 섭식장애를 초래하는 진짜 원인을 이해하지 못해요. 허영심이나 미적인 문제가 아니라, 실은 삶의 통제력을 찾고 싶은 것입니다.
- 섭식장애와 씨름하는 사람들은 체중/체형이나 음식을 조절하는 능력으로 자신을 평가한다. 이러한 행동의 기저에는 자존감의 저하, 우울, 분노, 통제력 상실, 적응하지 못하는 불안감 등이 깔려있다. 결국 식이조절은 주관적으로 느끼는 결핍과 어려움을 극복하기 위한 일종의 대안이다.

섭식장애와 트라우마

- 트라우마를 겪은 사람은 이후에 다양한 증상을 경험한다. ex) 약물 중독도 많고, 폭식, 구토, 절식, 음주, 성적인 문란, 자해 등
- 트라우마를 겪은 후 섭식장애가 나타나기도 하고, 그 경험이 섭식장애를 악화시키거나 재발시키기도 한다.
- 섭식장애가 있는 사람들이 트라우마를 겪은 경우가 일반적인 사람들보다 많다.
- 트라우마 경험은 섭식장애 증상을 촉발시키거나 장기화시킬 수 있다.
- 트라우마 자체가 식이장애로 나타난다기보다는, 트라우마에 의해 생성된 감정을 극복하는 방식이 식이장애로 나타나는 경우
- 즉 겉으로 자기파괴적인 행동이 속에서는 자기보호적인 측면이 있다.
- 따라서 무조건적인 인지행동치료보다는 고통스러워 보이는 이 행동 속에 그러한 감정이 있다는 것을 알아줘야 한다.
- 환자들은 자기가 트라우마가 있다는 것을 초진에서 말하지 않는다. 어느정도 라포가 쌓여야 말한다. 심지어 본인이 기억하지 못하는 트라우마가 있을 수도 있다. 30년 전의 트라우마 경험이 원인이 될 수도 있다.

원인

- 유전적 요인: 유전적 취약성 (불안, 강박적인 특징 등)
- 심리적 요인
 - 성적인 욕구에 대한 방어적 행동
 - 임신에 대한 두려움의 표시(생리를 안 하게 되므로)
 - 모녀 관계에서 자율성을 얻으려는 대치된 행동(자식은 엄마에게서 음식을 받아먹음. 거식증은 이러한 관계를 깨뜨림으로써 자신에 대한 결정권을 되찾으려는 시도)
- 사회문화적 요인
 - 대중매체의 영향, 온갖 다이어트법
 - 날씬함을 강조하는 사회
- 외상성 스트레스와 부정적 생활사건: 아동기 성적학대, 정서적 학대, 심리적 외상과 같은 사건들

거식증으로 인한 손상

- 몸매에 대한 과도한 집착과 똥똥해지는 것에 대한 공포심
- 정신적 손상: 기력없어 쉽게 짜증, 대인관계 위축, 성욕 상실. 강박적으로 일, 운동, 먹는 음식, 칼로리에 매우 예민
- 신체적 손상: 대부분 기아로 오는 문제. 무월경, 변비, 복통, 기면발작, 무기력감, 저혈압, 서맥, 저체온, 말초신경 부종, 손떨림, 점상출혈 등. 치료의 필요성 느끼지 못함.

치료

- 입원치료 필수인 경우: 체중이 3개월간 정상체중에서 30%이상 감소 시, 자살충동이 있을 경우
 - 호전된 환자의 50% 정도는 1년 이내 재발하는 경우가 많아 체중이 정상 이하로 떨어지면 재입원을 하겠다는 서약을 미리 받아두는 것이 좋다.
- 음식섭취를 통해 체중을 늘리는 것이 목표
- 행동치료: 식사 전후 감정과 음식섭취를 기록하는 음식 일지 작성
- 인지행동치료: 신체상에 대한 둔감화 및 비합리적 신념, 왜곡된 인지 교정
- 가족치료: 청소년에 유효
- 섭식장애 관련 병원, 커뮤니티

역학, 예후

- 최근 수십년간 증가 추세
- 젊은 여성 1년 유병률 0.4%
- 여성이 남성에 비해 훨씬 많음: 90% 이상이 여자 청소년, 젊은 여성
- 대부분 청소년기 시작(평균 발병 연령: 약 17세): 15~19세 여자 청소년이 전체의 40%
- 경과: 자연 회복에서부터 심각한 합병증에 의한 사망에 이르기까지 다양함
- 미국 10년 추적연구: 전체 완전한 정상(25%), 상당한 호전으로 일상생활 문제X(50%), 나머지 25%는 만성적 저체중이거나 실생활에 적응하지 못하고 이중 7%는 사망
- 단기적 치료 성과는 나쁘지 않으나 체중을 회복한 뒤에도 몸매와 음식에 대한 부적절한 인식이 지속되는 경우가 흔하고, 대인관계 장애, 우울증을 보이는 경우가 흔하다.
- 자살 시도, 자살률도 높게 나타난다.

6절. 신경성 폭식증(Bulimia nervosa)

- 자제력을 잃고 아주 짧은 시간 동안 엄청난 양의 음식을 먹은 적이 자주 있는가?

- ① 반복적인 폭식 행동
- ② 그로 인한 체중 증가를 막기 위해 반복적이고 부적절한 보상행동
- ③ 이러한 폭식/보상행동이 평균 1주일에 1회 이상, 3개월 동안 발생
- ④ 체형과 체중이 자기평가에 과도한 영향을 미치는 경우

- 폭식증 = 폭식행동 + 보상행동 (보상행동 없이 폭식행동만 있으면 폭식장애)

폭식행동	보상행동
- 일정시간 동안 대부분의 사람들이 유사한 상황에서 동일한 시간동안 먹는 것에 비해 분명하게 더 많은 양의 음식을 먹는 것 - 폭식을 하는 동안 먹는 것에 대한 자제력 상실 Ex) 먹는 것을 멈출 수 없음, 무엇을 얼마나 많이 먹어야 할지 조절할 수 없는 느낌	- 폭식으로 인한 체중 증가와 몸매의 손상을 막기 위해 부적절한 자기방어적 행동 - 구토 또는 설사제, 이뇨제, 관장제 등의 약물복용, 금식, 과도한 운동 등

DSM-V 신경성 폭식증 진단기준

- A. 반복적인 폭식 행동이 있고 폭식 행동은 다음 2가지의 특징으로 나타난다.

1. **일정한 시간 동안**(예:2시간 이내) 대부분의 사람들이 유사한 상황에서 동일한 시간 동안 먹는 것에 비해 분명하게 **더 많은 양의 음식을 먹음**
2. 폭식을 하는 동안 먹는 것에 대한 **조절능력의 상실**
(예: 먹는 것을 멈출 수가 없거나 또는 무엇을 얼마나 많이 먹어야 할 것인지를 조절할 수 없는 느낌)

- B. 체중 증가를 억제하기 위해 반복적이고 부적절한 **보상행동**을 나타낸다,
(예: 스스로 유도한 구토, 설사제, 이뇨제, 관장제, 기타 약물의 오용, 금식, 과도한 운동)
- C. 폭식과 부적절한 보상행동 모두 평균적으로 최소한 **1주일에 1회 이상 3개월 동안** 발생한다.
- D. 체형과 체중이 자기평가에 과도한 영향을 미친다.
- E. 이러한 장애가 신경성 식욕부진증의 삽화 기간 중에만 나타나는 것은 아니어야 한다.

- 현재의 심각도의 구분(부적절한 보상행동의 1주일 평균 횟수)

- 경도(mild): 1~3번
- 중등도(moderate): 4~7번
- 중증도(severe): 8~13번
- 최중증도(extreme): 14번 이상

특징

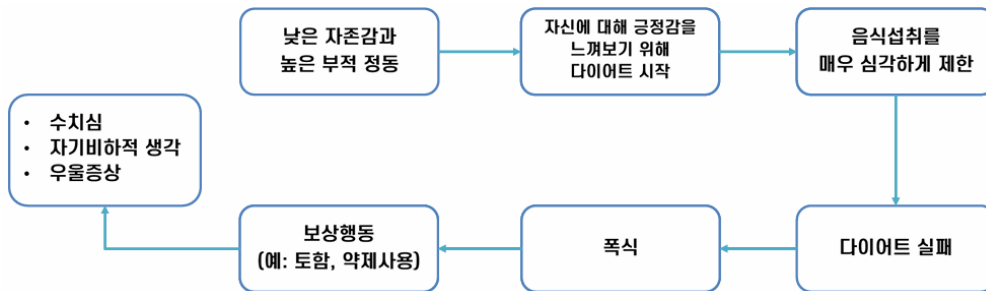
- 체중증가, 몸의 손상에 대한 공포
- **수치심(자신의 식사문제를 부끄럽게 여김). 자발적 치료 多** ← 신경성 식욕부진증과 차이점
- 주로 밤에, 혼자, 집에서, 아무도 보지 않을 때, 우울하거나 스트레스 받을 때
- 우울 증상 선행하거나, 자해, 자살 기도 동반하기도
- 80% 이상이 다이어트를 하다가⁴, 20%는 신경성 식욕상실증(거식증) 시작 이후
- **정상 체중을 유지 혹은 체중 과다가 많다 (2/3은 비만 동반)**
- 불규칙한 월경, 치아 손상, 식도 파열 (위산으로 인해), 심부정맥과 같은 합병증

⁴ 너무 누르면 튀어오르는 것처럼 식욕을 억누르다가 실패하고 폭식함

- 만성적, 간헐적인 경과. 우울증과 공병률이 높다.

- **청소년기 보호자가 알아도 무심코 넘기거나 알기 어려움: 먹고 토하는 것을 숨기기에 모르는 경우가 많다.**

신경성 폭식증의 인지행동적 악순환



원인

- 생물학적 요인: 가족에게 유전되는 성향

- 심리적 요인: 체중에 대한 걱정, 낮은 자존감, 우울증상, 사회불안장애, 아동기 과잉 불안 증상, 아동기 성적 신체적 학대, 청소년기 욕구 표출 부족, 충동 조절능력 저하

• 불안, 긴장, 초조를 대처하기 힘들니 이를 음식으로 대체해서 감정을 소화시키려는 시도

- 정신분석적 요인: 부모상에 대한 무의식적 공격성의 표출

• 음식은 모성의 상징. 폭식증은 모성을 갈구하면서도 거부하려는 공격성을 나타내는 것

- 사회문화적 요인: 날씬한 몸매에 대한 사회문화적 기대와 압력

치료

- 치료 목표: 폭식/구토 주기를 차단하여 식사습관을 정상화

- **너무 잦으면 입원치료**

- 우울, 불안 약물 남용 문제가 있다면 치료 병행(삼환계 항우울제, Fluoxetine HC1)

- 영양상담, 인지재구조화⁵, 가족치료⁶ 병행

⁵ 체중과 몸매에 대한 비합리적인 신념과 태도를 변화

⁶ 가족에 문제 있는 경우 많음

- 발병 후 상당 기간 경과한 후 오는 경우가 대부분

- 충동조절 불능으로 인하여 괴로워하기 때문에 자발적으로 치료를 원하는 경향

- 마음챙김먹기: 건포도 명상

- 예후: 완치율은 50% 이상으로 식욕부진증보다 완치율이 높다.

역학

- 최근 급속하게 증가하는 추세, 신경성 식욕부진증보다 더 빈번하게 발병한다.

- 1년 유병률은 청소년이나 젊은 여성에서 1~3%, 임상 장면에서 90%가 여성

- 발병 연령은 대개 청소년기 후기, 성인기 초기 환자의 90~95%가 10대 후반, 20대 초반

- 사춘기 이전이나 40대 이후에는 그리 흔하지 않음.

7절. 폭식장애(Binge-eating disorder)

- 폭식 행동을 일삼으면서 폭식 때문에 고통을 느끼지만 보상행동은 나타내지 않는 경우

DSM-V 폭식장애 진단기준

A. 반복적인 폭식 행동이 있고 폭식 행동은 다음 2가지의 특징으로 나타난다.⁷

1. **일정한 시간 동안**(예:2시간 이내) 대부분의 사람들이 유사한 상황에서 동일한 시간 동안 먹는 것에 비해 분명하게 **더 많은 양의 음식을 먹음**
2. 폭식을 하는 동안 먹는 것에 대한 **조절능력의 상실**
(예: 먹는 것을 멈출 수가 없거나 또는 무엇을 얼마나 많이 먹어야 할 것인지를 조절할 수 없는 느낌)

B. 폭식행동이 나타날 때는 다음 중 **3가지 이상**과 관련되어 있다.⁸

1. 정상보다 더 빨리 많이 먹음
2. 불편할 정도로 포만감을 느낄 때까지 먹음
3. 신체적으로 배고픔을 느끼지 않을 때에도 많은 양의 음식을 먹음
4. 너무 많은 양을 먹음으로 인한 당혹감 때문에 혼자 먹음
5. 먹고 나서 자신에 대한 혐오감, 우울, 또는 심한 죄책감을 느낌

⁷ 신경성 폭식증과 동일

⁸ 신경성 폭식증보다 자세하게 적어놓음

C. 폭식행동에 대한 **뚜렷한 고통**을 느낀다.

D. 폭식행동이 평균적으로 **1주일에 1회 이상 3개월 동안** 나타난다.

E. 폭식행동이 신경성 폭식증의 경우처럼 부적절한 보상행동과 관련이 없어야 하고, 신경성 폭식증 또는 신경성 식욕부진증의 경과 중에만 나타나는 것은 아니어야 한다.

- 현재의 심각도의 구분(폭식행동의 1주일 평균 횟수)

- 경도(mild): 1~3번
- 중등도(moderate): 4~7번
- 중증도(severe): 8~13번
- 최중증도(extreme): 14번 이상

특징

- DSM-5에서 새롭게 추가된 진단명

- **폭식행동 O + 보상행동 X**

- 과체중, 비만인 경우가 많음

- **자신의 몸매에 과도한 걱정 없으며 심한 왜곡을 보이지 않음.**

- 계속 먹어라 일정한 시간 동안 너무 많이 먹는다, 배고프지 않아도 먹는다, 장기간 폭식, 주말이나 저녁에 몰아서 폭식

- 폭식 후 자신이 혐오스럽고 우울, 죄책감과 수치심을 느낀다.

원인, 치료

- 먹는 데서 오는 대뇌 쾌감활동으로 인해(**배고파서 먹는 것X**)

- 음식섭취에 대한 통제력의 상실 (알코올처럼)
- 내성 (점점 더 많이)
- 금단증상 (폭식하지 않으면 불안, 초조, 긴장감)의 순환고리

- 심리적 요인: 불안, 긴장감, 초조함, 수치심, 외로움, 분노 등의 부정적 감정이 폭식 행동 촉진

● 감정식사

- 배고픔을 유발하는 것은 생리적인 허기뿐만 아니라 감정적 허기도 있다. 배고픔을 유발하는 감정이 외로움, 불안, 수치심, 분노 그 무엇이든지 결국 힘든 상황 속에서 우리가 필요로 하는 것은 **‘관심과 사랑’**이다.

- 자신의 감정을 잘 다룰 줄 모르는 사람은 음식을 통해 이 감정적 허기를 채운다. 그

러나 정작 음식을 먹고 나서도 이 허기는 채워지지 않고, 식욕 하나 참지 못하는 자신을 보며 자존감은 낮은 사람들은 더욱 심하게 자책하게 된다.

- 자신의 감정을 잘 다루는 사람은 음식 외의 방법으로 허기를 채울 줄, 자신을 위로할 줄 안다. 즉 먹어서 얻는 단기적인 즐거움과 먹는 것이 미칠 장기적인 건강과 정서적 행복을 비교해서 자신에게 더 유리한 선택을 한다는 것이다.

- **자신을 사랑하듯 먹어라. 음식을 선택할 수 있는 사람은 오직 당신 자신에게 있다.** 자기감정에 대해 말할 수 있을 때, 그 감정은 견딜 만해지고 두려움도 줄어든다.

- 약물치료(SSRI, 항비만제, 항경련제), 인지행동치료, 대인관계 심리치료, 집단치료

한의학적으로 보는 섭식장애

- 납매(納呆), 음식불납(飮食不納), 불사식(不思食), 납식(納食), 음식욕차(飮食欲差) 등에 해당

- 원인: 간기범위, 간비불화, 우사노과다, 칠정울결 등

- 이 중 정지내상으로 인해 칠정이 울결하여 비장의 운화기능이 손상을 받거나 중기가 허약해지면서 음식을 삼키지 못하거나 음식을 거부하는 등 신경성 식욕부진의 양상

- 신경성 폭식증은 칠정이 비위의 생리기능에 영향을 끼친 칠정상에 해당

- 변증: 심화항성, 담화요심, 심간열성, 간기울결, 간화항성, 간울담결

[2] 비만

1절. 비만의 정의

- 과잉체중의 상태를 말하는 것 X

- 대사장애로 인해 체내에 지방이 과잉 축적된 상태

- 즉, 칼로리 섭취가 신체활동과 성장에 필요한 에너지보다 초과되어 중성지방의 형태로 지방조직에 과잉 축적된 열량 불균형

2절. 비만의 분류

원인별 분류

1. 단순성 비만: 대부분의 비만이 여기에 속하며, 과식을 포함한 잘못된 식이나 운동부족 등으로 발생하여 장기의 기질적 원인을 밝힐 수 없는 경우가 대부분이다.
2. 증후성 비만
 - ① 내분비성: 쿠싱증후군, 갑상선기능저하증, 당뇨병, 성선기능저하증
 - ② 시상하부성: 시상하부의 포만중추, 공복중추에 병변
 - ③ 유전성: 선천성 염색체 이상, 소아비만

비만의 형성 원인에 의한 분류

1. 조절성 비만: 중추신경계 내에서 일어나는 식욕충동에 의해 섭취조절이 되지 않아 발생
2. 대사성 비만: 음식섭취의 양과 관계없이 선천적 또는 후천적 원인으로 대사에 이상이 생겨 지방조직이 증식되거나 당이 에너지로 사용되지 못하고 지방조직으로 흘러 들어가 지방으로 변해 이것이 축적되어 비만이 발생. 비만체질자는 근육세포 내에서 산소의 작용이 활발하지 못하여 결국 당이 이용되지 못하고 지방조직으로 흘러 들어가 지방으로 변한다.

지방세포의 양상에 따른 분류

1. 비대형: 지방세포 수는 정상, 크기만 증가 (성인형 비만)
2. 증식형: 지방세포 수가 증가. 크기, 지방함유량은 정상 (소아형 비만)⁹
3. 혼합형: 세포수, 크기, 지방함량이 모두 비정상적으로 많아짐

축적된 신체부위에 따른 분류

1. 중심성: 주로 복부에 과량의 지방이 축적.
WHR¹⁰: (남성) 1 이상 / (여성) 0.9 이상
2. 말초성: 엉덩이나 허벅지 또는 어깨에 과량의 지방이 축적
WHR: (남성) 1 미만 / (여성) 0.9 미만

비만의 한의학적 분류

1. 脾虛: 부종, 몸이 무겁고 움직이는 거 싫어함. 식욕 저하, 식사량 적음, 설사 자주, 가스가 차고 더부룩, 배를 누르면 편하다.
2. 痰飲: 전신이 무겁고 어지러움, 피부 희고 푸석, 구토, 구역, 더부룩
3. 陽虛: 창백, 손발 차고 피곤, 오한, 허리 무릎 자주 아프고 무릎뻐, 소변 시원하지 않음.
4. 食積: 소화 잘 안되고 자주 체함, 가스 많고 더부룩, 과식 폭식 자주하고 배가 불러도 음식 섭취
5. 肝鬱: 가슴 답답, 화 쉽게 냄, 스트레스 받으면 소화 안되고 누르면 답답, 월경불순
6. 瘀血: 피부에 멍, 자반, 실핏줄, 찌르는 듯한 통증, 아랫배 아프고 야간에 통증 증가

변증	치법	처방
비허형	건비이습	방기황기탕 합 영계출감탕
위열형	청열이습	방풍통성산 가감
간울형	소간이기	대시호탕 가감
어혈형	이기활혈	도홍사물탕 가감
담음형	건비화담	온담탕 가감
양허형	온신건비	진무탕 합 방기황기탕 가감

사상체질별 비만

- 사상체질에서는 체질에 따른 장부의 강약에 의한 차이에서 비만을 바라본다.

1. 태음인
 - 비만환자의 거의 70~80%.
 - 간대폐소
 - 과도한 섭식 및 운동 부족으로 비만 발생. 배출의 문제. 소모열량 부족
 - 치법: 발산(마황이 중심약재)
 - 처방: 태음조위탕, 조위승청탕
 - 커피먹어도 괜찮은 사람은 마황제를 좀 안심하고 쓸 수 있지만 민감한 사람에게는 쓰기 꺼려짐
2. 소양인
 - 비대신소
 - 상하 순환이 되면서 대소변으로 상부의 열이 빠져나가야 하는데, 그대로 남아있는 상

⁹ 소아비만으로 지방세포 수가 많다면 쉽게 살이 찌는 체질이 된다.

¹⁰ WHR(weist/hip ratio, 허리둘레/엉덩이 둘레)

부의 열 때문에 식욕증가. 전반적인 섭취량 증가로 비만

- 치법: 발산 + 청열
- 처방: 목통대안탕, 양격산화탕, 형방지황탕(근육 잘 굳는 사람), 형방도적산, 방풍통성산

3. 소음인

- 신대비소
- 소화기 이상이나 허약으로 소통이 되지 않아 복부쪽에 집중된 비만. 실제 지방이 많기 보단 소화, 배설 능력이 약해 음식물이 남아있는 시간이 많아 피하지방 대비 내장지방 축적비율이 많다.
- 혈액 및 림프액 순환도 잘 되지 않아 부종이 잘 발생한다.
- 치법: 이기제습거어 + 보양온리
- 처방: (십이미)관중탕, 양위탕, 곽향정기산 등
- 소음인의 비만, 특히 복부 비만에는 소화관을 활성화시켜 주위 포도당을 소비시키며 더 이상 음식이 저류되지 않도록 方香, 理氣, 祛痰除濕, 祛瘀 약재를 사용하여 소화 활성화 및 혈액 순환 개선

3절. 비만의 요인

1. 식사습관

- 식사량과 내용 및 섭취방법 등이 문제
- 특히 간식, 야식 먹는 습관

2. 활동부족

- 정상량의 에너지를 섭취하여도 활동량이 적어 에너지 소모가 감소

3. 유전적 요인

- 비만이 가족성으로 집중발생함
- 가족성 집중 발생현상은 가족의 식생활과도 관련 있음
- 10세 이전에서는 유전요인이 상당히 중요함

4. 중추신경계 이상

- 에너지 섭취의 조절은 자율신경에 의해 조절

5. 호르몬 요인

- 갑상선 기능저하증, 쿠싱증후군 등 내분비 질환
- 수면부족은 호르몬을 변화시켜 식욕을 자극하고 인슐린 저항성을 증가시킨다.

6. 심리적 장애

- 감정의 미숙, 부모의 과잉보호로 인한 영향, 열등의식 등

7. 사회, 문화, 경제적 요인

- 식생활이 개선되고 활동량이 감소되면서 과체중과 비만체형의 발생빈도가 높아져 사회병으로 간주

8. 나이

- 똑같이 먹어도 나이를 먹으면 대사량이 감소하며 살이 찌 수 있다.

비만과 호르몬

1. Insulin

- 인슐린 저항을 동반한 고인슐린 혈증은 중심성/내장성 비만을 일으킬 수 있음
- 고인슐린 혈증은 섭취량을 증가시키며, 간과 지방조직에서 지방합성을 촉진
- 시상하부 외측핵에 있는 공복 혹은 섭식중추를 직접 자극하여 섭식 증가

2. Cortisol

- 스트레스 호르몬으로, 지방세포에서 중성지방의 주요 합성조절원인 lipoprotein lipase를 자극하여 지방분해를 억제
- 쿠싱증후군: 체중 증가 현상은 특징적, 지방은 몸통, 쇄골 상부, 경부의 뒤쪽에 축적. Moon face, Buffalo hump의 양상

3. Serotonin

- 내측 시상하부 중추에 존재하는 신경전달물질
- 식욕, 음식물 선택에 있어서 중요한 조절자로 작용, 탄수화물 섭취와 가장 관련

4. Leptin

- 렙틴은 지방조직에서 분비되어 에너지 대사 상태의 센서로 작용
- 중추인 시상하부에 직접적 작용 혹 말초에 되먹임 기전 중 하나로 작용하여 지방생성 억제와 지방분해 촉진 작용
- 비만인 사람들은 렙틴을 많이 생산해도 적절하게 전달되지 않아 식욕을 제어하지 못하는 경우가 많음. 그 이유를 최근의 연구에서 cortisol 등에 의해 렙틴 저항이 생기는 것이라고 주장한다.

5. Catecholamine

- 교감신경계의 흥분을 전달하는 신경전달물질: 도파민, 에피네프린, 노르에피네프린 등을 통칭
- 주요한 지방축적의 원인으로 지방세포에서의 카테콜아민에 대한 저항

6. Thyroid hormone

- 갑상선 호르몬은 카테콜아민 자극에 대한 감수성을 높여서 지방분해를 촉진시킴
- 갑상선 호르몬제제의 투약은 체중 감소, 기초대사량을 증가시키지만, 심장질환, 근위축, 근육량 감소 등의 부작용 있어 주의해야 한다.
- 갑상선 저하증이 오면 조금만 먹어도 살이 찐

7. Growth hormone

- 비만한 사람에게서는 성장호르몬의 분비가 매우 감소되어 있고 다양한 자극에 대한 성장호르몬 방출 정도가 감소 또는 소실되어 있다.
- 성장호르몬은 지방을 분해시킨다.
- GH의 결핍 → 지방이 분해되지 못해 비만 → 혈당이 높아져 GH 분비 억제, 사춘기가 빨리 시작, GH 부족 → 지방의 국소 침착이 이루어진다.

8. Female sex hormones

- 에스트로겐: 지방세포의 대사 조절에 관여
- 지방세포의 분포가 남성과 여성에서 다르다.
- 폐경 후 비만의 양상이 남성 국소비만인 중심성 복부비만으로 옮겨감

9. Male sex hormones

- 테스토스테론: 성장호르몬과 함께 강력한 지방분해 호르몬
- 테스토스테론은 남성과 여성에서 다르게 작용한다.
- 남성: 지방분해를 촉진하여 내장 지방량과 반비례
- 여성: 남성호르몬 과분비는 중심성 비만을 일으킴

4절. 비만의 진단 및 검사

1. 체질량 지수(BMI)

- 자신의 몸무게(kg)을 키(m)의 제곱으로 나눈 값

분류	BMI(서양인)	BMI(아시아인)
저체중	<18.5	<18.5
정상체중	18.5 ~ 24.9	18.5 ~ 22.9
과체중	≥25.0	≥23.0
비만 전단계	25.0 ~ 29.9	-
위험체중	-	23.0 ~ 24.9
경증 비만	30.0 ~ 34.9	25.0 ~ 29.9
중등도 비만	35.0 ~ 39.9	30.0 ~ 34.9
고도 비만	≥40.0	≥35.0

2. 허리 둘레를 이용한 복부비만의 진단

- 복부 내장 지방량을 반영하는 지표
- 진단기준: (남성) 90 이상 / (여성) 80 이상
- 방법: 양발을 25~30cm 벌려 체중을 고루 분산시키고 숨을 편안히 내쉬 상태에서 측정한다. 갈비뼈 가장 아래 위치와 골반의 가장 높은 위치(장골능)의 중간부위를 줄자로 측정한다. 피하지방이 많아 허리가 겹치는 경우 똑바로 선 상태에서 피하지방을 들어올려 측정한다.

3. 체지방율

- BMI는 사실 서양인들에게 맞추어 제작된 것.
- 근육이 지방보다 부피 당 무게가 더 나간다.
- 남자: (1.1 X 몸무게) - (128 X 몸무게/키)
- 여자: (1.07 X 몸무게) - (128 X 몸무게/키)

4. 기초 대사량(Bsala Metabolic Rate, BMR)

- 남자: $66.47 + (13.75 \times \text{체중}) + (5 \times \text{키}) - (6.67 \times \text{나이})$
- 여자: $65.51 + (9.56 \times \text{체중}) + (1.85 \times \text{키}) - (4.68 \times \text{나이})$
- 운동량에 따라 BMR이 추가로 증가한다.

5절. 비만의 치료

개괄적 치료

- 식이요법: 총 섭취열량을 소모열량보다 낮추기. 균형있는 저칼로리 식사
- 운동요법: 열량소모, 식욕조절, 근육량 증가, 감소된 체중 유지
- 인지행동요법: 인지교정, 생활양식기록, 정신적지지, 동기강화
- 약물요법: 식욕억제, 특정고분자영양소 흡수 저해, 저지방 식사
- 수술요법: 위절제술, 위기문 축소술, 지방흡입술, 근육퇴축술
- 정서 장애 병력 있거나 광범위한 정신병력 있으면 주의 깊은 관리를 요함

이침

- 신문, 내분비점, 위점, 비점, 기점, 구점, 폐점 등
- 매회 4~5개 선택하여 2~3일에 한 번씩 좌우로 바꾸어 취혈
- 식욕억제, 식욕항진 조절작용, 진정, 이뇨작용, 수분 나트륨대사 개선 작용, 식후 소화속도 지연

체침

- 주로 족양명위경, 족태음비경

장침 전기자극술

- 침형의 전극을 피하지방층에 직접 삽입
- 저주파로 국소 지방분해 촉진
- 전류가 흐르면서 열이 발생하여 국소 혈류 순환 개선
- 지방세포벽에 있는 교감신경 말단에서 지방을 분해하는 카테콜아민의 분비를 자극
→ 이는 지방의 분해와 이동을 증가 But 체외로의 배출은 유산소운동을 겸해야 한다.



- 30분 이상 자극해줘야 한다.

매선요법

- 지방분해 및 탄력 증가를 목적으로 주로 시행
- 장침전기자극술과 다부위 약침술과 복합사용

약침요법

- 약물 주입 위주의 일반적인 주입법뿐만 아니라 산침요법을 동시에 실시
- 이는 메조테라피의 PPP, 및 nappage와 유사

[3] 부인 관련 증후

1절. 臍躁

정의

- 『金匱要略·婦人雜病篇』: “婦人臍躁, 喜悲傷欲哭, 象如神靈所作, 數欠伸, 甘麥大棗湯主之”
- 슬프고 마음이 쓰러 울려고 하며 마치 헛것이 들린 것 같기도 하고 자주 하품하며 (한숨을 쉬며) 기지개를 켜고, 공연히 울기도 웃기도 하여 喜怒의 조절이 잘되지 않는 것을 말한다.
- 임신 중에 생기면 孕悲, 출산 후에 생기면 產後臍躁

증상

- 心神混亂, 情志抑鬱, 煩燥不寧, 悲傷欲哭, 精神恍惚
- 특별한 검사 소견이 없고, 정지 자극이 클 때 발생하여, 제반 증상이 오래지 않아 완해된다.
- 중증의 경우 心煩不寧, 喜怒無常, 精神恍惚不定이 나타나며, 손발을 떨고 욕하고 소리 지르기도 하며, 혼곶하고 정서적인 자극을 받으면 더 심해진다.
- 失音, 失聽, 失明, 四肢不用 등이 생길 수도 있으며, 자극 요인이 사라진 이후에도 심신혼란의 증상은 지속되며 자연적 완화는 쉽지 않다.

처방

- 감맥대조탕, 소요산, 산조인탕, 백합지황탕, 혈부축어탕 등

감별진단

- 장조는 슬퍼 우는 주증상과 마음이 어지럽고 혼란스러움, 여성에게 많고 정서자극이나 정신적인 요소가 있을 때 간헐적으로 울고 웃는 정지변화가 발생하며, **발작하지 않았을 때는 정상인과 같다.**

- 서양의학의 히스테리 발작, 갱년기 증후군, 월경 전 긴장증후군, 신경증, 정신증 등과 유사

- ① 울증: 감정이 억울, 가슴 답답, 사람과 이야기하기 싫어하고, 흉협창만, 脘悶噯氣, 매핵기 증상이 있는 경우가 많으며 맥현
- ② 전광: 정지변화와 心身失調이 매우 심함. 발생에 남녀 차가 없음
- ③ 변조: 장조와 변조 모두 심번불녕한 증상이 있으나 장조는 독립적으로 병을 이루고, 변조는 외감열병 혹은 내상잡병 중에 동반되어 나타남. 또한, 장조는 중장년기 여성에 많이 발생하지만, 변조는 성별/연령의 차이가 없음.

2절. 갱년기장애

증상

- 폐경 전, 폐경기, 폐경기 이후 일정 기간 난소의 기능이 쇠퇴하여 나타나는 여러 가지 증상들
- 요통, 요배통, 견통, **상열감, 발한, 안면홍조**, 심계항진, 불면, 불안, 권태감, 두통, 현훈, 빈뇨, 요실금, 질위화감, 대하, 성욕 저하 등
- 감별진단: 갑상선기능항진증 (식욕증가, 체중저하, 갑상선종대 등 동반)

변증

1. 肝鬱型

- 증상: 긴장 多, 정서억울, 화를 잘 내고, 우울, 심하면 자제력과 지남력 X. 가슴 답답, 복부 그득함, 불면다몽, 불규칙한 월경, 경변과 연변이 교대로 나타남. 舌紅, 舌苔薄, 薄黃 혹은 黃膩, 脈沈弦 혹은 脈弦數
- 치법/처방: 소간해울법/소요산

2. 心腎不交型

- 증상: 잘 놀라고, 가슴이 두근, 잠에 얹게 들고 꿈 多, 주의 집중력 감퇴, 허리와 무릎이 차고 약해지고, 월경이 불규칙. 舌紅, 舌苔少, 脈沈弦細 혹은 細數
- 치법/처방: 자음강화, 보신녕심/감리기제한, 감맥대조탕합계지가용골모려탕
- 초반에는 간울형, 만성화되면 심신불교형으로 간다.

3절. 산후풍

정의 및 분류

- 산후풍: 산후, 유산 후 전신기능의 약화, 섭생부주의, 과사용 등에 의해 관절의 통증과 냉감을 중심으로 다양한 전신증상이 발현되는 것을 말하며 다른 질환으로 진단되지 않아야 한다.
- 문화적 특수성이 반영된 문화 관련 증후군
- 산후遍身동통, 산후신통, 산후관절통, 산후비증, 산후통풍, 산후발한, 산후실명, 산후허로 및 육로, 산후우울 등의 병증
- 주로 관절 및 근육통을 중심으로 한 통증 및 저림의 국소적 장애, 전신 및 자율신경계통 증상을 포함한 전신적 장애(광의의 산후풍)로 분류

산후풍 병리 및 원인

1. 과사용 및 과로

- 육아, 가사활동, 근육과 관절의 과사용
- 과로, 스트레스 등으로 인한 피로가 누적된 통각과민상태

2. 기존 근골격계 통증과 역학적 원인

- 임신으로 인한 체중 증가, 가사, 육아, 수유 등으로 인한 특정 자세의 지속적 유지는 손목, 어깨, 목, 허리, 무릎, 발목 등의 관절에 역학적 부담
- 자연분만 시 골반관절의 과도한 견인은 치골결합을 분리시켜서 분만 후 치골부 통증의 원인

3. 내분비요인
- 에스트로겐이나 릴렉신 등의 호르몬(골반 관절의 가동성 증가), 이로 인해 관절은 외부 물리적 자극에 취약

4. 스트레스: 통각 과민, 근골격계 긴장 초래

감별 및 진단

1. 산후풍의 진단

필수증상		부수증상
국소증상	전신증상	
지절통 (수지,완,주,견,슬,족관절통)	전신 근육 통증 전신 관절통	피로 부종 및 붓는 느낌
경향통	전신냉감 및 외한	수면장애
요통		
수족저림	발한과다	우울 및 의욕저하
수족냉감		

- *단, 진단 기준을 충족하기 위해서는 위 증상이 출산 및 유산 후에 발생하고, 증상의 주도적 원인이 다른 질환으로 분류되지 않아야 함.
- 기기진단: HRV, DITI

2. 감별

- 류마티스관절염, 근육이나 인대의 염좌, 섬유 근육통, 추간판 탈출증, 드퀘르뱅 건초염, 손목터널증후군 등

변증

- 변증은 예후에 중요하다.

1. 氣血虛弱型

- 증상: 강한 통증보다는 **피로감**이 두드러짐 / 면색위황, 두훈심계, 설담홍소태 / 수유 후에 통증이 심화되거나 유즙분비 부족 동반할 수 있음
- 치법: 養血益氣, 溫經通絡
- 처방: 황기계지오물탕가감방(빈혈 소견시 加 구기자 구판 각8g, 아교 4g), 팔물탕 加

계지 4~8g, 계혈등 8g, 갈근 6~8g, 해동피 4~6g, 우슬 4~6g, 방풍 4g

2. 外感型

- 겨울철 한랭노출, 여름철 냉방 후 발생하는 경우가 많다.
- 증상: **통증 심**하고 유주할 수 있음 / **파냉오통**, 설담태백, **맥부긴**, 맥세삭
- 치법: 養血祛風, 散寒除濕
- 처방: 오적산가감방(견응통 있으면 갈근 8g, 계지 8~12g 加하거나 독활기생탕)

3. 腎虛型

- 증상: **요슬관절의 산통**이 주 / **족근통**, 두훈, 이명, 야뇨 동반 / 舌淡黯苔薄白, 脈沈細
- 치법: 補腎, 強腰, 壯筋骨
- 처방: 양영장신탕加 진교 3g 숙지황 8g / 좌귀음
- 畏寒하고 四肢不溫하여 便溏하면 加 육계 2g 익지인 3g 보골지 4g
- 통증이 만성화되며 근육과 관절이 이완되면 加 두통 구척 각 3g, 속단 4~8g

4. 瘀血型

- 증상: **少腹疼痛**을 겸하기도 하고 惡露不暢하거나 不絕하며 자색의 혈괴, **자통** / 舌黯紅 苔白, 脈細弦 혹은 澀
- 치법: 養血活血, 化瘀通絡
- 처방: 사물탕 加 포강 홍화 도인 각3g 택란 4~6g / 생화탕 加 계혈등 8g 해동피 4~6g 갈근 8g / 신통축어탕

치법 개요

- 분만 방식, 모유수유 여부, 산후 정서 상태, 산후조리와 섭생 상태 고려
- 제왕 절개 분만 산모의 경우 복근의 수술로 인한 무력과 천부 통증 / 자연분만 산모의 경우 요실금의 병발 가능성과 요통의 빈도가 상대적으로 높았다는 연구.
- 산후의 우울과 정서상태는 산후풍의 임상경과에 중요. 우울감은 통증이나 기타 심신의 증상을 더 악화. 치료를 위한 의사-환자 관계 수립에 부정적 효과
- 산후조리 과정에서의 과도한 보온이나 지나친 와상 안정은 없는지 확인
- 환자의 연령, 신생아의 수면 습관과 체중 증가양상, 가족 내 정서적지지 구조와 육아 및 가사노동 분담 정도, 직장으로서의 복직 기간 등에 대한 종합적인 파악

- 누워있으면 오히려 회복이 잘 안되기 때문에 잘 걸어도다니도록해야 한다.

환자교육

- 잘 치료하지 않으면 장기간 유지되어 평생 고생한다? → X
- 추가 출산을 한 후 조리를 잘 하면 자연 회복된다? → X
- 관절의 가동범위를 넘는 동작이나 특정 관절에 긴 시간 동안 부하가 걸리는 활동을 하지 않도록
- 임신 중의 빈혈을 치료/ 동시에 건강한 체력을 유지
- 정신적 우울은 증상을 악화시키고, 치료 기간을 연장시킬 수 있으므로 정서적 안정과 기분 전환에 유의 §환자와 가족을 교육하고 지지.
- 차가운 곳이나 습한 곳에 있지 않도록 피한다.(반대로 너무 따뜻해서 땀 흘리면 기허가 유발되므로 주의)
- 과도한 전신 보온은 발한 과다를 유발하여 위기를 악화시키고 냉기에 대한 저항력을 감퇴시키므로 주의

4절. 모유수유와 산후우울증

모유량 부족

- 모유가 부족하다
 - 산후 6~8주에 모유수유를 중단하게 되는 주요한 이유
 - 생후 4개월경에 주로 발생
- 정말 모유가 부족한지, 그렇다고 생각한 것인지 구분할 필요가 있다.
- 올바른 수유방법에 대한 교육이 필요
- 모유량 부족
 - 임신 중 유방 변화가 있었는가
 - 비대칭 유방
 - 불임의 과거력(다낭성 난소증후군)
 - 이전의 모유수유의 어려운 경험

모유양이 감소하는 원인

- 의원성
 - 물 또는 분유의 보충
 - 젖 제거 없이 모유수유 지연 또는 중지
 - 모유를 효율적으로 못 빠는 아기(자극 부족)
 - 유방울혈
 - 엄마와 아기의 분리
- 엄마의 잘못된 이해
 - 제한적이거나 길지 못한 수유시간
 - 노리게 젖꼭지, 유두보호기
- 잠재적 요인
 - 모유수유 결정을 늦게 하거나 처음부터 혼합수유를 계획
 - 제한된 기간 동안만 모유 수유를 할 계획
 - 48시간 이후의 수유
 - 수유에 대한 자신감 결여
 - 남편, 친정어머니, 시어머니로부터 덜 격려 받음

젖이 부족하지 않는데 부족하다고 느끼는 이유

1. 젖이 차는 느낌이 들기도 전에 아기가 먹으려 함
출생 직후와 달리 일주일 정도 지나면 젖이 불어나는 느낌이 들지 않는다. 이것은 아기가 필요한 만큼 엄마의 젖 양이 적당하게 만들어지는 경우에 아무런 느낌이 없는 경우가 많으므로 걱정할 필요가 없다.
2. 아기가 젖을 자주 찾는다, 젖 먹고 한 시간 이내에 또 먹고 싶어 함
아기들은 배가 불러도 빨고자 하는 욕구 때문에 젖을 빠는 경우가 있다. 또한 엄마젖은 소화가 잘되기 때문에 빠르면 30분만에 소화가 되기도 한다.
3. 젖을 먹은 후 분유를 먹이면 또 먹는다.
가끔 젖이 부족하다고 생각하는 엄마들은 수유 후에 분유를 타 먹이는데, 아기는 빨기 욕

구가 있어 배고프지 않아도 젖병을 빨게 된다.

4. 유축하면 젖이 조금밖에 나오지 않음

어떤 엄마들은 유축한 젖양이 30cc밖에 되지 않는다고 호소하기도 하는데, 유축기로 짰 젖양은 항상 아기가 빨아먹는 양보다 적다. 유축한 젖양은 전혀 근거가 될 수 없다.

5. 젖을 먹은 아기가 깊은 잠을 자지 못하고 자꾸 깬다.

젖을 먹은 후 아기가 내려놓기만 하면 깬다고 하며 젖이 모자란다고 생각하는 엄마들이 많다. 그러나 자는 아기가 내려놓았을 때 깨는 것은 엄마를 찾는 것이다. 젖을 먹인 후에 다시 분유를 먹이고 오래 재우는 것은 아기가 지나치네 배가 불러 오래 자는 것으로 오히려 위장에 좋지 않을 수 있다.

6. 단순한 의심

젖이 진짜 부족할 때 나타나는 증상들

1. 아기가 나른해하고 무기력하다.
2. 배의 피부를 잡았다 놓았을 때 금방 회복되지 않는다.
3. 울음소리가 약하고, 울어도 눈물이 나오지 않음 (눈과 입의 건조증상)
4. 소변감소, 가장 중요한 객관적 지표로서 처음 이틀간은 젖은 기저귀가 한 개나 두 개도 정상이지만 그 이후에는 세 개 이하이면 위험하다.
5. 발열
6. 성장의 지체현상: 아기가 생후 3~4일 동안 5~7% 체중이 감소하다가 생후 2~3주에는 다시 출생시 체중으로 돌아와야한다. 10% 이상 감소한다면 수유지도가 필요하다.

모유 늘이기 - 지지와 격려

- 가족 구성원 교육
- 가족들이 육아나 가사를 도울 수 있도록 함
- \$잘 먹고 있지 못해 걱정하는 엄마: 낮은 섭취는 모유생산에 영향, 첫 6개월엔 평소보다 500칼로리 필요(우유 2~3컵 정도. **기름진 것은 유방울혈 초래 가능**)

모유량 늘이기

- 하루에 엄마들은 8-12회 모유수유를 해야함
- 밤중 수유 (밤12시-새벽 5시)를 적어도 1회 이상
- 유축기 사용은 권장 X, 수유를 다 마치고 나서 유축기 사용
- 유두동통, 유방염, 아기가 유륜을 깊숙이 물지 못하는 것은 모유량 감소의 원인, 교정해야 함
- 아기의 소변횟수와 체중증가를 통해 모유가 충분한지 확인 가능
- 아기가 늦은 오후나 이른저녁에 몰아 수유하는 경향이 있음. 이는 모유가 부족한 것이 아님
- 수유나 유축을 하는 동안 손으로 유방을 압박하면 모유 생산이 증가됨

유즙부족의 치료

- 허증과 실증의 감별(동의보감•유문)
 1. 실증: 氣血이 너무 왕성하여 젖이 물리고 막혀서 나오지 않는 것. 통하게 해줘야함. 통초, 누로, 토과 用
 2. 허증: 氣血이 약하여 젖이 마른 것. 보해야 함. 종류분, 돼지발족, 붕어 用
- 처방: 궁귀조혈음
- 모유 수유에 도움이 되는 침치료
 - 모유 부족: 전중, 소택, 유근, 족삼리
 - 유선염: 소해, 견정, 삼음교

모체 산후우울증

1. 산후 우울감(baby blue)
 - 산후 50~80%에 달하는 여성이 분만 후 3~5일에 시작되는 스트레스 경험
 - 슬픔, 불면, 불안, 자신감 결여 \$첫 번째 출산이 가장 흔함. 실망스러운 출산 경험. 혼란스러운 아기로 슬픔
 - 산후우울감이 2주 이상 지속시 우울증 의심
2. 산후우울증(postpartum depression)
 - 분만 후 2~6주에 시작, 수개월간 지속. 새로이 엄마가 된 이들 중 10~20% 발생한다고 알려져 있음 / 고위험군에선 50%까지 발생

- 위험요인

- 싱글맘, 낮은 사회경제적 지위, 낮은 교육수준, 임신 합병증, 사회적 지지의 부족, 외상이나 학대의 기왕력, 난산경험, 우울증의 과거력 혹은 가족력
- 기분의 변화, 슬픈 감정, 즐거움의 상실, 집중에의 어려움, 낮은 자긍심, 엄마와 아내로서의 역할을 잘 해내지 못했다는 죄책감

- 교수님 논문: 산후우울증 환자는 실패한듯한 기분을 느끼며, 기존의 자아와 새로운 엄마의 역할 사이에서 갈등을 겪는다. **산후우울증을 극복하는 좋은 방법은 다른 사람에게 도움을 구하는 것이다. 주변 사람들이 산후우울증을 앓고 있다는 사실을 인식시키는 것이 중요하다.**

산후우울증과 모유수유

- 우울한 엄마는 모유수유를 더 잘 중단
- 모유수유가 엄마의 감정을 부드럽게 보호해줄 수 있다는 연구 존재
- 모유수유에 관한 문제들이 해결되었을 때 엄마의 정서상태 정상회복

모유수유의 이점 - 엄마

- 산후회복을 도움 (옥시토신 분비 - 자궁수축을 도움)
- 산후비만 예방 § 자존감, 자신감 향상 § 골다공증 발생 낮춤
- 심혈관, 고지혈증, 당뇨병 발생을 낮춤 (1년 이상 모유수유 했을 경우)
- 난소암과 유방암의 발병의 발생을 낮춤

산후관리와 모유수유

- 모유수유로 엄마 몸에서 500칼로리를 소모(아기가 커지면서 더 많은 열량 소모 가능)
- 산후 관절통이나 산후풍을 악화시키지 않음

⇒신경정신과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: **파랑**
- 강조: **빨간색** 밑줄
- 말없이 지나간 부분 OR 교과서 내용: 회색
- 이번주차는 피피티에서 색깔 표시된 감별 포인트 위주로 보라고 하셨습니다. **해당내용 분홍색으로 표시하겠습니다.**

[1] 성 관련 장애

[DSM-5 범주]

성기능부전 (Sexual Dysfunctions)

성별불쾌감 (Gender Dysphoria)

변태성욕장애 (Paraphilic Disorders)

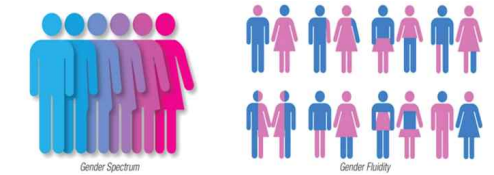
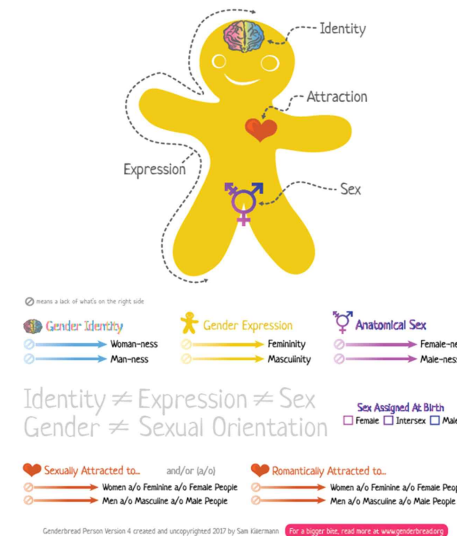
1절. 개요

정신 성적 요인 (개인의 성에 대한 논의)★★

개인의 성을 결정하는 4가지 요인

Anatomical sex (생물학적 성징)	염색체, 내부/외부 생식기, 호르몬 구성, 생식선, 2차 성징
Gender identity (Who you are)	'여성, 남성, 둘 다, 어느 쪽도 아니다' 등의 젠더 스펙트럼의 어느 곳이든 존재한다는 각 개인의 내적 감각 - 개인의 gender identity는 출생 시 성과 같거나 또는 다를 수 있음 정신적 정체성, 사회적이고 심리적인 측면. 보통 2~3세에 확신을 함
Gender Expression	개인이 자신의 gender identity를 공개적으로 표현하거나 표현하는 방법(행동, 복장, 태도, 이름, 대명사를 통해) 및 이러한 표현이 전통적, 사회적 gender의 규범에 따라 해석되는 방법 gender role. 나를 표현하는 방법 (ex. 나를 She로 불러주세요)
Sexual attraction (Who you want to be with)	- 타인과 관련하여 낭만적이고, 성적으로 느끼는 방식 - sexual orientation(누구에게 끌리고 관계를 맺고 싶은지)은 근본적으로 gender identity와 다르다. 성지향성, 성지남력

The Genderbread Person v4 by its pronounced? **AgTRQsexual**



요즘에는 젠더 스펙트럼이 다양해지고 있고, 누구도 아니라는 식으로 표현을 하기도 한다.

남녀 성욕의 차이

- 성욕 : 성행위를 하고 싶어하는 욕망이나 충동 (성능력과 구별)
- 성충동
 - 남자 : 월 1회 큰 충동, 주 1회 작은 충동
 - 여자 : 배란기에 충동
- 왜 성충동에 차이가 있을까?
 - 테스토스테론 호르몬 차이 : 전반적인 리비도(성욕)는 테스토스테론 수치와 연관 리비도가 낮다고 테스토스테론 수치가 낮은 건 아니다!
 - 뇌구조 차이 : 시상하부(성 센터) 크기 차이 / 남자가 여자보다 3배 정도 크다.
 - 개념 차이 : 남자(성적인 행위 몰두, 스트레스 해소, 배설 욕구) / 여자(섹스와 사랑 동일시) 하지만 시대에 따른 변화가 있다.
 - 남녀의 성욕 차이는 생물학적인 원인과 사회문화적 원인이 모두 작동

건강한 성과 성행위

- 건강한 성
 - 사랑과 친밀감이 전제로 되어야 한다.
 - 공포와 갈등을 최소한으로 하여, 사랑을 주고 받을 수 있을 때 타인과 진실로 친밀한 관계에 들어갈 수 있다.
- 정상적인 성행위
 - 사랑이 그 기초가 되며, 전희(foreplay)가 있고 적절한 체위로서 성기결합이 이루어지며, 충분한 성행위로서 상호절정기(mutual orgasm)를 공유하는 것
- 비정상적인 성행위
 - 자신이나 타인에게 파괴적일 때
 - 성행동이 상대방에게 향하지 않고, 성기 자극을 포함하지 않고
 - 죄악감이나 불안과 연관되며, 강박적일 때

사랑의 과학 (Stages of love)

미국의 인류학자가 사랑을 3단계로 나눠 설명

1) Lust 갈망

- 성적인 끌림. 성욕
- 에스트로겐과 테스토스테론이 관여

신체적, 비언어적으로 끌림

2) Attraction 끌림

- 노르에피네프린과 도파민, 세로토닌이 관여

머리속이 온통 상대방에 대한 생각으로 가득참. 공작지 낀 상태.

3) Attachment 유착

: bond를 만드는 것 장기적인 관계. 오래된 연인이나 결혼한 부부

- 성적인 것만을 얘기하는 것은 아니다.
- 옥시토신과 바소프레신이 관여 (바소프레신은 옥시토신의 남성형)
- 자발적인 성적 욕구는 성호르몬, 도파민 분비가 많이 관여하지만 오르가즘에 영

향을 많이 미치는 것은 옥시토신

- 옥시토신을 충분히 분비하게끔 하려면 스킨십이 중요하다.
- 오르가즘을 느끼면 테스토스테론이 나오고 이후 옥시토신이 나온다. (남녀 모두)
- 옥시토신은 상대에 대한 애착을 더 강화!
- 감정적인 친밀감이 강화되면 성적인 반응에 더 잘 반응하게 됨.

2절. 각론

DSM-5 Sexual and Gender Identity Disorders

1. 성기능 장애 (Sexual Dysfunction)

- 원활한 **성교행위**를 방해하는 다양한 기능장애, 성 반응 주기 중 해소 단계를 제외한 한 단계 이상에서 비정상적인 반응이 나타나는 경우
 - 남성 : 남성 성욕감퇴 장애, 발기 장애, 조루증, 지루증
 - 여성 : 여성 성적 관심 및 흥분 장애, 여성 절정감 장애, 생식기-골반 통증/삽입 장애

2. 성도착 장애 (Paraphilic Disorders) ★

- 성행위 대상이나 성행위 방식에서 비정상성을 나타내는 다양한 문제행동, 변태 성욕증. '부적절한 대상이나 목표'에 대해서 강렬한 **성적 욕망**을 느끼고 성적 상상이나 행위를 반복적으로 나타내는 것
 - **관음 장애, 노출 장애, 접촉마찰 장애, 성적 피학 장애, 성적 가학 장애, 아동성애 장애, 성애물 장애, 의상전환 장애**

=변태성욕장애. 6개월이상 반복하는 경우 진단할 수 있다.

3. 성 불편증 (Gender Dysphoria) ★[14, 15]

- 자신에게 주어진 생물학적 성에 대한 불편감을 느끼며 다른 성이 되고자 하는 강렬한 열망을 지니는 경우, 동성애와 다르다. **트랜스젠더**
- 동성애 : 일부 성 불편증을 지니는 경우도 있으나 자신의 생물학적 성이나 성 역할에 대해 불편감을 겪지 않고 성전환을 원하지 않는다.

성 반응 주기★

1. 4단계의 성 반응 주기 ★

1) 욕구기(desire) - 성욕장애

- 성행위에 대한 공상과 욕구가 나타남

2) 흥분기(excitement) - 성적흥분장애

- 정신적, 신체적 자극에 대한 지각과 이에 따른 생리적 변화(남성 생식기의 발기, 여성 생식기의 윤활-팽창, 남녀의 유두발기)가 나타남

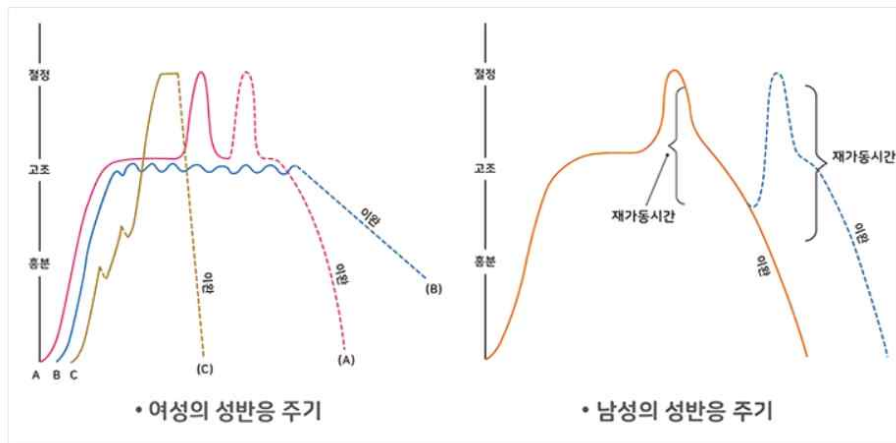
3) 절정기(orgasm) - 절정감장애

- 성적 쾌감이 최고조에 달하면서 성적 긴장이 해소됨. 남성의 사정, 여성의 질 하부 1/3의 주기적인 수축이 나타남.

4) 해소기(resolution)

- 근육의 이완, 만족감과 더불어 성 반응 이전의 상태로 되돌아가는 시기
 - 남성 : 발기와 절정기에 대해 생리학적 불응기(수분~수시간, 나이에 따라 다르다)
 - 여성 : 거의 즉시 추가의 자극에 대해 반응 (연속적인 절정감을 경험)

2. 남녀의 성 반응 주기★★



- 남성은 불응기가 필요하지만, 여성은 그렇지 않음
- 여성의 성반응 주기는 3가지 유형이 있음
 - A: : 연속적으로 절정을 경험할 수 있는 유형.
 - B : 절정기에 오르지 못하고 고조 단계에서 머무르는 경우
 - C : 급격하게 절정기에 이르고 해소기를 맞이함

성기능 장애의 분류 ★

성욕장애	성욕 감퇴 장애	- 성적 공상이나 성행위에 대한 욕구가 부족 - 성기능 장애의 결과로 나타날 수 있다 - 심리사회적 요인 고려 - 우울증과 관련된 경우 多 - 여성 多
	성적 혐오 장애	- 성적 대상과의 성접촉을 극심하게 회피, 혐오 - 부부갈등, 정신적 외상 多
성적 흥분 장애	여성 흥분 장애	- 성적 흥분에 수반되는 윤활-팽창 반응이 성행위 동안 유지되지 않거나 아예 처음부터 나타나지 않음 - 죄책감, 불안, 정신적 외상, 배우자에 대한 분노 - 성교통증, 성욕장애 동반 - 기혼여성의 33% 경험 - 폐경기, 수유기
	남성 발기 장애	- 성행위에 필요한 발기가 일어나지 않거나, 성행위 마칠 때까지 지속 되지 않음 - 심리적 문제가 대부분, 특히 성행위 실패에 대한 공포 多 만족시켜야 한다는 부담감 - 전체 남성의 10~20%
절정감 장애 ★[	여성 절정감 장애	- 성적흥분은 가능하지만 절정감이 나타나지 않음 - 여성의 연령, 성경험, 적절한 성적 자극의 유무 고려하여 진단 - 젊은 여성 多 (연령증가에 따라 절정감 증가) - 정신적 원인 多 (두려움, 적개심, 죄책감, 갈등)
	남성 절정감	- 사정에 어려움 겪으며, 성적 절정감을 느끼지 못함 - 성인 남성의 4~10%

	장애 (지루증)	정신적 원인 다 (적개심, 죄책감)
	조루증	- 절정감과 사정이 삽입 전후에 곧바로 나타나고 자신의 의지대로 조절이 안된다. - 남성 3명 중 1명의 비율 - 심리적 원인 다 (상대방 만족에 대한 강박, 불안, 스트레스, 술, 담배)
성적 통증장애	성교 통증	- 성행위 회피, 만성화 - 남녀 모두 발병 가능, 여성이 다 - 심리적 요인과 신체적 문제(염증, 윤활부족-폐경기 전후) 구분
	질경련	- 성교 시 질 외측 1/3 근육의 불수의적 수축 발생, 성행위 곤란, 통증 유발 - 심리적 요인 (정신적 외상, 성적인 죄책감)
신체질환 에 의한 성기능 장애	성기능 장애를 유발할 수 있는 신체질환 1. 신경계 질환 (다발성 경화증, 신경질환) 2. 내분비계 질환 (당뇨병, 갑상선 기능저하증, 생식선 기능 이상, 뇌하수체 기능 이상) 3. 혈관계 질환 4. 비뇨생식기계 질환 (고환질환, 페이로니병, 수술 후유증, 성기 손상, 염증)	
물질에 의한 성기능 장애	- 물질 사용 중이거나 사용 후 1개월 내에 발생하거나 물질 사용의 결과로서 나타난 것 - 남용물질(알코올, 암페타민, 코카인, 아편, 진정제, 최면제, 항불안제)에 의해 유발 가능	

치료

- Masters와 Johnson의 기법(Dual-sex therapy), Kaplan 기법 (정신역동적 성치료)이 가장 많이 사용
- 그 밖에 최면치료, 이완요법, 행동치료, 집단치료, 약물치료, 외과적 수술 등

#Masters와 Johnson의 이론

■ 성기능 장애의 원인 : 즉시적 원인/ 역사적 원인

1) 즉시적 원인

현재 심리적 과정에 개입되는 원인들

- 성적 수행에 대한 두려움 (성기능을 잘 발휘하지 못하여 상대방을 실망시키고 실패할 것에 대한 두려움)
- 성행위 시에 불안 수준이 급격히 증가하고 몸이 긴장하여 자연스러운 흥분을 억제

자기 신체반응이 어떤지 관찰하는 관찰자적인 역할에 서게 된다. 오히려 위축되어 쾌감이 감소된다.

→ 성기능은 우리 몸의 자동적인 신체적 반응에 따라 자연스럽게 내맡길 때 원활하게 발휘된다.

2) 역사적 원인

- 종교적 신념(성을 죄악시), 충격적인 성경험(어린 시절 성추행, 성폭행 등의 외상 경험), 동성애적 경향, 잘못된 성 지식, 과도한 음주(술은 성적 흥분을 감소시킨다), 신체적 문제(성병, 신체적 질병, 약물복용, 폐경), 사회문화적 요인(여성의 성적 욕구 억압, 성행위 시 소극적인 역할 하도록 요구되는 사회적 분위기)

■ 치료

- 부부치료 : 부부간의 협동적 노력, 치료진도 남녀 두 명의 치료자로 구성
- 일차목표 : 성적 수행에 대한 두려움, 관찰자적 태도 극복
- 감각집중법 : 성행위시 느끼는 감각에 집중하는 훈련, 성적쾌감 증진, 성행위 몰입
- 비요구적 성교단계 : 자신이나 상대방이 절정감을 느껴야 한다는 부담감 없이 편안한 상태에서 성교

1) 심리치료: 감각집중법, 압축법

-감각집중법(Sensate focus): 성반응의 각 단계에서 체험되는 신체적 감각에 주의를 집중하여 충분히 느낌으로써 성적 쾌감을 증진하고 성행위에 몰입하도록 하는 방법. 3단계로(쾌감단계, 성기자극단계, 성교훈련단계)로 나누어 집중

-압축법(Squeeze 기법): 조루증 치료. 사정 직전에 귀두를 손으로 조요 주는 방법.
스톱-스타트 기법은 사정직전에 귀두를 조이지 않고 그냥 자극을 중지했다가 다시 자극하는 것을 반복하는 방법

2) 약물치료

-조루증: SSRI

-발기부전: Sildenafil(비아그라. 음경 혈류 증가), Apomorphine(유프리마. 중추계 작용 도파민 농도 증가)

3) 수술치료: 음경보철물 삽입

[2] 성 관련 증후

0절. 개요

- 결혼한 부부의 50% 정도에서 나타날 정도로 보편적
- 생물학적 과정상의 문제 외에도 사회문화적 영향과 도덕규범 및 개인적 특성까지 고려해야 함
- 한방신경정신과 영역의 성기능장애는 기질적 질환 배제한 이후에 한함. 당뇨병, 갑상선 질환, 소모성 질환 등 성기능에 영향을 미칠 수 있는 질환에 대한 검사가 필요할 수 있음.
- 각종 성기능 장애의 치료에 침구치료, 한약치료 외 심리적 치료가 반드시 수반되어야 함. 심리적 안정을 도모하고 질환에 대한 극복의지를 도와야 함. 올바른 성 지식에 대한 교육과 배우자에 대한 면담이 필수적임.

광사기요: 五不男, 五不女

시험에는 내지 않은 것이지만 국시에 자주 나온다.

:명 시대의 광사기요: 五不男, 五不女 생식기관의 선천적 기형이나 기타 병변으로 인해 생식능력이 없는 것

- 五不男: 생(生), 종(縱), 변(變), 반(半), 투(妒) -생: 2차 성징이 나타나지 않음 -종: 고환이 1개이거나 없는 것 -변: 성발육이 늦은 것 -반: 남녀 성기 겸한 경우 -투: 陰莖短小한 경우	- 五不女: 나(螺), 문(紋), 고(鼓), 각(角), 맥(脈) -나: 陰戶에 螺紋이 있는 것으로 성교하기 힘든 것 -문: 음도 협착증 -고: 처녀막의 폐쇄 -각: 여성의 성기가 과도하게 큰 것 -맥: 월경부조 혹은 월경이 없는 경우
---	---

1절. 남성의 성 관련 증후

- 동양의 사회문화적인 특성상 성은 쾌락의 도구 <<< 생식의 수단 (종족보존)

1. 양위(陽痿) = 발기장애

- 남성 성기능 장애 중 가장 흔함
 - 성욕은 있으나 음경의 발기력과 경도가 약해 성교가 불가능한 것
 - 虛損, 濕熱이나 肝腎의 손상으로 올 수 있지만, 대부분 思慮過度, 憂思鬱悶, 驚恐不解 등의 정지내상이 주요 원인이다. (심인성)
 - 성행위에 대한 불안, 초조, 긴장이 가장 큰 원인으로 심리치료가 필수적인 질환임
 - 서양의학에서의 정신장애 중 남성발기장애 male erectile disorder에 해당한다.
- 전신성과 기능성으로 구분하기도 함

2. 조설(早泄) = 조루

- 早漏, 鷄精이라고도 하며 남성 성기능 장애 중 양위 다음으로 흔함
- 증상은 삽입 전이나 삽입 후 극치감에 이르기 전에 사정하는 것이며, 성교의 시간이 대단히 짧아 남녀가 충분한 성적인 쾌감에 이르지 못한다.
- 한의학에서는 심, 간, 신의 기능실조와 연관하다고 본다.

과음, 과색, 과로등으로 인하여 신기가 허약해지면 심화가 성해져서 쉽게 흥분이 되고 이를 억제하지 못하는 '신기부족 불능제화'로 설명하고 있다. 또한 정지불서로 간기가 울체되어 소설실상한 경우에도 나타난다.

- 서양의학에서의 정신장애 중 조루증 premature ejaculation에 해당한다.

신경과민, 욕구불만, 불안, 초조, 정신적 불안정 때문에 발생하게 된다.

진단에 있어서 정신적 소인이나 성교의 지속시간, 간격, 체질상태 등을 종합적으로 고려해야한다.

- 조설은 발기력 정상, 사정시간 빠른 것/ 양위는 발기력이 약하여 성교가 불가능
- 조설은 정상적인 성행위 과정에서 발생 / 유정은 성행위와 무관하게 발생

3. 유정(遺精)

- 물리적인 자극이 없는 상황에서 정액이 스스로 나가는 것을 말함
- 滑精 : 각성 상태(腎病, 신허불고) / 夢遺 : 수면 상태(心病, 음허화왕) ★
- 정신적 안정이 필수적

3-(1). 유설정증(遺泄精證) : 성교나 물리적 자극이 없는데도 사정을 하는 것을 말함.

- 동의보감 : 심의 군화가 동하는 것에 기인
- 격치여론 : 심의 군화가 동함에 따라 간신의 상화가 동하는 것에서 기인
- 인재직지 : 심신의 기가 허한 것에서 기인

3-(2). 정활탈증(精滑脫證) : 유설정증보다 정도가 심한 증상.

- 過色으로 신을 손상하거나, 습열하주로 발생

3-(3). 夢遺: 수면 중 사정하는 것

- 주 2회 이상 빈번하게 나타나면 병적인 것으로 판단
- 의학입문 : 몽유는 심에 관련되고, 낮의 생각이 꿈속에 나타나면서 사정한다고 설명함.

3-(4). 정만이일(精滿而溢) : 주 1회 이하로 몽정하는 것. 주2회 이상은 병적인 것

젊은 남성에게 있어서 오랜 기간 성생활이 없을 경우 주 1회 이하로 몽정하는 것은 精滿而溢이라 하여 정상적인 상태이므로 별다른 치료가 필요하지 않다.

3-(5). 백음증(白淫證)

- 음경의 통증과 소양감, 소변빈삭, 뇨탁의 증상을 나타내는 병증
- 성욕을 해소하지 못하거나 과도한 성생활이 원인이 됨.

4. 양강(陽強)

- 성욕, 성적자극이 없는 상황에서 발기가 지속되는 것.
- 돌연 발병하여 장시간 발기되며, 음경의 통증과 배뇨곤란이 나타남.
- 주로 간, 신의 기능실조와 연관
- 허증 : 방로과다, 신음휴손, 음허양항
- 실증 : 습열하주, 질타손상
- 치료의 주안점은 이상발기 상태인 음경 내의 혈액순환을 도모하여 혈류를 개선함으로써 발기상태를 완화시키는 것이다.

2절. 여성의 성 관련 증후

한방에서는 여성 성기능장애를 남성만큼 많이 다루지 않는다.

1. 여성 성고조 장애 (불감증) ★

- 여성의 성 기능 장애 중 가장 흔함
- 정상적인 성적 욕구를 가진 여성이 충분한 성적 행위를 함에도 불구하고 흥분기에 이르러 극치감을 느끼지 못하는 질환
- 90% 이상이 정신적 요인
- 한의학적으로는 정지불서나 억울한 감정이 간기울결을 일으켜 소설실상하게 되고 기기가 실조된 결과 기혈이 불화하여 발생하게 된다.
- 서양의학에서의 정신장애 중 여성 절정감장애 female orgasmic disorder에 해당한다.

우울증, 불면증 같은 것들이 관련될 수 있다. /부부간의 불화가 있을 때 나타날 수 있다.

부부간 불화 후 남녀간의 차이: 남자는 성관계를 통해 화해하고 풀 수 있다고 생각하는데, 여자는 용납이 안되어서 성고조 장애가 생길 수 있다.

2. 몽교 : 여성이 꿈속에서 남성과 성교하는 것, 남성의 夢遺.

- 부인대전양방 : 장부기혈의 俱虛, 神明失養
- 의종금감 : 칠정이 심비를 손상한 결과
- 몽교는 신경증에서 나타날 수 있으며, 대부분 정신이상과는 관계가 없으나 조현병에서 나타날 수 있음.

3절. 남녀 공통의 성 관련 증후

1. 성욕저하

- 한의학적으로 심, 간, 신과 밀접한 관계
- 성욕 저하는 대부분 정신심리적 요소가 원인이 되어 발생, 과도한 긴장, 恐懼, 憂愁, 思慮過度, 大怒大喜, 부부관계 불화 등
- 우울증 유무 파악
- 성욕의 결핍은 성교육(성을 부정적이거나 추한 것으로 인식하게 하는)과 밀접한 관계가 있다.
- 양위는 정상적 성욕을 가지고 있으나 발기가 이루어지지 않는다는 점에서 성욕저하와 다름.
- 여성의 경우에는 '女子陰痿'라고도 하며 윤활-종창 반응의 장애가 동반. 심리적 요인으로서 임신과 성병에 대한 두려움, 상대방에 대한 거부감, 정신적 스트레스 등에 기인하며, 성교통증이나 극치감 장애 등 다른 성기능장애에 의한 것인지를 감별하여야 한다.
- 서양의학에서의 정신장애 중 성욕감퇴장애 hypoactive sexual desire disorder에 해당한다.

2. 성욕 항진

- 한의학적으로 심, 간, 신과 밀접한 관계
- 남성의 성욕 항진은 화치(花痴)라고 하기도 함
- 성욕 항진은 표출되지 못한 정신적 억압이나 스트레스가 원인이 됨
- 또한 정신적으로 과도한 흥분이 지속될 때나 조증(양극성 장애)에서도 나타날 수 있음.

3. 축양(縮陽), 축음(縮陰)

- 恐懼로 인해 생식기 수축, 소복급통, 공포, 번조 불안이 나타나는 것
- 대부분 남성, 주요원인은 정신적 요인, 남성의 경우에는 축양, 여성의 경우에는 축음이라고 함.
- 여성은 음도경련. 서양의학의 질경련증에 해당하는 것.

- 축양과 비교할 때 양위는 음경이 연축되어 성교가 불가능한 것이며, 돌연수축 및 소복통의 증상이 나타나지 않는다는 점에서 다르다.

4. 성교통증

- 성행위시만 통증이 발생, 한의학적으로 간과 밀접한 관계
- 기질적인 원인으로서는 생식기 염증 가능, 또한 남성은 정관수술 이상, 여성은 질구협착과 골반내 병증, 그리고 성교시에 질내 분비물 부족으로 인한 陰道乾澀에 기인함
- 서양의학에서의 정신장애 중 성교통증 dyspareunia에 해당한다.

5. 성혐오증

- 성에 대한 관념이나 성행위에 대한 극도의 거부감을 나타내는 질환
- 주로 성장기의 정신적 충격, 잘못된 성교육에서 기인, 성과 관련된 것에서만 거부, 일체 접촉, 생각 회피
- 성욕저하는 일상생활이나 성행위에 있어서 전반적인 욕구의 저하를 나타내는 데 반해, 성혐오증은 정상적인 생활에도 불구하고 성과 관련된 것에 대해서만 거부하고 일체의 생각이나 접촉을 회피한다는 점에서 다르다.
- 서양의학에서의 정신장애 중에서 성적혐오장애 sexual aversion disorder에 해당한다.

4절. 치료

1. 변증시치(교과서 p.388) ✓ 참조하세요 하고 넘어감 밑줄만 언급.

- 신양허쇠 : 찬육단
- 간기울결 : 시호소간산, 시호가용골모려탕, 소요산
- 심비허손 : 귀비탕
- 습열하주 : 용담사간탕
- 음허화왕 : 지백지황환, 대보음환
- 어조경맥 : 도홍사물탕, 혈부축어탕

2. 침구치료 : 증상에 맞춰서 치료

#진료시 주의사항

비밀스럽고 민감한 문제이므로 수치심을 느낄 수 있기 때문에, 먼저 의사-환자의 라포 형성이 이루어져야 함,

불편함에 대해 충분히 공감하고, 정중하고, 신뢰할 수 있는 태도를 취해야 함.

자신의 증상을 표현하는 것에 주저할 수 있기 때문에 비언어적 표현에 주의를 기울여야 함

잘 모르거나 오해에서 비롯될 수도 있기 때문에 정상적인 성 반응이 어떻게 이루어진다는 교육이 필요할 수 있음

환자 혼자만의 문제가 아니라 부부간에 협조해서 진료할 필요가 있다.

5절. 양생법

1. 성 양생법 ★

- 성생활의 칠손 팔익

시험에는 내지 않은 것이지만 국시에 자주 나온다2

(1) 칠손

- 폐(閉) : 교합시 精道가 폐색되어 사정이 불가능한 것
- 설(泄) : 교합시 汗出하여 정기가 외설하는 것
- 갈(竭) : 성생활을 절제하지 않아 정액이 고갈되는 것
- 물(勿) : 발기가 되지 않는데 강제로 성교하는 것
- 번(煩) : 교합 시 심중번란한 것
- 절(絶) : 여성이 원하지 않는데 강제로 성교하는 것
- 비(費) : 충분한 전희 없이 급하고 난폭하게 성교하는 것

(2) 팔익

- 치기(治氣) : 교합하기 전에 기공과 도인법을 통해 기를 단전에 모으는 것
- 치말(治沫) : 설하에 진액을 모아 삼키는 것
- 지시(知時) : 충분히 흥분기에 접어든 후 성교하는 것
- 축기(蓄氣) : 기를 항문에 수렴해 전음으로 도기하는 것
- 화말(和沫) : 교합시 조급하거나 난폭하지 않게 하는 것
- 적기(積氣) : 욕구를 조절하여 성교를 절제하는 것

- 시파(侍羸) : 깊이 호흡하여 적기를 음기에 모으는 것
- 정정경(定精傾) : 교합시 성기를 청결히 하는 것

2. 성생활의 금기 ✓ 교수님 曰 기억해 두시면 좋을 것 같아요~

- 취이입방
- 칠정이 태과한 경우
- 포식노권 후
- 질환의 初愈시
- 기후와 환경이 좋지 않은 경우
- 여성의 三期(經期, 孕期, 産後哺乳期)
- 성기가 불결한 경우
- 주간에 行房
- 補腎약물을 과용한 行房